复杂性创伤后压力综合征的自我疗愈

——基于躯体体验的视角

Self-Healing for Complex PTSD: From the Perspective of Somatic Experience

◎ 光瞳

2025.12.31 • 郑州

目录

前言.....1

缘起.....1

基本思路.....2

阅读提示.....3

1 自助的基本认识.....5

1.1 人性观.....5

1.1.1 亲社会性.....5

1.1.2 生命的基本矛盾.....5

1.1.3 全局观.....5

1.2 责任观.....6

1.2.1 自我负责精神.....6

1.2.2 防疫精神.....7

1.2.3 爱与大我精神.....7

1.2.4 全力斗争精神.....8

1.2.5 持久战精神.....8

1.3 心理治疗的社会关系范式.....9

1.3.1 先天与后天观.....9

1.3.2 社会关系模型与神经生理模型.....11

1.3.3 自愈的典型过程.....11

1.4 积极心理学的差异观.....12

1.4.1 大同小异观.....12

1.4.2 谱系观.....12

1.4.3 谱系观视角下的诊断标签.....14

1.4.4 谱系观视角下的自助.....14

1.5 交流圈.....16

1.5.1 交流圈的概念.....16

1.5.2 主体-世界交流圈与主体间交流圈.....16

1.5.3 观察者与当事者.....17
1.5.4 同步性.....18
1.5.5 合作与对抗.....19
1.5.6 互馈.....20
1.6 体感疗法的身心观.....20
1.6.1 整体观.....20
1.6.2 整合的身心观.....21
1.6.3 适应策略的降级与过度应激.....23
1.6.4 两种成长.....24
1.6.5 身心协同性.....25
1.6.6 整合观视角下的自助.....26
2 概念解析.....27
2.1 活动.....27
2.1.1 活动与活动性.....27
2.1.2 微活动、冲动与显著活动.....28
2.1.3 冲动与想法.....30
2.1.4 活动与互动.....31
2.1.5 活动与感知觉.....31
2.1.6 微活动与感知觉品质.....33
2.1.7 活动性与现实检验.....33
2.1.8 活动性与植物神经系统.....34
2.1.9 活动性与注意力品质.....34
2.1.10 强迫性.....35
2.2 感觉与知觉.....35
2.2.1 感觉与知觉的关系.....35
2.2.2 现实感.....36
2.2.3 想象知觉与现实知觉.....37
2.2.4 现实检验.....37
2.2.5 体觉.....38

2.3 唤醒水平.....39
2.3.1 唤醒的概念.....39
2.3.2 唤醒水平与活动性.....40
2.3.3 活力.....41
2.4 意识与意识对象.....41
2.4.1 意识对象的概念.....41
2.4.2 意识对象的切分.....42
2.4.3 意识对象的残迹与身心状态的滞留.....43
2.4.4 心理创伤的形成.....44
2.5 注意.....45
2.5.1 注意的概念.....45
2.5.2 注意的能动性.....46
2.5.3 注意力的品质.....46
2.5.4 互动平衡.....47
2.5.5 专注.....47
2.5.6 正念.....49
2.6 压力.....51
2.6.1 压力与应激.....51
2.6.2 生理压力与心理压力.....51
2.6.3 心理冲突与心理压力.....52
2.6.4 魔鬼的气球.....54
2.6.5 赤子之心.....55
2.6.6 防御.....56
2.6.7 动力.....56
2.7 情绪.....58
2.7.1 情绪的概念.....58
2.7.2 初级情绪与次生情绪.....58
2.7.3 积极情绪与消极情绪.....59
2.7.4 受困者的消极情绪.....60

2.7.5 情绪与感受.....63
2.7.6 感受的主体间性.....64
2.7.7 述情障碍.....66
2.7.8 宣泄.....67
2.8 解离.....67
2.8.1 解离的概念.....67
2.8.2 身心解离.....68
2.8.3 心智解离.....69
2.8.4 解离与正念.....70
2.9 体会.....71
2.9.1 体会的概念.....71
2.9.2 话语霸权与共识.....72
2.9.3 体会与身心智关系.....74
2.9.4 体会与表达.....75
2.9.5 体会与自我倾听.....76
2.10 序列化行为.....77
2.10.1 序列化行为的概念.....77
2.10.2 序列化行为的建立与瓦解.....77
2.11 条件反射.....78
2.11.1 条件反射的序列化解释.....78
2.11.2 情绪闪回.....79
2.11.3 广场焦虑反射.....80
2.11.4 创伤的微妙化与显著化.....80
2.11.5 创伤性重演.....81
2.12 身心状态.....81
2.12.1 习惯状态与最佳状态.....81
2.12.2 中立状态.....82
2.12.3 中立状态的养成.....82
2.12.4 自我安抚.....83

2.12.5 内在声音.....84
2.12.6 躯体记忆、直觉和依恋.....84
2.12.7 依恋关系与交流圈的品质.....85
2.12.8 情感底色.....86
2.12.9 情感遗弃与情感忽视.....87
2.12.10 中立状态的意义.....87
2.12.11 身心状态的划分.....88
2.12.12 身心状态视角下的自助.....90
3 病理论述.....91
3.1 应激.....91
3.1.1 应激与应对.....91
3.1.2 僵直.....92
3.1.3 应对能力的发展.....94
3.1.4 心理韧性.....95
3.2 定向反应.....96
3.2.1 定向反应的概念.....96
3.2.2 定向反应与情绪.....97
3.2.3 创伤化的过程.....97
3.2.4 自我对抗.....99
3.2.5 寄生性紧张的补偿效应与省减效应.....99
3.2.6 危机信号的泛化与闪回的触发.....101
3.2.7 僵直的发展与解除.....102
3.2.8 定向反应的重启.....103
3.3 自我抑制与微观管理.....104
3.3.1 自我抑制.....104
3.3.2 意志力.....104
3.3.3 自我抑制与克制.....104
3.3.4 自我抑制与解离.....105
3.3.5 微观管理.....106

3.4 神秘主义与情绪推理.....107
3.4.1 神秘主义.....107
3.4.2 情绪化推理.....108
3.5 无助.....109
3.5.1 无助与掌控.....109
3.5.2 主体-世界交流圈视角下的无助.....109
3.5.3 主体间交流圈视角下的无助.....111
3.6 活动视角下的创伤.....111
3.6.1 创伤与活动性的退化.....111
3.6.2 磨损性创伤.....112
3.6.3 破碎的自我认知.....113
3.7 注意力品质视角下的创伤.....114
3.7.1 无可注意.....114
3.7.2 自我沉迷.....114
3.7.3 自我催眠.....115
3.7.4 注意力缺陷与多动表现.....116
3.7.5 瞬间定位能力.....117
3.7.6 异常注意力品质的常态化.....118
3.7.7 敏感与愚钝.....119
3.7.8 神游.....120
3.7.9 思维反刍.....121
3.8 身心状态视角下的创伤.....122
3.8.1 中立状态的变形与瓦解.....123
3.8.2 摇摆不定的性情.....125
3.8.3 社会性退化.....126
3.8.4 中立状态与述情障碍.....127
3.9 复杂性创伤的形成.....128
3.9.1 受伤与停滞.....128
3.9.2 创伤性压力与创伤化.....129

3.9.3 创伤易感性与二次创伤.....131
3.9.4 生理脆弱性与心理脆弱性.....132
3.9.5 微妙的生理缺陷与情感忽视.....133
3.9.6 创伤的代际传递.....134
3.9.7 共情与创伤的传染.....135
3.9.8 家庭关系中的课题分离.....137
3.9.9 消沉的代际传递.....138
3.9.10 推拉效应.....139
3.9.11 情绪稳定性的丧失.....139
3.10 早期崩溃.....140
3.10.1 创伤知情思想的扩展.....140
3.10.2 神经多样性与标签化.....141
3.10.3 显著的早期崩溃.....142
3.10.4 微妙的早期崩溃.....144
3.10.5 ASD 和 ADHD 的创伤故事.....144
3.10.6 儿童创伤的隐蔽性.....145
3.11 创伤的交织.....145
4 自助的基本工具.....147
4.1 生物性节律.....147
4.1.1 生物性节律的概念.....147
4.1.2 情绪节律.....148
4.1.3 摆动.....148
4.1.4 劳动.....149
4.2 眼动脱敏与再加工技术的启示.....149
4.3 肢体对抗能力训练.....151
4.3.1 对抗的意义.....151
4.3.2 肌肉的强化与松解.....151
4.4 注意力的牵引.....152
4.4.1 补充知觉反馈.....152

4.4.2 看见空白.....152
4.4.3 看见他人.....152
4.4.4 树立榜样.....153
4.4.5 找到精神寄托.....153
4.4.6 找到值得对话的伙伴.....154
4.5 动中觉察与体感疗法.....154
4.5.1 滴定.....154
4.5.2 动中觉察和体感疗法的自助改造.....155
4.5.3 获取流畅感.....156
4.5.4 激活创伤体验.....157
4.5.5 见证自我抑制.....157
4.5.6 注意自身驱力.....157
4.5.7 身体与心智的对话.....158
4.5.8 突破自我抑制.....159
4.5.9 重建情感连接.....160
4.6 特殊思想工具.....161
4.6.1 链网释法与互释法.....161
4.6.2 配对意识.....162
4.6.3 图像式思考.....162
4.6.4 关系映射.....163
4.6.5 角色代换.....164
4.7 认知矫正与社会常模.....164
4.8 哀悼.....165
4.8.1 哀悼的概念.....165
4.8.2 哀悼与羁绊.....166
4.8.3 哀悼与仇恨.....166
4.8.4 哀悼实例一则.....167
4.9 书面表达.....169
4.9.1 书面表达的意义.....169

4.9.2 书面表达的原则.....170
4.10 梦境与半醒时分.....171
4.10.1 梦.....171
4.10.2 半醒时间.....172
4.10.3 梦与闪回.....174
4.11 幽默感训练.....175
4.12 贵人.....175
4.13 饮食调整.....176
5 自我概念化.....177
5.1 自我概念化的内涵.....177
5.2 从复杂性创伤中毕业.....178
5.2.1 康复与毕业.....178
5.2.2 强者与弱者.....178
5.2.3 毕业的现象学指征.....179
5.3 迷路者的小故事.....181
5.3.1 自我认知类.....182
5.3.2 人际关系类.....189
5.4 觉醒时刻的小故事.....201
6 念给自己的咒语.....207
7 参考资料与推荐书目.....208
7.1 心理学基础必读.....208
7.2 早期崩溃必读.....208
7.3 认知行为疗法必读.....209
7.4 心理动力学必读.....210
7.5 体感疗法&感觉运动心理疗法&身心学必读.....210
7.6 无伤运动必读.....211
7.7 选读.....211

前言

缘起

很多年前，我参加过某高校的一个心理学研究项目。其中有一个测试，我前后做了两次，两次间隔好几个月。测试过程中我需要戴上一个特殊的帽子，然后在电脑屏幕的提示下操作鼠标。我在两次测试时的心态完全不一样。第一次测试令我感到十分新奇，同时出于对实验的重视，我做得十分用心，自以为做得还行，结果却相当糟糕——相比测试成绩，实验者更关注受试者在接受测试时的大脑活动，而我的前额叶皮层的活动得到了一个很差的评估。第二次测试时，我已经没有了新鲜感，而且因为第一次结果太差，我的心态就有些摆烂了。我在测试过程中感觉很不好，中间好几次低级失误气得我想要骂人，我竭力控制住了自己。出乎意料的是，结果很不错，我得到了一个与常人无异的评估。

他们只拿了我的测试结果和评估结果，对我的主观体验显然没有兴趣。但这两次测试给了我两个重要启示：一是我可以通过对自身现象学世界的觉察评估自己大脑的活动状态和工作模式。就像我们可以通过触觉感受物体的形状一样，现象学体验就是大脑的“触觉”。在此之前我一直以为了解大脑状态只能依靠功能性磁共振成像（fMRI）等专业工具，无法主观评估。二是我对“正常状态”的理解和常人存在很大偏差。当我“努力”做一件事的时候，我其实在强迫自己的大脑往错误的方向使劲儿。当我放弃这种努力的时候，大脑反而会回归正常。这种自发回归一般状态的潜力是受困者与精神病患者的根本区别。

这次经历宛如一枚闪光弹自夜空坠下，让我短暂而模糊地看到了身前的地形，从此开始艰难前行。本文虽然参考了很多资料，但并非简单拼凑而成，它的核心思想全部来自我的现实经历。正因为来自一个完整主体的现实经历，所以我才坚信它有足够的生命力，可以帮助别人。

基本思路

自助的前提是独立生活能力。对于尚年幼的当事者，治疗必须从重建依恋关系（attachment）入手。这需要当事者、养育者和专业人员共同参与，非本文力所能及。本文主要服务于已在跌跌撞撞中步入成年，拥有一定独立生活能力的当事者。

认知行为疗法（Cognitive Behavior Therapy，CBT）在创伤后应激障碍（posttraumatic stress disorder，PTSD）治疗领域占据着绝对主导地位。其中尤以认知加工治疗（Cognitive Processing Therapy, CPT）和延时暴露疗法（Prolonged Exposure Therapy, PET）应用最为广泛。但是，当认知行为疗法应用于复杂性创伤后压力综合征（Complex PTSD，CPTSD）时，效果却不尽如人意。

与 PTSD 相比，CPTSD 涉及的创伤源往往相对温和，主体更容易承受在处理创伤过程中激起的各种痛苦情绪，这为自救提供了一定空间。主体作为亲历者，在梳理复杂感受方面也有特殊的资源优势。从心理学角度来说，CPTSD 远比 PTSD 复杂，但是从自救角度来说，CPTSD 反而比 PTSD 容易处理。这也是我更倾向于将 CPTSD 译作“复杂性创伤后压力综合征”而非“复杂性创伤后应激障碍”的原因。

心理障碍的消解需要依托良好的社会关系，但当事者往往极度缺乏与他人发展有意义的关系的能力。如果强行将他们推入各种复杂的社会环境（类似暴露疗法的做法），不但无益于成长，而且可能造成二次伤害。实际上，自我疗愈的早期阶段完全可以在相对简单的社交情境甚至安宁的独处中进行。只有在处理了一些顽固的基础问题以后，社会层面上的支持才能充分发挥作用。本文重点关注的就是处理这些基础问题的方法。

着眼于躯体体验的创伤治疗技术脱胎于格式塔疗法（Gestalt Therapy，或称完形治疗）。其中以彼得·莱文（Peter Levin）的体感疗法（the Somatic Experiencing approach，简称 SE，又译“身体体验疗法”或“躯体体验疗法”）最为知名。认知行为疗法从认知图式和行为习惯入手，驱动身心状态发生转变。但 CPTSD 还需要更多复杂微妙的处理，需要用到很多特殊的思想工具和实践技巧。体感疗法从躯体体验切入，正好弥补认知行为疗法的不足。从认知行为疗

法的角度来看，体感疗法在操作上很像是认知加工疗法和延长暴露疗法的一种特殊封装版本。它以具体个案为中心，充分关注难以表达的微妙细节，极具耐心和专注度。本文关注的正是以体感疗法为代表的各种基于躯体体验的创伤治疗技术对认知行为疗法的补充作用。

国人对心理治疗的印象主要局限于认知行为疗法和心理动力学（psychodynamics），对基于躯体体验的治疗技术较为陌生，相关资料与国际前沿存在显著代差。如果不做足铺垫，文章内容怕是会令很多读者瞠目。因此本文会用较多篇幅介绍相关概念和思想，对认知行为疗法和心理动力学不再赘述，有关资料可通过文末推荐书目获得。

注意力缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，ADHD）和自闭症谱系障碍（Autism Spectrum Disorder，ASD）只是宽泛的症状集合而非严格的病理标签。对其内涵的具体理解直接影响干预方式的选择。本文基于早期崩溃（early breakdown）理解 ADHD 和 ASD，也就意味着 ADHD/ASD 的干预必须以 PTSD/CPTSD 的干预为基础。相比神经多样性范式、病理学范式和传统的社会关系范式，本文对 ADHD/ASD 的认识和理解可概括为“立足于现象学世界的社会关系范式”。

在不致造成歧义的前提下，本文将心理创伤称作创伤。但我们将很快看到，心理创伤与身体创伤有很大的同源性。脆弱的心理与脆弱的身体是一对孪生兄弟。

本文既非保姆式的教程，也非字典式的手册。本文仅是作者基于自身知识储备和切身经验所作的分享。希望能为有需要的人带来一些帮助，也希望普通人能够借此一窥当事者的现象学世界（或称“主观现实”），从而能够多一些理解与包容。检验真理的最终标准是实践而非权威，不能给出解决方案的诊断对于当事者缺少意义。用后现代心理治疗理论的话说，每个来访者都是自身问题的专家。对于心理治疗理论的科学性，当事者和研究者拥有同等发言权，二者是对等合作关系。

阅读提示

全文共计十六万余字，分为七章。为使行文简洁，对于在文末必读书目中

已经详尽解释的概念（譬如应激障碍的定义、CPTSD 的定义等）或案例，本文不再多做说明。这可能给缺少心理学基础的读者或者因为严重创伤化而导致注意力缺陷的读者带来一定阅读难度。这种难度是必要的，可以理解成作者有意安排的挑战。读者也可尝试从第四章开始阅读。

文章末尾的必读资料（详见 7.1-7.6 节）绝非本文可有可无的点缀。如果这些资料看不进去，恐怕本文也难合胃口。其中，标★的两本是本文思想的直接来源，没有它们就没有本文。

与 PTSD 不同，CPTSD 相关的负面经历更加强调主观体验的极度痛苦而非客观事实的致命性。这些经历虽然不见得致命，却最终造成了一样严重甚至更加严重的心理后果，将主体困在了深渊之中。因此，相比“幸存者”，我更倾向于用“受困者（无自觉）”和“自救者（有自觉）”来称呼当事者。

本文无意于囊括全部 CPTSD 类型。在直面创伤之前，主体适应创伤的基本策略可以分成激越型（高能量型）和消沉型（低能量型）两类。激越型受困者摆脱 CPTSD 的过程有赖于成长道路上的各种“贵人”，阅读自救读物对于他们是一种折磨。只有消沉型受困者才有可能从本文获益。因此本文所述 CPTSD 特指消沉型 CPTSD。同理，本文所述 ASD/ADHD 也无法覆盖其所有类型。

自助对主体自身的要求远比常规意义的心理治疗高得多。离开了治疗师的支持，自己的身体就成为了疗愈能量最主要的来源。离开了专业的治疗关系，健康的日常关系就成为了心灵最主要的养料。CPTSD 的自救是一项严肃、漫长、极具挑战性的工作。知识储备、生活阅历、学习能力、耐心、决心、悟性都不可或缺。只有坚信自己拥有这些能力的人才能自救。超越创伤的旅程宛如一次重生，许多人会因此而收获更高的思想境界，正所谓功不唐捐。本文不适合追求速成之人或者仅仅只是为日常琐事困扰之人。

除引文段落外，本文属于原创作品。本作品采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议(CC BY-NC-ND 4.0) 进行许可。

1 自助的基本认识

1.1 人性观

1.1.1 亲社会性

本文不讨论反社会性人格。

亲社会性（爱）是人类的本能。常人之所以偏好社交，并不是因为常人的亲社会本能更强，而是因为常人在生活中积累了丰富的积极互动体验。如果一个人从未与他人建立过有意义的情感连接，就不可能知道什么是孤独，更不可能主动去抗拒孤独，但这并不意味着他们不会遭受孤独的影响。例如自闭症谱系障碍（或其他广泛性发育障碍）儿童普遍存在植物神经紊乱、免疫力低下、唤醒水平异常、注意力调节困难等问题，这些问题在很大程度上都是由长期孤独造成的。

心理治疗的目标是充分舒展主体自身的天性，而非追求什么“理想人格”。如果主体表达爱意的能力受限，那只是因为他遭受过很深的伤害。

与反社会人格的高度自洽形成鲜明对比，受困者既放不下羁绊，也放不下怨念，既不知感恩，也无力周旋。这种内耗是他们长期痛苦的根源。

1.1.2 生命的基本矛盾

“万物合一（爱）”与“独立自主（力）”之间的矛盾是生命的基本矛盾，也是我们谈论一切分化与整合问题的出发点。主体在二者间的取舍决定了他获取平静、安全、掌控和满足的底层逻辑。

1.1.3 全局观

一个人的唤醒水平、生理机能、思维习惯、行为习惯、社会角色、人际关系是一个庞大而密不可分的整体，任何一个环节的显著变化都可能触发出乎预料的连锁反应，造成严重后果。不论施助者还是受助者都必须对此保持清醒的认识和充分的敬畏。改变只能由当事者完成，别人充其量只能搭把手而已。本

文作者更希望自己被看成一位分享者而非施助者。真正支持自救的是这个社会，作者只是其间一位发声者。如果本文让你感受到了这世界的爱和阳光，那么希望你能把同样的爱和阳光回馈给这个世界。

1.2 责任观

1.2.1 自我负责精神

创伤与缺陷并非自己的过错，但自己必须为自己的解救负起最终的责任。能看清自己的责任，才能看清自己拥有的能动性和影响力。“为自己负责”绝非“受害者有罪”。负责本身涵盖了保全自己而非代人受过。

虽然很多受困者的不幸都和生理缺陷、原生家庭或成长环境相关，但是这些因素都属于人生的“初始设定”。走出创伤阴影的第一步，就是接受自己的初始设定。只有能领悟这一点的人才有可能实现自救。

培养自我负责精神，首先需要完成从受害者到参与者和博弈者的身份转换。将核心关注点从“自己受到了哪些伤害”转移至“自己何以坚持至今”和“自己还可以做些什么”。

疗愈的过程会唤起大量愤怒。受困者必须牢记“恨事不恨人”的原则。原谅和清算都与疗愈无关，它们应该是在疗愈完成后由主体凭借自己完整的认知能力重新评估的事情。感受愤怒是为了让我们重拾被自己放弃的内在力量，而不是为了将失去力量的原因归咎于他人的剥夺。把原因归咎于他人，相当于承认了他人可以控制我们的疗愈进程，这无疑是自挫的做法。把对别人的期待转化成对自己的期待，专注培养自身力量，自己就永远不会气急败坏。

上边这番话是我对启程者的忠告。当读者完成了自救之旅，找到了自己的内在力量，超越了小我大我之辨后，相信他们很容易看出这种表述的局限。人生从来不存在什么被动的设定，只有我们的主动选择。我们选择这样的起点，是因为我们希望以这样的方式度过此生。我们身边的人既带给了我们最需要的挑战，也给了我们最需要的支持。

1.2.2防疫精神

心理创伤与其说是创伤，不如说是病毒。它总是在最亲近的人之间互相传染。主体既是病毒的受害者，也是整个病毒传播链条中的一环。看清楚自己的角色，才能看清楚自己责任和力量。

如果养育者总是不自觉地压抑自己的感受，那么被养育者就很难学会与自己的感受相处。他们甚至可能连学习如厕之类简单的生存技能都比一般的孩子困难，因为他们无法理解自己的便意。面对一个神经质的家庭成员，其他成员如果爱他却无法改变他，就只能努力适应他，从而发展出相似或互补的神经质特质。每个家庭成员说过的每句话、做过的每件事都参与了家庭氛围的塑造。家庭氛围就像家族的基因一样代代相传，塑造了每个人的品格与灵性。

主体学习自救，不只是为了自己，更是为了自己所爱的人，尤其是自己的下一代。

1.2.3爱与大我精神

主体如果不能明确自救的目的，一旦触及实质性问题，必然临阵脱逃。自助读物大都立足于西方文化背景，喜欢强调“自我”在疗愈中的核心地位。然而这个“自我”并非我们理解的主体，它的背后实际站着一个“上帝”。在中国文化背景下，为何疗愈、为谁疗愈是值得深入思考的问题。

如果是为了摆脱痛苦或者是为了取得成就，那就完全没有必要自救。因为自救的过程充满了各种痛苦，却无法直接带来任何世俗意义上的成就。这两个目的只需要当事者拥抱流浪者人生观，成为“短生种”就可以快速达到。创伤带来的解离状态正是流浪者所需要的最舒服的状态。流浪者不需要疗愈创伤，他们只需要以怨恨为食。参考反社会人格者，他们没有良知，也就没有什么力量能够伤害他们。失去了道德的约束，他们可以快速取得万众“瞩目”的成就。

自救的过程是学会爱、理解爱的过程。没有爱就不可能有足够的自救动力。所有“摆烂”或“躺平”的人都有关键的怨恨（很可能指向他们最亲近的人）没有得到正视和处理。他们压抑了这种怨恨，也就压抑了自己的生命力。

爱与被爱是一体两面的关系。有能力爱，才有能力接受爱，反之亦然。受困者能意识到人们对他的爱，但无法感受爱（Awareness is present, but affect is

absent）。他只能感受到爱的匮乏。他也想爱别人，但作出的行动却只是讨好。爱人与爱己也是一体两面的关系。我们无法指望一个不自爱的人去爱别人，也无法指望一个没有爱心的人学会自爱。大众传媒惯于利用割裂制造话题，作为自救者必须抛弃这种二元对立思维。

正如骨盆的问题有可能源自足底的异常，“连锁反应”和“长期蓄力”是心理问题的常态。问题很少会直接暴露在它形成的地方，而它的解决方案更不会出现在它暴露的地方。一直盯紧自己的创伤和缺陷的人只会在其中越陷越深。找到自己的心灵寄托与人生追求，在追求的过程中与他人建立并发展情感连接，才是人格发展的正途。没有爱就不可能有足够的自救资源。

人格发展的过程是主体走出自我，走向他人的过程。走向他人的过程又是完善自我，学会独处的过程。这听起来有些矛盾，然而这种矛盾正是生命与死物的本质区别。理解矛盾，达到“欲辨已忘言”的境界，往往是觉醒的起点。

自救初学者可以将爱简单理解成“情感连接”。它代表了人与人之间、人与世界之间最朴素、最真实的信任关系。当我们允许一个人影响我们的情绪的时候，此人与我们之间就有爱存在。情绪受到的影响越大，爱就越深。可见，心理学讨论的爱与日常用法大不相同。恨（心血被辜负）不是爱的对立面，而是爱的产物之一。爱的对立面是疏离、孤立和忽视。随着学习逐步深入，自救者自然会对爱形成超越文字的理解。

1.2.4全力斗争精神

如果将创伤比作树木的伤口，CPTSD 就是遍体鳞伤的树木倒下后散落的枯枝败叶。CPTSD 的治疗过程既不是简单的处理创伤的过程，也不是简单的清理垃圾的过程，而是在残躯上再度长出一棵大树的过程。受困者必须丢掉“缝缝补补又三年”的幻想，做好脱胎换骨的准备。受困者只有认识到自己已退无可退，一切逃避手段都已经彻底失效时，才能走向觉醒。否则，他们很容易在自救过程中陷入自怜。

1.2.5持久战精神

反应的极端化总是和事件的孤立性紧密相连。面对一个麻烦，如果一个人

相信自己不可能第二次碰到它，他很可能要么孤注一掷，透支自己，要么什么也不做，只是闭上眼睛祈祷它快点过去。但如果他相信这个麻烦会成为常客，如果置之不理，自己将受到越来越多的限制，他就会采取完全不同的态度。能够走出创伤阴影的人远比常人更加懂得“周旋”二字的分量。

CPTSD 的自救是一个螺旋上升的过程，无法一蹴而就。过程中每一轮新的循环都比上一轮需要承受更大的压力，同时也有更多的资源可以利用，循环结束后主体也会收获更多的活力和更深刻的平静。在循环的过程中，主体的身心从一地碎屑开始，逐渐形成较大的碎片，最后融合成一个统一的整体。

每一轮循环都是一个“开窍”“觉醒”或者“升维”的过程。它是在主体最本真的生命力得到释放后自然完成的。心理治疗是为了使我们舒展天性，从生活的“流畅感”中找回自信，而不是把我们变得小心翼翼。

1.3 心理治疗的社会关系范式

1.3.1 先天与后天观

异常的神经模式是心理问题的原因还是结果？这个问题无法在神经科学的框架中得到回答。很少有人寄希望于通过研究社群成员的消化系统来理解当地的饮食文化，但吊轨的是总有一些人希望通过研究神经系统来理解人类的心理活动，这称得上是这个时代的一大文化特色。

作为生物体的人和作为社会个体的人并不在一个层面上。这一观点可以借助计算机科学中“软件系统”与“硬件系统”的关系来理解：早期的计算机系统并不刻意区分“软件”与“硬件”。随着计算机系统日趋复杂，人们开始从“硬件系统”和“软件系统”两个维度描述计算机系统。虽然软件系统以硬件系统为基础，但两者的概念系统和话语体系相互独立，软件系统并不能简单还原为硬件系统。计算机的一次作业过程可以从硬件过程和软件过程两个角度进行表述，两种表述都是自洽的。二者在结构上无法简单对应，在逻辑上不能强加因果。二者之间的关系是复杂的（complex）而非线性的（linear）。同样，描述人的活动能力（尤其是社会活动能力）所使用的概念并不能与人体（包括人脑）的解剖结构或物质成分简单对应。

例如，人们曾经以为大脑的枕叶负责视觉功能。但随着技术的进步，人们发现盲人的枕叶同样高度活跃，于是人们对枕叶的认识上升到了负责空间辨识功能。后来，人们发现单凭枕叶无法形成完整的空间感知能力，枕叶也不仅仅在辨识空间的过程中发挥作用。如今，科学家对大脑的认识已经发展到了非常抽象的程度，一系列独特的、脱离生活语言的概念系统正在形成。

与神经科学的情况类似，基因在分子生物学中的地位远没有普通人看得那么高。DNA 序列本身是静态的，但生命是动态的，这个动态性主要由“调控网络”赋予。那么调控网络的“活力”又从何而来呢？只要我们愿意刨根问底，这个问题可以无限循环下去。受困者关心先后天之争无非是为了获得心理安慰，然而这不可能有什么结果。体感疗法的创始人彼得·莱文是科学主义的信徒，可我不是。在我看来，他那种为心理创伤寻找生理基础的执念就跟计算机科学的门外汉执着于将软件功能对应到电路板上的电流一样荒谬。相比心理的神经生理基础，我更关心这些生理基础背后的演化动力。

计算机软件工程师并不需要了解硬件工作过程的无穷细节，也不会因为自身能力不足就轻率要求变更硬件系统。我们也无须为了理解和处理自己的创伤而学习无穷无尽的神经生物学或神经化学知识，这对于自助意义不大，而且药物干预或物理介入常常意味着风险。研究者们生硬地区分“先天因素”和“后天因素”，“内生因素”和“外界因素”，主要是为了完成责任切割，明确限定“不可干预”与“可干预”、“理化干预”与“认知干预”的分野，以回答“能否干预，谁来干预”的问题。这个问题的答案关乎研究者（观察者）的切身利益，对于当事者却几乎毫无价值。

假如我们将心理障碍的生理基础比作母鸡，将异常的认知图式和行为习惯比作鸡蛋（这样类比是考虑到鸡生蛋比蛋生鸡更容易），那么心理障碍形成的过程就是鸡生蛋蛋生鸡直到鸡圈被挤爆的过程。干预的首要目标在于打破这一循环，而非关心最初到底是蛋多还是鸡多。情绪智力如同肌肉，它既是天生的，又是练出来的；既是命运赐予我们的礼物，也是命运为我们施加的限制；既是在各种活动中下意识地发展的，也可以通过有意识的锻炼得到发展。任何心理障碍都是先天因素（不可抗力）和后天因素（可抗力）共同作用的结果。一种心理障碍主要被归因于先天还是后天，取决于当事者或研究者如何看待自身在

其中的责任。如果当事者（研究者）倾向于主动承担责任（选择非介入性手段），就比较容易接受后天归因，否则，就更容易接受先天归因。所谓先后天之争看似属于科学讨论，实际上是心理障碍各方干预势力的权力斗争。先后天之争正在随着科学话语体系的演进而失去讨论价值。

1.3.2社会关系模型与神经生理模型

心理问题的本质是各种各样的“疏离（alienation）”。心理问题只有在社会关系框架中才能得到最全面的认识和最准确的干预。对心理问题的观察、理解和干预有赖于具体互动中最微妙的各种细节。心理问题是对社会关系问题的内化。神经生理层面的差异并不能直接决定个体适应能力的差异。过度关注神经生理因素有舍本逐末之嫌。脱离具体个体探讨心理问题的抽象本质意义有限。受困者不应该以“天赋不可改变”为借口逃避责任。

上面这段话集中体现了 “社会关系范式”的核心思想。基于社会关系范式开发的心理干预模型都属于社会关系模型。与之相对，将心理问题的成因和干预手段主要归于神经生理因素的干预模型属于神经生理模型。认知行为疗法以社会关系模型为基础，体感疗法、感觉运动心理疗法以社会关系模型和神经生理模型的统一为追求。就目前心理干预技术的发展水平而言，所有效果良好的干预手段都离不开社会关系模型。本文主要使用社会关系范式理解各类心理问题，不会涉及太多神经生理学知识。

1.3.3自愈的典型过程

常人遭受创伤后，往往会首先回到自己的“安全基地”，这个基地对于儿童是自己的依恋对象，对于成人是一个安全的避难所。等到初步定神以后，他会以更高的警觉性审视自己的环境和人际关系，从恢复最普通的活动（出行、购物、探访朋友、重返岗位）开始，逐渐打开心门。当恢复活力以后，他就能够以各种情境下偶发的闪回为契机，检查并修正自己的认知，直至将创伤在各个层面上整合为自身阅历的一部分。此后，他将带着更深刻的体会和领悟投入新的生活。这是最典型的创伤自愈过程。如果其中任一环节受到限制，例如安全基地缺失、升高的警觉性不被认可、缺少稳定的事业和可靠的人际关系、被

不明原因的身体缺陷限制活力、无力承受闪回带来的情绪和身体唤起、缺少认知资源等，主体就可能被卡在创伤之中，发展出应激障碍。

这一自愈的典型过程完全符合国际创伤应激研究学会（International Society for Traumatic Stress Studies，ISTSS）的 CPTSD 三阶段干预模型。可见心理自助与心理治疗的底层逻辑完全一致。

1.4 积极心理学的差异观

本文基于积极心理学（Positive Psychology）的差异观看待心理障碍者与常人之间的差异。这种差异观可概括为“大同小异观”和“谱系观”，前者是后者的基础。

1.4.1大同小异观

人类既有一致性，又有多样性，而一致性在其中占据主导地位，因此，人类才可以既拥有丰富的可能性，又能作为一个整体存在。显著的一致中往往蕴含了微妙的差异，显著的差异中又存在广泛的一致。无论我们如何关注心理障碍者与常人之间的不同，这些差别与区隔都是次要的，细微的。人们之间的共同点和联系才是普遍的，主要的，只不过人们出于猎奇心理更愿意关注那一点不同罢了。

受困者可以把自己的各种异常表现看成最原始的求助意愿的表达。它们是在不暴露自身动机的前提下对自身困境的公开化和显著化。这相当于在拷问别人：“我好痛苦啊，这是怎么回事，你有什么头绪吗？”诚然大多数人的第一反应是猎奇或戒备，但总有一些人能作出最具意义的回应，这些人很可能成为受困者人生道路上的“贵人”。但可惜的是大多数受困者忙着处理自己的羞耻感，忽视了这些最重要的信息。

1.4.2谱系观

谱系观反对标签化，强调连续性。

所谓的正常与异常不过是人们为了偷懒，强行给程度不同的同一表现贴上

的对立标签而已。例如社会达尔文主义者简单粗暴地将人类划分为强者与弱者，将社会关系定义为“竞争”，从此就再也不必关心人类的多样性与社会活动的复杂性了。一个有价值的表述应当有能力涵盖同一谱系内从典型到非典型或者从一般到特殊的所有现象，而不是先将它们分开表述，再额外说明彼此的关联，这样只会人为制造割裂。

例如，本文将受困者异乎常人的身心状态解释成个体的“习惯状态”显著偏离了公认的“高效状态”。常人也会有各种偏离，只是这种偏离并不显著，可以无意识地完成调整或代偿而无需额外耗费认知资源，也不会产生明显的不适。又如许多受困者习惯于将意识对象分为内心对象与外界对象，这显示了他们某种程度上的分裂感。但即便如此，他们对世界的主要体验仍然和常人相同，甚至常人有时也会认同这种划分，因为常人也会经历这些意识状态，只不过没有造成显著的适应不良罢了。本文为了表述方便，有时也会用“内”和“外”来区分事物，但是要用谱系观的立场来看待。

强迫行为和反射行为也可以看作处于同一谱系，两者的区别在于前者所依托的激发条件相对苛刻因而在常人看来更容易得到觉察与调节。条件反射、非条件反射和操作性条件反射也可看作处于同一谱系。条件反射是以非条件反射为核心构件形成的序列化行为与契合要素一起构成的，包含了显著的操作行为的条件反射是操作性条件反射，在漫长演化中发展成硬连接的操作性条件反射是非条件反射。

可爱与可怕同样处于统一谱系。不论可爱还是可怕，本质都是各种偏差和意外。这些偏差和意外所唤起的联想越具有灾难性就越可怕，否则就越可爱。联想可分为遐思和闪回，二者处于同一谱系。闪回偏向情绪体验简单激烈的一端，遐思偏向情绪体验复杂温和的一端。

人类和高等哺乳动物的智能也可以纳入连续的谱系。智能的有无并不是非此即彼的关系。从高等哺乳动物到人类，双手越来越灵活，散热机制越来越完善，神经系统越来越发达，身心整合所能达到的水平越来越高，智力越来越发达。如果人科人属的其它物种没有灭绝的话，我们会更容易观测到这种连续性。甚至可以说得更激进一些，现代人类未必比其他已灭绝的人种拥有更高的智能。现代人类的胜出存在很大偶然性，如果历史上的自然地理条件稍微发生一点改

变，留下来的可能就不是我们这支人类了。

谱系观同时意味着我们要看到各种“特色”所共享的底色，看到各种图案所共享的背景，看到它们之间的空白，看到在零散的“有”之下无所不在的包容一切的“无”，甚至进一步透过这“无”看到更深层的“有”，这个过程可以无限循环下去。我们不仅要聆听此刻听到的任何声音，还要欢迎声音底下的静默；不仅要看到此刻看到的任何东西，还要留意物体周围的空间（空气）；不仅要体会当下的情绪，也要体会情绪之下的平和。不仅要看到闪回的生活片段，也要允许自身人生经历的展开。

1.4.3谱系观视角下的诊断标签

一个恰当的标签可以使原本无法名状的痛苦形成可分享的意义，主体可以以此出发，寻找有关资源，争取改变自身处境，这才是标签的意义。标签应该被理解为一种索引，而非一种身份。

可现实是标签往往会使人“标签化”。有的人因标签而被边缘化，受到了各种特殊对待，许多父母仅仅因为孩子被打上了“阿斯伯格”或“自闭症”的标签就对孩子彻底丧失了信心。有的人因标签而偏执地寻找所谓“同类”以谋求心理安慰。人被异化成了标签的附属品，也就失去了改变的可能性。

如果一个人某方面的特质过于突出，就很容易把拥有相似特质的人看做同类，全然不顾其他更基本也更重要的品质。儿童往往热衷于寻找身份认同，他们一旦被贴上标签，就更容易跟其他带有特殊标签的人走到一起，这无疑会给成长引入新的风险。

1.4.4谱系观视角下的自助

心理自助并非自己充当自己的咨询师，这完全不现实。

社会环境充满了各种潜在的创伤源，我们的免疫力和自愈力决定了我们所受到的影响。从这一角度来说，受困者似乎应该向免疫力和自愈力强大的人学习。然而遗憾的是，这些“强者”的现象学世界与受困者的现象学世界差异过大，它们很难在同一话语体系中被表述清楚。常人无法理解受困者为何如此脆弱，受困者也无法理解常人何以利用创伤实现成长。自助理论的价值在于构建

起一套科学的、能够同时涵盖受困者和常人的现象学世界的话语体系，一方面使受困者能够体会常人的现象学世界，理解他们的免疫力与自愈力，因而明确自身努力的方向和方法，另一方面使常人能够体会受困者的现象学世界，理解他们的脆弱性，因而更容易与之相处。

自救不是发展出一系列特殊技能以代偿自身缺陷，而是锻炼那些因创伤而萎缩的“心理肌肉”。以正念为例，情绪智力出色的人普遍拥有整合自身各种感受而免于被单一强烈情绪裹挟的能力，但他们从来不会强调自己的这种能力。在受困者眼中，他们仿佛拥有某种神力。通过引入正念的概念，充分解释它的内涵，展示它的各种应用，我们就可以帮助自救者培养这种能力，从而帮助他们实现创伤后成长。

与生理缺陷相比，心理障碍具有很强的异质性。与其说人们难以找到心理障碍的生理基础，不如说心理障碍根本就没有共同的生理基础。每位当事者的“病理”可能都是独特的。这也是病理学范式饱受争议的原因之一。心理障碍需要个体化的干预方案，而制定个体化的干预方案，离不开一套能够沟通不同现象学世界的话语体系。好比我们学开车必须首先认识刹车、油门等等。不清楚这些基本配置就强行上路只会造成交通事故。

人生充满了黑色幽默。有时简简单单一个问题就可能困住一个人一辈子。很多心理困境看似无解，只是因为它们难以在现有的话语体系下得到恰当表述。既然根本说不清楚，当事人就只能听天由命，将问题归结于某种先天缺陷。一套恰当的、能够沟通常人与心理障碍者的现象学世界的话语体系可以帮助我们在一张足够广阔而详尽的地图上定位自己的坐标，从而找到回家的路。作为一套有价值的自助理论，它的语言必须能够发挥“路标”“桥梁”和“翻译官”的作用。无法为受困者指明方向的理论无论多么精妙都只是花瓶。

这项工作的最佳人选是那些曾在两种（或多种）截然不同的现象学世界中生活过并且具有一定学术素养和表达能力的人。在人类历史上，往来于不同社群的“边民”往往会成为最早的翻译官，他们为文明的传播与发展作出了重要贡献。

本文作者曾有幸在受困者与常人的现象学世界之间穿梭过。愿我的文章能够抛砖引玉，让人们对受困者的现象学世界产生兴趣。

1.5 交流圈

1.5.1 交流圈的概念

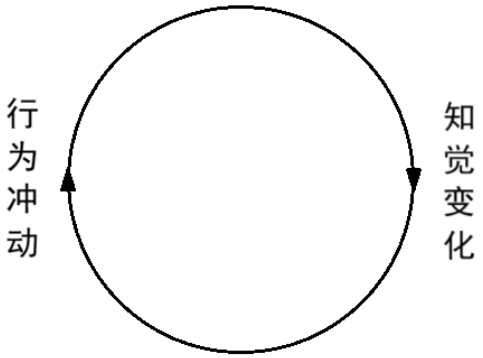
互动形成交流圈（loops）。一方发起一个邀请，另一方作出回应，回应又驱使发起方改变状态，双方的状态在互为因果地快速变化。在交流圈不断地产生和消解的过程中，冲动（本文中的“冲动”特指行为冲动）、情绪和概念不断地涌现、发展、分化和消解，主体对刺激的适应和改造也在同步进行。

在劳恩·考夫曼（Raun K. Kaufman）的自闭症家庭内部治疗技术中，交流圈是一个重要的原始概念。本文以此概念为逻辑起点，全篇所有内容都应该放在交流圈中理解。

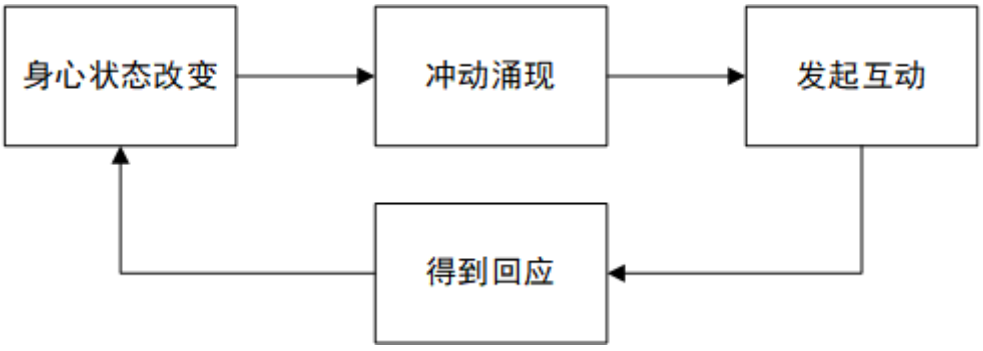
正如“症状”与“体征”是不同的概念（前者是主体感知的不适，后者指观察者检查出的异常），交流圈有两种自洽的表述。

1.5.2 主体-世界交流圈与主体间交流圈

主体-世界交流圈示意图：



主体间交流圈示意图：



从主体-世界关系的角度来看，成长的过程就是主体与世界的交流越来越丰富，交融越来越深入的过程。在主观体验上，交流圈是感觉和行为的无限循环。主体在交流圈的无限循环中学会组织感官、使用身体。主体-世界交流圈决定了主体的现象学世界。

就主体-世界交流圈而言，一切互动都是主体与整个世界的互动。具体的互动对象（人、事、物）只是互动的锚点或接口而已，不具有主体性。世界如同一把梳子，这些互动对象只是一个个梳齿的齿尖而已。主体间叙事容易夸大它们的独立性，因此容易被“小我”局限。

从主体间关系的角度来看，一切的活动都发生在主体间交流圈中。一切交流都是主体间的交流。所谓主体-世界交流圈不过是主体的“自我交流”罢了，而自我交流只是对主体间交流的内化，内化意味着经验的积累和习惯的养成。主体-世界叙事容易夸大讲述者的主体性，忽视了他人的主体性，甚至根本意识不到他人的存在，因此容易陷入自恋。

在谈论主体间交流圈时，讲述者必须明确自身位置，避免剥夺参与者的主体性（去人格化，学者型叙事）或者赋予事物本不存在的主体性（拟人化，童话型叙事）。否则他自己就成了事实上的唯一主体，主体间交流圈也就退化成了主体-世界交流圈。他讲的就不再是主体间的故事而是自己的故事了。成长的过程就是讲述者明确自身位置的过程。这既是发现自身主体性的过程，也是看见他人主体性的过程。

一些理论用交流指代主体间交流圈，用“自传入知觉（reafference）” 理解主体-世界交流圈。

1.5.3观察者与当事者

在主体-世界交流圈中不存在观察者与当事者的分化。主体-世界交流圈下的叙事就是“自我中心叙事”或者“上帝叙事”。在主体间交流圈中，观察者与当事者高度分化。主体必须有相当高的灵活性，在两种身份之间保持动态平衡，在积极参与活动的同时保持相对客观的观察，才能形成高质量的互动。

受困者由于人际互动匮乏，两种角色的分化程度很低。他们只有在二者分化不明显的情境下（例如解数学题时）才会有较好的表现。当生活场景涉及二

者的分化时，他们不是成为纯粹的观察者，无法融入情境，就是沦为纯粹的当事者，处处受制于人。

心理问题只有在主体间交流圈中才可能充分暴露并得到解决。当主体想要回避心理问题，甚至将其渲染为一种天赋时，往往会沉浸于自我中心叙事，回避主体间叙事。

人际互动匮乏导致受困者只有在自我中心叙事下才能讲出令自己满意的故事。他们以为自己在客观陈述被观察主体的故事，殊不知这只是他们自己的故事。明明自己才是故事的唯一主体，可他们讲的故事中偏偏没有自己。在他们的故事中，根本不存在有主体性的“人”。他们把一切事物都去人格化（客体化）了。

观察者与当事者存在相互作用，正是这种相互作用在推动着二者身份的不断转换。观察者一旦开始体会当事者的处境，他的状态必然受到当事者影响。当事者一旦意识到观察者的存在，他的行为必然在一定程度上变成对观察者的争取。这与科学实验中的研究者与研究对象的关系完全不同。科学实验以研究对象的去人格化为前提，研究对象和研究者之间不存在心理层面的互动，即使有也会被去人格化的表达遮蔽。研究者充当了实验中的上帝，他们在享受“上帝视角”，科学家本质上都是神学家。

有些人用控制论（Cybernetics）中的“一级混沌”与“二级混沌”类比观察者与当事者的概念，这虽然有趣却容易把主体困在自我中心叙事中。

1.5.4同步性

主体-世界交流圈是随着行为和感知的分化而形成的，体现了动作指令和感知觉反馈之间的同步性。初生婴儿的行为过程、感觉过程和知觉过程具有同一性，而后逐渐分化开来，成了在观察者看来相互关联而又有所区别的不同概念，同一性就成为了同步性。同步意味着相互确认、相互适应与相互交融。这种同步性使“我”成为“世界的我”，使“世界”成为“我的世界”。主体认识世界的过程也就成了认识自我的过程，整合自我不同部分的过程就成为了整合世界不同侧面的过程。

同理，主体间交流圈是随着自我与他人（或“属我”与“非我”）的分化

而形成的，体现了互动双方的同步性。一个和谐的互动意味着双方在互动的过程中身心状态逐渐同步。这种同步性使“我”成为“关系中的我”，使“关系”成为“我的关系”。主体建立自身主体性的过程就成为了认识他人主体性的过程。

在主体活着的任一时刻，他的一切活动都在交流圈中进行着。无论这些活动是受注意的（有意识的）还是不受注意的（无意识的），是情节性的（可回忆的）还是非情节性的（不可回忆的）。所有的，同时也是无限的交流圈汇集成了互动流。

1.5.5合作与对抗

在主体间交流圈中，建立和维持互动的过程就是合作。无论主体向对方传达的态度是支持还是反对，只要以维持互动为目的，就是在肯定对方的存在感和影响力。我们接受了对方传达的信息，整理出其中的要点，然后给出我们的意见。我们承认双方共享相同的话语空间（语境），赋予了对方与我们平等对话的资格，允许他们影响我们，这就是合作。矛盾不可怕，有矛盾才有来往。双方你来我往，才能合作出一部完美的戏剧。在合作过程中，双方被彼此深刻影响，逐渐打上对方的烙印。

在主体-世界交流圈中，对应合作的概念是探索。

妨碍或破坏互动的活动就是对抗。合作具有持续性，对抗具有不可持续性。正如任何成果都不能一蹴而就，但都可以毁于一旦。对抗最终会引出新的合作，否则主体将陷入危机。关于对抗的最著名实例就是由印度革命家莫罕达斯·甘地（Mohandas Karamchand Gandhi）组织领导的非暴力不合作运动。

受困者对合作的理解接近“被控制”或“被逼迫”，相应地，他们对对抗的理解也会变得偏执。特殊的生活体验使受困者与常人缺少共同的话语空间，他们发出的请求或作出的回应常常偏离社会常模，令人困惑，这种不自主的对抗会严重限制他们的互动能力。为了弥补自己对互动造成的破坏，他们常常倾向于过度合作，导致自己很容易被自己不喜欢的东西影响，这让他们十分痛苦。严重的挫败感使他们越来越逃避现实。逃避和逃跑是完全不同的概念。逃跑是对抗的一种形式。逃避既不是合作，也不是对抗，是对自身社会性的剥离。一

个行为是逃避还是逃跑，有时并不直观。它在一定程度上取决于主体的参与感。逃跑往往伴随着兴奋，逃避往往伴随着强烈的恐惧甚至绝望。逃跑者能够在事后进行有效的复盘。逃避者往往难以自圆其说，认知表现出碎片化甚至解离的特点。

1.5.6互馈

我们每个人在接收他人反馈的同时，也在向他人作出再反馈。我们在通过对方的反馈了解对方的同时，也在了解自己实际传达出了什么。我们的本能允许我们把对方的态度在第一时间反馈回去而不必有任何犹豫（犹豫本身也是一种反馈）。对方无礼，我们就不敬，对方以礼相待，我们马上不计前嫌。行走江湖，这是最基本的生存策略。一切更加复杂、更加周延的社交策略都是在此基础上发展出来的。受困者关注了太多华而不实的社交技巧，反而忽视了最基本的原则。

不要担心这样会受到对方的报复，实际上，如果我们真的能从一开始就做到这样，反而能和那些刻薄之人相处得很好。即便偶尔遇到了不可救药之人，我们在他身上失去的东西也可以很容易从其他坚持此原则的人那里找回来。同在江湖漂，有的人被人争相拉拢，有的人则处处受排挤。他们的能力不见得有实质性差距，但相比前者，后者的反馈普遍滞后而混沌。这种迟钝是他们受到轻视的根源之一。

1.6 体感疗法的身心观

1.6.1整体观

基于躯体体验的各种心理治疗技术不会用二元对立的叙事理解生理与心理的关系，更不会简单地将心理或智慧和身体特定部位（大脑皮层）绑定。

即使是草履虫这种原生动物，其日常活动也清楚地展现了某种为生物所独有的品质。我们在观察草履虫的生活时，总是不自觉地体验到与观察高等动物的生活时相似的情感。这种情感用“投射”无法解释，因为我们无论观察多么复杂的机械运动都很难有这种感受。即使是非常原始的生命，我们也能从它们

的活动中感到某种类似情绪、意图之类的东西。本文无意于探讨生命的本质，只是想以此切入体感疗法的分层心理模型。

从肢体到大脑，从大脑的低级皮层到高级皮层，并非前者从属于后者，低级服务于高级。相反，前者是后者的前提、基础、来源和归宿，后者是对前者的增强、扩展和整合。后者从前者中来，到前者中去，使前者在更高层面得到整合。让前者的能量流动变得更加高效而顺畅，从而发挥出更高的创造性才是后者存在的意义。这种整体观是一切身心学流派的共同观点。它将物种的演化历程和个体的发展过程相统一，将低级的本能活动和高级的认知活动相统一，使我们可以通过观察低等动物的生命活动认识高等动物生命活动的底层逻辑，通过观察儿童的活动理解成人活动的内在动力，通过身体活动所展示的外显信息了解大脑中发生的事情。

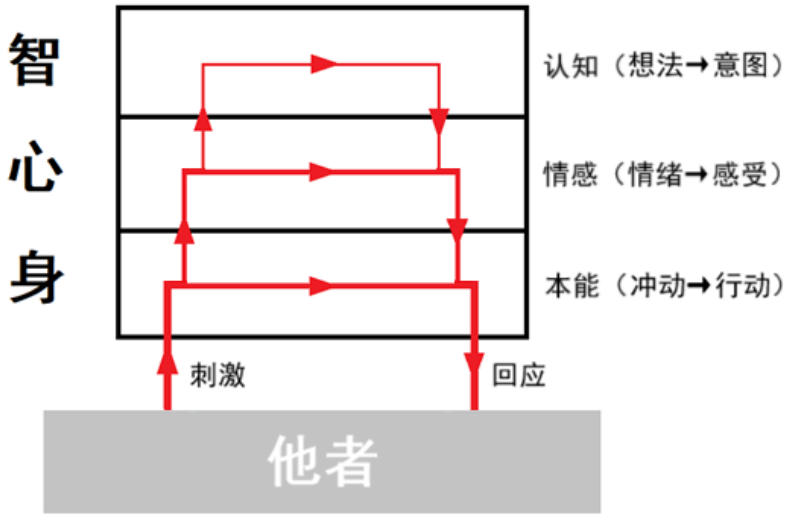
“本能”“情绪”和“认知”都是“整合”的产物，它们的整合水平依次提升。在日常语境下，人们常用“身体”指代本能。“整合”是一个略显尴尬的词汇，情感与认知并不能简单还原为生理活动，于是只能用“整合”“涌现”这类说法来笼统地表达身心关系。

1.6.2整合的身心观

行为是本能、情感和认知相整合的结果。

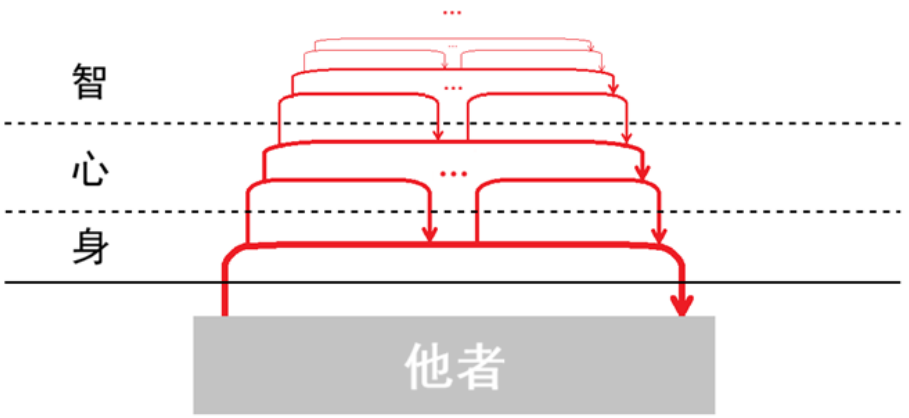
本能（“身”或“爬行动物脑”）、情感（“心”或“哺乳动物脑”）和认知（“智”或“新脑”）三者之间的关系可与上文所述身脑关系相类比，这种身心观可称为“整合的身心观”。它将物种的演化历程、个体的发展过程和具体的行为过程相统一，具有极强的承载力和指导意义。它让我们可以用身体和生活的语言（身体和生活所展示的外显信息）讲心理（现象学世界）的故事。“身”既是真实的身体，也是所谓的“潜意识”，它和外部环境直接统一。

身-心-智模型示意图：

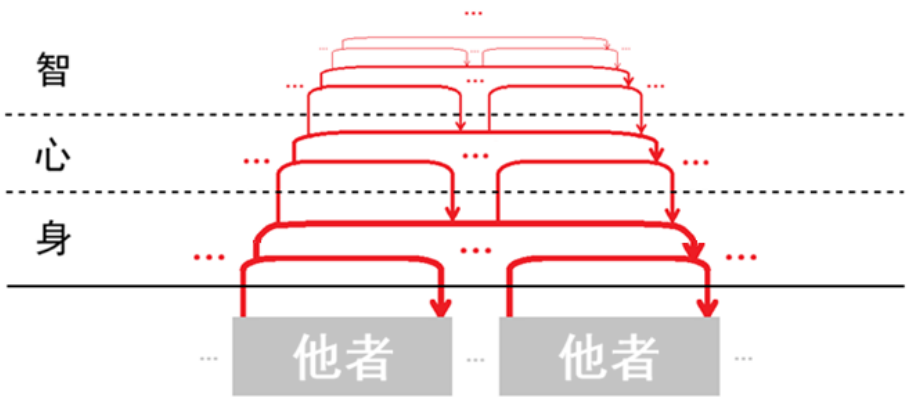


上图可与排便运动中的神经反射相类比。身、心、智可顺次类比为低级中枢与高级中枢。

或者也可以画成这样（请想象成一个分形结构）：



又或者这样：



身是体验流的一阶整合，心是体验流的二阶整合，智是体验流的高阶整合。

高阶整合可以进一步细分，某些理论将其顶层结构称作“无我”或“绝对存在”。

如果读者了解分形几何（Fractal Geometry）相关知识的话，就能理解这三种画法完全等价。图中只有最底层是完整的交流圈，上层都是“半环”，它们只有汇入底层才能成为完整的交流圈。

行动流、体验流和意识流相统一，使用哪个说法取决于我们关注互动的哪个层面。

个体在成长过程中会和其他个体发生无穷的互动。每次互动都会在一定程度上影响到个体更深一层的状态，进而影响到个体的下一次互动。结构化的互动会促进序列化行为的形成，使个体逐渐形成适应，随机性的互动会引发更多互动并需求新的整合。随着低阶互动的不断积累，高一阶的整合会自发涌现。

1.6.3 适应策略的降级与过度应激

一个人偶然进入一个阴暗逼仄的空间执行任务，他会立刻感到心率加快、血压升高、呼吸急促。应激反应调动的身心资源使他能够忍受不适，集中精神，加快动作，在完成任务后快速离开。但如果他要长期在此环境工作，他就会探索环境，了解状况，调整心态，采取防护措施，而不是靠过去的习惯和身体的原始适应机制硬扛。相比前者，后者不仅意味着强烈的生理唤醒，也伴随着更强的心理唤醒。

那些复杂温和的，需要用到更多高级皮层功能（计划、社交），涉及微妙的心理建设（身心整合）的适应策略就是相对高级的适应策略。那些简单激烈的，主要依赖下意识的自动反应和原始适应机制的适应策略就是相对低级的适应策略。

人体的排便反射受到脊髓初级中枢和大脑皮层高级中枢的双重调控。当初级中枢失去和高级中枢的联系（比如主体因意外事故而截瘫）后，主体并不会丧失排便能力，而是会失禁。也就是说，失去了高级中枢的调节后，个体的排便活动完全被更加基础的本能反应支配了。

如果高层级的适应策略受到抑制，那么低一级的适应策略就会占据主导，这就是适应策略的降级。在心理动力学中，降级也被称为退行（regression）。

面对压力，如果习惯已经失效，而个体因为种种限制无法完成心理建设和生理动员，就会有过多的压力被交给更原始的适应机制。此时身体必然出现过度应激，导致严重的适应不良。这可以形象地理解成“领导不作为，下属被累死”。也可以用社会生活作类比，如果法律法规过于不合理，人们就会诉诸原始的暴力本能以讨回公道，社会的稳定性就会受损。

晕动症就是一种非常典型的过度应激。晕动者普遍存在注意力缺陷，他们在乘车时无法利用“应激-唤醒-应对”的本能过程将身体调整到与车辆同步的状态，感官失衡的压力被抛给了更低级的适应机制。在更低一级的适应机制中，这种持续性的感官失衡通常与食物中毒匹配，于是呕吐反射就被激活了。因此，解决晕车问题可以从缓解（比如训练平衡能力）或者规避（比如补充感官反馈）注意力缺陷入手，但根本的解决办法在于疗愈应激障碍。

过度应激导致身体的原始适应能力被过度消耗，是很多功能性疾病和心身疾病（psychosomatic diseases）的来源。前者如失眠、肠易激综合征、吞气征、反流病等，后者如中浆病（中心性浆液性脉络膜视网膜病变）、冠心病等。只有找到心理上的根源，这些病情的发展才能得到控制。

1.6.4两种成长

在身心层面考察的自我称作 “儿童自我”，在身、心、智整体层面考察的自我称作“成人自我”。注意儿童和成人都有成人自我。一方面，从儿童和社会接触的那一刻起成人自我就开始发展了，另一方面，养育者在相当程度上充当了儿童的成人自我。这部分来自养育者的有待儿童在自我实践中逐渐扬弃的成人自我也叫“父母自我”。养育者的人格是儿童人格组成中不可忽视的一部分，脱离养育者的问题讨论儿童的心理问题没有意义。创伤可以使父母自我被卡在既无法消化也无法释放的状态。

儿童自我、成人自我和父母自我的概念可以呼应传统心理动力学人格结构模型中的本我（Id）、自我（Ego）和超我（Superego）的概念。

儿童自我是成人自我的基础，因此我们可以用儿童的活动理解成人活动的底层逻辑。我们在儿童时期的各种表现并没有随年龄的增长而轻易消失或改变，相反，它们成为了更复杂的行为和认知过程的基础。当我们遭遇了极端情形，

这些复杂的行为和认知过程全部失效，我们被迫重新从非常基础的层面开始处理问题时，我们儿童时期的行为风格就会清晰表现出来，此时脑海中甚至还会闪过儿时的一些画面，这种现象就是一种退行。

成长既是不断地重塑基本的序列化行为和认知图式的过程，也是发展出更复杂的习惯和认知图式的过程。前者是第一类成长，后者是第二类成长。第一类成长通常发生在个体的实际活动能力远远超出认知能力的状态下，具有显著的“行而后知”的特点。成人所论述的成长，主要是第二类成长，“知行合一”是第二类成长的基本要求。第一类成长有两个高峰，一个在胎儿至幼儿期，一个在青春期前期。常人的第一类成长在青春期后期已经基本完成，其适应意义在于使主体能够以相对独立的姿态面对社会现实中的各种冲击，从而使第二类成长达到非常高的水平。受困者的第一类成长从未完成，这既使他们的人格在成年期也能表现出良好的可塑性，也使他们的第二类成长极不稳定。受困者的绝大多数异常表现都可看作第一类成长严重不足而第二类成长过度代偿的产物。

冲动向行动的转化通常遵循两种路径：“冲动→行动→观察与体会→改善行动”路径和“冲动→自我抑制→分析与思考→行动”路径。前者反映第一类成长的质量，后者体现第二类成长的品质。前者是后者的前提和基础，后者是对前者的补充和扩展。前者可类比为儿童习得母语的过程，后者可类比为普通人习得外语的过程。（这个类比有些粗糙，因为学习显然不等于成长。成长意味着从简单到复杂，从可能到现实，从易变到稳定的演进。）第一类成长越充分，第二类成长的空间就越大，个体的“潜力”也就越大。受困者要想发展行动力，就必须勇敢实践，补上被落下的第一类成长。

受困者自救的过程就是已成年个体用自己的“成人自我”承担起曾经缺位的父母的责任，在科学指导下，在社会生活中，扬弃创伤性的“父母自我”，整合被忽视的“儿童自我”，培养起行动力和自我约束能力的过程。

1.6.5 身心协同性

充满活力的身体孕育不出一颗抑郁的心。身、心、智的协同性被彼得·莱文表述为“三重脑，一颗心（Three Brains, One Mind）。” 当这种协同性受到超出自我调节能力的强烈扰动时，心理问题就出现了。

协同性可分为协同与互补两个相对的方面，也可分为自上而下和自下而上两个相对的方向。在长期水平上，身心智的活动性保持一致。但是具体到某个瞬间，会反复出现此消彼长的情况。在我们捕捉到环境中异常气息的瞬间，我们的肢体可能僵住，但大脑会高度激活（表现为大动作的突然消失和微活动的骤然增强，细致而全面的观察力被激活）。然后肢体再度活跃起来，大脑稍微平静了一些。如此反复多次，直到恢复常态。如果大脑激活不足，身体就很难从僵直中恢复活力，除非有恰当的外力介入，否则个体会一直看起来愣愣的。这很像两个人打乒乓球，只要有一方没接到球，互动就停滞了，双方都会愣在原地，直到有人把球捡起来。在反复的对局中，双方的水准会趋于一致。

体感疗法关注身心协同性，重建身体与心智的连接是体感疗法的重要内容。认知疗法关注心智协同性，帮助个体建立能够充分反映自身主观现实的生活叙事，是认知疗法的重要内容。

1.6.6整合观视角下的自助

“整合”与“分化”是一体两面的关系。“整合不足”与“分化不足”内涵基本一致。不同的是整合不足侧重于表达创伤所造成的分裂状态乃至“碎片化状态”，而分化不足侧重于表达发展停滞所导致的“混沌状态”。整合是紧密联系的分化，分化是清晰化的整合。整合与分化的反义词是分裂与解体。分裂与解体的极端形态就是分离障碍（dissociative disorder）。

创伤疗愈的过程类似团队内部克服分裂倾向，重新形成凝聚力的过程。体验流的整合通常伴随着剧烈的、不自主的战栗和极高的唤醒水平。

2 概念解析

2.1 活动

2.1.1 活动与活动性

在我们活着的每时每刻，我们的身体无不在进行着丰富的活动。

本文所述“活动”绝非机械运动。现实中的所有活动，尤其是人类的社会活动，都既有节律性，又有丰富的随机性与混沌性。想象正在摔跤的两个人，彼此通过双方的推、拉、拧、绊中的坚定、勉强、犹豫、飘忽等等动作品质感受到对方是一个和自己一样鲜活的人而非一台机器。双方既彼此相似，又各自拥有独特而值得欣赏的个性。

活动因为人的参与而获得意义。主体在心智层面上从纷繁的活动中理出头绪的过程，就是主体在身心层面上融入活动，与世界调谐的过程，也是主体充分发挥自身能动性的过程。个体如果不能参与活动，就永远只能感受到混乱和随机。活动的契合或共鸣是形成亲和感的前提。活动性体现在主体能够建设性地维持与改变动作的品质和活动的状态，使自己免于被“固定”或“套牢”。活动性可以看作自然事物所普遍具有的使自身免于“被定义”的能力。

活动性使主体能够对外界刺激作出合目的的反应。健康的主体不仅能够对刺激作出反应，而且拥有充分的自由选择如何反应，这样的身体才会灵便之感。拳击手（尤其是还不够老练的拳击手）在对战中常常要保持一种不断跳动的状态，其意义就是为了保证身体能够达到竞技情境所要求的活动性水平。活跃的身体可以提供足够的反应倾向，随时可被触发各种反应。如同倒立的椎体，处在一种不稳定平衡（unstable equilibrium）状态，只需要被施加一点点作用就可以倒向任意方向。

僵化、涩滞（笨拙）和灵活（灵便）一起构成了一个描述活动能力的连续谱系。活动性、应激性、灵活性（flexibility）、自发性（spontaneity）和机动性拥有相似的内涵和不同的侧重点。

从测量学角度来说，活动性是一个过于抽象的概念，比用数学语言精确描

述蚊子的飞行轨迹还要抽象。但是从现象学角度来说，活动性是一个非常可靠而且十分生动的概念。活动性高的个体无论身材胖瘦，总能给人以敏捷轻盈之感，活动性低的个体总是给人以沉重笨拙之感。活动性高的人即便在入睡状态下也能轻易击落身上的异物，活动性低的个体在入睡状态下甚至连翻身都比常人少得多。暴力犯罪分子普遍擅长观察别人的活动性，他们总是优先选择活动性低下的人作为目标。

活动性如同体温与脉搏，很难被有意识地调节。活动性陡然下降的瞬间，个体会感到“从头凉到脚”，“身体像灌了铅一样”。活动性迅速上升之时，个体会有耳聪目明、身轻体健之感。

2.1.2微活动、冲动与显著活动

一个活动可以在微活动和显著活动两个层面上得到观察。微活动层面体现了活动的细腻性与微妙性，显著活动（亦即“行动”“行为”）层面体现了活动的具体性与情节性。具体、显著、强烈的行为越多，活动就越具体，越显著，越强烈。显著活动最少而微活动最丰富的状态就是主体的平静状态，也叫中立状态。

一般地，能够被互动双方的感官直接感知的活动被称为显著活动。虽然不能被直接感知，但可以通过感知觉品质的变化、注意力品质的变化、情绪的波动、“气场”的变化等得到间接感知的活动称为微活动。微活动的“微”强调的是程度的微妙（subtle）而非范围的微小（micro）。活动越微妙就越不可切分。在极微妙的层面上，所有的活动共为一体，构成感知觉的背景，奠定感知觉的基调。微活动体现了大脑活动的总体模式。人们通过一个人的微活动感知他的精神状态。

冲动产生自微活动。不能被感官感知为活动，意味着冲动的产生不受意志控制。只有在冲动发展为行动，具体的行为开始涌现时，主体才能有所觉察并对它们进行有意识地引导或抑制。这意味着冲动必然先于想法（念头）。在人们形成确切的想法前，身体就已经产生了冲动。想法是对冲动的肯定，帮助想法发展成完整的行为。我们在历史的演化和生活经验的积累中建立了各种具体而微妙的反射，它们都可以激发冲动，引导行为，唤起回忆，提示想法。创伤

限制了这些反射，使主体常常感到头脑一片空白。他们缺少的不是想法，而是能够激活想法的冲动。

冲动开始作为行动被主体所觉察（或者说在情节记忆中作为行为被记录）的那一刻所发展到的程度就是微活动与显著活动的临界水平。由于活动性较低，受困者所能感知的临界水平通常比常人低得多。他们一方面对注意力焦点之外的活动异常迟钝，另一方面对注意力焦点之内的活动表现出惊人的洞察力。当他们的活动性得到改善后，这种洞察力往往也会退化甚至消失。

冲动先于想法，所以主体想要对自身正在发展为行动的冲动“抓现行”很困难。只有在极偶然的情况下（例如身体极度疲惫而大脑相对清醒之时，或者主体处在“半睡半醒时间”时），我们才有机会直接观察到它们。在大部分情况下，主体对自身冲动和无意识行为的觉察是通过互动对象的回应间接实现的。受困者的生活以孤独为基调，缺少可信对象，他们的自我洞察能力可看作对孤独的代偿。然而很可惜的是，很少有受困者能够用好这种能力。在羞耻感作用下，这种洞察力往往被导向了苛刻的自我抑制和微观管理。

如果说冲动是行为的萌芽的话，微活动就是行为的种子。无限的微活动之间持续不断的冲突（对抗）与妥协构成了微活动的基本内容（一般地说，行为构成活动，但是在微活动层面上，区分行为与活动没有意义）。行为都是由微活动在相互协调之中发展而成的，神经系统是专用于协调身体活动的结构，大脑是负责协调的核心。行为的涨落反过来又会“搅动”微活动，因此丰富的显著活动也会使微活动变得更加丰富而细腻。微活动与显著活动的关系有些类似“整合的身心观”之下的低层结构与高层结构的关系。从微活动的角度看，微活动相当于舞台和演职员班子，显著活动只是演员在舞台上表演的节目，任何一个显著活动中的行为都被包含在微活动中。从显著活动的角度看，显著活动相当于演员的“台上一分钟”，而微活动相当于演员的“台下十年功”，任何一个行为都需要微活动的支撑，任何一个显著活动都包含了无数的微活动，微活动的价值最终需要依靠显著活动来实现。

当冲动得到肯定，行为开始涌现时，微活动水平会短暂下降。这相当于身体在特定的一个或几个方向上“绷紧”时，其他所有方向多少也会受到些影响。当行为完成，冲动平息时，微活动水平又会恢复，身体恢复了平静。在一次完

整的活动中，身体会经历无数次这样的“紧张-放松”循环。当我们认真尝试某种陌生的活动时，身体可能在多个方向上同时“绷紧”，我们会感觉身体变得僵硬而笨拙，这种状态就是“僵直（freezing）”。

不同社会或不同时代的人们对意识对象的切分方式、关注重点和观察工具往往不同，因此人们对显著活动的识别能力不仅存在个体差异，而且存在时代差异与社会差异。如果语言中缺少与某个活动相关联的概念或表达方式，那么个体对它的观察就很难在公共的话语空间中得到有意义的认知加工，此时个体把它看作从属于更大的显著活动的微活动往往更经济。例如对于“假笑”表情，中国古人常常爱用“皮笑肉不笑（外笑里不笑）”的说法。如今我们已经知道所谓假笑就是“嘴笑眼不笑”，但你如果要跟古人沟通，“皮笑肉不笑”这种玄学表达往往效率更高。

行为具有显著性，显著意味着它需要在公共的话语空间中接受是非对错的道德评价。这些评价既是对行为的压力，也是对行为的肯定。冲动具有微妙性，微妙意味着主体必须无条件接受它。不能被接纳的冲动将会在主体的意识之外悄悄破坏他在当下的一切活动，以此向主体宣示它的存在。主体可能感到焦虑、烦躁、注意力不集中却找不到原因。

在微活动层面上，活动性既代表一种“任意作出反应”的能力，又代表一种“变动不居”的状态。从机械运动的角度来说，一个将“能力”与“状态”混淆的概念是荒谬的。但这一特点正是生命体的本质特征，也就是俗话说的“流水不腐户枢不蠹”。正如拳击初学者持续不断的轻微跳动，它使主体能够保持足够敏捷，同时本身也是一种不安定的状态。可见，谈论活动性时必须要同时考虑唤醒水平（arousal）。

从躯体体验的角度来说，我们的一切活动都是为了以某种方式刺激自己，调节自己的感受，使自己的各种冲动保持动态平衡。

显著活动与微活动的品质在长期水平上相统一，流畅的举止只能来自灵便的体态。主体的微活动能力与显著活动能力在长期水平上保持一致。

2.1.3 冲动与想法

冲动驱动想法（念头）。我们可以通过观察自己的想法体会自己的冲动。

冲动具有随机性，也就意味着想法的性质完全不受控制。虽然冲动无所谓善恶，但想法具有故事性，因此我们会不自觉地评判想法的善与恶。有些人会尝试压抑自己的恶念，仿佛它们会让自己变得邪恶，这没有必要。

我们不仅要接纳那些宽容的、正义的想法，也要接纳那些小气的甚至是邪恶的想法。我们只有接纳了自己的全部想法，才能接纳自己的全部冲动。能够接纳自己的全部冲动，我们才会有完整的共情能力，才会有足够的内在资源应对随机的挑战。当我们能够接纳甚至欣赏自己的所有邪念时，我们才能自信地说我们不作恶是因为我们选择了善良而非因为我们懦弱。

2.1.4 活动与互动

活动与互动是同义语，活动突出主体，互动突出关系。

活动是行为和心理的统一体，本文不会刻意区分行为活动和心理活动。任何一个活动都是各个层面上的微活动和显著活动整合的结果。基于显微之别而非内外之别划分范畴，界定概念，是本文的原则之一。

身心不同层面的分化是在互动中完成的，它们只有放在互动中讨论才有意义。

2.1.5 活动与感知觉

活动产生感知，静止造成麻痹。本文所称“静止”特指现象学意义上的静止，日常口语所称“静止”在下文被称作“平静”或“安宁”。“平静”是观察者基于感官信息作出的一种认知判断，它是一种虽不显著却内涵丰富的活动状态。所谓平静时产生的感觉就是一些不显著的活动产生的感觉，它们作为难以言表的意识对象进入知觉，成为了认知活动的“底噪”或“基调”，被一些理论称作“潜意识”。在本文的语境下，身体即潜意识。

生物的感官只能感知活动，无法感知静止。这一规律显然适用于感官能力远比人类粗糙的生物。例如著名的“青蛙捕蚊”实验就证明了青蛙只能感知飞行中的蚊子，无法感知静止的蚊子。青蛙的视觉系统太简陋了，必须额外增加一个“运动”维度，它才能识别猎物。青蛙对于食物的理解，仅止于“一个飞动的小斑点”。如果一个人不借助任何帮助就能认识到这一规律同样适用于人

类，通常意味着他拥有比常人更高的感觉加工敏感性，能感知更加精细微妙的活动（或者说得更大胆一些，他们就像四色视觉者那样拥有分化程度更高的感觉通道，只是这些感官维度无法进入公共话语空间，所以只能表现为更加高效的感觉加工能力）。感官只能感知活动与变化，其适应意义在于帮助我们聚焦于更具意义的环境信息，但它也常常导致我们没有自知力。

活动具有相对性，主体自身的活动也会影响自身对环境的感知。例如，我们必须不断活动眼球才能维持视觉，尽管这种活动通常很微妙而且无须刻意控制。如果我们想办法让眼球静止下来（这需要依靠药物或者极为特殊的身心状态）或者移除视野内所有可能的焦点（这往往需要严格的实验室环境），我们很快就会丧失视觉。换个角度，我们也可以说感官拥有“中和”（或“适应”）刺激的倾向。例如我们盯住一个物体一段时间以后，移开视线就可以看到如电影胶片般的残影，它和物体的真实影像具有光学意义上的互补性。我们必须不断活动才能避免刺激因完全中和而无法感知。受困者的眼球活动远不如常人活跃（常被嘲讽为“死鱼眼”），他们所能感知的视觉信息远不如常人生动。

如果用投影等方式放大我们的身体，就会发现即使在平静状态下，我们的全身也如清风拂过的树梢般在活动着。我们稍微移动一下身体的某个部位，身体其他部位也会立即改变状态，我们不可能单独移动身体某一部分而不影响身体其他部分。我们的感官允许我们觉察身体发生的任何细微变化，但只有显著的变化能够用语言表达出来并在公共的话语空间中得到有意义的认知加工。

在主体极度疲劳或严重抑郁的状态下，身体的活动性可能会异常下降。比如我们有时在半夜苏醒时会感觉到身体的某一部分仿佛消失了一样，但我们只要稍微活动一下对应部位，感觉立刻就回来了。又比如我们在早上刚刚睁开眼的恍惚状态下，如果长时间呆呆地盯住某个角落，就有机会看到视野内的物体像融化一般逐渐消失了边界，然后视野开始出现残缺。残缺迅速扩大，像洪水泛滥一样要淹没整个视野，此时我们会因为应激而迅速转动眼球，从而恢复视觉（这个实验有一定危险性，如果因为某些原因无法唤起应激，可能导致灾难性后果。因此仅供参考，不要刻意尝试）。在这两种情况下，我们都体会到了现象学意义上的静止。

每个个体都有独特的活动偏好，这些偏好既使主体在某些方面更加敏感，

也使主体在另一些方面更加迟钝甚至完全麻痹，不同的活动偏好使每个人对世界的体验都独一无二。受困者的微活动普遍脆弱而单调，很难与外界活动相契合，参与感的缺失导致他们情感淡漠。

2.1.6微活动与感知觉品质

微活动决定感知觉品质，所谓感知觉品质，就是感知觉的背景和基调。良好的活动性水平使大脑时刻能够接受足够丰富的感觉刺激，从而维持唤醒并为知觉的形成提供丰富的素材。活动性越强，感知觉的品质就越好，犹如充分校准的提琴，可以表现出最完美的音色。

焦虑和消沉都能破坏身体的微活动，使感觉输入变得匮乏而单调，缺失了各种细节。主体即使找到了貌似有意义的意识对象，也会因为无法激起相应的感觉而不敢笃定。主体会感觉到世界好像不那么生动了。创伤化严重的受困者缺失了各种感知觉细节，他们与常人仿佛生活在不同的世界中。

2.1.7活动性与现实检验

人们通过持续不断的互动保持现实感。创伤易感者活动性较低，现实检验能力也会弱于常人。他们常常体验到各种似是而非的幻觉。他们觉得自己好像疯了，但别人却只觉得他们“矫情”，这可能会促使他们发展出神秘主义倾向。

假如我们在一个自己很容易遭受批评的苛刻环境中生活久了以后，我们的脑海中就会在身体行动前响起一个批评的声音。这一现象的适应意义在于提醒我们及时调整行为，免于受到真正的批评。我们的身体会告诉我们这只是一种想象，因此它不会影响到我们的适应能力。一旦我们离开了这样的环境，我们的想象知觉就会随着我们在新环境中的探索而更新，脑海中那个批评的声音自然会消失。但对于创伤易感者而言，他们的身体能提供的反馈太弱了。这种声音的逼真程度虽然不足以形成幻觉，但足以使主体受到持续性的影响。这种声音所带来的被压迫感已经融入了他们的“情感底色”。他们的想象知觉难以更新，也就在现象学层面上把自己困在了那种严重限制自身活动的苛刻环境中，他们的适应能力因此难以发展。

2.1.8活动性与植物神经系统

微活动的品质直接反映植物神经系统的活动状态。微活动异常总是伴随着植物神经紊乱。

在一个人活着的每时每刻，他的肌肉系统都在进行着一种不随意的、微妙的牵张反射（stretch reflex；myotatic reflex）。这些牵张反射维持着人体各种姿势和行为的稳定、连续和平滑，持续创造着体觉，形成了人体的肌张力（muscle tone）。

肌张力和我们在力量训练中提到的肌力（muscle strength）是不同的概念。肌张力的整体改变总是伴随着情绪的波动，情绪的波动又会干扰认知过程。受困者的日常肌张力水平往往略低于典型发展的同龄个体（下文简称为“常人”）。他们在婴儿期往往就已经表现出肌肉无力、走路不稳、进食吃力、性格过于安静、易受惊吓等特点。他们在日常活动中表现出很强的惰性，任何轻微的活动（尤其是有对抗性的活动）对于他们都显得格外吃力。他们从未体验过健康的兴奋状态，也就很难意识到这种无力感并非来自肌力不足而是来自自己不够“振作”。当他们偶然振作起来完成挑战之后常会有“觉醒”之感，但由于缺少自觉，这种偶然的觉醒状态往往难以持续。

牵张反射、呼吸、脉搏、胃肠蠕动以及人体的各种生物性节律都是微活动的基本组成部分，都受植物神经系统调节。植物神经系统不直接参与运动控制，它在更基础的层面上决定了主体的运动表现。如果主体的运动能力在高压之下受到全面的抑制（这正是在创伤事件中发生的），植物神经系统必然受到冲击。

2.1.9活动性与注意力品质

注意力的转移包括视线的调整和姿势的变化等丰富的活动。活动性差的人，调节注意力的难度也更大，他们相比于常人更容易表现出对具体事物的沉迷和执念。

基于整合的身心观，身体和心智的活动性在长期水平上保持一致。一般情况下我们可以通过观察身体的活动性判断心智的活动性，但二者偶尔也会出现错位。当身体的活动性明显超过心智的活动性时，主体会体验到失控感，他会觉得自己需要“缓一缓”。当心智的活动性明显超过身体的活动性时，主体会

体验到压迫感，他会觉得自己需要“分个心”。（由于受困者普遍存在述情障碍，他们在这些时刻也可能只能体验到笼统的恐惧感。）这种活动性错位的短暂瞬间往往是疗愈的关键节点，十分考验当事者（包括施助者、受助者以及自助者）的能力。它既可能是超越创伤的突破口，也可能成为二次创伤的来源。

2.1.10 强迫性

一般地，当我们产生不得不怎样或必须怎样的想法的时候，我们就感受到了强迫。有强迫就有抗拒（反强迫），这种自我对抗令主体心神不宁。强迫无法改善表现，反而会降低表现。强迫如果得不到疏导，就只能以破坏性地发泄和放纵告终。

强迫性与活动性相对，主体感到自身行为的备选范围变窄，体验到了强烈的身不由己的感受。强迫性总是与异常下降的活动性相伴，主体通常会体验到某种僵直或笨拙之感。强迫性的形成需要同时满足两大条件：一是受限的活动性，二是反活动性的正反馈循环。比如森田疗法（Morita therapy）中的“精神交互作用”：由于注意具有能动性，主体越是注意某个想法或感觉，此想法或感觉就越强烈，这反过来又使注意更加固着于此想法或感觉，从而形成强迫性。又比如活动性的下降造成了感知觉品质的变异，相同的行为不能再产生相同的完成感。主体感到好像自己一直没有做到位，总是“差点意思”，于是只能不断重复。不断重复的结果可能是终于找到了完成感，也可能是身体越来越僵直，感觉品质变得更差了，从而形成强迫性。

2.2 感觉与知觉

2.2.1 感觉与知觉的关系

感觉是知觉的基础，知觉是感觉的综合与经验的统合，并且与感觉同时进行。由于涉及到经验，因此知觉必然包含一定的想象成分。事实上，感觉神经系统能够给主体提供的信息极为有限，经验和想象在知觉的形成中具有惊人的作用。有时即使完全不存在感官刺激也可以形成相应的知觉（比如“幻肢”现象），由此形成了“想象知觉”与“现实知觉”的分野。

2.2.2现实感

某种程度上，我们每个人都活在自己的想象里。在现象学层面上正确认识想象与现实的关系可以为处理某些心理问题带来启发。

如果感官受限会影响我们的现实感，那么天生的盲人岂不是无法认识现实？如果开启了全部感官就能充分感知现实，那么比起拥有特殊感官的生物或者拥有某种“超级感官”的人（比如四色视觉者，他们能辨别常人无法区分的色彩），常人岂不是只能活在想象中了？事实上，人类的神经系统能够传输的信息十分有限，如果我们没有想象力，就根本无法形成完整的感知觉。想象与现实其实是同一枚硬币的两个侧面。

在一些地区，为盲人提供支持的社工在入职早期会被要求体验一周的盲人生活。参与者必须在失去视觉的同时尽力像常人那样生活而不能无所事事。这项活动就是为了让他们能够在现象学层面上领会盲人的生活体验。这部分知识无法用语言传达，但对于他们未来的工作十分必要。参与者失去了视觉信息，努力利用其他感觉通道感受现实，他们的视觉皮层就会逐渐被其他感官通道所利用。虽然刚开始他们会出现各种幻觉，但他们慢慢地就能从那些平时忽视的触感和声音细节中品尝出意义。随着他们逐渐“进入状态”，他们就可以利用听觉、触觉等感官信息建构空间感知，幻觉也随之消失。这种情况下主体虽然失去了视觉，但毫无疑问仍然活在“现实”中。

盲人不能视物，为了像常人那样感受现实，他们必须有更多的触碰行为。也就是说，他们相比于常人，必须和环境之间保持更多、更显著的互动。同时，他们必须使身体在更大程度上保持放松，才能利用有限的信息充分辩识不同感官刺激的微妙差异。这意味着他们向环境和他人让渡了更多的控制权，因而更容易遭受创伤。所以，当我们讨论想象与现实的关系的时候，也是在讨论互动的品质。一个能够与外界保持积极互动的人，就是现实感强的人。那些以自我为中心，过度关注自我的人，就是活在想象中的人。他们沉迷于分析和思考，但这些思考无论多么复杂精妙都无法导向有意义的行动。思考对于他们不仅不能服务于现实检验（reality testing），反而成了为自己的不作为找借口的工具。

2.2.3想象知觉与现实知觉

想象知觉即主体基于经验自发地对知觉进行补全（或扩展）而形成的知觉。可以是基于彼通道知觉补充此通道知觉，例如通过不同岩石的视觉形象的差别想象它们在触感上的差别；也可以是通过此处知觉补全他处知觉，例如通过面前的一段铁轨补全它在视野外继续延伸的部分；也可以是通过前置知觉预期继起知觉或通过后置知觉回溯前置知觉，例如通过“打”的动作预期“疼”的感觉或者反过来。想象知觉被证实后就是现实知觉，被证伪后就是错觉或幻觉。在缺少现实检验手段（或者说缺少与之相拮抗的知觉）时，想象知觉具有和现实知觉相同的主观真实感。

这一机制的适应意义在于使主体可以无需关注感官刺激的无穷细节就能形成完整而连续的体验流（例如人类由于进化过程中的缺陷，导致在视觉中心外侧约 15°左右的位置存在一个圆形的视觉盲区，但我们在生活中很难注意到它的存在，我们用想象把缺失的信息补全了），但它有时候也会成为适应不良（maladaptation）的根源。

想象知觉与现实知觉共同构成了具有现象学意义的知觉，参与主观现实的构建和更新。在自助治疗中，知觉以现象学体验和行为反应为测量尺度。一种知觉激起的现象学体验越生动，激发的行为越显著，该知觉就越强烈。

2.2.4现实检验

对于健康的主体，体验流的扰动会触发“定向反应（详见 3.2 节）”。在定向反应中，主体自觉地发起交流圈，不断地确认想象知觉的现实性，整合并更新知觉，消解幻觉的过程就是现实检验。这一过程在盲人身上比较容易观察。当一个盲人意识到自己的感知出现了偏差时，他会强烈地感到惊讶，然后立刻行动起来不断触碰，仔细体会，然后随着知觉的整合与更新而逐渐平静下来，再度接受了现实。

现实检验的过程如果因为某种限制而无法完成，主体就会出现挥之不去的幻觉。例如常年疼痛的胳膊被截肢后，胳膊的运动神经、感觉神经和视觉形象同时缺失。胳膊的运动-感觉交流圈没有遭遇冲突，而是直接消失了。胳膊的状态无法得到主体的确认，主体的身体意象无法得到更新，于是就形成了“幻肢

痛”。这一现象可类比囚犯因长期羁押而出现的发展停滞现象。囚犯对社会的认知停留在了被拘禁前的水平。光靠几张外部世界的照片无法让他们感受到世界的变化。对幻肢痛的理解可参考文末参考资料中维莱亚努尔·拉马钱德兰（Vilayanur Ramachandran）的镜盒实验。该实验用一种戏剧性的方式唤起了当事者强烈的好奇心去关注残肢的真实感受，帮助现实知觉战胜想象知觉，消除了幻肢痛。

某些主体即使不存在显著的残疾，也可能因为现实检验过程的某些微妙异常而出现挥之不去的幻觉（本文讨论不涉及精神分裂症）。

创伤限制了受困者发起或响应互动的能力，也就限制了他们的现实检验能力。他们的自我意象难以更新，把自己长期困在了如惊弓之鸟般的反应模式中。

2.2.5体觉

已分化的不同感觉通道可以互相印证。当孩子听到了父母的脚步声，他就会看向声音的方向，因为他知道会看到父母。如果我们听到了一个新声音，却没有看到任何新东西，惊讶的感觉就会出现。虽然我们习惯于利用已分化的感觉通道留给我们的概念系统，将惊讶描述成一系列来自于肌肉和内脏的复杂感觉，但这很不准确。当我们感到惊讶时，我们的视觉、听觉、嗅觉、皮肤觉、内脏觉等各种感觉通道都会受到不同程度的影响，它并不是单纯的身体不舒服。惊讶的感觉是一种分化程度过低因而无法清晰描述也无法借由其他感觉通道简单印证的感觉，这类感觉统称体觉。体觉也可理解成各感觉通道受到的全局性扰动。

正如地球上进化程度较低的生物不论数量还是种类都远超进化程度较高的生物，体觉的丰富程度远超视觉听觉之类高度分化的感觉。从主体-世界交流圈的角度来说，体觉的复杂性与物种的演化同步，物种越高级，感觉通道的分化程度越高，就越能承载复杂的体觉。从主体间交流圈的角度来说，体觉的分化与主体的成长相伴，情绪和感受是体觉的语言。

创伤的痛苦体验使主体学会了和体觉保持疏远（解离），因而容易混淆体觉与具体的身体感觉。体觉一旦紊乱，最先波及的是内脏觉、皮肤觉等分化程度较低的感觉，其次是嗅觉和听觉，最后才轮到视觉。

2.3 唤醒水平

2.3.1 唤醒的概念

唤醒（arousal，俗作“兴奋”）是指机体总的生理性激活的不同状态或不同程度，是由感觉兴奋性水平、腺体和激素水平以及肌肉的准备性所决定的一种生理和心理活动的准备状态。情绪的识别以唤醒水平的评估为基础，在一些心理学理论中，情绪依据唤醒水平的不同进行分类。我们平常说的“感受到了力量”就是感受到了激动，感受到了唤醒水平的提升。

高唤醒可能使人兴奋激动或焦虑不安，低唤醒可能使人感到放松愉快或厌倦冷漠。高水平的唤醒可促进粗糙或简单的活动，但会干扰精细或复杂的活动；较低水平的唤醒有助于精细或复杂任务的完成，却会阻碍粗糙的或简单的活动取得更好的成绩。决断的数量少、备选范围狭窄、速度要求快的技能，其适宜的唤醒水平比较高。刺激的数量多、持续时间短、强度小的技能，在相对低的唤醒水平下容易获得最佳表现。参与活动的肌肉越多，对肌肉协调性、动作精确性和稳定性的要求越高，越需要在相对较低的唤醒水平下才能够取得理想表现。当个体较为自信时，就会维持较高的唤醒水平，优先保障执行的效率。当个体缺乏自信时，唤醒水平就会下降，以确保细节的正确和考虑的周全。

个体的心理准备越充分，就越容易在压力之下保持相对稳定的唤醒水平，反之，唤醒水平就越容易出现极端波动。

一些复杂的活动往往会对唤醒水平提出看似矛盾实则微妙的要求。例如篮球运动既要求足够高的兴奋度，又要求足够的精确度与协调性（协调性可以从身心协调与主体间协调两个视角理解），甚至要求唤醒水平能够动态调整。这些微妙的要求与不怀好意之徒为了“打压”他人而提出的自相矛盾的要求完全不同。这些要求在一个信息足够全面，主体足够自由，反馈足够及时，不含人格评价和隐匿动机的过程中可以达到。这类要求主体在唤醒水平发生剧烈波动的同时保持良好活动性的运动对发展情绪智力（Emotional Intelligence）通常大有帮助。

这里说的相对较高或较低都是针对常人而言，受困者的情况要极端得多。一方面，受困者的日常唤醒水平远低于保持身心的最佳激活状态所需要的唤醒

水平，以致他人身上的活力几乎总是令他们恐惧而很少能带动他们一起活跃。另一方面，常人眼中微不足道的压力却常常引起他们的极度唤醒，令他们惶恐不安。受困者一方面显得沉闷而内向，一方面又表现出对社交的强烈渴望，这种矛盾性使他们给人以“拧巴”的印象。

受困者的身体和心灵一样，总是给人以笨拙而脆弱的印象。他们很难学会像常人那样，在相对放松的状态下，由大关节带动小关节、大肌肉带动小肌肉轻松自然地完成动作。

唤醒的概念可以进一步细分为生理唤醒（侧重身心关系）与心理唤醒（侧重心智关系）。常人的心理唤醒水平、生理唤醒水平和压力水平一般情况下保持一致。但是在受困者身上，不论生理唤醒水平如何，心理唤醒水平几乎总是很低。常人的兴奋具有自限性（因为过度兴奋会破坏连接），而受困者的兴奋常常表现出强烈的溢出效应。

2.3.2 唤醒水平与活动性

活动性代表了活动的自由度，唤醒水平代表了活动的强度。在唤醒水平相同的条件下，活动性越弱，行为表现越简单粗暴；活动性越强，行为表现越复杂温和。在活动性相同的条件下，唤醒水平越高，主体的抗逆性（或“自主性”）越强；唤醒水平越低，主体显得越温顺。

唤醒水平与活动性在一定范围内相对独立，当超出这一范围后，二者也会相互制约。在雅尼娜·菲舍尔（Janina Fisher）的理论中，这一范围被称作“容纳之窗（window of tolerance）”。如果主体必须在较低的唤醒水平下才能维持较好的活动性，就会表现出相对安静内敛的性格。如果主体必须在较高的唤醒水平下才能维持较好的活动性，就会表现出相对活跃张扬的性格。如果主体可以在很大的唤醒水平范围内保持较好的活动性（拥有很大的容纳之窗），就会表现出极为坚韧的性格。这样的主体就是“创伤免疫者”。

创伤免疫者即使遭遇唤醒水平的剧烈波动也可以保持良好的活动性。创伤易感者只有在最佳唤醒水平附近才有较好的活动性。

当个体同时保持很高的唤醒水平和很高的活动性时，就可以将当下从事的各种活动整合为一，达到“一心多用”的境界。也就是说，那些能够一心多用

的人都是精力充沛且拥有极强专注力的人。这种能力曾陪伴过很多人的童年，只是随着精力的衰退和创伤的积累而逐渐消失了。

一个知识或技能在何种身心状态下被习得，就在何种身心状态下最容易被调用。受困者习惯于在非常低的唤醒水平下学习知识，分析问题，训练技能，这些知识和能力很难在高唤醒的应激状态下被自然地调用，这严重限制了他们的适应能力。

2.3.3 活力

人们平常说的活力（vitality）或能量（energy）是对唤醒水平和活动性两个维度的综合评估。

活力直接影响当事者对压力的体验。活力强的人面对压力总能感到“心头一振”，他们经常有意识地寻找压力让自己维持在比较振奋的状态，这些人都是“压力偏好者”。活力弱的人面对压力总是感到“心中一紧”。他们需要额外的生理动员和心理建设才能将唤醒水平调节到合适的位置，这些人都是“压力厌恶者”。

使自己充满活力的最佳方法和最大挑战是为自己创造一种充满正面情绪记忆的、丰富多彩的生活。受困者要像珍惜冬日的炉火和风中的残烛那样，体会生活中每一个唤醒活力的瞬间。他们总是抱怨生活中没有阳光，但实际上是他们的认知习惯导致他们选择性地忽视了这些珍贵的时刻。

2.4 意识与意识对象

2.4.1 意识对象的概念

意识总是指向一系列的意识对象，意识活动通过意识对象得到定义。就本文而言，只有能够通过某种方式被意识到的对象才是有意义的。因此可以说，没有无对象的意识，也没有无意识的对象。

意识在主体的活动中形成，主体形成认知能力的过程就是意识对象分化的过程。意识既是活动，也是活动的积淀。主体的意识活动能力与行为活动能力在长期水平上保持一致。

2.4.2意识对象的切分

切分与“分化（differentiation）”含义接近。不同之处在于切分更加强调分化的过程以及主体自身的能动性。

人类的认知加工过程（或“思维过程”）围绕着意识对象的切分展开。意识对象并非一个个实体，它应该理解成意识活动的“落脚点”。主体对意识对象的切分并不以一般意义上的物理边界或概念边界为界，而是与主体和对象的关系有关。世界上本不存在明确的对象，是主体自身的活动使对象变得明确。对于初生婴儿来说，整个世界连同他自身一起构成自己的意识对象。不过既然此时一切皆为一体，所以也可以认为根本没有意识，也没有意识对象。随着儿童探索能力的扩大和经验的积累，各种意识对象的分野才逐渐形成。有了分化就有了“边界”，有了边界就有了“关联”，有了关联就有了“条件”。

彼此同步的事物容易被视为一个整体，彼此异步的事物容易被视作独立的单元。当一个主体刚刚进入陌生环境，尚未发起显著互动时，整个环境对于他就是一个完整的意识对象。如果此时他受到了环境内某一部分的伤害，他会理解为整个环境在伤害他。如果他有机会充分展开探索，就可能认识到环境内部的异质性，他对意识对象的切分就会变得越来越细腻，自身的能动性也会越来越强。

比如塞利格曼电击实验中的狗，面对无法逃脱的电击，它们的挣扎（对抗）起初仅针对具体的实验情境，当挣扎越来越激烈却得不到任何反馈（感受到了环境中某种可怕的同步性）时，对抗就逐渐升级成了与整个世界的对抗。当它们发现自己无论怎样挣扎都没有任何结果（感受到自己失去了和外界之间最基本的同步性）时，就会感到来自整个世界的否定（“他们都是一伙的”或“一切都是安排好的”），它们的情绪就会从恐惧变成绝望。它们从互动的参与者变成了孤独的承受者。又如在找孩子的母亲，她看见自己的孩子时的生理反应（包括微活动的变化）和看到陌生孩子时的生理反应是不同的，她自身的一部分微活动与孩子身上的某些独特活动相契合，孩子的活动驱动了她身上的相应活动，她通过这些生理过程感受到了某种亲和感，从而确认这真的是自己的孩子，因此她自己身上的这部分生理属性可以和孩子一起构成一个完整的意识对象。如果某些因素（比如中风或严重的交通事故）致使大脑中从杏仁核到边缘

系统的神经通路出现损伤，导致母亲无法在看到自己的孩子时产生亲和感，她将断定这个与自己的孩子外貌相同的孩子是骗子伪装的。

意识对象可根据其对探索的接受程度简单切分为可信任的（支持探索的），待探索的和敌对的（抗拒探索的）。

当主体与意识对象达成同步后，主体就得到了扩展，他对世界的体验也会随之发生变化。就好比我们戴着手套触摸物体的感受和我们直接触摸物体的感受会有差异一样。同步意味着信任，主体会和同步的对象分享相匹配的控制权，就好像彼此在一定程度上成为了一体。高等哺乳动物甚至进化出了专门的神经元以保障同步的效率和质量，这就是镜像神经元（Mirror Neuron）。主体对其他主体的情感（心）和意图（智）的体会越细腻，镜像神经元（身）的工作就越高效，反之亦然。大多数时候，主体只需要允许这些本能充分发挥作用，就能自然而然地学会转化和利用压力。

意识对象的切分也是一种活动，和其他一切活动一样具有活动性。例如某些情绪成熟度（emotional maturity）极低的人在情绪稳定时可以被列入可信对象，可他们一旦陷入情绪化就必须被列入敌对对象以维护主体自身安全。

2.4.3 意识对象的残迹与身心状态的滞留

所有的过往都会在我们的身心状态中留下不同性质、不同程度的残迹。

想象一位街头摊主，面对迎面走来的地头蛇，一面起身点头哈腰，笑脸相迎，一面仔细观察对方，琢磨其意图，然后按照事先准备，巧妙作出反应。待地头蛇走后，他迅速站定，收敛笑容，放下紧张情绪，恢复到之前的状态。在这个过程中，摊主表现出了良好的心理韧性。

再看另一位摊主，他无依无靠，懵懵懂懂地开始了他的生意，从未了解过行情。面对地头蛇，他惊慌失措，好不容易打发走了，仍然心有余悸。他没有恢复到之前的状态，而是变得畏畏缩缩，之前应对地头蛇的痛苦体验在他的身心状态中留下了显著的残迹。他看起来好像恢复了平静，但他的身心在不易观察的层面上仍然有一部分停留在惊慌无措的状态。这种不舒展的状态使他做什么都不舒服，而他自己却很快忘了原因是什么，于是这种状态就成了他自身气质乃至性情的一部分。他只能在当下的环境中不断尝试为自己挥之不去的别扭

感受寻找各种貌似合理的解释。他起初觉得自己是被孩子不听话气的，于是他就把孩子打出了心理阴影，孩子再也不敢不听话了。但他发现自己的焦虑并没有消失，于是又转向别处。身边的一切变得越来越不顺眼，这种“情绪推理（emotional reasoning）”习惯使身边的人成为了他的出气筒。他的人际关系逐渐恶化，而他自己也开始为自己不明缘由的坏脾气苦恼。健康的社会支持系统是身心状态最重要的调节器，而他本来就薄弱的调节器被自己亲手破坏了。在无止境的反思中，他逐渐建立起一套过度精细而不切实际的认知图式，给自己造成了巨大的精神负担。

2.4.4心理创伤的形成

如果主体不能在第一时间对压力事件作出充分反应，压力对身心状态造成的影响就会被带进下一次互动中。这种使自身困于“不舒展状态”的压力事件就是“创伤事件”。第一反应具有不随意性，所以应对压力的能力也是主体与自身本能（不随意活动）相处的能力。这种能力是在养育者的关怀下发展起来的，因为只有养育者能充分关注他们最原始的第一反应。如果主体没有能力与自身本能相处，就只能学会笼统地压抑自身本能，这就是“自我抑制”。这些在创伤性事件中被卡住的能量可能在自我抑制减弱时重新进入意识，此时主体可能会表现出一些令自己惊讶甚至羞耻的行为表现。

比如前面故事的主人公正在认真地和一位新朋友互动，互动中偶然出现的小问题可能就会重新激活这些积压的能量，使他突然表现得仿佛对方就是曾经那位地头蛇一般，这既可能使他惊慌失措，轻易地将自己置于“下位者”的地位，也可能使他突然发狂，这些反应将摧毁他们之间发展健康关系的可能性。如果主体由于孤独等原因长期找不到处理创伤性事件的办法，无法完成对创伤性事件的再加工，他就可能因过度压抑和长期解离而发展出各种身心问题。

在摩谢·费登奎斯（Moshe Feldenkrais）的身心学（Somatics）理论中，残迹被表述为“寄生性紧张（parasitic forces，parasitic strain）”。费登奎斯借用“寄生”一词来表示有些不必要的力量会像寄生虫一样依附在主体身上消耗主体，干扰主体的活动。寄生性紧张的存在意味着在观察者眼中主体明显处于一种高度紧张的状态，但是当他们建议主体放松自己时，主体却完全不知道有什

么好放松的。在心理动力学理论中，残迹被表述为“被卡住的冲动”“被阻塞的能量”或“不自觉的自我对抗”。在认知与行为主义理论中，残迹被表述为难以被整合的极端生活经验。

这些残迹卡住了主体，就像严重的伤口会强迫我们保持特定的姿势，稍微一动就痛苦不堪。因此，这些残迹被形象地称作心理创伤（显著）或心理阴影（微妙）。心理创伤如果无法得到有效处理，将逐渐发展为应激障碍。

本文用残迹理解一般意义的创伤，将早期创伤列入“早期崩溃”的范畴。因为从主观体验的角度来说，早期创伤并不直接体验为创伤，而是作为一种底色限制主体的日常生活。

人们常用“刻舟求剑”形容一个人愚蠢顽固。实际上，创伤就是舟上那个刻痕，每个困在创伤中的受困者都是刻舟求剑的人。

2.5 注意

2.5.1 注意的概念

主体使自身状态与意识对象保持同步以维持特定交流圈的活动就是“注意”。假如我们在自行车车头上固定一个老式摄像头，用它录制一段骑行影像，我们会发现影像一片混乱，画面抖动剧烈，根本注意不到任何有意义的内容，但我们自己作为骑行者显然很清楚路上的一切。我们的身体在活动中高效地保持着与环境的同步，使我们能看清楚环境中的事物。受困者由于活动性低下，与环境保持同步的能力往往弱于常人，因此他们在乘坐交通工具时更容易感到眩晕。当他们成为司机（或者改为更难保持平衡的姿势，比如从坐姿改为站姿）而不得不提高注意水平（意即需要调动更多身心资源以保持同步）时，眩晕感就消失了。

注意使身心冲动得到了有意义的组织。为了维持注意，完成探索，身体必须充分调动各种冲动，以协同有利于维持注意的活动，对抗不利于维持注意的活动。这一过程主要在注意焦点之外“自发”完成，除非使用正念等技巧，否则很难意识到这些活动。所谓“探索”就是由无数微妙的协同（微协同）与对抗（微对抗）在注意的驱动下结成的整体。

创伤将主体的身体状态强迫性地限制在了与之相关的活动上，从而造成注意力缺陷。有经验的治疗师可以根据活动受限的细节识别具体的创伤。

2.5.2注意的能动性

注意并不是完全被动地接受意识对象的刺激，它是主体与意识对象之间的相互作用，会影响意识对象的状态。主体不可能不经任何互动就认识到意识对象的存在。当缺少显著的独立参照时（这也是现实中的一般情况），主体只能通过自身与意识对象的关系确认意识对象的状态，因此主体自身状态必然影响主体对意识对象状态的理解。注意是一种有能动性的微活动，是一种试探性的同步，类似“倚靠”“照亮”或“敲击”。

在主体-世界交流圈中，注意（观测）具有直接能动性。在主体间交流圈中，注意的能动性通过主体间关系表现出来。

当主体集中注意于自己身上的某种感觉时，身体会在某种程度上变得僵直，这种感觉就可能变得更加强烈，从而更加吸引主体的注意。这种强烈的正反馈循环就是森田疗法中的“精神交互作用”。

想象我们盯住墙上的一颗斑点，如果我们不打算对它采取行动，斑点似乎不会发生任何变化。但简单地“盯”不算注意，否则雕像才有最好的注意力。一个普通的斑点能够吸引我们的注意，一定是我们身上正在发生某些事件。盯住这个斑点可能有助于我们保持特定的身心状态，进而激发或者平息某些体验。主体看似盯的是斑点，其实注意力在这些心理活动上。如果我们是在别人家作客时盯住了这个斑点，此时周围的环境是主人自我的扩展，主人与环境（包括这个斑点）一起构成了一个完整的意识对象。我们盯住斑点，类似于盯住主人身上的某些部位，这将迫使主人有所反应，尽管他的反应未必直接针对这个斑点。

注意具有能动性，这是“聚焦（focusing）”能够发挥作用的前提，也是自我调节能力的基础。

2.5.3注意力的品质

注意力品质直接定义意识状态。常人的注意力品质以互动平衡的注意力品

质为中心，随情境而轻微波动。

要活动性弱的人调节注意力总是会遇到各种困难。他们转移或聚焦视线、调整身体姿态的过程总是格外吃力。这些微活动水平上的吃力体验一般不会被直接觉察，而是以"容易产生执念"的性格特点表现出来。

2.5.4互动平衡

互动平衡的注意力品质就是注意能够随着刺激的变化在意识对象之间自由切换，在交流圈的无限循环中使互动最有效地进行。主体既能保持一定的注意焦点，又能有效响应来自焦点之外的刺激的“邀请”。主体的警醒程度与环境压力相协调，主体在注意力集中的同时能够从压力中感受到自身的力量。此状态下的主体可以直面现实，能够边体会边思考，既可以实时地察觉他人的情绪，也能轻松地表达自我。

互动平衡是人类的本能，体现了个体与外界之间天然的默契，是最自然的注意力品质。它使主体在任何一个清醒的时刻都能形成一个注意力的焦点，同时又能保持对环境的完整感知。比如我们可以一边打电话一边对身边的人作出足够灵活的反应。但受困者在通电话时身体常会出现一定程度的僵直，反应能力变得很差。即使通话内容和外界信息都十分简单，他们也很难兼顾。事后他们甚至可能否认自己接收到了外界信息。如果他们被质疑只是在刻意抗拒信息，他们就会反驳说自己需要保持专注。但是这种强迫性的专注有什么意义呢？难道能让他们的表现更出色吗？他们不敢回答，甚至不敢思考这种问题。他们已经合理化了自己的创伤化表现，很难改变了。

2.5.5专注

信任，意味着分享控制权。一个演员如果无法感到舞台的稳固，他就不可能洒脱地展开表演。

一个真实情境中时刻存在着各种事物，发生着各种活动。这些活动既相互关联，又相对独立；既相互支持，又有一定互斥性。这些活动的“密集并发”和 “互容互斥”形成了情境的活动性。当主体专注于其中某项活动时，就是选择了对环境中其它活动的信任，让它们作为所专注活动的舞台和背景。主体将

直接用自己的本能面对它们，而不再为之分配认知资源，这也是对自身本能的信任。主体带着信任关系所赋予自己的能量在交流圈的流畅循环中与待探索对象发生激烈的相互作用，成为了所参与活动的一部分。主体既是在注意互动对象，也是在注意自身的体验，自身的体验与互动对象的表现逐渐契合，彼此达成同步，意识对象的切分开始向更深层次发展。在这种状态下，主体会给所有当下的活动打上所专注活动的烙印，比如身边狂风的呼啸声可能被主体作为一种鼓励而接受，墙上的光线、花纹和图案可能成为某种思路的提示，即使这些东西几乎不可能在情节记忆中被记录。如果信任关系继续发展，意识对象切分的显著水平逐渐低于日常表达能力的范围，那么主体就会进入心流（flow）状态。

真正的专注（concentration），只有在互动平衡的状态下才会产生，它是互动双方的“共舞”。受困者很少体验过基于互动平衡的专注状态。他们所理解的专注更接近常人所理解的沉迷（preoccupation）。沉迷是解离性的专注，主体因为某种强烈共鸣而陷入了催眠状态。他没有变得警醒和灵活，而是陷入了一个以自我为中心的想象空间。他的活力集中在了意识空间中的一个极小范围内，这种体验类似“被拐骗”。人们离开专注状态时会感到清醒和平静，离开沉迷状态时往往会强烈地感到瘫软、无力和恍惚。这种不舒服的体验很容易导致主体对类似刺激产生阻抗。在大部分情境（尤其是激烈的人际互动情境）中，受困者都很难建立恰当的信任关系，也就不敢轻易去专注什么东西，因而表现出类似 ADHD 的特点。

在人际互动中，这种信任关系体现为“情感连接”。个体只有在与他人建立了基本的情感连接后，才可能在社会活动中展开有效率的探索。建立情感连接的能力是人的本能。面对一个无法与之建立情感连接的人，人们会本能地感到恐惧并敬而远之。严重的创伤限制了个体的活动性，使个体在精神上瘫痪了。受困者无法与他人建立实时的情感连接，在人际互动中总是本能地感到恐惧，根本无法集中注意力。他不知道，他的状态一样会让别人恐惧。

注意，无法建立实时的情感连接不代表不能建立情感连接，否则个体根本不能独立生活。受困者有能力感受生活中的各种触动，只是述情障碍让他们只能把自己的各种触动归于愤怒和恐惧。等到他们真正体会到触动时，“黄花菜

都凉了”。

2.5.6正念

正念（mindfulness）是一种特殊的专注状态。它的操作性定义是“有意识地、不加评判地关注当下”。正念使主体能够挣脱具体的知觉、情绪和想法的束缚，回归觉知本身。这种纯粹的觉知就像心灵的镜子一样，是自救者的基本工具。

正念只有在放松而活跃的身体状态下才能充分激活。一个充满活力的人在绝大多数情况下都是自身活动的观察者，他的本能可以带他到任何地方，他无须刻意驱动身体或抑制身体，只需做好身体的“监护人”就行了。这样的主体很容易理解“观察性自我（见证性自我）”的概念，也就很容易理解正念。如果身体无法放松，自我观察必然沦为强迫性的自我凝视。如果身体过于懒散，觉察就会成为无米之炊，练习过程必然令自己昏昏欲睡。用有目的的活动激活身体对于练习十分必要。

正念的修习可以从两个方向切入：一是从观察感知觉切入，比如正念冥想（mindfulness meditation），这需要坚持不懈的努力；二是从发现和体会爱（关怀与信任等）切入，这往往需要一些机缘和顿悟。

正念冥想通常以观呼吸和身体扫描作为起点。我们如果理解二者的渊源，就更容易掌握好它们。

当主体刚刚完成一项需要全力以赴的任务，感到如释重负时，那种精神振奋而又不需要注意特定事物的状态就是正念状态。遗憾的是这样得到的正念状态转瞬即逝，缺少利用价值。我们将其中聚焦-释放的循环过程提取出来，就得到了“观呼吸”。

走钢丝的人在练习过程中必须仔细体会身体得到的一切反馈，他的注意力高度集中，但又没有被限制在任何特定的知觉（微活动）或行为（显著活动）上。他的一切活动都锚定在“走到对岸”这一目标上，这个目标将全体知觉整合为一体。当他足够熟练后，就不必再刻意控制什么。他会体验到一种深刻的信任（爱）——信任绳索，信任气流，信任观众，信任身体乃至身边的一切。这也是正念状态，而且是可持续利用的正念状态，遗憾的是难度过高，风险太

大，不适合普通人。我们将其中体会全体知觉的过程提取出来，就得到了“身体扫描”。

从它们的来源可以看出来，正念练习本身并不轻松，正念并不是获得放松的工具。

体验产生于应激，而应激本身就意味着阻抗。接纳体验不是完全放下阻抗，而是通过引导注意力，最大程度减少经验（成见）对应激过程的干扰，使阻抗回归原始状态，避免自我觉察变成自我抑制。这有点像综艺节目里让嘉宾一边打乒乓球一边回答尖锐的问题，嘉宾因为没有足够精力进行“自我审查”而更容易表达出真实想法。在正念练习中，牵制注意力的功能主要由“锚点”承担。

锚点是受主体信任的活动。如果将正念比作巡航，那么锚点就是灯塔。主体以锚点为依托整合自己的知觉。抓住锚点，身体才能得到足够的放松和激活。前文提到的呼吸和身体知觉都是这样的锚点。否则，强烈的控制欲很容易导致旧模式被唤起，自我觉察就变成了自我凝视和自我抑制。

借用通俗自助读物的语言，面对同样糟糕的处境，有的人能注意到其中的爱，有的人只能注意到其中的痛苦。正念就是完整地看见爱和痛苦，同时坚定地以爱为中心，这个中心就是正念的锚点。

锚点可以牵制注意，组织感官，避免精神交互作用，从而使我们更容易和当下涌现的全体冲动相处。这有点像我们在视野测量实验（Perimetry）中盯住一个锚点，通过余光和测试者互动，从而了解整体视野的健康状况。

抓住了锚点，外界的喧嚣和身体的痛苦就不再是练习的干扰因素，而是必要的“配重”。可我们又不能抓得太紧，否则正念就会消失。锚点如灯，正念如影。灯明影清，灯暗影昏。灯动影乱，灯定影静。就灯观影，光影自在。提灯寻影，灯至影灭。

在受困者身上，锚点的位置被白日梦（幻想、神游）取代了。

最纯粹最原始的好奇心同样也是赤子之心。一定程度上，正念教会我们重新以儿童的视角看待世界，看待自己。

很多受困者一方面完全不了解自己的能量，另一方面又对自身本能反应存在极端的阻抗，仿佛他们和自己的身体有仇。正念可以重新教会他们与自己的身体相处。比如很多焦虑障碍者由于在日常饮食过程中对吞咽动作序列过度觉

察，致使吞咽功能受到严重干扰，从而形成了严重影响生活质量的“吞气征”，患者如西西弗斯一般陷入了痛苦而无休止的吞气-嗳气循环之中。正念可以打破这种极端的精神交互作用，使患者重新像婴儿那样自然地学会吞咽，像以前一样吃饭喝水。

2.6 压力

2.6.1压力与应激

谈论创伤话题必须尊重当事者的语言习惯，否则很难形成体会。

汉语“应激”一词原指对刺激作出反应。将 stress 统一译作应激显然不尊重汉语的习惯，但随便翻译又会破坏概念的逻辑关系。要兼顾二者就必须从应激和压力两方面理解 stress。前者的主语是主体，后者的主语是压力源（应激源）。压力源（stressor）的刺激产生压力（stress），主体受刺激后（be stressed）进入紧张状态，感到内脏被挤压，这种紧张状态伴随的身体和情绪变化就是应激反应（stress reaction）。主体必须了解压力，评估压力，适应（不是顺从）压力，完成应对。在紧张状态下了解、评估（appraisal）与适应（adaptation）压力的过程就是应激（stress）。可见在汉语语境下，应激源的概念并不重要，压力本身就已经隐含了应激源。

本节主要讲述压力。

2.6.2生理压力与心理压力

物理概念、生理概念和心理概念的共通之处使人们乐于使用动力学的语言来描述心理过程，这是心理动力学能够在心理治疗中长期占据一席之地的原因之一。

想象我们身处一个光线柔和，氛围和谐的环境中，一个闪光灯在我们面前突然亮起，强烈的光芒伤害了我们的眼睛，使我们感到刺痛。与此同时，我们也会感到心中一惊。我们对环境的信任被意外事件否定，我们对抗环境的冲动变得强烈。强烈的冲动会迅速发展为眯眼、扭头、遮挡、后退等行动。如果这种心理冲突过于强烈，我们就会战栗甚至完全僵住。

在这一过程中，“不明原因的闪光灯亮”这一刺激事件就是应激源（stressor），我们的反应就是应激反应。应激反应虽然在客观上指向应激源，但它在很大程度上是心理冲突的产物。生理压力产生在应激源和感官之间，但心理压力并不直接产生于应激源与主体之间。相比生理压力，心理压力中相互作用的“主体”要微妙得多，复杂得多。

生理压力反映了人类的自然属性，而心理压力与个体的社会化进程密切相关。下文所述压力如无特殊说明皆指心理压力。心理压力在体觉上表现为内脏被牵拉的感觉（主要由迷走神经传导），在认知上体现为意识空间被压缩的体验。在心理压力之下才能看见真正的人格和智商。很多人所谓的高智商其实是以解离甚至献祭部分人性为代价的。

2.6.3心理冲突与心理压力

绝对混沌的世界无法吸引我们的注意。一个世界能够吸引我们去探索，一定是因为它在混沌之中夹杂着某种难以言说的熟悉感，犹如散落着点点星光的夜空一样。将一名幼儿置于新异的情境，他会立即产生一种陌生与熟悉混合的矛盾感受。情境中有一些自己熟悉的模式在以一种陌生而又充满力量的方式运行着。他感受到了同步，也感受到了敌对。他的身上涌现出了各种矛盾的冲动。这些冲动相互对抗，使他进入应激状态。他的身体出现了轻微的僵直，大脑皮层活动水平骤升，这种感受就是警惕，这种心态就是“好奇”。自身不同冲动或倾向之间的相互作用就是心理冲突。

心理冲突可以与“拔河”相类比。所不同的是，拔河比赛的双方总是在裁判的指挥下同时发力，而心理冲突经常有突发性，冲突的双方（或多方）之间经常存在极微妙的时间差。这种突发的、缺少协调的冲突与膝跳反射中的撞击有相似的生理意义，它会引起惊跳反射（startle reflex）。微妙的惊跳反射会被体验为“惊讶”，显著的惊跳反射就是“吓一跳”。惊跳反射属于非条件发射，是应激过程的起点。

心理冲突产生心理压力，心理压力造成紧张感。习得性无助者总是轻易屈服，也就感受不到压力。

心理压力影响唤醒水平，唤醒水平的提升造成警惕感。也就是说，我们在

感到紧张和警惕之前，身体就已经有了反应。我们只能顺应这些反应，引导它们发挥建设性，而无法完全控制它们。我们的意识掌控了身体的“方向盘”和“离合器”却没有拿到“发动机”的开关。虽然应激反应在很大程度上是下意识的，但是它更多地体现了主体长期的积淀而非实时的策略。生活中最自然的部分正是我们投入最多训练的部分，只是我们对这些训练常常缺少自觉。所谓直觉都是经验积累的产物。社会经验丰富的人可以通过观察应激反应了解一个人的性格和阅历。可靠的创伤疗愈技术可以教我们学会和身体的应激反应相处，通过新经验的长期积累逐渐改变我们的应激模式。对自身的应激反应保持诚实，是发展应对能力的前提。如果直接在神经生理层面上介入我们的应激反应（比如使用药物），虽然可能短暂地改变我们不想要的应激模式，但也会产生可怕的连锁反应。

一张地图如果存在大片的空白，就会给人留下想象的空间。对于出色的探险家来说，这些空白如同一个朋友对自己发出的邀请，他会非常兴奋地走上探索之路。但是，对于普通人来说，这些空白如同魔鬼对自己的诱惑，隐藏着生死难料的可怕风险，令人敬而远之。主体在面对待探索的混沌世界时，各类冲动相互冲突，相互妥协，最终决定了不同的行动、情绪和看法的涌现（emergence）。

回到幼儿的例子。彼此冲突的冲动使幼儿陷入了轻微的僵直。他会转向自己的社会支持系统寻求帮助。如果养育者表现出了支持探索的态度，接近待探索空间的冲动就会得到更多的支持。幼儿将在压力之下展开探索，混沌的世界逐渐变得清晰，儿童的心理现实（现象学世界）也在探索中得到扩展。否则他会继续观察，直到获得更多支持接近或逃离的信息。所谓“支持探索”不是由养育者说了算的，而是说幼儿从养育者的身上看到了与成功探索相关联的态度和气场，这会激活幼儿身上与成功探索相关的行为模式。如果养育者带着鼓励的眼神，却总是给幼儿的探索添堵，那么这种眼神将不再能起到鼓励作用，甚至可能加剧幼儿的僵直。在很多失败的养育者身上都能看到这种矛盾的模式。他们表现得似乎很支持探索，但幼儿一旦开始探索，他们甚至比幼儿还要紧张。这些养育者自身存在严重的心理创伤，幼儿的探索行为很容易触发他们的情绪闪回（详见 2.12.2 节）。他们不但无法为孩子提供精神上的支持，反而加重了

孩子的恐惧，但他们对此却毫不自知。长此以往，任何鼓励都很难再发挥支持作用，幼儿的好奇心和探索能力将严重受损，他们的人格发展将严重受限。

只有当我们对心理压力的理解具体到这种程度时，才能将它和物理意义的力进行系统性的类比。否则，心理动力学就只能看作一种粗糙的比喻，意义十分有限。

2.6.4魔鬼的气球

将心理系统类比为物理系统当然不可靠。但是，在基本的认识论层面上，我们从未超过古人“腐草为萤”的类比想象太远。类比是人类认识世界和分享体验的基本方式。当我们刚刚接触一个陌生概念时，总会不自觉地将之与自己熟悉的概念类比，类比选取的恰当与否直接决定了我们接纳新概念的速度。

在经典物理学中，力是物体之间的相互作用。孤立物体的运动状态永远不变。可是我们显然不能把人类比成物体，更不能假设存在孤立的人，否则我们就丢掉了最值得关注的东西，也就不可能建立起有意义的模型。为了帮助理解心理动力学中的压力等概念，我曾使用过一个悬浮气球的类比。

现在，你看见一个充满空气的气球（忽略球壁厚度）正悬浮在空中。在它的内部和外部，所有的空气分子都在无规律地快速运动着，碰撞着。这种无休止的碰撞使气球能够维持一定的形状和体积。这个气球就相当于一个人，这种稳定悬浮的状态就相当于人的平静状态。它看似安静，其实内部一点都不太平。气球内部躁动不息的分子就相当于人心之中纷扰不休的各种冲动。气球内部所有空气分子的碰撞形成了气球的内在压力，这相当于人的心理压力。空气分子在球壁的两侧相互冲撞着，达到了动态平衡。球壁内外两侧的相互作用构成了气球与外界之间的压力，这相当于人与环境之间的压力。与气球不同的是，人只会承认环境对自己施加的压力，不会承认自己对环境施加的压力。

现在，魔鬼伸出了双手，开始从两侧挤压气球。气球体积开始变小，同时内部分子的碰撞变得更加激烈。其中与挤压方向相反或垂直的碰撞变化尤其明显，这相当于冲动发展成了具体的对抗行为。气球的表面积因挤压而增大，球壁在与挤压方向垂直的方向上变得更薄更“紧张”，仿佛有一部分分子要冲破球壁，这相当于个体在巨大的压力下产生了强烈的紧张感和解离倾向。气球内

部的压力、气球与外界之间的压力同步升高。最后，气球或者爆炸（解离和崩溃）或者从魔鬼手中滑脱（逃离和复原），或者达到新的平衡（接纳和适应）。这一过程就是应激。

气球不是凭空出现的，是魔鬼从其他地方拿来的。在你之前没有看见它时，它就已经在努力适应这里的空气了。也就是说，它本来就处在应激状态。但是，我们现在还没工夫关心它之前的应激过程。我们只能将我们刚开始看见的状态作为参考基准。这个作为参考基准的状态就是无压力状态。在无压力状态上增加的压力才是我们现在关心的压力。

现在，魔鬼开始对气球作法，让它内部所有空气分子立刻停止运动，气球内部温度立刻下降到绝对零度。由于气球内部失去了空气分子的碰撞所产生的张力，在忽略了空气分子的体积和分子间斥力的情况下，气球的体积会在外界空气压迫下迅速收缩为零。它和环境之间的压力消失了，它内部的压力也不存在了。这种状态就是现象学意义上的静止，也是真正的无压力状态。它意味着一个人的社会性存在消失了，他在社会学意义上死亡了。

2.6.5赤子之心

以学习手机操作为例。

对于孩子来说，一部手机就像散落着点点星光的夜空一样，在混沌之中夹杂着某种难以言说的熟悉感。孩子虽然熟悉“戳”和“点”的动作，但戳和点的各种组合方式所带来的各种效果却可以给他们带来充满活力的体验。一个孩子拿到手机以后，他会立刻被手机上那些按钮和色块的奇异组合吸引。在不断地试探中，孩子逐渐发现了某些模式，然后就慢慢地掌握了手机的使用方法。

对于从来没有接触过手机的成年人来说，这些能戳能点的按钮已经很难提起他们的兴趣了，难道还有什么按钮是他们没见过的吗（尽管他们确实没见过）？这些按钮和色块的组合对于他们来说已经熟悉到无聊，戳戳点点对于他们来说简直幼稚到可笑，而手机中的世界对于他们却是绝对混沌的。他们无法将这些乏味的组合和充满活力的全新世界关联起来。二者过于割裂，不能给他们带来“熟悉而陌生”的感受，也就提不起他们的好奇心。当他们需要使用手机的时候，必然是碰到了某些重要任务，手机对于这些任务只是一个载体而已。

他们不会为了完成这些任务从零开始学习手机操作，正如普通人不会为了一碟醋去包饺子，他们既没有耐心也没有时间。这些任务的严肃性也不允许他们像孩子那样通过全神贯注而又不顾后果的戳戳点点来熟悉操作。

这些因素导致很多大人永远都无法像青少年那样快速接纳新鲜事物，发展适应能力。但是，我们身边总有一些例外，他们似乎能永葆赤子之心，像儿童那样满怀激情，百折不挠，对一切都充满好奇，这些人都是受困者的榜样。受困者必须为自己找到这样的榜样，否则即使自己走出了创伤阴影，也会因为落下了太多的成长功课而难以适应社会。

2.6.6防御

心理动力学中的防御是以治疗师为中心的一系列概念，在自助语境下缺少意义。从主体间关系的角度，所谓防御只是一种被动的沟通方式，它反映了主体在自己对压力最直接的应对受到否定、对感受最直接的解读受到忽视之后，被迫降级的适应策略。

因为人们对需求的理解过于肤浅，所以需求在很大程度上是由满足它的主流方式定义的。如果对于一个主体来说，这种主流的满足方式不可得，他就只能寻找其它非主流的方式。在只会用满足需求的方式定义需求的精神分析师们看来，主体用一种防御策略压抑了自己的需求。但对于当事者来说，这根本无法想象。当事者只会觉得自己根本没有那些需求，于是双方就陷入了鸡同鸭讲的境地。精神分析的理论家们不得不为此发明更多抽象的概念来增强自己的说服力。

2.6.7动力

动力（驱力）是压力的另一种表述。在日常语境下，动力侧重于建设性，压力侧重于威胁性。

动力可分为两类：一类驱使主体保持一定唤醒水平，一类驱使主体有所行动。在主观体验上，前者主要作为情感底色被觉察，后者主要作为欲望或冲动被觉察。在日常表述中，只有后一类动力被视为动力，前一类动力代表了一种基准或参考平面。人们说的“无压力状态”或“平静状态”就是指第一类动力

占主导的状态。

主体-世界交流圈叙事下，最基本的第一类驱力是惊讶感。最基本的第二类驱力是探索欲。它们体现了人类的好奇心。我们在醒着的时候会不断受到轻微的惊吓，正是这些轻微的惊吓使我们得以保持一定程度的唤醒。

主体间交流圈叙事下，最基本的第一类驱力是亲和感。最基本的第二类驱力是沟通欲。它们体现了人类的亲社会本能。

沟通欲是主体向外沟通的冲动，包括表达欲与被表达欲两个侧面。表达欲或称“被理解欲”，意指我们期待自身感受得到包括自己在内的人们的普遍认可和接纳。被表达欲或称“理解欲”，意指我们期待自己为他人所需要。如果探索行为被反射性的消极情绪抑制，沟通欲就无法发展为有效的沟通。受困者即使获得表达的机会，也会在慌乱中口不择言，举止无措，真实的表达欲反而被抑制。他们即使获得理解他人的机会，也难以发起有效的探索，反倒经常使自己成为自恋者的“垃圾桶”，真实的理解欲深受挫折。表达欲得不到满足，主体容易发展出自恋（narcissism）倾向。被表达欲得不到满足，主体容易发展出受虐倾向。

确认成就感的过程就像一个小孩子对着母亲喊：“妈妈你看！”然后他就可以从母亲的反应中确认成就的性质与意义。对常人来说，亲和感与成就感构成稳定的循环。亏欠感来自于主体的互动表现与人们的一般期待之间的偏差，对循环起调节作用。在极端情况下，亏欠感会发展为羞耻感。亲和感的缺失使成就感无法得到确认，主体常常会产生强迫性的沟通欲，并感到莫名的孤独。受困者的驱力时常由亏欠感主导。受困者明白自己的表现存在各种问题但又不能明确问题在哪儿，因此他们常常会有各种亏欠感。这使他们在面对人格打压时很容易屈服，在“地位博弈”（“地位博弈”指的是双边关系中的主体对“上位”和“下位”身份的博弈。上位属于支配者，下位属于被支配者，地位对等的双方属于“合作者”）中总是处于劣势。

由于对亏欠感过于熟悉，受困者常常有意无意地将他人拖入这种“相互亏欠”的人际关系中，给他人带来巨大压力而不自知。

2.7 情绪

2.7.1 情绪的概念

从体觉的角度来说，情绪（emotion）是对体觉的总结性命名。从活动的角度来说，情绪是对微活动（包括冲动）的总结性命名。活动性越强，就越能容纳复杂的情绪；唤醒水平越高，就越能承载强烈的情绪。所谓“饱满的人格”就是指同时保持相对较高的运动唤醒水平和较强的活动性的能力。从意识对象分化的角度来说，不同的压力所引起的紧张感（应激）需要不同的应对方式，不同的应对方式会使这些紧张感产生不同的变化。应对方式的分化造成了意识对象的分化。同时，原始的紧张感也分化成了不同的情绪。人类共享相似的感官和行动能力，因此会发展出相似的情绪体验能力。情绪分化过程一旦出现偏差，个体将在某些最基本的人格方面与大众分离，比如一部分性少数人士（Sexual Minority）。

情绪与植物神经系统的状态密切相关。神经系统功能的周期性波动会影响情绪的周期性涨落。植物神经系统偶发的紊乱也会造成情绪的异常波动，类似于肌肉的“抽搐”。

母体植物神经系统的性能与胎儿存在相当程度的一致性。如果母亲存在严重的植物神经紊乱，婴儿很可能自出生起就带着一套极为脆弱的植物神经系统，这是创伤易感性的来源之一。

情绪无所谓对错，那些一时无法找到现实落点的情绪无不在诉说着现象学世界的独特性。对常人来说，接住情绪并为之找到现实的落点在大多数时候就像呼吸一样自然。但是对于受困者来说，压抑、否认甚至抽象化情绪已成为习惯。被忽视的情绪不断积压，主体必然心神不宁，注意力无法集中。

2.7.2 初级情绪与次生情绪

初级情绪是在事件发生时当事人基于一般的认知加工过程必然会体验到的情绪，次生情绪是在初级情绪的基础上由于个性化的认知加工而产生的情绪。比如大家正在玩游戏，自己手中的气球突然爆炸了。此时恐惧就是初级情绪，羞耻就是次生情绪。情绪模式的异常是心理创伤最直接的表现。受困者起初往

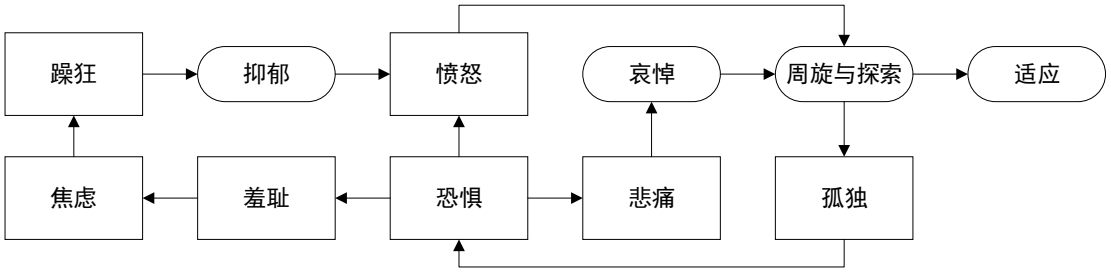
往难以分辨初级情绪与次生情绪，但随着治疗的推进，他们会发现很多原本以为是初级情绪的情绪都是次生情绪。认知行为疗法（包括认知加工疗法等变体）在处理次生情绪方面拥有绝对优势，它将解开受困者身上最外层的枷锁，成为受困者自愈之路的第一位引路人。认知行为疗法如同一架水平仪，使受困者能够在一些最基本最重要的认识上与常人“对齐”。随着受困者对情绪的理解逐渐与常人趋同，他们将有能力踏上专属自己的自愈之旅。

2.7.3积极情绪与消极情绪

“惊讶”或“紧张”是所有应激情绪的原始形态。它将随着不同的应对过程发展为不同的应激情绪。积极情绪可以理解为能量顺畅流动的体验，是完成度相对较高的情绪。消极情绪可以理解为能量被阻塞的体验，是完成度相对较低的情绪。所有积极情绪都带有某种“自我实现”的基调。所有的消极情绪都带有某种“自我对抗”或者“力不从心”的基调。同样是心情激动，如果身体能够有条不紊地展开行动，脑海中能够不断涌现出各种思路，它就会被解读为兴奋，如果一身的力气使不出来，脑海中的各种思路反复被打断，它就变成了愤怒，如果身体完全僵住，头脑陷入空白，它就变成了恐惧。不论我们体验到多么强烈的消极情绪，都要努力将注意力集中到该做的事情上，才能推动情绪向积极方向转化。在森田疗法中，这个道理被集中概括为“顺其自然，为所当为”。

积极的应对会促使消极情绪汇集为具体的愤怒或悲痛，最终通过拼搏和哀悼释放出来。消极的应对会促使尖锐而强烈的情绪逐渐弥散为温和而混沌的焦虑，不断累积成为强烈而混沌的躁狂，最终使主体崩溃，陷入抑郁。

消极情绪转化示意图（仅作示意，不具有唯一性）：



受困者对消极情绪的转化极为熟练。他们可以在极短的时间内将愤怒转化

为极具破坏性的躁狂。受困者必须觉察到情绪转化的中间过程才能调整自己，否则就只能求助于专业人员。

2.7.4受困者的消极情绪

情绪识别主要是认知行为疗法的工作。这里仅简述一些消极情绪在受困者身上表现出的特殊性。

1) 焦虑

“焦虑”是所有消极情绪的终极形态。消极情绪如果一直得不到处理，将逐渐弥散为混沌的阻塞感，这种情绪就是焦虑（anxiety）。焦虑是一种弥漫性的情绪，不同于具体的担忧。

焦虑的混沌性决定了它并不总是被体验为消极情绪。焦虑既可能表现为易激惹，也可能表现为莫名其妙的兴奋和欣快感。这种欣快感可以成为神游（daydreaming）的直接动力。注意这里说的是焦虑的特点，不要与双相情感障碍中的“躁狂”相提并论。

2) 愤怒

健康的人拥有健康的攻击性（对抗性、排异性）。对于儿童来说，高兴就笑，伤心就哭，生气就掉，害怕就跑，跑不了就叫，叫不了就抖是再自然不过的事情。成人的应激模式无论多么复杂，多么成熟，都是在此基础上发展起来的。人生早期的创伤使受困者早早就学会了自我凝视和自我抑制，虽然这些儿童大部分时间看起来很安静，很“乖巧”，但实际上他们应对问题的能力从未得到发展。事中恐惧退缩，事后愤怒懊恼是受困者应激模式的基本特点。行为表达不足，情绪的解读也会变得困难，受困者普遍存在述情障碍（alexithymia）。

与常人相比，受困者的愤怒总是格外强烈，难以自制。这一方面是因为受困者的愤怒总是和恐惧、悲痛、羞耻等情绪混在一起，他们心中的自我对抗远比常人激烈得多。换句话说，他们的愤怒有相当一部分是对自己的愤怒，因此他们无论如何发泄都不可能尽兴。一旦他们看见了自己在愤怒背后的恐惧、悲痛和羞耻，愤怒往往会迅速平息。另一方面是因为受困者感受力受限，他们在探索过程中总是倾向于过度卷入，逃离时自然需要更多能量。好比盲人总要亲手触摸一个物体才能确认它是什么。一旦发现自己碰到了炸弹，便只能迅速丢

下，狼狈逃窜。

3) 恐惧

物理意义的压力（pressure）一方面会使我们产生倒下的倾向，另一方面使我们感受到自身肌肉所蕴含的力量。心理压力一方面会压迫我们的感官，使我们不由自主地产生封闭感官的倾向和活动受限的体验，另一方面也会使我们产生搏斗的冲动。当前者占优势时，我们会体验到恐惧，当后者占优势时，我们会体验到愤怒。任何超出我们适应能力的急性压力事件都会在我们的心里组织起一场恐惧与愤怒的“拔河比赛”。

压力使我们感到惊讶并变得警觉。这种惊讶与警觉的感受就是“危机感”。如果主体已经得到充分的生理动员与心理建设，对自身的认知资源和及社会支持系统拥有足够自信，这种危机感也可以被体会成单纯的兴奋感。

当压力使主体感受到了巨大的冲击，唤醒水平剧烈提升，而他既来不及仔细探索，又不知道如何释放对抗性时，封闭感官的倾向就会越来越强烈，危机感就会发展成恐惧感。就活动能力而言，恐惧可以理解为退缩和自我封闭的倾向。

所有恐惧的背后，都是主体无力负担的责任。想象一场突如其来的危机使你进入了紧张状态。如果你能够扛住压力，完成应对，你在危机中的感受就会被解读为危机感。如果你始终无法完成应对，你就会感到恐惧。极端的恐惧往往会造成解离，解离意味着感官的封闭。

对于受困者来说，闪回和觉醒都会带来强烈的恐惧体验。如果主体不能做好负责的准备，不注重在平时积累内在资源（或者释放被压抑的内在资源），他就可能会顺应这种封闭感官的倾向，使自己陷入一种麻木的状态。他不是无视了压力，而是在压力造成真正的灾难之前就屈服了。他逃避了恐惧，也就逃避了觉醒，他的人格将无法得到发展。

从植物神经系统的角度来说，恐惧状态下的个体一方面要全面了解处境，仔细寻找线索，这要求副交感神经系统必须足够兴奋，另一方面，交感神经系统必须足够兴奋才能让主体对压力形成足够的抗性。两者之间的巨大矛盾使恐惧成为了极具创伤性的情绪。如果主体不能稳妥地释放出其中的能量，必将陷入植物神经紊乱，植物神经紊乱是应激障碍的标志之一。在很大程度上，创伤

干预技术就是干预恐惧感的技术。

4) 孤独

当主体建立连接的冲动或行动落空时，主体就体验到了孤独。不自觉的孤独感就是寂寞、空虚、被抛弃感。自觉的孤独感可以让主体学会坚强。

隐秘的生理缺陷给探索造成的困难、家庭的某些危机（成员被疾病拖累、经济困境等）所造成的持续而无意识的情感忽视都会使主体感受到隔阂与孤立。主体感到世界拒绝了自己，自己与自身的资源之间失去了基本的连接。

正如我们了解自己的仪容常常需要镜子，主体对情绪的解读往往需要依赖他人的共情，不自觉的孤独者普遍存在述情障碍。他们在压力之下只能感到强烈而混沌的恐惧和焦虑。主体可能不自觉地陷入反刍状态，以回避这种压倒性的恐惧感和被抛弃感。主体自我报告在反刍中感受到的是痛苦和愤怒，但是在观察者看来，真正的主角是孤独。

5) 羞耻

要说在心理治疗中最棘手也最具破坏性的情绪，毫无疑问就是病态的羞耻。羞耻感扭曲了同情心，阻断了主体间的情感连接，使受困者错过了一切能拯救他的力量。

羞耻与惭愧或内疚不同，惭愧或内疚会使我们有所作为，而羞耻会阻断我们的作为。自我凝视和微观管理都和羞耻直接相关。正常的羞耻感具有一过性，而受困者的羞耻感常伴随僵直与笨拙，有很强的强迫性。

主体只有感受到自身原始冲动的可靠性，才能体验到自身和世界之间天然存在的羁绊，进而对自己和世界产生亲和感。毒性的羞耻导致主体不知如何与自身的冲动相处，心理冲突总是陷入僵局。羞耻一旦成为习惯，主体就可以熟练地在冲动得到确认（也就是形成“想法”）之前打断驱力，恢复活力也就无从谈起了。到了这一步，受困者已经很难依靠自己走出毒性羞耻感的阴影了。

对羞耻的易感性容易让受困者给人留下心胸狭隘或者敏感脆弱的印象，他们自己也为此苦恼。一些理论将这种易感性归于童年阶段来自养育者的持续打压。但我们必须看到，同样是来自养育者的打压，有很多坚强的孩子并不会受到影响。每个人都充满了缺点，都可能错误地批评他人，也都可能受到错误的批评。但是，有灵性的人不论受到多大的干扰，都能很快将注意力重新集中到

该做的事情上。他们会因为批评变得警觉，但也会避免过度卷入批评者的情绪。养育者对被养育者的打压来自养育者自身的创伤与恐惧，聪明的孩子能分清养育者的恐惧和自己的恐惧，不会简单地将恐惧与权威关联，也就不会额外赋予恐惧力量。将问题归因于养育者的错误，并不能帮助受困者，但我们也不认为错在受困者，这根本不是纠结对错的时候。受困者能够在创伤化的养育中幸存，必然做对了一些什么。但他们被困在这种勉强生存的状态中，必然也有一些重要的事情没做。只有让受困者意识到自己做了什么，还可以做什么，才能真正帮到他们。

羞耻易感性常常可以追溯至某些隐秘的生理缺陷。这些生理缺陷限制了主体的适应能力，主体常常感到自己仿佛存在某种幻觉。这限制了他的自信，使他很容易受到各种负面评价的影响。受困者需要花很长时间才能学会对自己的感受保持诚实。缺陷让自己更容易遭遇恶意，也让自己更容易看见人的良知。隐秘生理缺陷的一个实例可参照 5.3 节。

亲近乐见自己变好的人，与看自己笑话的人保持心理距离，是处理毒性羞耻感的前提。

6) 悲恸

悲恸（悲痛）因丧失而生，是一种无助而不屈的强烈体验。悲恸是一种矛盾的情绪，兼具抑郁与愤怒的特点。根据心理支持和认知加工的不同，悲恸可能被导向哀悼、绝望或愤怒。

2.7.5 情绪与感受

情绪具有显著性，是重要的社交信号。感受具有微妙性，是经过了发酵的情绪。发酵的过程就是体会（felt sense）。感受力是认知加工能力（所谓“理性”）的基础，认知对感受起催化和调节作用。丰沛的情感不会支持狭隘的认知图式，富有智慧的人也不会是冷血动物。想一想，自己灵感最丰富的时候是不是总是情绪体验最丰富的时候？

如果说“紧张”是所有应激情绪的原始形态，那么“警惕”就是所有感受的原始形态。受困者很少感到警醒，他们在观察者眼中就像从来没睡醒一样。他们很少体验到丰富细腻的情感，只能体验到原始而强烈的情绪或者完全体验

不到任何东西，因此常给人以粗鲁或冷漠的印象。他们总是被简单激烈的情绪裹挟，只能作出简单僵化的应激反应，适应能力严重受限。可见，前文所述“活动性”实际上是描述个体情感体验丰富程度的外在指标。活动性不足相当于说情感世界“荒漠化”了。

感受具有一定个体性和差异性。但正如谱系观所言，这些差异只有在我们重点谈论个性时才有意义。再多的差异也无法否定整体的一致。面对治疗师，受困者通常只需要关注感受的个体性。但受困者如果要自救，就必须对共通性有足够的自觉。能够认识到人类情感在根本上的一致性，这是最深切的慈悲。

个体成长的过程也是情感不断分化的过程，我们的个性随着情感的不断分化而愈发突出。受困者由于缺少社会活动，情感分化程度往往较低。比如很多受困者无法在情感层面上区分害羞和羞耻。他们为了对抗创伤带来的毒性羞耻感，把害羞的能力也丢掉了。这使他们在人际交往中常常显得粗鲁而冒犯，富有攻击性。当他们学会了健康的害羞，完成了羞涩和羞耻的分化以后，自然就学会尊重别人了。

2.7.6感受的主体间性

需求（requirement/demand）和想法（thought/idea）源于自我（self），而感受（feeling）和需要（need）是比“你”“我”这种身份概念更加基础的东西。人类的感受和需要都是相通的，因此人类才能互相理解，实现沟通。这种情意相通的能力就是共情。一个人很难只关心别人的感受而完全忽略自己的感受，反之亦然。接纳感受，感受就会流动，流动的感受会逐渐构筑起自我。受困者因为身心解离而失去了感受力，也就发展不出自我，更不会有主体性。

活动的主体间性决定了感受的主体间性。想象一位沉浸在幸福感中的母亲温柔地将婴儿抱起，放在自己温暖的怀抱中。母亲轻轻晃动着婴儿，哼起了摇篮曲。母亲身上一切活动中的微妙细节都会刺激婴儿，婴儿会产生和母亲相似的感受，脸上逐渐浮现出微笑。母亲被婴儿的微笑感染，也开始露出笑容，动作品质中的情感也更加强烈，婴儿更加开心，发出了咯咯的笑声，母亲的笑容也变得灿烂。在双方情感实现调谐的同时，婴儿也把自己身体的感受、自己面部肌肉的知觉、自己的笑声和母亲的动作、声音、表情关联了起来。婴儿虽然

看不见自己的脸，但是通过母亲的脸认识了自己的表情。所有这一切汇集成了“开心”的体验。因此，从出生开始人类的情感就是一个整体。两个人的互动越密切，情绪就越容易互相感染。

身心解离使感受变得黯淡而僵硬，导致受困者无法轻易意识到感受的复杂性（或者从未发展出复杂性）。他们很难像常人那样在发展出自我的同时自然而然地学会区分感受中属于自己的成分和属于别人的成分。

A 和 B 新相识，陌生但投缘。A 对 B 的某个表述感到困惑，提出了尖锐的质疑。B 唤起了在公共场合被权威质疑的恐怖体验，他在恐惧之下艰难地回应了 A。A 尝试理解 B，同时感染了 B 的恐惧感。此时，A 对自身感受的自觉程度将决定这个互动会往哪个方向发展。

1. 自觉共情方向：A 意识到了双方各自的恐惧，开始提示并安抚 B。双方共同面对了这份恐惧，耐心探讨背后的问题。A 发现 B 的问题与自己长期思考的一些问题有相似之处，A 在帮助 B 解决问题的同时也加深了对自己的理解。

2. 拯救者方向：A 没有意识到自己的恐惧，把它完全当成了 B 的恐惧。他开始用处理自身恐惧的方式应对 B 的恐惧，完全忽视了自己的角色和 B 的真实情况，A 事实上已经陷入了闪回。A 认为自己在帮助 B，B 却感到羞辱与冒犯。A 卖力不讨好，十分沮丧。如果他不能识别这种沮丧，沮丧很快会发展为被抛弃感。

3. 闪回漩涡方向：A 没有意识到 B 的恐惧，把它完全当成了自己的恐惧。由于 A 尚未学会如何应对这种恐惧，更多的恐惧体验被关联唤起，A 在闪回中越陷越深。他疲于应对自己的恐惧，把 B 的问题晾在了一边，开始讲一些令 B 感到匪夷所思的话。B 一头雾水，不知道发生了什么。

4. 活现（enact）方向：A 完全没有意识到恐惧的存在。A 被恐惧唤起了应激，开始带着攻击性与 B 对话，B 对 A 的攻击作出防御。个体的恐惧变成了双方的恐惧，微妙的恐惧变成了更加显著的恐惧，互动被恐惧和愤怒支配了。双方的对话中完全没有类似恐惧的字眼，但他们的一切行为都写满了恐惧。

类似的还有对当下感受与过去感受的区分。确切地说，一切感受都是当下的感受，所谓过去感受指的是产生于过去，但一直未被处理，从而一直暗在于当下的感受。如果这种感受形成得太早，甚至会成为体验流的底色。如果一个

人无法区分自己的感受和别人的感受，就很容易作出越界的行为。如果一个人无法区分当下的感受和过去的感受，就很容易被闪回支配。

2.7.7述情障碍

述情障碍可能存在生理基础。如果主体没有感觉，没有幻觉，甚至做的梦也没有色彩，那么他的述情障碍很可能是生理性的。对于这类人，本文无能为力。本文仅关注可通过心理治疗手段干预的述情障碍。

述情障碍的严重程度存在显著个体差异，来源也多种多样。社会化程度不足、超出日常经验的极端体验、身心解离、心智解离、异常的身心状态都可以造成述情障碍。

从社会化角度来说，每个人都存在不同程度的述情障碍。我们每个人都体验过各种无法形容的感受，这些无法形容的感受可能在心间萦绕很久，直到我们在某一个不经意的瞬间突然意识到了它们是什么。当个体进入了一个新鲜的环境却没有人引导他时，他就只能发挥自己的探索精神和环境建立关系。对于常人来说，这通常是很普通的挑战。但是对于受困者来说，他们的体验流因为低下的活动性和唤醒水平而缺失了各种细节。得不到发展的冲动、无法完成的探索使他们难以解读自身体验流的变化。各种触动最终只能归于焦虑、愤怒和抑郁。

从极端体验角度来说，因为这些体验远远超出了人们对情绪的一般理解，所以人们很容易以为这是自己的身体出了毛病。例如抑郁障碍者普遍存在“躯体化”（somaticizing）现象，他们感受到的痛苦就是一种极端的消极情绪。

述情障碍者不理解自己的情绪，也就无法实时觉察自身情绪的影响力，更不能自觉利用这种影响力。他们不能掌控自己的情绪，也就更容易情绪化。他们因无法控制情绪而冲动行事，冒犯他人，却毫不自知。情绪中的巨大能量如果不能成为财富，就必然成为负担。

人们通过共情（empathy）感受和理解他人的情感，述情障碍者无法辨认自己的情感，也就无法辨认他人的情感。在述情障碍者眼中，别人的言行举止经常显得特别夸张。

创伤化摧毁了受困者正常的发展轨迹，即使已成年，他们积累的互动经验

在深度和广度上也不会比儿童强多少。他们的各种异常表现，很大程度上都是发展停滞的结果。

2.7.8宣泄

宣泄（Katharsis）与发泄或抱怨不同。发泄和抱怨是对能量的净消耗，它们无助于发展关系，只能暂时让主体因疲劳而减少活力。活力减少后，心理冲突变弱，痛苦随之减轻。

宣泄是强烈情感体验集中而坦诚的表达。宣泄者对自身的情感体验完全负责，抱怨者和发泄者则表里不一。抱怨者带着攻击性表达脆弱性，把应对攻击性的压力抛给了倾听者。如果外界拒绝配合，他们会更加委屈。发泄者带着脆弱性表达攻击性，把应对脆弱性的压力抛给了承受者，如果别人拒绝配合，他们会更加愤怒。一旦别人配合了他们的抱怨和发泄，就会沦落为他们的“血包”。

宣泄来自共鸣（resonance）与触动（transport）。有关共鸣与触动，可参考文末必读书目中迈克尔·怀特（Michael White）的著作。

2.8 解离

2.8.1解离的概念

解离（dissociation）又作“离解”。解离是个内涵丰富的概念。它既可以指主体与现实的疏离，也可以指主体内在的分裂。神游、情感麻木、分离障碍都可看作解离的表现。在小说《了不起的盖茨比》中，主人公尼克那种“置身事外而又身在其中”的状态就是一种轻度解离。创伤使尼克对世界失去了信心，他的心灵失去了归宿。所有长期困于某种程度的解离状态的人都可以说是在心灵的荒原流浪。

假如一个人喝了很多水，然后坚持不上厕所，尿意在到达极点以后就会消失。一段时间后，尿意卷土重来，变得更加强烈，然后再度消失。如此可以循环多次，直至失禁（这个实验可能造成生命危险，不要轻易尝试）。其间尿意消失的体验，就是一种解离体验。又如一个经历了重大丧失的人，在精神痛苦

到极点后突然失去了一切情绪，这也是一种解离体验。在前一个案例中，解离体验来自感觉神经的暂时耗竭。在后一个案例中，解离体验来自身体冲动的暂时耗竭。这些解离体验都是一过性的正常生理反应，不具有病理性。

主体对于解离体验的自我报告往往不可靠。对于罕见的体验，人们会因缺少表达方式而进行过度的认知加工，甚至描述成灵魂出窍，此时的体验已经不再是体验而是解释甚至想象了。在观察者眼中，解离状态下的主体往往冰冷、僵化、没有活力。在依恋关系中，养育者的解离极具创伤性，会让被养育者感到恐惧和无所适从。强烈的恐惧和无所适从也会诱发被养育者的解离。

借用通俗自助读物的语言，情感遗弃是爱的缺席，解离是爱的抗拒，二者互为因果。

2.8.2 身心解离

在极端的痛苦中，主体可以通过全神贯注于某个具体的感觉（或某个随机选定的锚点）而切断感觉和情绪反应的关联。以恐惧为例，某些人在令人绝望的无助中通过集中注意于身体的无力感来避免直视内心的恐惧。当危机解除后，主体不必再努力放下恐惧，因为恐惧早就被切断了。可是身上那种无力感却再也挥之不去了。他的身体处在恐惧和无助之中，心里却感受不到恐惧和绝望。在一定程度上，他成了一个有感觉而无感受的人，这就是身心解离。从此，绝望成为了他的情感底色。他感到身体越来越虚弱，似乎做什么都很累，却说不清楚原因。明明同事关系都还可以，可他就是天天迟到，工作效率低下，仿佛存心和所有人作对一般。他的活动能力在非常基础的层面上受到了限制。身心解离是述情障碍的重要来源。

切断关联简单，想要有意识地重连可不容易。这些未处理的恐惧通常都是在毫无防备的状态下以闪回（flashback）的形式再次被注意到，然后在一地鸡毛中再度被断开。从躯体体验的视角来说，要解除身心解离，首先要在可靠的引导下，通过仔细体会身体知觉，渐次触及痛苦体验的每一个细节，然后通过重新协商（renegotiation），消解这些被困在身体中的强大能量。这谈何容易！在灾难发生的当时，个体尚且无法面对恐惧，如今时过境迁，也就更难捡起勇气了。人类发明各种心理治疗技术，在很大程度上都是为了安全地面对极端创

伤体验的再次唤起。

身心解离可以发生在一生中的任意时刻。成人的身心解离追溯起来尚且有难度，儿童的身心解离追溯起来就更困难了。极端情况下，儿童可能在出生不久甚至出生前就已经经历严重的身心解离。这些孩子的创伤经历无人见证，他们只知道自己好像天生就是这种状态。

儿童处在发展基本适应力的关键阶段。如果他经常承受超出自身应对能力的压力，就很可能发现解离的工具性价值，甚至完全用解离取代一般意义的战或逃反应。他会利用频繁发生的解离找到让自己快速抽离现实的某种诀窍，将解离作为自己适应环境的一种方式，引导自己不再关注任何东西，身体也不再和环境共鸣。他由此习得了最简单粗暴的一种生存策略，一切威胁似乎都不那么可怕了，但世界也似乎不那么生动，不那么值得关注、值得珍惜了。他的现实感被破坏了。

身心解离使压力源（应激源）无法对主体造成心理压力，也让主体失去了利用压力发展自身适应力的机会。失去了环境压力的持续刺激，受困者的唤醒水平将持续走低，他们可能发展出各种自我刺激甚至自虐的习惯以维持唤醒。

2.8.3心智解离

在阿希从众实验（Asch Conformity Experiments）中，被试者如果搞明白了状况，意识到自己被做局了，其他参与者的发言对于他就会完全成为普通的背景音，不再能左右他的情绪。其他参与者在某种意义上被“去人格化”了，他们的发言已经不再具有人格，不再能激起主体对于一般人类发言的反应。他们对于体验流的意义已经和路边的小猫小狗没有区别。此时，主体就习得了一种适应性的解离。这种自主性的解离可以称作“心智解离”。它和身心解离的区别在于它直接受到认知的调节。将对方去人格化以实现心理隔离的过程就是“嫌弃”。身心解离容易给人留下麻木迟钝的印象，而心智解离容易给人留下冷漠无情的印象。

与去人格化相对的就是人格化（拟人化）。面对较难胜任但又无须逃脱的压力，常人往往会尝试找到其中的人格因素，甚至赋予它本来不存在的人格因素，然后与之周旋，直至化整为零，各个击破。受困者容易感到恐惧的一个原

因就是他们往往注意不到压力中的人格因素，任何压力都会被他们体验为来自整个世界的压力。比如一个人正在屋里看书，室外的道路上传来了机械的轰鸣声。常人可能会联想到使用这些机器的人，联想到他们在做什么，对他们有什么意义，对自己有什么影响，然后选择有所行动或者直接忽视，但受困者可能会直接陷入无法排解的焦虑。

心智解离的自觉程度和个体接受的社会化教育有很大关系。集体性的心智解离一般较难自觉，童年情感忽视造成的心智解离往往完全不自觉，很容易和身心解离混淆。

童年遭受的情感忽视可能使主体从未学会如何将自己的体觉整合为情绪并命名，更不能整合出复杂的情感。例如他们可能表达自己心跳加速、出汗、头晕，却无法意识到这是一种紧张感。他们甚至可能因此以为自己身体出了问题，却意识不到这是对压力的自然反应。心智解离同样是述情障碍的重要来源。

CPTSD 涉及的解离主要是身心解离和心智解离。它们不如解离障碍（Dissociative Disorder）中的解离那么极端，因而给自救留下了一定空间。后文提及的解离如无特殊说明，都指这两种解离。

2.8.4解离与正念

解离导致主体很容易混淆体觉和具体的身体知觉。每当强烈的情绪涌起，他们就会感到自己的身体仿佛要出问题。实际上，无论事态多么严峻，情绪本身都不危险。一切情绪都是为了调动身心资源，使主体更好地应对事态。不论体觉多么令我们难以忍受，亲近体觉都不会让我们失控，疏远体觉才会。身体能承载的体觉越多，主体就越有力量。亲近自己的体觉，时刻准备欢迎自己的每一个触动，感受它们的自发涨落所带来的身心能量的波动，给它们取恰如其分的名字，然后放下它们（为了避免将放下理解成压抑，可以默念一句“由它去吧”）。把“但是……”“至于吗”“别人都可以……”之类字眼从自己的字典中抠掉。这是正念的精神，也是走出解离的起点。常言所谓“放松”便是赋予体觉以自由。

健康的主体天然具有整合一切感官刺激的能力。除了中风和重大事故造成的脑损伤以外，只有解离会限制这种能力。解离可以是自觉的，也可以是不自

觉的，心理治疗中提及的解离主要是不自觉的解离。自觉的解离一般是由不自觉的解离训练而来的，但很多人喜欢将这种解离粉饰为“正念”。

一些理论用观察性自我（Observing Ego）或见证性自我（Witnessing Self）定义正念，这本来是很精炼的概括，却意外地让一些人混淆了正念和解离。因为对于很多受困者来说，和自我见证、自我观察这类说法在字面意义上最接近的体验就是解离状态下那种身心分离甚至灵魂出窍的体验。

正念绝不意味着和手边的活动保持距离，相反，它意味着全然的投入。正念不是将注意力贯注于意识空间的一边一隅，而是用全身心拥抱整个意识空间，重新激活心灵中那些早已麻木的部分。沉迷欲念而废寝忘食的行为是一种解离，但也正是这样的人最喜欢曲解“专注”等品质以美化自己的行为。在正念状态下，所有的活动，不论微妙还是显著，不论在视线内还是视线外，不论是知觉还是想法，都在更高的维度上成为了一个整体。主体平静而警觉地注意着意识空间里的一切，就像一位尽责的母亲在孩子沉浸于游戏时温和地注意着环境中的一切，守护着孩子的安全；又像一位称职的管理员时刻监视着面前的监控墙，他不必把神经绷得太紧，因为绝大多数时间一切正常，但他必须有能力在第一时间捕获可疑信息，随时准备进入紧张状态。可见，人们在社会生产中最容易领悟正念的法门，这也正是修行者普遍强调辛勤劳动、动静结合的原因。

2.9 体会

2.9.1体会的概念

聚焦理论（Focusing）中的“felt sense”一般译作“体会”。“felt”意味着这些体觉（sense）已经进入了意识，但还没有受到过度的认知加工的“污染”。体会是身心互动的产物，是感受，也是体验，是一种基于体觉的直觉智慧。“体会”一词很好地体现了这一概念的具身性（embodiment），体现了聚焦理论和中国古典思想的某种契合。比起我们日常使用的“体会”一词，这里说的“体会”更加强调主体在相对安宁的情境中仔细地感受身体中由于各种活动的残迹所造成的失谐感和阻塞感。受困者由于自身活动性严重衰退，在尝试体会时往往只能感到脑中一片空白，因此受困者的体会通常需要结合“滴定

（titrition）”或“动中觉察（awareness through movement）”等手段。体会使失谐的认知和感受得到了整合，最终使被阻塞的体验流恢复了流动。体会具有全局性，同时又非常具体，是一个颇有格式塔（Gestalt）意味的概念。体会的形成伴随着活动性的短暂提升，主观上往往伴随着一种“开悟”或“通透”的体验。

所谓过度的认知加工也叫“过度思考”，指的是认知过程充斥了特异性的、局限性的、情绪化的经验和过度精细却不可靠的认知图式，使主体对事物的认知在变得更具体的同时也更草率，更狭隘，更自以为是。事实上，即使避开过度思考，体会也仍然被主体的生活经验所限制，但它体现了一个有智慧的人在实时互动中能实现的最大程度的平衡。只有重视体会才能培养出良好的社交直觉。良好的社交直觉有助于预判风险，免疫创伤。

A felt sense is not a mental experience but a physical one. Physical. A bodily awareness of a situation or person or event. An internal aura that encompasses everything you feel and know about the given subject at a given time—encompasses it and communicates it to you all at once rather than detail by detail.

Eugene T. Gendlin

体会不是一种精神体验，而是一种身体体验。它是对情况、人或事件的在身体层面上的觉知。它涵盖了你在特定时刻对特定对象的所有感觉和了解——它涵盖了它们，并立即将其传达给你，而不是通过各种细节一点一点地告诉你。

——尤金·T·简德林

关于聚焦理论，可参考文末相关资料。

2.9.2话语霸权与共识

我们应该以怎样的态度对待体会呢？这里补充一个侧面的理解角度。在文化人类学（Cultural Anthropology）中，原始社会宗教信仰被一些学者概括为“泛灵论”，即“万物有灵”。“泛灵论”是一个带有某种滤镜的概念，它是用现代语言构拟原始社会人类生活体验的产物，体现了一种“话语霸权”。当我们从人类学家那里了解异域文化时，我们常常会有猎奇者的兴奋感和上帝俯瞰众生般的优越感。但是当我们看到西方人类学者对于中国文化的研究分析时，

又常常会感到不适。究其原因，除了他们言辞间的傲慢，更重要的是“分析”本身对文化的活力与内涵的消解。在貌似严谨实则冰冷的各种名词与概念的解构下，充满了生命力的文化变成了一堆光怪陆离的碎片。对于原始社会的人来说，他们对自然的亲近与敬畏是生命的一部分，这种情感是无以言表的。正因为无以言表，才会用各种文化现象来表达它。他们的一切仪式无不流露出与大自然之间的深刻羁绊。随着社会发展，人们逐渐远离自然。在人们与自然的亲和感明显退化而又没有完全消失时，语言中才有了“灵魂”的概念。然后人们又反过来用这种已经成型的概念去描述去理解曾经那种难以表达的体验。但此时表达出来的，已经不可能是当年想表达的那个感觉了。曾经的体验已经随着时光一道远去，再也不会回来了（灵魂的内涵也在随时代不断迁移，今人所言“灵魂”内涵不同于古人，这种差异同样无以言表，只能靠有灵性的人自行体会）。我们对待自己的体会也应该有这种认识，我们在体会形成时可以守护它，但绝不要急于寻找解释，解释只会摧毁体会。人生的觉醒时刻（觉醒或称“开窍”，与“唤醒”不同，后者是严格的心理学概念）是命运赋予的宝贵礼物，我们可以给它取一个合乎其特征的名字，在以后慢慢回味它，但是在它到来时，请先用自己的全身心拥抱它。这种全心拥抱体会的意识状态就是“正念”。

当心理学家研究儿童的认知发展时，他们展现出了与人类学家相似的话语霸权主义。诸如“心智理论（theory of mind）”等概念虽然精致，对于体会儿童的心灵世界却没有任何帮助。以萨利-安妮测试（Sally-Anne test）为例，实验者通过被试对“萨利会去哪里找弹珠”的回答判断儿童处于自我中心阶段还是心智理论形成阶段。实际上，处于“自我中心”阶段的不是儿童，而是实验者。3岁以前的儿童对世界的探索活动具有很强的一般性。对于他们来说，所有一起玩的儿童都是一伙的，不分彼此。他们拥有无条件的默契（“默契”就是不言自明的隐性共识）。因此在被试儿童看来，萨利去安妮那里找弹珠是理所当然的事情。等他们长大了些，对周旋和博弈有了体会，理解了默契的条件性，学会了合理地“以己度人”，自然就可以正确回答了。创伤使儿童的发展陷入停滞，当同龄人已经在追求自我时，他仍在很大程度上处于无我状态，因此很容易沦为“工具人”的角色。他会体验到沮丧和空虚，但无法将这种情感命名，因为没有人和他共鸣，他的沮丧和空虚无法被看见。在很多儿童期创伤受困者

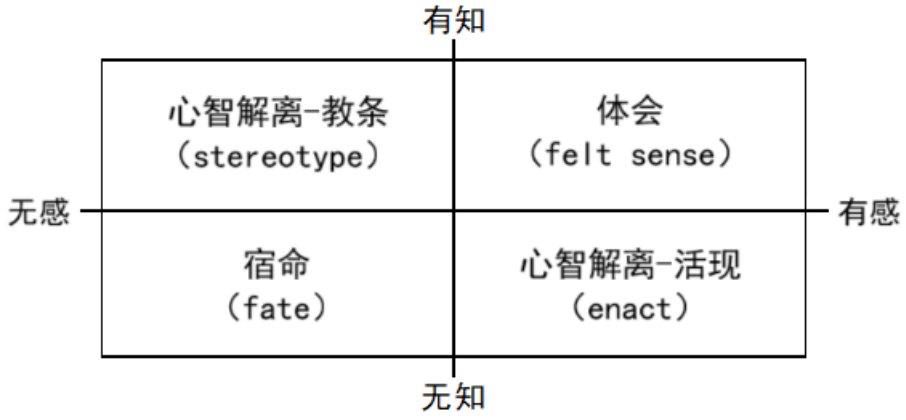
眼中，世界上除自己以外的所有人仿佛都是一伙的。那些人不费吹灰之力就能建立各种默契，自己则被排斥在世界之外。这种被孤立感成了他们的现象学世界的底色。为了自保，他们不得不将自己的情感世界与他人隔离开，在自己的小世界里自成一统。从此，任何观念上的分歧仿佛都是在破坏他心中的“共识”，任何有情绪色彩的互动仿佛都是在冒犯他的整个世界，这些都会激起他的防御。他将给他人留下“自恋”的印象。与自恋一词的字面含义相反，他的自我从未发展起来。他的“小我”和“大我”之间失去了连续性。

2.9.3体会与身心智关系

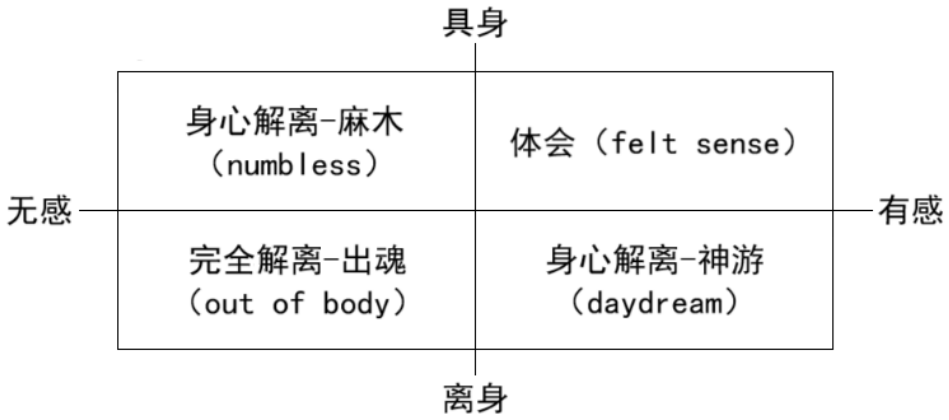
体会像一条线，串联起了身、心、智三个层面，又像一张网，把不同时期的不同经验整合在一起。

体会是主体调节自身微活动（身）的工具。体感疗法中的“重新协商（renegotiation）”必须经由体会完成。人的各种微活动虽然无法进入公共的话语空间（智），但是都可以被体会容纳。它们在体会之中逐渐发酵，最终完成心智化（mentalization），形成领悟（智）。只有经过充分的体会才能形成可靠的认知。正念和动中觉察都是为体会服务的，体会是自救者的核心能力。解离可以断开体觉（身）和情绪反应（心）的连接，把主体变成有感觉（身）而无感受（心）的人，而体会就是重建连接的最基本工具。主体如果无力培养自己的体会能力，就可能代偿出严重的微观管理（智）倾向。

心（感）智（知）四象限示意图：



身心四象限示意图：



因体觉或情绪反应的偏差所造成的注意力缺陷是不自觉的，由之造成的观点分歧在一般意义的社会关系中没有协商空间。最生动的证明就是某些中风患者存在的“单侧空间忽略”现象。因此，心理问题的确认需要各种关系的交叉验证，这为“创伤性重演”提供了动力。

2.9.4体会与表达

如果把体会比作主体看到的一个完整的场景，那么表达就是选取一定的工具和载体，采用一定的手法，按照一定的顺序将场景勾勒出来。

良好的表达可以促进体会，发展认知，使边体会边思考成为可能。对于心烦意乱的儿童，一种简单有效的教育手段就是强迫他用语言将自己的感受贴切地表达出来。在和聆听者对质的过程中，儿童的感受会逐渐变得清晰，认知能力也会得到发展。

许多受困者已经在相当程度上失去了和身体的连接，导致他们对“表达”的理解与常人有很大差异。这可以从他们的语言风格中看出来：他们的日常表达常常表现出如学术语言般的繁冗和精确，而不像生活语言那样简洁有力，富于感情色彩。这种繁冗而“无情”的表达会打断体会，使主体逐渐走神，转而妄想梳理出某种理论来解释刚刚获得的一点点珍贵的体会。体会的苗头刚刚冒出，就这样被扼杀了。学术语言往往抗拒有感情色彩的表达，这会掩盖体会之中的“情感动力”。对于日常沟通来说，表达的感情色彩和表达的内容一样重要，有些时候甚至只要读出言辞中的情绪就足够了。这些被掩盖的情感动力将导致寄生性紧张的不断积累。因此体感疗法更关注体会而不太关注表达。

2.9.5体会与自我倾听

前文从体觉入手讨论体会，这是一种自下而上的视角。如果换成自上而下的视角，体会可以理解为全身心投入的自我倾听或自我观察，只是这里倾听的不是一般的言语，而是全部感觉交织成的奇妙画卷。在最基本的体会层面，看见即是理解，理解即是释放。我们看见了一种感觉，也就意味着它不再是一种干扰，而是我们的一部分。体会自身冲动的灵敏有力是接纳感觉的起点，接纳感觉是自我接纳的起点。体会和精神交互作用是完全相反的过程，前者伴随着意识空间的不断扩大，而后者伴随着意识空间的急剧收缩。主体越能感受到自己与世界、与他人的情感连结，就越容易接纳自己的感觉和冲动；越感受到孤立和情感遗弃，精神交互作用就越容易发生。

体会的过程中脑海中必然涌现各种画面和念头，这些画面和念头对于体会有一定的提示和引导作用，但我们必须牢记体会的对象是各种微妙的活动而不是那些思考或想象出来的东西。

受困者身体僵硬，注意力受限。当要求他们倾听自己的身体时，他们不是感到一片空白就是完全局限于某个具体的刺激，因此需要更多耐心才能逐渐摸到门道。我自己摸索出的一个技巧是在椅子上坐好，用静音耳塞堵住耳朵，然而慢慢找到自己的心跳，仔细地倾听它。心跳的声音通过骨骼而非空气传导，因此耳塞不但堵不住它，反而能让它变得清晰。身体越放松，姿势越端正，心跳的声音和感觉就越清晰，越稳定。在心跳足够清晰稳定后，把呼吸的感觉也加进来。呼吸会带动身体起伏，当我注意到呼吸以后，身体的其他感觉也会很自然地被注意到，此时我能体会到深刻的平静。随着注意力越来越集中，各种感觉都会清晰起来，这是真正的专注状态。

当拥有敏锐倾听能力的自救者接受了认知行为疗法的基本训练后，一个“护航者”的内在角色就会逐渐觉醒，成为他们自救之路的第二位引路人。当主体直面过自己深层的痛苦后，他既会对自己的局限产生深切的同情，又会对自己的一系列过失感到深切的懊恼和自责。这种混合着自我同情和自责的强烈感受蕴含着巨大的能量，要仔细倾听这种体验流的扰动，不要随便用安慰打断它，“护航者”将在这些冲突能量的自发整合中诞生。

为什么安慰会帮倒忙呢？可以看下我们平时是怎样使用安慰的。很多时候，

安慰只是一种敷衍的艺术。它使我们能够体面地逃避关系，从而避免沦为自恋者的“血包”。如果我们想要与对方发展关系，就要抑制自己的安慰冲动，学会用心倾听（同理倾听）。当一个我们认为值得发展关系的人向我们倾诉他的创伤经历并感到自责时，他通常是想对自己的行为作出一个公平合理的评价，好让他在不切实际的负罪感和否认自身一切责任之间找到一个平衡点。自责的背后都有现实的原因，笼统地告诉他“这不是你的错，你已经尽力了”并不能起到安慰作用。因为责任不仅意味着压力，同时也意味着内在力量，草率的安慰卸下了他的责任，他的力量也被剥夺了。

这个觉醒的过程对于自救是绝对必要的，但它存在危险性，不可强求。如果无法胜任，建议寻找专业帮助。

2.10 序列化行为

2.10.1 序列化行为的概念

所有可观察的行为都可分解为一系列更加基本的行为或动作，也可看作更复杂的行为或动作的基本组成部分。所有行为（动作）都在一定程度上由前置行为（动作）驱动，同时又暗含了后续行为（动作）所需的驱力和倾向。当序列中每一个行为（动作）的全部驱力和倾向都由前置行为（动作）决定，而序列的起点由主体与交互对象的关系决定时，整个行为过程就无意识化了，此时我们就说主体与交互对象形成了“默契”，或者说主体形成了“习惯”。这样的行为（动作）序列通常会被主体看作自身行为的基本单元，可称为序列化行为。序列化行为如同一串鞭炮，点燃开头便会依次引爆，一旦引爆就必然全部炸完。系统性的序列化行为就是“肌肉记忆”。

2.10.2 序列化行为的建立与瓦解

绝大多数的序列化行为都是在意识中不被注意的角落里建立的。少数序列化行为是主体在有意识的学习过程中，对特定的动作序列（包括已建立的其他序列化行为）经过反复探索、尝试、拆分、重组和微调，逐渐摸索出了某种“诀窍”或者说“找到了感觉”，最终无意识化而形成。这个“找感觉”的过程越顺利，

耗费的认知资源越少，主体就越容易给人以聪敏的印象。能够顺利找到感觉，除了可能是因为主体积累了特定领域内的较多经验外，往往是因为他们的身体具有良好的活动性。良好的活动性与互动平衡的注意力品质相协调，使身体能够根据情境的需要随时涌现出各种序列化行为而无须像受困者那样总是有意识地控制自己的身体而显得极为笨拙。

一般地，找感觉的过程可概括为：放松（静下来）→为手头的事活跃起来（忙起来）→找到打动自己的地方作为切入点（找感觉）→进入状态。找感觉的过程就是探索的过程。如果找感觉的过程陷入了僵局，主体就会陷入一种坐立不安、心神不宁的慌乱状态，这种状态就是焦虑。焦虑影响了感觉的品质，可能使找感觉变得更加困难，主体也就更加无所适从。焦虑与感觉品质退化的循环一旦建立，焦虑就具有了强迫性，焦虑障碍就形成了。

有意识地建立的序列化行为有很强的韧性，而下意识形成的序列化行为往往因情随境迁而很不稳定。对于下意识形成的序列化行为，如果被某种外力强行中止，主体可能突然陷入不知所措的境地；如果触发序列的条件发生改变，这些下意识形成的序列就可能瓦解。比如有的焦虑障碍患者会患上“吞气征”，原有的吞咽动作序列因受到过度觉察而被破坏，食团与口腔肌肉失去了默契，以前的“感觉”再也找不到了，患者在吞咽食物的同时会强迫性地吞入大量气体，然后因腹压过高而反复嗳气，十分痛苦。对于普通人，吞咽具有调节植物神经系统的神奇功能，人们可以通过饮水调节紧张状态。吞气征使人丧失了这种调节能力，使焦虑障碍雪上加霜。又比如“于右任放胡子”的故事，同样因为自我凝视破坏了契合动作序列的行为条件和心理条件，导致夜不能寐。还好于老很快领悟了“顺其自然”的真谛，找回了感觉。

2.11 条件反射

2.11.1 条件反射的序列化解释

条件反射的建立过程也可以用序列化行为的形成过程来理解。条件反应可以看作以非条件反射为核心构件形成的序列化行为，条件刺激可以看作契合序列化行为的条件中的显著成分。以巴甫洛夫实验为例，食物刺激口腔引起唾液

分泌，这种默契是由进化历程中长期稳定的契合发展而成的一种“硬连接”。当狗第一次听到铃声时，体验流的扰动（维持平静的交流圈和回应刺激的交流圈发生冲突）使它进入应激状态，它感受到了“惊讶”并变得警觉，同时激活所有感官通道以仔细辨别环境中的可探索对象，然后它就在身体层面上感受到（而不仅仅是“意识到”）了铃声与食物之间的关联。随着它对这种关联的应对愈发熟练，它在听到铃声时就可以完成接触食物的准备（也就是所谓“预测”），引起唾液分泌，从而最大程度提高接触、咀嚼和消化食物的效率。

主体的应激反应越强烈（感到的惊讶越强烈），条件反射就越容易建立。条件反射的建立过程可分为“震撼”与“重复”两类。对应到创伤的形成过程，就是“急性压力事件”和“反复摧残”。

2.11.2 情绪闪回

条件反射总是伴随着一定的情绪波动，如果一种条件反射以剧烈的体觉变化和唤醒水平波动为主要内容，那么这种条件反射可称作“情绪反射”。其中的情绪反应称作“情绪闪回（emotional flashbacks）”，条件刺激称作情绪闪回的“触发器（triggers）”。一般意义上的“闪回（flashbacks）”除了包含这些强烈的情绪成分，还伴随着想象碎片或记忆碎片的唤起。在 PTSD 的治疗中，常常区分“闯入（intrusion）”和“闪回”，前者来自想象而后者来自记忆。与 PTSD 的情况不同，对于受困者，这些想象或记忆的真实性已经很难核实，因此本文不会刻意区分“闪回”与“闯入”，将之统一称作“闪回”。比起带有想象或记忆碎片的闪回，单纯的情绪闪回由于相关的情节记忆已经丢失，因此更加难以识别和处理。这些失去相应情节记忆的情绪闪回意味着主体虽然已经在认知层面上忘记了这些创伤的故事，可在身体层面上却从未忘记。这些受困者往往已经习惯了情绪闪回对活动能力的限制，把它们看成了自身本能的一部分。

对创伤免疫者来说，闪回的体验和当下现实的冲突可以使他们意识到情况已经发生变化，这是一个整合自身历史、校准自身状态的机会。对创伤易感者来说，情绪闪回会阻断主体的体验流，破坏主体与现实的互动，导致想象知觉无法在现实检验中得到更新。因此除非有一个可靠的支持者帮助主体在情绪闪回被触发时保持清醒，否则情绪反射很难像一般的条件反射那样自行消退。心

理治疗师在一定程度上承担的就是这种支持者的角色。在自助治疗中，需要主体自己借助第四章中的技巧在闪回被触发时稳住自己。

强烈而频繁的情绪闪回可造成植物神经紊乱，从而形成各种躯体症状。

2.11.3 广场焦虑反射

这是情绪反射的一个实例。某些受困者只要一摆出抬头挺胸等比较挺拔的姿势就会感到心里发慌头脑发懵，一到人员密集场所就情绪激动，被焦虑、恐惧或亢奋淹没。这些表现与广场恐惧症相似，但强度不及后者，可称为广场焦虑反射。创伤经历使普通的生活情境失去了原本的温和意味。受困者面对扰攘的人群，犹如面对满地的蟑螂，满树的知了，满山的野兽，只感到焦躁甚至恶心，这种不合常理的反应使受困者难以接受并回应他人的善意。当情境被摆脱之后，焦虑随着解脱感（松弛反应）而转化为窃喜。这就是一些受困者令人感到莫名其妙的焦虑-欣快循环。它是抑郁-躁狂循环的弱化版本。

2.11.4 创伤的微妙化与显著化

基于谱系观，本文不使用“内”与“外”这种有分裂色彩的划分方式。

当闪回因为失去相应情节记忆而发展为情绪闪回后，主体就会把这些极端反应看成自身性格的一部分。创伤会成为一种底色渗透进主体的一切活动中，此时主体就完成了对创伤经历的微妙化（类似于内化）。

序列化行为的触发在瞬息之间，即使主体时刻保持正念状态也难以及时觉察。主体虽然能识别出创伤给自己带来了怎样的困扰，但很难定位到具体的情绪反射，更难捋清楚它的来龙去脉。但这不代表他们就不能识别自身的情绪反射并找到隐藏在背后的创伤了。首先，CPTSD 的创伤经历总是在以各种不同的方式在受困者身上反复重演，并不是非要找到其中最初的创伤性事件不可。其次，我们可以通过“聚焦”，体会到情绪反射的内涵，从而给它赋予一定的意象，让难以名状的感受得到确认和解读。

为情绪闪回找到情节上的归宿的过程就是显著化（类似于外化）。显著化不一定意味着还原最初的创伤事件。对于 CPTSD 来说，显著化的结果很可能比真实的创伤事件更具社会性、更笼统和更抽象。前文论述广场焦虑反射时，主

体意识到自己面对人群的体验与面对蟑螂是相似的，自己曾经见识过兽群般的人群，这为显著化提供了线索。恰如其分的显著化离不开微妙而深刻的体会和安全情境下的充分活现（enact）。显著化服务于创伤叙事的解构和重构。在对创伤经历的深切体会中，羞愧和屈辱的叙事将最终被重构为尊严和美德的叙事，融入个体的人生叙事之中。

2.11.5 创伤性重演

CPTSD 的创伤经历总是在以各种不同的方式在受困者身上反复重演，这种“创伤性重演”是创伤外化的一种形式。

如果个体在压力事件中体验到了同心协力，那么他们在战胜困难以后的空闲时间可能会尝试扮演事件中的不同角色，以此巩固经验，这就是玩耍性重演。玩耍性重演通常具有一定创造性，很多集体仪式都起源于各种玩耍性重演。如果个体在压力事件中感受到了孤立、遗弃和无法排遣的恐惧，就可能发展出创伤性重演。如果个体在重演中扮演了加害者的角色，意味着他在反问这个世界：“这难道不过分吗？”如果他在重演中扮演的是受害者的角色，意味着他在寻求被看见，被救助。在一次重演中，个体可能在加害者与受害者的角色之间快速切换。创伤性重演由闪回直接驱动，个体在创伤性重演的当时往往缺少自觉，但由于创伤性重演总是遵循相同的“剧本”，缺少灵活性，善于记录的人可以在回顾中发现问题。书面表达是重要的自助工具。

2.12 身心状态

基于整合的身心观，可以通过与“体态”或“姿势”相类比，将身心状态形象化。每一种活动都需要依托一定的身心状态，正如所有的行为都需要依托一定的姿势。身心状态限定了身体牵张反射的总体模式和感知觉的基调，也就限定了主体在面对挑战时可选的应对方式。

2.12.1 习惯状态与最佳状态

主体在从事某类活动时的一般心境和体态就是他的习惯状态，最佳活动品

质所要求的心境和体态就是最佳状态。习惯状态与最佳状态往往存在一定偏差。例如写字有公认的最佳执笔姿势，在最佳姿势下才最容易把字写好。每个个体都有自己的习惯姿势，虽然不一定最佳但也能凑合。如果他们想突破自我写出好字就必须改变自己的习惯姿势，这意味着要暂时丢掉流畅感（在这里可理解为掌控感和熟悉感），短时间内书写能力可能明显退化。

2.12.2 中立状态

中立状态（即“平静状态”）可与解剖学中的“中立位”或日常活动中的“站姿”相类比。中立状态的品质可以通过整合性的知觉被观察者感知，人们习惯上称之为主体的“气场”。气场能够体现出一个人的心理韧性和情绪成熟度。

中立状态意味着良好的兴奋度和应激性，体现为放松而灵便的体态和安宁而警醒的心境，是一种微妙的不稳定平衡。维持中立状态所需要的唤醒水平（能量水平）就是个体的最佳唤醒水平（最佳能量水平）。当主体的认知陷入混乱时，首先要回到自己的中立状态，然后才能重启探索活动。当主体想要理解他人的想法和感受时，也必须先回到中立状态。中立状态与互动平衡密不可分。

个体的应激过程是体态和心境受到扰动（产生压力，积蓄能量）后重归平衡（消解压力，释放能量）的过程，也是形成体会、获得领悟的过程。体会形成的过程就是各种冲动以特定的身心状态为中心不断冲突、交融、消解和升华的过程。

一些心理治疗理论将中立状态表述为“活在当下”。

2.12.3 中立状态的养成

主体养成中立状态的过程与主体学会稳定站立和灵活走动的过程基本同步。健康主体的心理活动能力总是能够与身体活动能力同步发展。

当婴儿被陌生人抱起时，身体往往会突然变得僵硬，这是一种对抗风险（不确定因素/未分化意识对象）的应激反应。当婴儿趴在母亲怀中时，身体就会变得柔软而有活力。婴儿能够从母亲平稳而富有节奏的呼吸和心跳中感受到

最深刻的平静和无所不能的力量。这种深度放松的状态是建立情感连接的最基本条件。对于婴儿来说，放松同样意味着脆弱。婴儿在放松状态下无力应对任何风险，必须借助养育者的力量方能存活，因此他们会十分谨慎地判断是否应该放松。婴儿通过感受养育者的生命力滋养自身的生命力，与养育者的情感连接使婴儿在精神上能够逐步学会“站立”，从依靠养育者维持中立状态逐渐过渡到自我维持。婴儿与养育者建立情感连接的过程就是“依恋关系”的建立过程。如果主体无法与养育者形成安全的依恋关系，他可能终其一生都无法明白中立状态的感受。

2.12.4 自我安抚

婴儿在与养育者发展依恋关系的过程中不仅可以养成中立状态，还会习得在强烈的应激反应后快速回归中立状态和在强烈的应激反应中保持灵活的能力，这就是自我安抚。

所谓安抚，就是在体验流发生扰动的第一时间肯定主体唤起的情绪，提示主体本次扰动与以往的不同。安抚是一个极为微妙的过程，发生在体验流受到扰动后的第一时间。在体验流的扰动-安抚-整合的无限循环中，个体的活动模式不断发生微妙的变迁，个体的适应能力也随之发展。儿童自我安抚的能力是在和养育者发展依恋关系的过程中逐渐建立的，因为只有全身心投入的养育者才能满足安抚对时机的严格要求。如果个体天生身体素质异于常人，他在活动中的各种异常体验无法被养育者注意到，他的自我安抚能力就可能无法得到发展。

比如一位来访者正在治疗师的提示下练习正念冥想。来访者刚刚进入状态，房间外传来了路人的争吵声，他被争吵声触发了焦躁情绪，身体开始变得僵硬。咨询师意识到这对来访者是一种挑战，他立刻温柔而坚定地提示来访者感受一下身体和周围的空间，然后再注意一下周围的声音，觉察自己对这些声音的抵触，让这一切自由来去。来访者从治疗师的提示和见证中“发现”了自己身上正在发生的活动，知道了这些情绪和身体反应都是正当的。他突然意识到这些吵闹声与自己往常受到的指责不同，它们并不能伤害自己。他的身体会立刻恢复放松，心境也会更加警醒。来访者切分了两种抵触：一种是身体对这些声音

的抵触，这是自然的应激反应。另一种是自己对这种抵触的抵触，这是自己在适应压力的过程中形成的习惯。治疗师精准地抓住了这一瞬间，让来访者看到了这个习惯的局限性，学会了信任自己的本能。来访者不但没有因此而分心，反而更清醒、更专注了。合格的治疗师对来访者身心状态的觉察必须达到一名尽责的养育者的水准。

2.12.5 内在声音

自我对话能力是自我支持能力的重要组成部分。面对一时无法摆脱的困境，内心的声音会帮助我们稳住自己，告诉我们如何在困境中伪装、周旋和摸索。如果没有这种声音，我们很快就会陷入无助。内在声音是对我们所受人格教育的内化，可以视作我们的“内在父母”。一个平衡而整合的内在声音像一个锚，使我们的身心状态不论受到了多大冲击，最终都可以回归中立状态。健康的内在声音总是能清晰而平和、坚定而富有同情心地道出事实，而受困者的内在声音常表现出过度纵容、过度苛刻或喜欢打岔的特点。

2.12.6 躯体记忆、直觉和依恋

大部分人理解的记忆（memory）是指自己的人生故事（自传体记忆）。2岁之前的我们不是没记忆，只是不会讲故事。2-3岁的我们虽然多少有了一些人生故事，但它们很容易被日新月异的生活经历冲淡而被快速遗忘。个体和养育者对感受和需要的早期沟通直接通过行动完成，身体语言是这一阶段唯一的语言。相应地，早期记忆主要以序列化行为和情感模式的形态存在，缺少可讲述的情节。没有可讲述的情节并不意味着这些经历不会影响个体，相反，正是这些沉默的记忆决定了个体的经历在多大程度上是可体验、可注意、可加工的，决定了个体更擅长以怎样的方式组织记忆、唤起记忆，决定了个体会形成怎样的语言，会怎样理解语言。它们以最基础的方式构筑起个体的人格，决定了个体对正常与否、安全与否、可靠与否的直觉，奠定了个体的情感底色。

个体和养育者的早期互动之所以如此重要，在于它直接关乎个体的生死。很少有动物像人类这样，在出生时像玻璃丝一样脆弱，却像水一样拥有近乎无限的可塑性。婴儿对养育者的这种关乎生死的依附性就是依恋（attachment）。

依恋关系是一切互动的起点，也是意识对象分化的起点。对于婴儿来说，养育者就是社会（世界）的全部。个体将通过依恋关系建构自身与社会（世界）之间最基本的心理羁绊，建构自己在探索中获取安抚和支持的底层逻辑，学会和自己身上的不随意活动（情感活动、反射活动、生物性节律等）相处。依恋关系决定了婴儿的生死，而个体与社会支持系统的关系决定了个体能否在社会上立足。理解依恋的关键在于理解这种心理羁绊的原始性、奠基性和致命性，它和具体的人与人之间的爱慕或牵挂不可同日而语，和一般意义的教育或驯化也不可同日而语，不要随便把依恋关系类比为亲密关系，也不要把不安全依恋简单类比为心理创伤。

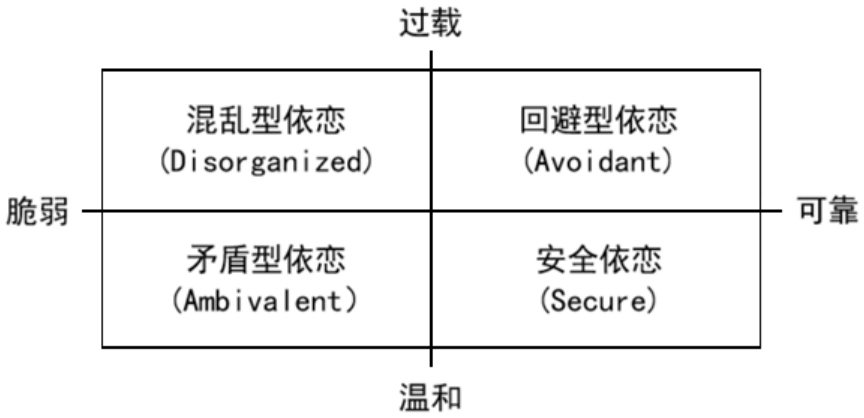
2.12.7 依恋关系与交流圈的品质

对于常人来说，交流圈是可靠而温和的。可靠意味着没有无意义的交流圈，温和意味着任何主体都有能力承载一切交流圈。发生在依恋关系中的互动是个体最早期、最重要的互动。这些互动会在根本层面上塑造主体对交流圈的体验。

想象你是一名外科医生，现在必须为病人做手术。然而此时有人告诉你手术室里的电子仪器随时可能失效，然后又可能自动恢复正常。失效与恢复可能存在某种规律，但没有人知道。你会是什么心情？那些无法感受到交流圈的可靠性的人就是终日沉浸在这样的情感底色里。

想象你即将开始为病人实施手术，突然发现所有的电动工具的输出功率都是你能控制的功率上限的 10 倍，你会是什么心情？那些无法感受到交流圈的温和性的人就是终日沉浸在这样的情感底色里。

依恋关系可以根据主体在可靠性和温和性两个维度上对交流圈的体验分为四种类型：安全型、矛盾型、回避型和混乱型。四种类型的关系如图所示：



2.12.8 情感底色

情感底色是现象学世界的基调。我们对自身或他人行为的解读会不自觉地带上这种基调。消极的情感底色会限制生活经验的扩展，使主体成为创伤易感者。如果个体在互动中没有尽力理解他人的内心，而是任由自己的情感底色支配互动， 投射（Projection）就会发生。比如，内心总是怀有羞耻感的父母会经常苛责孩子做错了事情。仿佛孩子和他们一样，行为中充满了偏差。

人们一般注意不到自己的情感底色，正如常人一般注意不到自己的中立状态。只有当某些因素使他们的情感底色受到剧烈扰动（比如陷入了抑郁状态或者收获了“灵性体验”）时，他们才能意识到情感底色意味着什么。

深夜，你独自醒来，世界一片寂静，四周一片昏暗，只有从窗帘的缝隙间透入的一点微光。白天的纷纷扰扰都被放在一边，身体的能量来到了一天当中的最低点，意志对感受的压抑也有所减弱。你静静地躺在那里，仔细体会着自己的感受。这时候的感受就代表了你的“情感底色”。

在这种情境下，有的人会感受到神圣的静谧，有的人会感到跃跃欲试的兴奋，有的人会感到焦躁不安，有的人会感到莫名的悲伤，有的人会感到无助和恐惧，有的人会感到麻木和空虚，有的人甚至会产生神秘体验，比如感到有人在盯着自己。如果一个人的情感底色以无法解释的消极情绪为主，通常意味着创伤的存在。如果我们用正念充分抱持这种情感底色，就可以唤起闪回，闪回的内容提示了创伤的性质。如此我们就得到了一个和自己内心对话的机会。如果一个人的情感底色以麻木空虚为主，有可能意味着他在成长过程中受到了大量的情感忽视。

CPTSD 可以根据情感底色区分为不同的亚型。例如以躁狂为底色的 CPTSD 时常表现出类似自恋型人格障碍（Narcissistic Personality Disorder）的特点。以孤独和抑郁为底色的 CPTSD 时常表现出类似自闭症谱系障碍的特点。

中立状态下的情感底色反映了主体与世界之间最基本的情感连接。这种最基本的情感连接就是安全感。安全依恋是安全感的根本来源。受困者偶然回归中立状态时，往往会有一种如同回归母亲怀抱般的灵性体验。

2.12.9 情感遗弃与情感忽视

情感遗弃（emotional abandonment）是指个体在情感上被重要他人（如父母、伴侣）忽视或拒绝，导致其情感需求长期得不到满足，造成心理创伤。这种遗弃可能表现为情感上的冷漠、缺乏支持或持续的贬低。

情感忽视（emotional neglect）特指儿童在情感层面受到的养育者的忽视。它远比情感遗弃微妙得多。它是树木本该长出而从未长出的枝丫，是家庭照片背影中的空白，是那些在成长历程中本该如呼吸一般自然发生却从未发生过的最普通的日常细节。这些养育者与被养育者往往深爱着彼此，但总感觉哪里不太对，直到他们在专业治疗师的抽丝剥茧下才发现了这一潜藏在成长过程中的致命问题。

类比显著活动与微活动的关系，情感忽视也可定义成微情感遗弃。有关情感忽视理论的权威信息，可参考文末乔尼丝·韦布（Jonice Webb）的著作。

2.12.10 中立状态的意义

中立状态为受困者的自救点亮了一座灯塔，照亮了他们混沌一片的现象学世界，使深入全面的探索变得方便。找到中立状态绝不意味着康复，主体不应该沉醉于这一点点“觉醒”之感，否则就掉进了新的深渊。中立状态绝非治疗的终点，就像学会站立并不是成长的终点。相反，它是主体走向世界的真正起点。

中立状态帮助我们在身体创伤与心理创伤之间建立起系统性的类比，使心理创伤形象化，有助于激发自救者的创意和灵感。

受困者在身心状态发生显著变化时往往感到各种不适，正如伤者的病痛总

是会在身体姿势变化时加重一样。受困者会强迫性地保持某种不良的身心状态，正如伤者会强迫性地保持某种姿势。我们可以在缓慢而细致地调整姿势（状态）的过程中识别出问题所在，从而加以针对性处理。

通过将身心状态与身体姿势相类比，受困者可以形象地了解到身心状态在活动中的变化就和身体姿势在运动中的变化一样，是值得注意而无法刻意干预的过程，这种变化正是我们自身活力的体现，干预反而会使主体变得僵硬。主体承担起了在特定状态下的责任，完成了该完成的活动，状态自然会实现转换。

2.12.11 身心状态的划分

身心状态的划分和命名可以采取两种方式。

在主体间叙事下，可以基于整合的身心观，通过相匹配的意识状态来划分身心状态。例如 3.8 节所使用的“学习状态”“日常状态”“对抗状态”“孤独状态”等。

常人的身心状态以日常状态为主轴，在学习状态和对抗状态之间自由摆动，显得十分灵活，而受困者很容易卡在某种异常状态。如果一个人的身心状态在常人视角下飘忽不定，行为表现越少“意图”，让人没有头绪，那么这些状态很可能只是某种异常身心状态在包装后的表象。

习惯怀疑状态的受困者总是在怀疑伙伴或者自己的可靠性，他对互动中的任何偏差都极度敏感。面对他人的信任和支持，他只能做出礼貌性的回应，缺少细腻而真实的触动，甚至可能怀疑这些信任意味着麻烦将至。在他的体验里，展开自主探索和维护支持系统是互斥的而非互相支持的，仿佛任何自主探索都会给支持系统造成麻烦。他对人际关系中的信任存在不切实际的期待，总是落空的信任可能使他寄希望于通过极抽象的互动方式维持情感连接，替代自主探索。这样的受困者容易给人留下神神叨叨的印象。

习惯孤独状态的受困者寄希望于通过纯粹的探索获取情感支持。对情感支持的客观需要使任何人都可能受到他的依赖，同时也成了任由他探索的“玩具”。这样的受困者容易给人留下爱管闲事、爱冒犯他人的印象，他们很容易因毫无防备地受到各种攻击而发展出复杂的创伤化表现。

习惯伺机报复状态的受困者的注意力总是在不重要的地方四处游荡，仿佛

随时准备躲避或者报复那些可能看自己不顺眼的人。他害怕亲密，同时又害怕被抛弃。他攻击性很强，同时又极易崩溃。这一般是因为养育者自身存在严重的心理问题，他们的恐惧、怨恨和焦虑侵入了和婴儿的互动过程。这样的受困者容易被视为患有 ADHD，他在建立依恋关系的过程中就已经创伤化了。

这三种状态同样不是简单的并列关系。习惯怀疑状态的人少有其他两种状态的表现；习惯孤独状态的人多有怀疑状态的表现，少有伺机报复状态的表现；习惯伺机报复状态的人常有另外两种状态的表现。随着生活经验的积累，受困者可以模仿常人，表现出日常状态的特征，但如果仔细观察就会发现他们随时处在濒临崩溃的状态。

在主体-世界叙事下，可以基于唤醒水平与活动性的相互关系划分身心状态。

基于唤醒水平与活动性划分的身心状态（命名方式为“身-心”）示意图：



在这种划分方式下，唤醒水平越高的状态越不可持续，活动性越高的状态越不容易达到。只有情绪智力极佳的人才能长期维持中立状态和拼搏状态。如果身心状态的转换过于迅速，各种神秘体验就可能出现。好比我们在快速变换身体姿势时，会体验到短暂的超重感和失重感。

2.12.12 身心状态视角下的自助

受困者对“日常状态”的理解和常人存在很大偏差。当他们“努力”做一件事时，其实在强迫自己的大脑往错误的方向使劲儿。当他们放弃这种努力的时候，大脑反而可能回归正常。这就像一位缺少专业素养的健身教练强迫学生作出违反人体解剖学的动作，这不仅会让学生产生挫败感，长此以往，它终将在解剖学层面上损伤自己的肌肉和骨骼，这无异于自毁。一部分人的心理问题之所以会发展为精神问题，很大程度上是过于勉强自己以致高级皮层被极端神经冲动“击穿”的结果。

不论创伤多么复杂，多么严重，在最简单、最原始、最微妙的层面上，受困者的应激反应仍然具有健康完整的形态。只要我们用心体会这些基本应激过程传出的信息，就能找到那些导致身心状态异常的病态因素。在消除病态因素的干扰之后，身心状态会自发向中立状态回归。这是心理自助的根本前提，也是心理问题和精神问题的根本区别。

本文仅适用于以 CPTSD 为主的一般心理问题，不适用于涉及精神问题（尤其是重性精神障碍）的情形。涉及精神问题的治疗请遵医嘱。

3 病理论述

3.1 应激

与 2.6 节对应，本文从应激与压力两个方面理解 Stress。应激可以理解为“对刺激的反应（身）”和“对压力的适应（心）”。个体的心理素质与身体素质统一于应激过程。

3.1.1 应激与应对

应激与应对是同一过程的两个侧面。应激强调反射性，应对强调能动性。成长的过程就是利用能动性调节反射性，再用反射性发展能动性的过程。在自助语境下，刻意强调应激与应对的区别没有意义。它们都是主体在平衡状态被打破后（或体验流受到扰动后），利用剧烈提升的唤醒水平所提供的能量，完成应对、恢复平衡的一系列非特异性过程。所有完整的应激（应对）过程都以恢复平静、发展适应为终点。

一个完整的应激过程不仅需要身心整合，也需要主体间的协调。主体的认知资源和外部支持越匮乏，应激过程对主体自身生理调节能力的要求就越高。如果主体缺少认知资源和外部支持，而身体又过于虚弱，用于维持应激状态的体能就很容易快速耗尽，使应激过程在僵局中无疾而终。如果套用塞雷（Hans Selye）的三阶段压力响应模型（GAS）进行描述的话，就是说完整的应激过程还没完成，机体对压力的阻抗就已经进入了耗竭阶段，主体的身心状态因而无法恢复平衡。这会在微活动层面上破坏主体承受与应对压力的能力，使主体在正常的应激过程中越来越多地感受到各种“拧巴”，自身的活动性受到越来越多的限制。原本中性的应激反应开始掺杂越来越多的消极情绪，好奇逐渐被恐惧取代。长此以往，主体必将发展出 CPTSD。CPTSD 意味着各种相互交织的悬而未决的应激过程。

一个人在活着的每时每刻都在应对着各种压力，即使在平静状态下，应激也在微活动的层面上不断发生着。仿照驱力的划分方式，应激也可分成维持基本唤醒的应激和应对显著失衡的应激。创伤性事件起初可能是作为挑战（急性）

或折磨（慢性）出现的，但它们最终影响到的都是维持基本唤醒的应激。应激障碍只有在强烈的应激状态下才能充分暴露，从而在公共的话语空间中得到有意义的认知加工。体感疗法关注的就是如何让主体安全地接近（即“滴定”）并保持这种强烈的应激状态（即“正念”）而免于失控，进而识别并完成长期悬而未决的应激过程，最后在认知层面上将创伤的故事整合进主体自身的生命进程中。可见，体感疗法关注的是应对显著失衡的应激，下文所述应激如无特殊说明，指的都是这种应激。要想将创伤的故事充分整合进主体的生命历程，完成应对的过程就不可能简单粗暴，有效的心理治疗实际上培养的是我们与压力“周旋”的能力。

一次完整的应激过程可概括为：受到冲击→惊讶（伴随着踉跄、震惊等体验）→定神→探索→应对→冲击被消解。常人会在短暂的踉跄后迅速站定并唤起能量准备反击，但已习惯自我凝视的受困者花了太多精力在体会恍惚感上，甚至能从恍惚中品出醉酒般的舒适感。由于定神和释放攻击性的过程无法完成，受困者的应激过程可能长期卡在未完成状态，从而形成心理创伤。对于常人，踉跄与震惊可以立即使主体进入应激状态，然后集中注意于探索并作出反应，因此唤醒水平的波动更多被感受为兴奋或警觉而非恐惧。

3.1.2僵直

本文所述僵直不单指由于极度紧张而造成的全身僵硬、动弹不得的状态，而是包括了从灵活性的轻度下降（紧张）到极度僵直（冻结）的连续谱系。压力的强度越大，持续时间越久，造成的僵直就越显著。僵直是一种力不从心的状态，意味着探索陷入了僵局。僵直被体验为笨拙感、脆弱感和恐惧感。僵直虽然使探索变得困难，但使简单粗暴的对抗变得容易。在理想的应激过程中，主体的各种行为在僵直到达极点时刚好收敛于最简单、有力、准确的反应。

僵直也是一种代偿反应，它使我们的肌肉在某种程度上成为了身体的“盔甲”，在无法明确压力性质的情况下使身体对冲击具备一定的抗性。应对能力发展程度极低的个体甚至会潦草地用僵直应对一切冲击，这种现象可称为“习惯性僵直”。习惯性僵直意味着主体丧失了“勇气”，他的应激反应将被恐惧感主导。持久性僵直和习惯性僵直必然导致活动能力退化，也就是“僵化”。

当一个对象使你感受到了全方位的冲击，而你既不能释放攻击性以完成对抗，又不能沉住气仔细探索时，你就会陷入僵直并体验到恐惧。比如你站在一块陌生的悬空钢板上，你不敢释放对抗冲动，因为这可能使情况更加危险，你也不能完全沉住气，因为你并不知道钢板有多可靠，它可能随时断裂或脱落。笨拙的状态是一种专注而吃力的探索状态，此时的主体极为脆弱，抵御伤害的能力很差。能够在这种“脆弱状态”下提供支持的人会被主体识别为朋友，使脆弱状态更加脆弱的则会被识别为敌人。

想象你是一个孩子，见过类似篮球的东西，但从没打过篮球。你正在缺少显著可信对象（例如母亲）守护的情况下探索环境，突然注意到一颗篮球迎面飞来，你感受到了它的视觉冲击。此时你的身体会根据过往对相似物体的一般印象与之产生微妙的互动，就好像球还没到但你已经在某种程度上被撞了一样，这是一种“想象知觉”。你可以根据这种知觉评估出球的力量与速度和你自身承受能力与反应能力之间的关系，感受（而非分析）它可能带来的伤害，并准备作出反应。在你感受到这种想象的被撞击感的同时，身体的牵张反射也使你感受到了自身对抗冲击的潜在力量，就好像你将不倒翁推离平衡位时感受到的阻抗那样。因此，这种视觉冲击也可以看作一种邀请，邀请你感受并释放出自身的力量。这种想象的被撞击感和真实的撞击一样会唤起你的应激，使你感到“惊讶”，此时你便处于定神阶段。

定神完成得越快，主体的适应能力就越强。如果定神无法完成，唤醒水平就会不断提升以尝试唤起更多身心资源。如果身体始终无法涌现任何可供选择的行为冲动（或者说准备好与这种冲击相契合的动作序列），主体就可能出现僵直并体验到恐惧。此时可信对象的作用是至关重要的，它可以指导主体作出更深刻的契合自身反应能力的切分并作出契合于待探索对象的有效反应，在高唤醒水平下勉力完成探索，这对于发展主体的应对能力十分重要。定神完成后，你将完成探索（学会有效地接球）或者发起战（慌张地、甚至带着怒意格挡或弹反）或逃（逃脱）反应，应激完成。主体如果无法确认可探索对象与可信对象（可信对象属于自身资源的一部分，属于主体的扩展）之间的关系，就无法完成探索，无法切分出与自身反应能力相契合的意识对象。如果对意识对象的切分遭到了可信对象或自身认知图式的否定（比如信赖者就是加害者），主体

就可能陷入恍惚。

恍惚是切分困难的信号。如果主体始终无法定神，就只能倒下（崩溃），甚至是顺应被撞击的想象知觉（也就是倒下的冲动）而主动倒下。换句话说，他在被球真正撞到之前就已经屈服了。提前屈服使他的恐惧感免于发展到天崩地裂般的程度，而代价是他的应对能力根本得不到发展。长此以往，所有相似的急性压力事件都将唤起他的恐惧与退缩，他的探索能力将趋于崩溃。恐惧并不是终点，当屈服越来越熟练，越来越“及时”，他将不再能体验到危机感和恐惧感，他的应对能力衰竭了。他不再能区分“邀请”与“侵扰”，既无力独自对抗危机，又不能回应别人的支持，恐惧发展成了习得性无助（learned helplessness）。

愤怒与恐惧相拮抗，切分完成后，恐惧就可能转化成愤怒或其他更复杂的情绪。恐惧感越强，转化出的愤怒感也越强。情绪之中的能量随着攻击性的释放而得到消解。

3.1.3 应对能力的发展

你在可信对象的示范下亲手拍了拍球，感受到了球的分量和质感。你先尝试了几遍近距离的抛球与接球，又试了几遍激烈快速的抛接，动作的优点和缺陷都得到了可信对象的及时反馈。你意识到自己只要保持冷静，完全有能力接好。而且自己绝不仅仅只是接球的角色，自己也可以抛球给别人，别人也会很痛快的回应自己。有了这些经验，你就不会轻易把飞过来的球看作对自己的袭击了。注意力也会更多地放在球的运动上，而不再过度关注自己的情绪和反应。这是典型的发展应对能力的良性过程。

受困者只擅长低唤醒水平下的探索。高唤醒水平下需要信任感官和本能并恰当地依靠援助，充分的认知加工是来不及的。受困者并不懂得如何信任他人，因此很容易感到恐惧并为自己的失态和笨拙感到羞耻。

在高唤醒水平下保持探索，可类比为落水之人拼命抓住一切可抓住的东西，努力维持自己的平衡而不仅仅只是使劲扑腾。主体在这种情形中放下了一切自我抑制，充分信任自己的感官和本能。主体如果能放下有毒的极端羞耻感，就有机会察觉他人的善意，甚至会发现自己慢慢能够感受到别人的性格而不再局

限于无穷无尽毫无规律的行为细节。

主体在高唤醒水平下的探索可看作对低唤醒水平下的探索的压缩。主体如果在低唤醒水平下总是表现出非常舒缓细腻的风格而缺少干练的表现，那么在高唤醒水平下的探索就更容易出现恐惧与僵直。

如果每次战或逃反应完成的质量都很差，主体在急性压力事件结束后总是处于心有余悸的状态，这同样意味着应激过程没有完成。主体在多次重复这样的经历后也会习得异常的情绪反射。

受困者在生活中的很多时间都处于“脆弱状态”，环境对于他们来说可信度太低了，这限制了他们对可探索对象的探索。当他们表现出常人眼中正常水平的探索能力时，他们对可信对象的信赖程度其实是远超常人的。这是可以被有心人观察到的。这使他们有可能建立更深刻的心理羁绊，也可能更容易受到利用和伤害。

3.1.4心理韧性

应激过程的品质表现为心理韧性。良好的心理韧性在应激过程中体现为紧张而不露怯，就像电影《泰坦尼克号（The Titanic）》中杰克在露丝晚宴上的表现那样。紧张意味着身心能量的全面激活，不露怯意味着有能力承载这份巨大的能量。心理韧性也是情绪智力的体现。

如果将主体的心理韧性比作弹簧片的弹性，将压力（stress）比作弹簧片受到的压力（pressure）。那么应激的完整过程就可以类比为弹簧片从发生形变到恢复原状的过程。如果压力超过了弹簧片的弹性限度，弹簧就会发生非弹性形变，即使压力解除也无法恢复原状。此时如果我们试图将其掰回原形，就会感到一种反抗复原的力。换句话说，弹簧已经将它之前受到的压力“内化”了，自己因之进入了一种“新常态”。如果主体勉强自己回到原本的平静状态，就会感到自己身上寄存着一种既不能准确定位也无法排遣的紧张感，这就是“寄生性紧张”。寄生性紧张把主体在应对特定压力时的各种自我对抗常态化了。当他面对必须在原初状态下才能胜任的局面时，就会感到一种莫名的压力。

3.2 定向反应

3.2.1 定向反应的概念

当主体接触到环境中的新异刺激，感受到混沌，并准备有意识地发起交流圈时，其行为被称为"定向反应（orienting response）"或“好奇-探索反应”。定向反应是应激的核心，探索行为是定向反应的核心。通俗地说，定向反应就是当体验流受到扰动时，主体为了弄清楚“这是怎么回事”而下意识地进行的活动。定向反应的过程可概括为：“惊讶→定神→探索→切分”。定向反应的品质直接反映出了大脑前额叶皮层（大脑皮层最高级部分）的活动性。

我们的注意力会固着在那些唤起我们好奇心（探索欲）的事物上，直到这种好奇心在探索中被肯定为止。好奇心如果总是被否定，个体就容易陷入自我怀疑，变得越来越神经质。所谓“煤气灯效应”之类的精神控制手段利用的就是这一原理。

探索欲是个体一切驱力的原型，探索行为（关注、试探、搜索、尝试等等）是定向反应的基本表现。健康发展的个体可以充分利用自身的定向反应了解环境中的细微差异，他们不必关注如何发起或者控制这些过程，就能下意识地对感官刺激作出恰当反应，面对打击和压迫时也就不容易陷入无助，也能够在日常活动中轻易识别和消弭创伤性事件的残迹，避免形成神经质倾向。

体验流的扰动触发了定向反应，唤醒水平的提升使高级皮层对感觉信息的防御暂时减弱，现实知觉能够短暂地压制想象知觉，从而为身体意象的更新开辟道路。定向反应是建立条件反射的前提，不能唤起定向反应的刺激不能成为条件刺激。“惊讶”所触发的身心激活状态只能短暂持续。在持续期内，所有的知觉和探索行为会被感知为一个整体，机体会竭力探索新的现实知觉和自身经验以及动作指令之间的关系，建立新的条件反射，形成新的认知。惊讶感越强，条件反射建立得就越容易，消退得就越困难。如果在整个持续期内定向反应都不能完成，就很容易产生心理创伤。

定向能力受损的人面对开放式问题总是急于抓住某个结论，完全无法正常表现出好奇和探索，面对要求高效反应的急性压力事件时总是反应不足，容易受伤。

3.2.2定向反应与情绪

定向反应总是伴随着唤醒水平的波动。情绪越激动，认知和充分探索的空间就越小，心态和行为的调整就越困难（当然完成调整的收获也可能越大）。在这种激动状态下，如果定向反应无法完成，受挫的战斗反应就可能演变成暴怒，受挫的逃跑反应就可能让位于无助。以阿希从众实验为例：当被试发现自己和大家不一致时，会唤起定向反应，如果他始终无法觉察到实验本身的捉弄性质而又无力和众人相对抗，那么他将在自我怀疑中陷入无助。如果他能及时看清自己的处境，对意识对象的切分就会更加深入，他将放下和这些人在具体认知水平上的心理羁绊，这些人就无法再影响到他了。如果他认为这些人比较守规矩，就会把他们划入“虽然不能共谋但可以作为背景来帮助自己维持实验状态”的可信对象，从而继续专注于实验。如果这些人对他加强了干扰，引起了他的应激，他可以将他们划入敌对对象，行使自己的权力——退出实验（即“逃反应”，这在实验中是被允许的）或者将这些人逐出自己的活动空间（即“战斗反应”，这在实验中并不现实），这便是“释放对抗性”。切分的完成意味着定向反应的完成，对抗性的完全释放意味着应激的完成。

战或逃都是显著的对抗行为，战或逃反应（fight or flight response）就是显著的“对抗反应”。对抗以恢复和发展同步为目的，逃离危险的过程就是奔向安全的过程。如果同步状态不能恢复，对抗性就无法完全释放，主体将被迫在“克制”“屈服”和“继续探索和对抗”之间作出选择。

在定向反应的探索阶段，意识对象的切分尚不清晰。探索反应包括了各种微妙的试探，如舞蹈般左顾右盼，进进退退。如果主体因为各种限制而无法完成探索（例如前置信息不足、时间不宽裕、受到恐吓、孤立无援、闪回闯入、遭遇可信对象的背叛，等等），这些相互矛盾的试探冲动就可能纠缠在一起，仿佛相互拮抗的肌肉同时绷紧，积蓄起很高的能量却动弹不得。冲动之间的激烈对抗使压力水平迅速提升。越密切的关系涉及的切分越复杂微妙，伴随的恐惧、愤怒、懊恼和无助也越多。

3.2.3创伤化的过程

适应良好的个体会在遭遇急性压力事件后的第一时间稳住自己，激活探索

冲动。在探索过程中，如果活动性的补充跟得上消耗，探索就可以不断深入。如果活动性迅速消耗，唤醒水平就会不断抬升，通过提高感官的反应性来代偿活动性的衰减，直至完成定向。随着压力的增大和唤醒水平的提高，探索的对抗性越来越强，危机感也逐渐发展为恐惧感。当恐惧感强烈到一定程度时，探索反应就会发展为激烈的对抗反应，也就是“战或逃反应”。

如果战或逃反应无法完成，主体将被迫在极高压状态下继续探索。随着活动性的耗竭，僵直越来越显著，定向反应陷入了困境。主体既不能作出有效的切分，又无法从探索中得到回应。主体“不知如何是好”，同时伴随着极高的唤醒水平，甚至可能引发濒死体验。这种极端的唤醒无法长期维持，如果主体不能释放能量，解除僵直，就有彻底丧失心智（“吓疯”或“吓傻”）乃至失去生命（“吓死”）的危险。面对无法逃脱的困境，主体只能接受这种现象学世界的混乱状态，通过集中注意于无意义信息等方式在精神上抽离困境，使身体像被戳破的气球一样卸下一切压力。巨大的应激能量没有帮助主体向外战胜危机，却向内摧毁了主体的自发反应模式和原始判断力，将僵直状态中大脑高级皮层（这里主要指前额叶皮层）对各种自发反应倾向的抑制固定了下来。主体和应激源之间自觉的对抗变成了主体和自身自发反应倾向之间不自觉的对抗，可称作自我对抗。

主体放弃了原有的定向反应模式，放弃了探索和挣扎，丢失了日常活动中的流畅感，陷入了一种恍惚的意识状态（呆滞）和松弛无力的身体状态（瘫软），这种状态就是屈服。主体就这样被困在了未完成的应激过程中。此后，当主体面对新的挑战，需要再度激活能量时，这些自我对抗也会被激活。当自我对抗被唤起时，主体会产生被羞耻感淹没的强烈体验。现象学世界中的新旧冲突混在一起，使主体更加不知所措。极端的僵直-瘫软循环取代了相对温和的紧张-放松循环，普通的探索过程反复被闪回或情绪闪回打断，正常的定向反应被反射性的僵直和自我对抗取代，此时我们就说主体被创伤化（traumatized）了，俗话说就是“魂丢了”。

单就活动性而言，瘫软与僵直具备相同的品质，二者都是肌肉协调性退化的表现。僵直是身体在所有方向上同时绷紧，活动性急剧减弱，身体积蓄起很高的能量，主体感到强烈的痛苦。瘫软是简单粗暴地释放掉了身体在僵直中积

蓄的能量，身体在所有方向上同时“泄气”了。虽然表面上看主体已经不再紧张，甚至十分放松，然而活动性却无法恢复。活动性的衰竭使序列化行为的建立和触发都变得困难，主体感到原本已经成为习惯的行动变得吃力，对新异刺激的探索也变得吃力而乏味了，主体出现了“启动困难”。

在具体的叙事中，僵直可能是震惊、惶恐、畏缩、笨拙、僵直、呆愣、癫狂、亢奋、崩溃、神经质等表述，瘫软可能是瘫软、萎靡、呆滞、发愣、茫然、空虚、恍惚、迷瞪、迟钝、沉闷、昏沉、漠然、崩溃、抑郁、失神、无助、无能、无力、松弛、退缩、屈服、解离等表述。这些表述可能和期待、吃惊、好奇、警觉、恭敬、沉着、镇定、沉浸、专注、放松、遐想、放空、入定等正常的探索反应混淆而具有欺骗性。

松弛和放松的区别在于前者意味着失能和麻痹，而后者意味着事实上的完成和心理上的放下。松弛意味着肌肉萎缩，而放松意味着潜在的爆发力。长期的放松会导致松弛（即“用进废退”），长期的松弛想要恢复放松则需要主体在一定的压力情境中经受锻炼。压力情境会使主体进入应激状态，这对于受困者往往意味着恐惧与癫狂。

3.2.4 自我对抗

自我对抗造成了多余的心理冲突。这些未处理的心理冲突就像多余的调料一样，使原本正常的活动变味。在情感层面上，滞留未处理的感受可以放大甚至扭曲当下的感受，这在心理动力学中称作移情（Transference），移情也是一种情绪闪回。自我对抗带来的额外压力使主体的攻击倾向和退缩倾向都更加强烈，主体必须竭力抑制自己才能免于失控。

在一次具体的活动中，人们通常只能注意到自我对抗的其中一极，另一极则被完全抑制。在自助情境下，主体要想准确识别和消解自我对抗，就必须有意识地将这些矛盾表现看成一个组合，这就是 4.3 节的“配对意识”。在治疗关系中，咨询师常常通过营造一个相对中立的环境来暴露个体的自我对抗。

3.2.5 寄生性紧张的补偿效应与省减效应

僵直和瘫软是活动性低下的典型表现，可以合称“僵瘫”。在许多 CPTSD

身上，僵瘫取代了正常的放松而灵便的中立体态，使他们在观察者眼中显得生硬笨拙而又慵懒散漫。

寄生性紧张虽然使很多原本轻松流畅的活动变得涩滞，使“找感觉”变得困难，使主体的活动性受限，但也使某些局限性的活动变得更加容易，使主体对某些类型的风险变得更加敏感。对于某些人来说，这可以使他们的活动能力更容易与各种草率的认知图式相适应，主体不但不排斥寄生性紧张，反而对其产生了依赖，以为自己“涨了见识”，可以更“省心”了。这就是寄生性紧张的补偿效应。这样的人往往会给观察者留下“愚鲁”的印象。

省减效应是指寄生性紧张使主体感到自己不再需要之前的基本能量了。能量水平的下降减轻了自我对抗的痛苦，带来了舒适的松弛感，这种松弛感与健康的放松感在主观上无法区分（正如我们很难区分把双手从热水转移到温水的感觉和从温水转移到凉水的感觉一样），导致主体在僵瘫的状态中越陷越深。对于被限制的那部分活动性，主体只有一种模糊的受限感，他并不会将之与寄生性紧张直接关联，他甚至意识不到寄生性紧张的存在。只有在寄生性紧张因为一些偶然的原因被解除时，主体才能看到自己的能量水平下降到了多么危险的程度。创伤源与主体的关系越密切，自我对抗就可能越严重，寄生性紧张就可能越复杂，补偿效应和省减效应就可能越显著。补偿效应和省减效应将最终瓦解受困者的中立状态，使他们和创伤建立共生关系，此时创伤就发展成了CPTSD。

可以把身体比作一个巨大的幼儿园，园里每一个孩子都代表了身上的一个冲动（活动倾向）。这些孩子的嬉戏与打闹构成了幼儿园的生活日常，园长虽然很累，但孩子们的活力令他感到满足。有一天，园里突发重大危机，孩子们乱作一团，园长这才发现自己根本没有足够的危机应对能力。于是他按照一种方便应对此类危机的方式把孩子们绑了起来，以后遇到相似的危机信号自己只要拖动绳子就能快速作出反应。孩子们被绑起来后，冲突明显变少了，自己再也不用每天那么劳累了，他觉得自己简直太聪明了，于是一天天懈怠下来。孩子们被绑得时间久了，慢慢地丧失了活力，从动不了变成了不想动，甚至连肌肉都有点萎缩了。园长总觉得与其他的园子比起来，自己的园子缺少一种朝气和创造力。他想做点什么，可他发现自己根本不知道如何下手，而且稍微动一

下就感觉很累。现在自己的状态明明很舒服，不如干脆这样混日子。直到有一天，幼儿园之间进行联谊活动，园长解开了孩子们身上的绳索，他才发现所有的孩子都已经奄奄一息了。

也可以把身体比作一杯液溶胶。胶体中的每一个胶粒都代表了身上的一个冲动（活动倾向）。巨大的外力冲击使胶粒产生了聚集。微小的胶粒变成了一个个相对较大的胶块，无法继续保持活跃的布朗运动，逐渐沉降在了杯底。溶胶的性质已经改变了，可不明就里的人却觉得它变得更通透、更纯粹了。

3.2.6危机信号的泛化与闪回的触发

在主体陷入显著的僵直之前，高唤醒水平会使感官刺激被全面纳入认知加工，主体会感受到自己的感官能力一时空前扩大，此时的主体会给观察者留下高度兴奋的印象。随着僵直的逐渐明显，主体给人的印象逐渐从兴奋变成笨拙。当主体在精神上逐渐崩溃时，笨拙又会逐渐变成呆滞。唤醒水平提升幅度越大、应激过程持续越久，被纳入认知的感觉信息就越多，以至于环境中非常普通的信息都有可能和急性压力事件建立关联。如果危机应对失败，这些普通信息就有可能被打上创伤的烙印，成为情绪闪回的触发器。从此，受困者总是感到生活中仿佛充满了难以名状而又无法定位的危险信号，这种感官超载令他们痛苦。即使是平静的情境也无法再令他们放松，生活中的一点点风吹草动都可能唤起他们创伤体验，这就是“闪回”。

闪回提示我们身心的应激状态从未完全解除，还在等着我们去处理。闪回体现了身体对环境的质疑和对自身应对能力的担忧，它是过去的自己给当下自己的提示，也是历史自我和当下自我的一次沟通。身体不断地在平静中唤起这些记忆来检验危机是否已经解除，同时考察主体是否已习得了所需的应对能力。闪回一般只出现在日常状态下，克制状态下由于自我抑制较强，一般不会出现闪回，因此从发生创伤性事件到出现闪回之间一般会有一个时间差。这个时间差越久，主体的克制状态持续得就越久，创伤对身体的影响就越大。

面对创伤性事件，健康发展的主体会否认其正当性，认可自身的应激与对抗的合理性，而受困者会否认创伤性事件发生前后自身状态和反应的正当性，将创伤性事件合理化，以为这是一次合理的“教训”，是“上位者”在让自己学习

调整自身状态。受困者不能区分受辱和受教两种体会，也不能区分僵直和镇定两种身心状态。因为早年的恐惧体验从未得到恰当的安抚，自己对危机的原始反应也没有得到恰当的认可和支持，他们的自我安抚能力和危机应对能力都没有得到发展。不管是受惊、受辱还是受教，他们都只会以退缩应对，同时体验到深切的羞耻感。

3.2.7僵直的发展与解除

危机应对的一般反应过程：危机信号→定向反应→对抗与同步→危机解除→恢复安宁。

危机应对的僵直复原过程：危机信号→定向反应困难→唤醒水平进一步提升→定向反应困难→……→僵直→危机解除→能量的延迟爆发→定向反应完成→恢复安宁。

创伤的形成过程与代偿过程：危机信号→定向反应困难→唤醒水平进一步提升→定向反应困难→……→僵直→危机解除→能量的延迟爆发→得不到响应或只能得到消极响应→危机信号的泛化与常态化→注意力缺陷及多动表现→压抑与适应→麻木→自闭。在这一路径中，僵直最终发展成了自闭，受困者的自闭与自闭症谱系障碍者的自闭往往难以区分。

以一名幼儿（不足 2 岁，刚开始学习语言，与祖父母一起生活了一段时间，彼此已经非常熟悉，但他们仍然无法提供父母般的安全感）为例，说明产生僵直与解除僵直的过程：祖父母将孩子带到了一个陌生的环境，他一时还无法确认环境的安全性，甚至找不到一个同龄的小伙伴充当探索的引路人→定向反应困难，唤醒水平提升，开始出现笨拙表现→尚未在祖父母支持下完成定向反应，就被陌生人轮流抱起，他们看起来很亲切，一旁的祖父母也显得很支持，但这些人身上陌生的气息还是令他警惕，幼儿同时产生了熟悉与陌生、亲切与威胁等相互矛盾的体验→唤醒水平剧烈提升，但幼儿却在竭力抑制自己作出战或逃反应，毕竟祖父母看起来很支持这些人，剧烈应激似乎是不合适的→陷入僵直→勉力自我抑制，承受巨大身心压力→危机场景解除，孩子回家了，回到了熟悉而亲切的环境→因过度疲惫而入睡→前额叶皮层活动减弱，自我抑制解除，被压抑的各种反应冲动重新激活，剧烈的心理冲突再度浮现→从噩梦中惊醒，

恐惧体验被全面唤起→大哭大闹→祖母的抚慰→再次入睡→再次从噩梦中惊醒，哭闹更加严重→祖母更加努力地抚慰→身心能量在哭闹中得到渐进释放，孩子通过环境的反馈（祖母在抚慰过程中慌而不乱、富有节奏的动作品质，对孩子全身心的关怀，环境的温暖与平静）逐渐认识到危险已经解除→哭闹平息，恢复安宁。

对于已成年的受困者，创伤能量的释放和身心控制权的下放仅仅只是觉醒过程中的第一个挑战。如何调动驱力使身心活跃起来是更大的问题。无活力的身心如同暴露的核心，随时可能遭遇二次创伤。激活身心不仅需要纠正自挫性的认知图式，也需要可靠的健康主体作为交互对象。生命体是活动性最强的交互对象，而人是活动性最强的生命体。与他人“共舞”是激活身心最简单有效且可持续的方法。受困者的生活环境中通常没有这种人，因此最关键的一步是“走出去”。在走出去之前又需要适当的认知准备。受困者应当以感恩的心态珍惜每一次邂逅，全新的人际关系犹如一套全新的镜盒（参考拉马钱德兰的“镜盒实验”），使感知觉有了新的“社交通道”，使主体获得了更新自我意象的机会。

3.2.8定向反应的重启

现实中的应激并非是线性的过程，而是众多基本应激过程层层嵌套的过程。其中的任何扰动都可能在不同层面上重启定向反应。

主体在定向反应中优先注意哪一部分内容、优先选择何种认知图式具有一定的偶然性和习惯性。如果在执行序列化行为的过程中再次出现体验流的扰动，就可能使定向反应重启。正如我们在沉浸式的体验中遇到一点小小的意外，思绪就可能被彻底打断。面对诈骗分子，我们在慌乱中即将上钩之际，路边的一声喇叭就可能使我们突然惊醒。影片《周处除三害》中，面对主角的枪口，已经自我催眠（自我抑制、自我麻痹）的信徒们无动于衷。但是偶然的一个哑弹就足以使某些信徒惊醒并选择逃命。体验流受到了意外刺激的扰动，使这部分人的自我催眠被突破，定向反应被重启，从而有机会重新确认情况。这些被惊醒的信徒从自己的战栗中确认了自身的求生欲，战或逃反应被重新唤起。最后讲台上的信徒们已经多次目睹了哑弹，他们已经形成了适应，体验流的扰动已经平息，手中的乐器也占据了他们的一部分注意力。在短暂的时间里自我催眠

得到了大幅度强化，定向反应难以重启，所以他们才会全部倒下。

3.3 自我抑制与微观管理

3.3.1 自我抑制

自我对抗如果得不到觉察和释放，它的影响就会逐渐扩散，表现为偏执的自我抑制或自我激励（执念），二者总是伴生。也就是说，“启动困难”和“停不下来”本质是一回事。

惯于自我抑制的人常给人以“拧巴”的印象，他们在互动中时而弱势得令人感到虚伪，时而强势得可怕。在他们的主观叙事（自我报告）中，这些拧巴表现总是被追溯至各种失态、尴尬或困窘的经历，被他们形容为心理阴影。这些自我报告有强烈的局部聚焦、过度反思和碎片化特点。这些经验使他们相信自己不能胜任某种压力，但又不甘心逃避。极端的失态体验所造成的羞耻感可能使受困者发展出近乎全局性的自我抑制。受困者顽固地相信自己本能的亲社会反应是丑陋的而非可爱的。自我抑制可以帮助他在行动前进行详尽的自我审查以避免出丑，最终发展为一套精细复杂的微观管理技巧和一套如哲学般复杂而低效的处世之道。自我抑制会造成一股无名怒火。这种愤怒会破坏主体与他人建立情感连接的可能性，反过来使主体更加羞耻，自我抑制被进一步强化，如此陷入恶性循环。

3.3.2 意志力

主体可以利用注意的能动性使特定的冲动得到更多支持，这种能力就是意志力。意志力也是主体自觉地与特定意识对象保持同步的能力。意志力会在短时间内大量消耗活力，活力越弱，可支配的意志力越弱。

意志力与自我安抚能力是一体两面的关系，意志力突出“活动”，自我安抚突出“平静”。

3.3.3 自我抑制与克制

面对一时无法逃脱的危机，如果放任对立的冲动不断发展，个体终将在极

度的僵直中崩溃。为避免崩溃，主体必须发挥意志力的作用，勉力保持克制。自觉的克制者是坚强而富有智慧的人，他们通过适当降低唤醒度使定向反应的可持续时间大大延长，从而使自己能够在隐忍中等待时机。他们对自身所寄存的能量有很高的自觉，当应激过程最终完成后，他们的品格仿佛也完成了一次历练。自觉的克制作为一种高度成熟的应对能力，掌握起来有一定难度。它使主体在极端的顺从与对抗之外，学会“周旋”。相比之下，人们更容易成为被动的克制者。

本文提到的自我抑制主要指被动的克制。被动的克制者虽然在身体层面上保持了克制，但在认知层面上缺少自觉，认知资源的匮乏使他们长期卡在克制状态而不自知。自我抑制需要耗费认知资源，当本来就稀缺的认知资源被其他活动占据，导致抑制无法稳定维持，或者安全的环境使他们感到不必再保持抑制时，这些寄存的能量就可能使他们表现出可怕的一面。许多被动的克制者在接触陌生人时常常竭力克制自己，即使自己受到了侵害也要表现出友善，这将导致能量的进一步积压。这些积压的能量只能在相对安全的家庭环境中或者在他们面对比自己还要脆弱的弱者时释放出来，因此被动的克制者普遍存在“窝里横”的特点。

3.3.4 自我抑制与解离

自我抑制的极端形态就是作为工具被自主使用的解离。有了解离这样一个神奇的工具，受困者抑制自身活力的技巧可以发展到十分惊人的程度。

在极度的僵直中，如果克制无法发挥作用，支持系统又完全缺席，个体终将崩溃，从“僵”变成“瘫”。在近乎瘫痪的状态中，个体不再与情境产生共鸣，不再被任何刺激触动。如果这种经历反复出现，个体就有机会习得一种切断情感连接的“诀窍”，学会用“麻木不仁”应对一切压力。他们不再产生融入情境的冲动，也就不再能感受到抗拒情境的冲动，也就不再感到任何压力。主体身在世界中，心却失去了对世界最基本的信任，“不跟这世界玩儿了”。解离一旦成为习惯，人格发展必然停滞。活动性低下的人往往十分擅长解离而不自知。

自我抑制只是在竭力避免冲动发展为行为，而解离是对冲动本身的抑制。

在主观体验上，前者常被解读为“忍耐”，伴随着血脉贲张之感，后者常被解读为乏力、无趣的体验。自我抑制伴随的不舒服体验会促使主体寻求改变，而解离使主体丧失了对刺激的兴趣，常常需要一些认知上的冲击才有可能使主体产生改变的意愿。

解离使身体缺失反应冲动，主体也就无法接收到相应的感知觉反馈，认知也就成了无米之炊。受困者常常感到自己缺失了正常人在相应情境下该有的感受。他们陷入了自我怀疑，逐渐变得神经质。解离是受困者经常出现记忆检索困难和述情障碍的原因之一。神游、茫然（思维空白）和忽然涌现的强烈消极情绪（情绪闪回）都提示了解离的存在。

常人理解的“观察者模式”一般指的是自觉的克制状态，而受困者理解的“观察者模式”往往指的是解离状态。受困者的呆滞麻木来自解离而非脑损伤，这是他们与智力障碍者在现象学层面上的根本区别。

3.3.5微观管理

绝望的受困者不再探索与痛苦体觉的相处之道，转而寻求彻底隔离它们。然而闪回的发生从不会放过一丝机会，可谓防不胜防。为了尽可能避免闪回造成的失态，受困者开始尝试压抑自身一切本能反应，幻想凭借自己的意志力控制自身各种感受和行为。受困者将自己的身心时刻维持在紧绷状态，堪比自我囚禁。然后小心翼翼地自我审查，避免出错，为此穷思竭虑。然而越具体的思考越容易有盲区，越具体的行为越容易“丢感觉”。 不论主体为这种“微观管理”积攒了多少所谓“科学的”认知图式和行为模式，用来应对极具灵活性的现实情境都显得捉襟见肘。对行为的控制越强，对感觉的体会就越少，积累的情绪越来越多，失控也就不可避免。受困者会发现自己无论如何小心都很难做到位，只能感到挫败和懊恼。

经过长期发展，受困者的微观管理习惯可以发展到十分惊人的程度。例如他们在学习动作技巧时，会强迫性地关注身体各部位的摆放而不关注肌肉的发力感和动作的具体效果，仿佛他们是在摆弄一具麻木僵硬的木偶。他们在谈话时总是想着怎样逃离紧张状态而无法把注意力集中在谈话内容带给自己的感受和想法上，因此对话很难持续。微观管理使他们的实际表现总是比自己的真实

能力笨拙、僵硬得多。

“情绪管理”也是一种微观管理。情绪是人类的本能，是心灵的“信号灯”。本能只能疏导，无法压抑。管理情绪无异于自戕，它只能带来创伤。主体该做的是对情绪的来源负责。

如果一条街治安很差，我们就应该避免经过它。如果必须经过，就要有足够的安保意识，并为后果做好预案。如果出现安全事故，失落和愤怒就是最自然的情绪，它们可以调动起我们的心理资源，帮助我们渡过危机，吸取教训，甚至可以驱动事情朝自己需要的方向发展，然后自己就能逐渐恢复平静。恢复平静需要时间，这段时间就是自己为事故付出的心理代价。又如一个人看领导不顺眼，在领导面前总是感到难以遏制自己的鄙夷和愤怒，那么他就应该做好简历，积极参加面试。如果几轮面试都很顺利，他就会变得冷静自信，不再被领导左右情绪；如果面试接连受挫，他就会注意到领导可爱的一面。刻意控制情绪是职场抑郁症高发的原因之一。

这意味着一个人要避免创伤，就必须成为生活的强者，成为一个积极主动的人。指望在事后管理情绪是缘木求鱼。

3.4 神秘主义与情绪推理

良性人际互动的缺失和生活体验的单调进一步限制了受困者的活动性。他们的身心状态更新极慢，常在实时的活动中过度保留过往体验的残迹，因此总是显得很累。残迹意味着意识活动的对象虽然消失了，但相应的体觉却还没来得及消失，这些缺少现实对象的体觉干扰着当下的活动，诱导出各种神秘体验。受困者习惯于自我凝视，特别善于捕捉这些异常体验。受困者很难意识到，很多自己难以理解的体觉都是孤独所致，也就是说孤独是这些异常体觉和定向反应障碍的社会学解释，良好的社会接触可以推动身心状态的迅速更新，从而消解残迹。受困者困惑于自己的异常体觉，既然它们无法被溯及既往，那便只能诉诸当下，这导致了他们的神秘主义倾向和情绪推理习惯。

3.4.1 神秘主义

当我们的体验感受与意识对象错位时，我们就产生了神秘体验。例如，当

长期情感淡漠的受困者因为某些机缘巧合短暂地恢复了与世界的情感连接时，他会莫名体验到像婴儿在母亲怀里一样的幸福感。这种体验超出了日常经验的范畴，令主体感到震惊、狂喜、困惑甚至恐惧。

神秘体验是一种特殊的失谐体验。神秘体验意味着主体陷入了心理上的两难处境：定向反应无法完成，同时又不得不接受失谐的现实。一旦定向反应完成，失谐在熟悉的认知图式下得到明确，神秘体验就消失了。神秘体验可以激活广泛的联想，有的人可以利用神秘体验激发出很强的创造力，有的人则因之陷入神秘主义。受困者的神秘体验极为丰富，因为他们很多时候都处在迷失状态。

神秘主义倾向可能促使受困者向各种宗教寻求精神慰藉。沉迷神秘体验同样可以产生“精神交互作用”，进一步干扰大脑，增加罹患精神障碍的风险。

3.4.2 情绪化推理

人们被现实触动而产生情绪。情绪反过来调节认知加工过程，也充当着认知加工的材料。情绪化推理是指主体由于现实检验能力受限，轻率地将主观情绪体验直接等同于客观事实，基于情绪而非现实证据做出判断或决策的现象。简单说就是“我感觉如此，所以事实一定如此”。例如“我感觉自己很尴尬，所以别人一定在嘲笑我。”“我好像没做什么，却体验到了像在母亲怀里一样的幸福感，这一定是某种终极力量显灵了。”实际上，除了客观事实之外，情感底色偶发的强化和弱化（情感底色越极端就越不稳定）或情绪闪回的触发都可能造成强烈的情绪波动。不能接受现实检验的情绪体验并不可靠。心理动力学所谓“投射”就是情绪化推理发生在人际互动中的结果。受困者的情绪化推理可以达到极为夸张的程度。挥之不去的焦虑让他们看什么都觉得不顺眼，仿佛别人都是蠢货。挥之不去的羞耻让他们感到仿佛每时每刻都有很多眼睛在监视自己。

情绪化推理会强化原有的负面情绪，形成“情绪→错误结论→更强烈的情绪”的恶性循环，使情绪化推理产生强迫性。

相比受困者，常人对现实检验能力受到的限制极为警觉。他们会首先将那些挥之不去的强烈情绪指向那些限制自己现实检验能力的因素，挑战并击破它

们，以保证自己可以很轻易地在情绪和现实之间保持平衡。一些创伤治疗理论将“在闪回的图景和当下现实情境之间保持平衡”看作一种需要刻意训练的能力，称为“双重意识（dual awareness）”。实际完全没有必要，它只是垃圾被打扫干净的自然结果。

3.5 无助

3.5.1 无助与掌控

本文所谈论的抑郁，主要指在 CPTSD、PTSD、ASD 和焦虑障碍中普遍存在的反应性抑郁（Reactive depression），而非典型意义的抑郁症。反应性抑郁也就是“微妙的绝望”。

抑郁在认知层面体现为意义感的丧失。然而正如欧文·亚隆（Irvin Yalom）所言，人生本来就没有意义，有意思的是为什么人类只有在抑郁时才会这样认为。

无助（绝望）与掌控（希望）相对。学者们热衷于探究二者哪个属于习得，哪个属于本能，这种问题对于自救没有意义。

“活动”是生命的本能，意义是人们为这种本能赋予的社会性解释。也就是说，有了活着的体验，才会有生命的意义。如果主体在充满好奇心的探索过程中始终无法获得有意义的反馈，这些活动就会被主体无意义化（虚无化）。没有了有意义的互动，现象学世界就无法得到更新，即使情况有变，也很难再引起主体的情绪波动，也就无法得到注意。

3.5.2 主体-世界交流圈视角下的无助

马丁·塞利格曼（Martin E. P. Seligman）用狗的电击实验给出了免疫无助的思路。野犬（狼）无论遭受多少次无法逃脱的电击，都不可能彻底放弃挣扎，它们会全力把握一切微妙线索，待情况有变时逃脱困境，恢复常态。而实验室饲养的狗则很容易在多次失败后放弃挣扎，陷入抑郁状态，即使危机已经解除，也无法恢复原先的活力。相比实验室饲养的狗，野犬在生活中总是面对更多的压力与风险，因此生活压力并不能解释抑郁的成因。野生动物之所以不容易陷

入无助，是因为它们在自然环境中必须自我信任，自我负责，直面挑战（如带领族群、吓退小孩等），不会轻易被任何力量驯服。这些控制压力的经历使他们能够免疫抑郁。

人类成长的过程就是引导自身的原始冲动充分发挥建设性的过程，这一过程涉及到众多复杂而微妙的平衡，需要全面协调自身的各种冲动，只有拥有强大“心理肌肉”的人才能做到游刃有余，脆弱的人则很容易在手忙脚乱中有意无意地阻断自身的体验流。所谓脆弱既指精神上的脆弱，也指身体的虚弱，甚至可以说所有精神上的脆弱本质上都来自身体的虚弱。“体弱”决定了对抑郁的易感。

无助使主体对自身行为效果和外界压力变化的关注度变差，大脑高级皮层对感官刺激和行为效果的敏感度变差，精神逐渐涣散。即使主体偶然作出了有利于脱离困境的行为，也无法产生“眼前一亮”（唤醒水平提升）的感受，反而感到“不过如此”。所以他们很难注意到环境变化，也就没有动力重新评估自身处境，也就只能涣散下去，无助下去。

抑郁者一旦看清楚自己的处境，就会知道自己多么应该愤怒。抑郁者的觉醒往往从停止压抑自己的怒火开始。这种可怕的愤怒对施助者的能力提出了极高要求。得不到正确疏导的暴怒很容易弥散成躁狂，使问题更加复杂。

对于常人来说，精神涣散令人警惕。常人会想方设法让注意力保持聚焦，逃避涣散的状态。而无助者已适应涣散，他们只会感到一种朦胧的焦虑感和恍惚感，甚至可能感觉这种状态很舒服。他们甚至会成为“涣散”的传染源，导致别人和他们打交道时常常感到莫名的不适。在互动过程中，有无助倾向的人可以适当提醒对方，自己思维比较跳跃（跳跃是涣散的遁辞），维护话题的能力比较差，为了保证对话的建设性，对方要更多地维护话题，减少发散。提醒对方远比提醒自己可靠，由于缺少自知，自我提醒常常造成其他方面的代偿，使问题变得复杂。在独立执行任务时，有无助倾向的人要不断提醒自己锚定核心目标，警惕随意给自己“加料”的行为或想法，哪怕它们披着鼓励或自信的外衣。

无助限制了个体的探索能力。无助者面对问题总是倾向于作表面化、一般化、理论化的归因，缺少生动具体的参与感，导致意识对象的分化程度很低。

这造成了抑郁者的悲观主义倾向和泛化归因倾向。消极悲观的归因风格反过来进一步强化了无助。

从来源看，抑郁是耗竭的对抗。从归宿看，抑郁是被卡住的哀悼。个体走出抑郁的过程就是重新学会信任自身本能，再度舒展自身天性，发展自身适应能力的过程。

3.5.3主体间交流圈视角下的无助

“无助（helpless）”的字面很好地揭示了它的本质，那就是“无人帮助的”或“孤立的”。但是当事者往往意识不到这种状态的来源，只能解释成自己能力不够或者过于脆弱。这里面当然有自身能力的因素，但很少有人生来就是强者，我们的内在力量都是在后天成长过程中通过与他人的互相支持而不断积累的。如果一个人总是陷入无助，而他身处的社会支持系统却不断暗示他将这种人际关系缺陷归结为自身缺陷，那么他就会接受无助作为自己的日常状态。这反过来又会进一步削弱主体与人发展关系的能力。从这个角度来说，造成无助的是人不是事，它的本质是有毒的人际关系。发展健康的人际关系，在健康有力的社会支持系统的陪伴下，不断以事实为师才能成长。

意义的解释权远比意义本身重要。主体必须努力学会抓住意义的解释权，尤其是学会寻找过程的意义。当主体意识到自己的行为越来越不值得关注，越来越没有意义时，要迅速从恍惚中定神，意识到自己正在沦为下位者、无助者、屈服者。这种警觉性会促使个体重新审视自己的支持系统，看见自己无法得到满足的需要（need），然后愤怒、憋屈、失望、孤独、悲悯（悲痛、同情）等情绪就会涌现。主体如果能充分抱持这些情绪，就有机会找到保存自身力量，免于陷入无助的办法。

3.6 活动视角下的创伤

3.6.1创伤与活动性的退化

良好的活动性是发展适应性和心理韧性的前提。创伤总是伴随着活动性的退化和日常唤醒水平的异常。活动性的退化限制了探索能力，互动流无法及时

更新，主体很容易卡在旧的体验和认知图式中出不来。创伤易感者不仅脆弱，而且会越来越脆弱，直到他们下决心作出改变或者彻底失去生活信心。

自我对抗、过度疲劳、环境与资源的限制、隐蔽的“驯化”都可能使活动变得涩滞。主体的活动性日益下降，活力不断衰减，原本无需注意、毫不费力、近乎本能的活动开始占用越来越多的注意力，外界刺激所能唤起的好奇反应越来越弱。这些变化都提示了创伤的存在。主体为了保证活动的效率，不得不降低唤醒水平，使身体变得松弛，然后用意志驱动笨重的身体。这样做会带来巨大的消耗感，受困者看似懒散，但他们在活动中的精神损耗却一点也不少。这就好像提线木偶的关节失去了灵活性，操作者不知道如何修复关节，所以只能软化木偶的肢体，用手直接扭动木偶以勉强完成原来的动作。这样做使受困者的行为普遍给人以“拧巴”的印象，仿佛他们永远处在进退两难的处境中一般。创伤化进程过早开始的受困者甚至认识不到什么是“驱力”。他们以为所有的活动都要受意志驱动，因此总是为常人在活动中自发涌现的强大能量感到惊恐。

逐渐下降的唤醒水平与寄生性紧张的省减效应相协调，使受困者能够自洽，因此他们很少会主动改变自己的状态。只有当他们走上社会开始独立生活后，四处碰壁的经历令他们怀疑人生时，他们才会产生改变自我的动力和意愿。

活动性的异常下降意味着主体进入了亚健康状态。 受困者普遍存在植物神经紊乱和免疫力低下等问题。

3.6.2 磨损性创伤

如果压力的持续时间过长而又无可逃避，身体的微活动就可能衰退，主体可能显得呆板而僵硬，表现出某种强迫性或神经质特质。磨损性创伤也叫“微创伤（subtle trauma）”。长期持续的“磨损”可能造成极为严重的后果。磨损性创伤也是 CPTSD 的来源之一。造成微创伤的压力是一种长期持续而无法逃避的可怕力量，它对主体自身的生理机能、经验储备和社会支持系统都是一种考验。在本文语境下，前缀“微”皆指“微妙”而非“微小”。

身体的慢性疾病也是磨损性创伤的来源，尤其是当病因无法确定，主体的各种独特感受被不负责任的医生暗示为“幻觉”时。

如果主体没有通过与养育者的依恋关系发展出良好的自我安抚能力，他在

日常压力下积累起来的微妙的僵直就会因无法得到松解而成为寄生性紧张。他将越来越笨拙，他的创伤免疫力（抗压能力）也会越来越弱，以致非常普通的压力事件就足以造成心理创伤。

“将心比心”是人们理解他人的基本方法，受困者以自身低下的活动性代入对他人的理解，只会觉得他人是如此的富有力量却又毫不可靠，这只会增加他的戒备而无法使他对他人的世界产生兴趣。没有互动就不会有契合或共鸣，也就不会产生亲和感。他人在受困者眼里常常只是一堆无规律活动的凌乱堆砌，受困者很难感受到“个性”是什么。人际互动所带来的巨大消耗感会使他们变得越来越抗拒社会接触。

遭遇暴力、身体伤害和情感虐待都会深刻地改变人的一生。但大多数人不知道的是，许多看起来温和无害的事件也可能致人心理受创。创伤的后果有时广泛而隐秘。从微创伤的角度来说，所有狼狈不堪的紧张经历都值得同情，所有一无所获的紧张经历都值得哀悼，所有努力取得收获的紧张经历都值得纪念和感恩。

3.6.3破碎的自我认知

人类的各种直觉和念头看似缺少逻辑关联，实际上都是在共同的微活动基础之上涌现的，微活动的现实性决定了这些直觉想法的现实性。严重的 CPTSD 摧毁了作为各种活动共同基底的微活动，这时候我们才能看到混乱的直觉和念头意味着什么。微活动的现实性为检索记忆提供了丰富的线索，活动性异常的人总是表现出某种出乎意料的健忘特点。

想象一位登山爱好者，因为遭遇意外事故而失去了登山的能力。一般说来，他虽然还会不时涌起登山的念头，但很快这种念头就会转变成深切的哀悼。可是，假如他患有严重的 CPTSD，他可能会在念头涌起后不假思索地开始准备工作，直到他意识到愿望已经无法实现时，他才开始陷入哀悼，但没过多久同一念头就可能再次涌现，他又重新开始准备……如此循环多次，直到他的注意力被其他活动占据为止。破碎的自我认知使受困者的直觉经常干扰正常生活而不再可靠。自我认知破碎的受困者往往唤醒水平很低，日常处在一种半睡半醒的恍惚状态。

3.7 注意力品质视角下的创伤

3.7.1 无可注意

如果主体在僵直状态下拼命挣扎、拼命思索却一无所获，主体对意识对象的切分就可能陷入困境，此时主体会产生强烈的恐惧感。主体的认知能力不但没能帮助身体摆脱困境，反而也陷入了“僵直”。他进入了一种“无可注意”的恍惚状态。此时他的注意力完全无法聚焦，他既不能切分出有意义的意识对象，也不能说明白身体上有什么感觉。微活动的衰竭使感觉输入变得匮乏而单调，他即使注意到了貌似有意义的意识对象，也因为缺少“感觉”而不敢笃定。他觉得世界好像不那么生动了。这种状态也是一种“催眠易感状态”。此时他在观察者眼中的印象就从“笨拙”变成了“呆滞”。

这相当于一部分体验流迷失了。对于受困者，无可注意取代了互动平衡。当他们尝试从无可注意状态进入专注状态时，很容易陷入沉迷状态。原本可以随意调节的注意力被“无可注意”与“自我沉迷”之间的极端摇摆所取代。

无可注意的意识状态在催眠技术中十分重要，主体在这种状态下具有最强烈的催眠易感性。在日常生活中，处在无可注意的意识状态下的主体往往显得麻木不仁、主次不分或者温顺而缺乏主见，令人感到缺少“活人感”。

3.7.2 自我沉迷

自我沉迷或自我关注（self-preoccupation/self-absorbed/self-involved）在心理动力学中也称作“自恋（narcissism）”。被羞耻感支配的自我关注就是自我凝视。自我沉迷就是失去了对人际互动的兴趣，沉迷于在自己身上“找感觉”。对于常人来说，“找感觉”意味着在尝试各种行为的同时不断仔细体会，直到找到感觉正确的那个行为或状态。他们说的是找感觉，其实也是找动作，找状态，找互动。但对于受困者来说，他真的会停下一切显著活动，安安静静地在自己身体内“找感觉”，他从健康的感受感觉的人变成了强迫性的寻找感觉的人。他的感觉只是品质变差了，真找起来还是很容易的。感觉又可以不断唤起情绪、记忆甚至想象，这些东西虽然在常人看来非常单调，但正如我们在梦中不会觉得自己是在做梦一样，他的意识状态使这些记忆或想象可以如梦境一般

生动，他由此进入了“神游”状态。以此维持着自己行将枯竭的体验流，让自己能够保持一定的唤醒水平。

神游虽然舒服，但他还需要面对生活。他挥舞着笨拙的肢体，却始终感觉不生动，不笃定。于是他只能增加对自己每个动作的注意力，或者用一些带有热烈情绪的白日梦给自己鼓劲儿，他的精力就这样被琐事消耗掉了。慢慢地，他发现自己对动作的感知和控制可以越来越具体。微活动与显著活动的临界水平明显下降了，他甚至能有意识地觉察和抑制很多无意识习得的序列化行为，他由此习得了过度的觉察能力和抑制能力。他还没有意识到问题的严重性，甚至为自己这点儿“特异功能”感到窃喜。这种能力一定程度上补偿了生动感和笃定感的消失，代价是糟蹋了很多精力，而肢体却更笨拙了。

3.7.3 自我催眠

无可注意所造成的恍惚状态使视线和活动对象的同步变得吃力，主体在跟踪活动性较高的物体（比如混在人群中的“逃犯”，飞在空中的苍蝇）时几乎总是跟丢。他的眼神空洞而僵硬，很容易被嘲讽为“死鱼眼”。

用这种“超稳态”的眼神打量新环境，相当于要把所有的信息不分主次一起收入大脑，他体验到了感官超载。这太痛苦了，于是他尽量只在熟悉的空间内活动。他的生存空间就这样被限制住了。感官超载常常会引起强烈的恐惧感，使主体表现出类似 ADHD 的特点。

为了缓解焦虑，他可能沉迷于寻找与已经退化的活动性和感知觉品质相匹配的意识对象，比如墙上的一缕光。他可以稳定地盯住某个狭小的固定对象，从而充分体验其中的细节。即使墙上的一缕光，也能让他品出电影级的质感。就算什么也品不出来，至少主体感受到了“笃定感”，因而可以获得安宁，这种做法相当于自我催眠。慢慢地，他发现获得安宁感变得越来越容易。他甚至可以在极端的矛盾冲突中，通过很隐蔽的方式实现“分神”，从而避免情绪唤起。他习得了一种简单粗暴地完成解离的能力。他很少再体验到人际冲突了，准确的说，他的人际关系已经被自己的麻木摧毁了。他的发展因此而停滞。

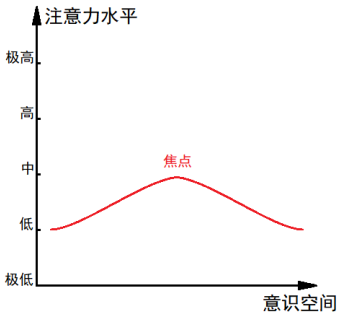
受困者在学会用语言和其他工具捕捉、感受和摆脱痛苦以前，先学会了自我催眠。解离成为了他们应对痛苦的基本工具。在他们的经验中，痛苦总是自

己退去的，而不是自己做了什么消除了痛苦；没感到痛苦是因为自己没犯错或逃脱得及时，而不是因为自己得到了足够的爱与支持。从追求刺激到忍受痛苦，忍受恐惧，忍受焦虑，正常的发展倾向被替换为自虐倾向，效能感被替换为负罪感。

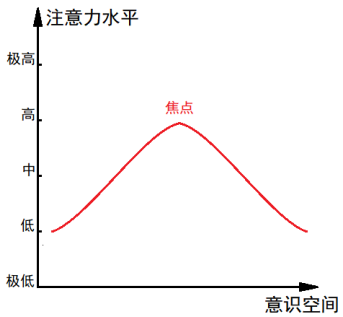
3.7.4注意力缺陷与多动表现

受困者普遍存在注意力缺陷与多动表现。这些表现虽然不及典型意义的ADHD（内源性 ADHD）严重，但极易与之混淆，很难区分，可称为反应性ADHD。下文所述 ADHD，如无特殊说明，均指反应性 ADHD。

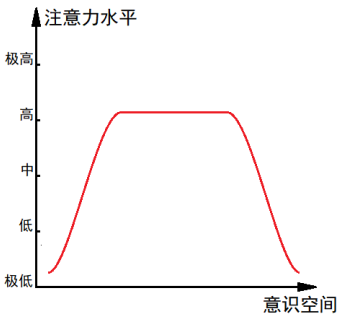
注意水平与身心状态的关系示意图：



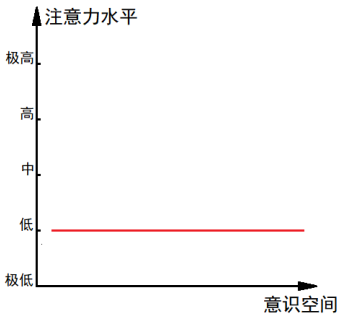
互动平衡的日常状态



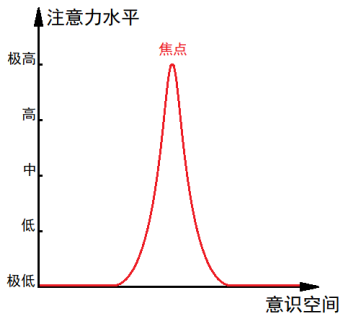
互动平衡的专注状态



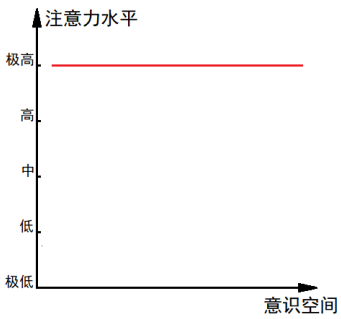
互动平衡的拼搏状态（定向反应）



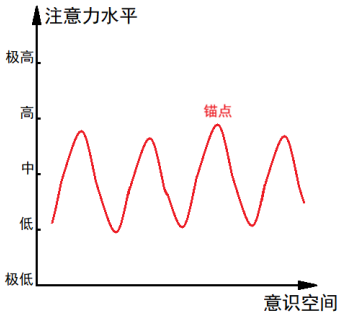
无可注意的日常状态（催眠状态）



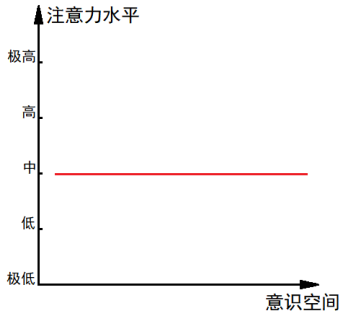
沉迷状态



无可注意的拼搏状态（绝望之时）



正念状态（集中式觉察）



正念状态（开放式觉察）

曲线的整体高度越高（或曲线与横坐标围起来的面积越大），对应的唤醒水平就越高。

虽然从主体间关系来看，处于沉迷状态的主体活动性明显受限，与之互动变得困难，但是在主观体验上，主体的活动性并没有消失，而是表现在了更狭隘的范围内和更细微的层面上，仿佛各种活动在他的眼中都被“放大”了。ADHD 人士可以从这些细微的活动中收获成就感。他们一方面对处在注意焦点之外的信息异常迟钝，一方面对处在焦点之内的信息极端敏感。这种极端化的注意力品质会显著放大急性压力事件的冲击力，甚至很多在常人眼中稀松平常的刺激对他们都可能有创伤性。反复遭受的急性创伤可能使他们意识到自己没有能力在专注和机警之间保持平衡，他们不得不保持一种躁动的状态以补偿缺失的活动性。躁动虽然可以补充感官刺激，增强笃定感，缓解沉迷状态所造成的如同“感官被剥夺”的体验，但也会给感知觉信息引入大量单调而强烈的“噪音”，使意识对象的切分更加困难，身心状态的调整也就更不可能。主体的注意力品质失去了适应性，在无可注意与沉迷状态两个极端之间不自觉地反复摇摆。

请牢记我们的“谱系观”。无可注意状态和沉迷状态绝非心理障碍者所独有，只是在他们身上更加典型而已。当常人无法融入某个情境，又不能轻易逃离时，他们就处在无可注意状态。当常人陷入“非此即彼”或“以偏概全”的思维模式中时，他们就处在沉迷状态。当 ADHD 人士置身于杂乱或喧嚣的情境（比如节假日的公园）时，他们的脑海会陷入一片混沌，不知道该注意些什么，只觉得吵闹。如果此时有一位善于共情、观察敏锐、受他信任的人（所谓“贵人”）带领他，让他知道什么值得注意，什么值得兴奋，那么他的 ADHD 表现会立刻缓解。

3.7.5瞬间定位能力

很多受困者拥有一种“瞬间定位能力”，他们可以在一幅无比复杂琐碎的画面上快速定位到某个极细微的目标，就像他们在游戏“威利在哪里（Where is Wally）”中所展示的那样。

这种能力是他们长期适应“无可注意”的结果。巨幅复杂画面带来的强烈

感官刺激可以使主体的唤醒水平迅速提升。在高唤醒状态下，“无可注意”意味着画面中的所有细节都平等地成为了注意的焦点。他们只需要短暂地忍受感官超载就可以快速地从一股脑涌入的琐碎信息中定位到需要识别的关键特征。

3.7.6异常注意力品质的常态化

注意力品质的长期变异使受困者表现出类似 ADHD 的特点。

受困者的呆滞使他们经常在产生感受时无法定位原因，很容易被诱导出“神秘体验”。因此有的受困者给人以神神叨叨的印象。

随着时间推移，主体可以从寻找感觉发展到寻找体会，寻找想法，探索内心世界各对象的关系。结合他观察到的各种细节知识，他变成了一个深度思考者。

丰富微妙的体觉是常人进行意识活动的背景。体觉的匮乏使受困者不得不用各种各样的白日梦和反刍式的思维活动填补意识背景中的空白，以维持唤醒。他已经适应了这种和现实有一定距离感的生活。甚至当他偶然进入互动平衡状态时，热烈环境下丰富的感官刺激会使他因“思考不过来”而体验到感官超载，平静环境下突如其来的流畅感会使他产生踩空般的坠落感，由此触发的应激反应会使他主动退出平衡状态。发展到了这一步，主体已经在相当程度上接受创伤了，他已经很难再靠自己走出来了。如果让已经长期失去互动平衡的主体对意识对象进行分类的话，他们很可能会将之划分为内心对象与外界对象，以对应这两种创伤化的意识状态。

创伤总是伴随着注意力的受限。呆滞、反刍、暴怒都是注意力受限的典型表现。注意力受限却能避免呆滞和反刍的人是坚强的，他们在受创伤后仍然保持了不算太差的社会适应能力，其代价是有更大概率发展出各种功能障碍性综合征，甚至罹患各种心身疾病，不可预料的暴怒也会让身边的人总是处在惊弓之鸟的状态。虽然他们的肢体并不显得笨拙，却在一定程度上长期滞留在了应激过程中的克制阶段。微活动衰退限制了“灵感”的涌现，这样的主体常常给人以“不太聪明”的印象。如果主体的社会支持系统和认知能力始终不足以使他完成对创伤事件的加工并释放被卡住的能量，主体就会因过度反思而形成一套过度精细却不可靠的认知图式，维持着貌似平衡实则摇摇欲坠的意识水平。这使

他们显得压抑而苛刻，容易产生焦虑障碍等各种心理问题。克制在长期尺度上无法稳定维持，被卡住的能量很容易在受信任的情境中因自我抑制减弱而释放出来。如果他们成为养育者，被养育者必然发展出相似的注意力缺陷。

在长期水平上，主体的活动性与意识水平保持一致。因此，习得性呆滞会使主体的微活动从衰退逐渐走向枯竭，同时主体也会在神游和无助中越陷越深。

消解不合理的认知图式，补全认知加工过程，是认知行为疗法的核心课题之一。

3.7.7敏感与愚钝

感觉加工敏感性（Sensory Processing Sensitivity）更高意味着个体对信息的处理更深入、情绪反应性更高、更富有同理心、对环境的细微之处意识更强以及更容易受到过度刺激。更容易受到过度刺激也就意味着更高的创伤风险。很多受困者喜欢用高敏感人格（highly sensitive personality）来解释自己的创伤易感性，但遗憾的是，这只是一种浪漫化的自欺。他们的高敏感是自己的身心整合水平显著滞后于自身感觉加工敏感度的必然后果。换句话说，这种敏感主要是是因缺少灵活性和统合性所造成的过度应激。

生理缺陷、心理创伤、体育锻炼不足、安全依恋缺失、生活经验匮乏等等都会使一个人对自己的身体以及身边的环境缺少控制感（表现在神经生理层面上就是前额叶皮层活跃度过低），很容易对刺激反应过度。他们的情绪反应性过强而行动能力很差，在生活中经常感到力不从心。好比一个对足球一无所知的人站在了战况激烈的球场上，他必然陷入茫然无措的状态，无法灵活地做出反应，也就更容易受伤。

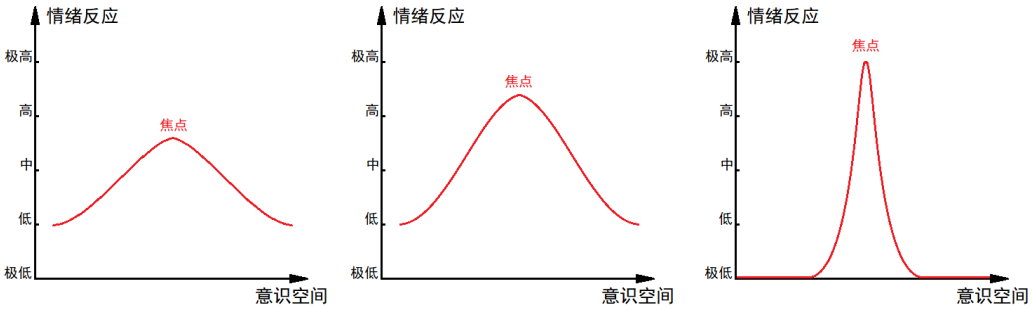
敏感与脆弱本是同义语，但给人的观感却大不相同。隐藏和美化自己的弱点是一种生存智慧，但这有时候也会造成自欺。有的人觉得自己在一些方面敏于常人，但总体适应能力却无法让自己满意。他们选择性地忽视自身反应不足的一面，将反应过度的一面描述成一种天赋，于是“高敏感人格”这样的概念就诞生了。适应能力强的人不会在乎什么敏感不敏感，因为他们有能力利用自己的敏感特质充分发展自己的适应能力。他们的世界非常广阔，不需要用“高敏感人格”这样的标签寻找认同，因为用“聪明”“有灵气”这样普通的词汇

形容他们就已经足够了。

创伤的痛苦体验使主体学会了疏远自己的体觉。这在熟悉的环境中并不会引发明显不适。可一旦主体置身于新奇的环境，由于没有共同的体觉作为根基，各种感官刺激就成了毫无关联的碎片。这些数不清的碎片一齐涌入大脑，必然造成“感官超载”。

某种程度上，“高敏感人格”、“多向思考者”这类概念都是对“聪明”的具体化，可以通俗理解为一种“不均衡的聪明”。个体因“聪明”而易伤，因创伤而显得愚蠢、笨拙、麻木、迟钝，这简直是人生的黑色幽默。高敏感特质是一把双刃剑，它既使主体暴露于更高的创伤风险，也使主体有机会与人建立更深刻的情感连接，发展出更高的认知水平，这又为超越创伤提供了工具。虽然“受创伤是因为聪明”这样的说法缺少意义，但能够走出创伤阴影的人毫无疑问都是聪明且有力量的人。

不同类型的情绪反应曲线示意图：



3.7.8 神游

自我调节能力是内化的交流圈，体现了主体积累的互动经验。儿童的自我调节能力有限，如果他们既无法建立交流圈又不能完成自我调节，就会产生躁动不安、注意力无法集中、视线难以聚焦等类似 ADHD 的表现。这种无法定神的恍惚状态如果长期持续，主体就可能逐渐学会用“神游（白日梦，daydreaming）”逃避压力，安抚自己。神游也是一种心智解离。

由躁动创造的感觉可以触发很多琐碎的意识活动，当主体集中注意于这些琐碎的意识活动时，他就进入了看起来很安静的神游状态。“神游”用认知层面的躁动代替了行为层面的躁动，用微妙的躁动代替了显著的躁动。受困者甚

至可以学会只要出现情绪波动或行为冲动就自发进入“神游”状态，以此抑制冲动，回避焦虑。他的活动能力逐渐萎缩为一个个极点而不再具备完整的行为谱系，他逐渐失去了与身体的连接，不再能感受到完整而丰厚的体觉，很难再信任自己的原始冲动（即“本能”）。然而人们的大部分日常活动都由来不及接受认知加工的下意识行为构成，人们通过这些下意识行为产生熟悉感并发展亲密关系，因此受困者只能惶惶不可终日。他竭力压抑着自己，忍受着焦虑与恐惧，可一旦有人指出他的压抑，他又容易感到羞耻甚至冒犯。

神游源自儿童时期的想象力。儿童的想象力之所以丰富，不是因为他们不能区分现实与想象，而是因为他们的身心极度活跃，体验极为丰富而强烈。想象是他们整合与表达这些体验的一种方式。例如两个儿童看着一个空白的屏幕就可以给对方讲出一系列故事，他们实际上只是在分享自身的一部分体验流。这些想象不仅不会使他们脱离现实，而且有助于他们学会与自己的体验相处，促进情绪智力的发展。神游之所以是适应不良的，在于受困者早已失去了儿童的活力，他们以封闭自我为代价才能从神游中获得一点点自以为生动其实十分单调的体验。

神游是主体在无法通过合作探索和情感联结获得安全感的情况下安抚自己的一种低成本手段。如果强迫他们放下神游，他们很可能体会到排山倒海般的恐惧感。

强迫性的神游是身体聚焦重复行为障碍（Body-Focused Repetitive Behavior Disorder, BFRBD）的微妙化形态。治疗身体聚焦重复行为障碍的技术，比如习惯逆转训练（Habit Reversal Training, HRT）和正念认知疗法（MBCT）可以直接用于治疗神游。那些能够引起最强烈不适的竞争性反应提示了这些重复行为的成因。

3.7.9思维反刍

利用新近获取的认知资源检查并修正自己的认知，使被悬置的定向反应得到完成的过程就是反思。闪回发生时，主体相当于在一个错位的、危机已经解除的时空中回到了未完成的应激过程中，从而有机会利用反思完成被悬置的应激过程。善于反思的主体拥有良好的创伤自愈能力，创伤在他们身上不仅不会

发展成PTSD，反而会成为他们改善应对能力的契机。反思绝不是为了找到各种抽象概念描述自身缺陷，诸如缺乏“同理心”，遇事不够“冷静”等，这类抽象的表述毫无意义。只要我们愿意，我们可以找出无数种此类表述，最后发现自己根本一无是处。

对于一般的受困者来说，闪回带来的强烈消极情绪会立刻触发战或逃反应。虽然这无助于问题的改善，但至少在当下抑制了闪回。已陷入习得性无助的受困者不会轻易触发逃反应，他们的问题也就更隐蔽。僵瘫使广泛而积极的联想变得困难，对创伤经历的再加工也就成为了无米之炊。他们会屈从于这些被唤起的消极情绪，使自己情绪化。此时过往各种消极体验会相互唤起，主体将被焦虑、羞耻、愤怒、悲痛等消极情绪淹没。他们无休止地品味这些痛苦的生活碎片，却无法整合出有意义的叙事，更不能作出任何应对。这种认知能力被强烈的消极情绪限制，主体沉湎于回味负性生活事件无法自拔的现象就是思维反刍。这些消极情绪使主体陷入思维反刍，思维反刍使主体在这些消极情绪中陷得更深。低下的活动性和二者之间的正反馈循环使思维反刍具有强迫性。

消极情绪胜过没有情绪，它们可以为丧失活力的身体带来能量，维持唤醒。主体可以从这些单调而强烈的体验流中获取兴奋感，以此逃避孤独和恐惧而不必承担任何实际的责任。因此思维反刍中的真正主角是这些情绪而非那些伪装成反思的各种不切实际的想法。

当人们面对真正紧急的状况而不得不活跃起来时，思维反刍就会自动消失。受困者需要的不是反刍式的穷思竭虑，而是激活麻痹的身心。在陷入反刍的第一时间找出闪回的触发器，往往是很多人走出创伤的起点。在经过了长期泛化之后，触发器可能已经十分隐蔽。主体必须依靠自己在正念练习的过程中培养的觉知力才能找到它们。

3.8 身心状态视角下的创伤

创伤造成身心状态受限。在观察者眼中，这意味着中立状态的变形乃至缺失。在主观体验上，这意味着身心状态的转换变得吃力。

3.8.1 中立状态的变形与瓦解

充满活力的中立状态是所有身心状态的组织核心（类比维持站位的能力是高效完成大多数活动的前提）。身心状态的切换往往需要中立状态作为中介，好比我们从一个座位转移到另一个座位之前通常需要先站起来。我们在两种机动性较弱、能量水平较低、较易保持稳定的身心状态之间切换时，往往要用一种机动性较强，能量水平较高，较难维持稳定但更具一般性的身心状态作为过渡。

创伤性事件摧毁了主体对自身中立状态的信任，将原本富有活力的中立状态与情绪闪回相关联。从此，健康的中立状态被主体看成了一种存在创伤风险的“脆弱状态”，主体只能借助于寄生性紧张代偿出一种“不合作”的姿态以回避或减轻痛苦。被阻塞的能量不仅没有得到疏导，反而被受困者所依赖。主体的中立状态从舒展的状态变成了某种不自然的状态。这种不自然的状态不仅使主体的活动能力受限，同时也限制了主体获取信息的效率和所获得信息的质量。好比一个习惯了垂头丧气的人总是会错过环境中很多细微但重要的变化，因为他根本就没看见。

受困者的习惯状态以“混沌散漫”为基本特征，他的日常活动往往给人以拖泥带水、效率低下的印象，就和他的日常体态不是瘫倒在座位上（瘫软）就是蜷缩不展（僵直）一样。当外界平静时，这种状态可能有利于创造力的发挥，也可能使主体深陷思维反刍。当外界热闹或混乱时，这种状态容易使主体陷入癫狂的情绪体验和混乱的认知状态，造成严重的适应不良。

这种拖泥带水的活动风格可以借助打字的比喻得到理解。打字时我们首先要把手放在初始键位（类比中立状态）上，手指在每一次击键后都要轻巧迅速地回归初始键位，准备下一次击键。对于打字熟练的人来说，手指的每一次移位-复位循环（类比紧张-放松循环）都是打字行为的基本单元，这使主体可以充分将精力集中在输入的内容上。但对于不熟练的人来说，他的双手很难轻松完成这种循环，手指在准备下一次击键时不是还停留在上次击键的状态（类比意识对象的残迹）就是出现了不自觉的游移（类比神游）。他的手指会很快在键盘上迷失，因此他不得不时时注意键盘，根本无法留出足够的精力去感受自己输入的内容（类比述情障碍与情感淡漠）。

中立状态的变形并不是终点，正如弯腰驼背并不是关节退化的终点。变形的中立状态难以发挥统合身心状态的作用，削弱了主体的抗压能力，主体因而更容易遭受创伤，新的创伤又会促进中立状态的变形。因此，中立状态的退化一旦开始就很难停止。随着中立状态变得越来越“模糊”，受困者终有一天会“醒悟”：这种说不清道不明的状态有什么意义？自己为什么要保留这种状态？受困者最终放弃了中立状态，就像关节严重退化而无法站立的人不再勉强自己走路而是选择了爬行，因为轻松的卧姿至少比勉强的站姿更具活动性。中立状态的瓦解使他得到了某种程度的自由，尽管这种自由再也无法与常人的自由相提并论了。

常人对中立状态通常无感，好比我们在大多数时间里都意识不到膀胱的存在。只有当我们因为无法忍受尿意而完成排尿后，强烈的放松感才能使我们感受到一个排空的膀胱意味着什么。

在日常活动中，受困者可能因为某些意外因素（比如经历了本文 5.4 节中的事件）一时解除了寄生性紧张，短暂回归到了接近中立状态的状态。此时身上由于创伤积攒的问题就会充分暴露——他僵瘫得太久了，如同长期卧床的病人，身体（心智）已经丧失了活力，能量水平非常低。他会感到自己如大病新愈一般，身体有一种“供血不足”般的无力感，就像因受到长时间压迫而麻木的肢体（比如睡觉时被压到的胳膊，或蹲得太久的双腿）刚刚恢复知觉时候的那种感觉，但同时他又感到了久违的放松与灵便。中立状态解除了活动能力的限制，解除了寄生性紧张的省减效应，此时主体才能深刻体会到长期的僵瘫意味着什么。

活动性的下降使主体的心智缺少感知觉反馈，这有利于他在进行创造性的想象活动时能够充分投入，但却不利于实时互动的稳定进行。这使他在遇到困难时总是倾向于向内而非向外寻求支持，如果找不到支持，就很容易陷入“神游”。低下的能量水平使需要高能量的身心状态难以维持稳定（类比站立比平躺对体能有更高要求），因而他的抗干扰能力极差，很难形成连续而宽厚的体验流和丰沛的情感，而社交是体验流的对抗与协同，因此受困者缺少社交动力。强烈的体验流甚至会唤起创伤体验，令他们恐惧。

中立状态的变形与瓦解使对象或事件的残迹能够维持更长时间，主体因而

更容易沉浸于思维反刍。

长期的僵瘫使主体缺少有目的的行为，有目的的行为可以使感官得到有意义的组织，从而避免感官超载。受困者总是苦于感官超载，只能借助神游和思维反刍结构化自己醒着的时间。

正常的驱力难以驱动如此缺乏活力的身躯，造成了受困者的“启动困难”，他们常常需要借助额外的微观管理甚至“神游”或“呵斥”产生额外的刺激才能发起行动。微观管理使他们的行为显得笨拙而低效，“神游”使他们脱离现实，“呵斥”容易让他们陷入不良的依恋关系和自挫性的次生情绪（比如懊悔、自责和羞耻）中。

受困者的创伤化进程一般开始得非常早，他们的中立状态几乎从未存在过。许多受困者终其一生都无法理解中立状态是什么滋味。

回归并加强最佳中立状态是受困者实现转变的最大难点。陌生的身心位意味着陌生的体验流，陌生的体验流有时意味着重生般的喜悦，有时却意味着恐惧和无所适从。受困者在生活中多多少少都经历过各种觉醒瞬间，但是他们很容易因为应激而主动退出觉醒状态。他们的自救之路不仅需要更多的支持，也需要儿童般的激情、无畏和坚持。

3.8.2 摇摆不定的性情

序列化行为通常依赖于特定的身心状态，正如平躺时做不出站立时的很多动作。身心状态的切换同样属于序列化行为，它们一般依赖于中立状态。中立状态的瓦解导致身心状态的切换和序列化行为的触发变得困难，造成了受困者的启动困难和“慢热”性格。如果把能量水平过低造成的启动困难称作“推不动（躯壳）”，那么中立状态的异常造成的启动困难可称作“找不着（感觉）”。

中立状态的瓦解使主体对身心状态之间的过渡与转换失去了掌控，身心状态之间的关联不再简单清晰，受困者很难根据情境轻松随意地调节身心状态。在受困者眼中，促成身心状态变换的因素往往难以捉摸，不知怎么地自己的状态就变了（很可能发生了情绪闪回），当自己想变的时候却常常变不了。

以“日常状态”“学习状态（定向状态）”和“对抗状态”的转换为例。

常人在日常状态下处理一般事务，在学习状态下扩展自我，以此保证自己既不被被琐碎的日常压垮，又能保持持久的学习能力。在日常状态下，主体干脆利落地反击破坏规则（挑战了主体对环境的信任）或影响流畅感（挑战了主体对自身本能的信任）的行为，确保日常活动高效进行。当体验流发生明显扰动，主体意识到新信息的出现时，就会放慢显著活动的节奏，停止自卫性的辩解或反击，开始试探性地让渡控制权，此时主体就进入了学习状态。主体在学习状态中必须根据互动对象的反应和自身的感受动态地调整控制权的分享与回收，最终完成意识对象的切分，体验流的扰动得到平息，主体也就回归了日常状态。学习状态是兴奋的，信赖的，同时也是笨拙的，吃力的，脆弱的。如果意识对象的切分始终无法完成，回收控制权就会逐渐成为主要任务，主体就入了对抗状态。在微活动层面上，整个转换过程流畅而高效，宽厚的体验流从未中断，主体因而得以保持自信，也就敢于维持高能量状态。受困者的各种身心位处于无组织状态，日常状态与学习状态的分化并不清晰。他在处理日常事务时无法确认互动对象的可信度，简单的日常活动对于他来说就像学习和探索一样耗费精力。面对各种不可信对象倾倒的“垃圾”，他只能任由自己被“污染”。而当他需要进入学习状态时，又很难放下戒备，注意力无法集中，不知道如何展开探索。

常人习惯于将身心保持在易于发挥高效能的状态。当他们的状态受到干扰和威胁时，他们可以立刻察觉问题并作出反应。而受困者由于找不到中立状态，只能在各种代偿状态之间随机切换，反复摇摆，勉强维持局面。虽然他们不知道自己出了什么问题，但他们知道自己的状态并不正常，因此他们总是很心虚。当他们的状态受到挑战时，他们无法明确责任的归属，因此常常倾向于委屈自己讨好别人。表面上看起来他们总是在勉力维持一些不健康的人际关系，实际上他们是在勉强维持自己那摇摇欲坠的身心状态。他们敬畏常人身上那种流畅自如，与常人相处时总是不自觉地放低自己，因而更容易受伤。

3.8.3社会性退化

驱力的不断受挫使受困者逐渐丧失了认识和探索他人的意愿和能力，失去了对自己和他人的主观现实和情绪模式的好奇心，逐渐与自闭人士趋同。他们

眼中只有一个个抽象的、无法理解的“人”而没有一个个具体鲜活的个体，正如在许多研究者的眼中只有一个个抽象的诊断标签，没有一个个鲜活的受困者。

3.8.4 中立状态与述情障碍

与 2.7 节不同，这里从身心状态的视角探讨叙情障碍的形成。

一个人如果从未振作过，就不可能知道什么是消沉。

一个人如果从未安宁过，就不可能知道什么是焦虑。

一个人如果从未灵活过，就不可能知道什么是僵化。

一个人如果从未与他人建立过有意义的情感连接，就不可能知道什么是孤独。

比起普通成年人的心理障碍，CPTSD/ADHD/ASD 等问题在干预中的最大难点，就是主体从未体验过精神上的“中立状态”。他们对各种精神体验的理解与常人有很大差异，他们即使意识到自己有问题，也根本不可能知道努力的方向。所有有关常人体验的描述，对他们来说都是似是而非的东西。跟他们讲自我调节，就好像跟一个从没吃过巧克力的人讲巧克力的味道。

要想借助别人的描述认识一个东西，或者想要向别人分享自己认识的东西，就必须要有一个公共的参照。人们通过事物相对参照的偏移来描述和理解它的状态。中立状态就是这样一种参照，它让分享体验成为可能。常人通过感知自身状态相对中立状态的偏离情况来认识自己的情绪波动。如果一个人的习惯状态严重偏离中立状态，他就会感到任何日常语言都不足以描述自己的真实情感，从而导致类似述情障碍的表现。好比一群人如果都是站着（处在中立位），他们在接东西或递东西时就会有一个身体前倾、手臂向前伸出的动作。但如果其中有一个人一直在趴着，他这时候需要的就是抬头挺胸、手向上伸的动作，他的感受必然和大家截然不同。如果主体不能认识到自己的习惯状态与常人的差异，他就无法解读自己的独特感受，更不知道该如何调整，因为常人的表达对于他根本不适用。

以“抑郁者”为例。抑郁者以“抑郁（无助）状态”为习惯状态。过低的活动性和唤醒水平使他们看不见自己的孤独和恐惧，只能感到莫名的悲痛和愤怒。他们责骂着自己的亲人和朋友，推开了能帮助自己走出困境的人，使自己

在孤独和恐惧中越陷越深。

又以“孤独者”为例。孤独者以“孤独状态”为习惯状态。对他来说，任何互动都有“扩展边界”的意味。面对陌生人，他会因为互动中的一点点流畅感就表现得十分兴奋，在他人眼中显得毫无边界感。面对亲近的人，他会因为一点点怠慢就强烈地感到背叛。他实际上是把所有人（甚至潜在的敌人）都看成了自己的心灵依托，仿佛所有人都是他的养育者一般，他的内心似乎从未长大。这既会使他人感到冒犯，也会给自身安全带来风险。但他却无法说明原因，无法理解自身状态在互动中的实际变化过程，他甚至比被冒犯的人还要震惊、伤心和懊恼。他的心灵干涸得太久了，迫切地想要抓住一切机会滋养自己。长期遭受情感遗弃的人可能把任何互动都理解成“回家”。他们无时无刻沉浸在孤独之中，却从来没有认识到什么是孤独。不管面对什么压力，他们的第一反应总是伴随着怨恨和恐惧。

自救者一旦体验过健康的中立状态，就再也不愿意回到以前的状态中了。中立状态的回归会使他们感到如重生般的深刻觉醒。

3.9 复杂性创伤的形成

3.9.1 受伤与停滞

一棵树，如果得不到足够的养料就不会长大，更不会开花结果。另一棵树，不断地砍掉它的枝丫，向它投放害虫，它也不会长大，也不会开花结果。虽然结局一样，但这两个故事完全不同。前者是“停滞”，后者是“受伤”。成长的停滞会造成“脆弱状态”，因脆弱而反复遭受的创伤又会造成更全面的停滞。二者互为因果。人们往往过度关注受伤的故事而忽视停滞的故事，过度关注那些被砍掉的枝丫留下的伤口而忽视那些本该存在却从未长出的枝丫，过度关注那些显著的戏剧性事件而忽视那些在成长历程中本该如呼吸一般自然发生却从未发生过的最普通的日常细节。

个体成长的过程就是个体在社会关系的支持下，在与现实的各种互动中，不断遭遇冲突，化解冲突，从自然人发展为社会人的过程。成长的过程在某种程度上就是心灵不断受伤又不断长好的过程。这可以类比为健身。肌纤维在反

复的抗压过程中不断地发生微妙的撕裂和超量的修复，逐渐变得越来越结实，主体对身体的掌控感也越来越强。

不论是“停滞”，还是“受伤”，来源都是遭遇冲突-解决冲突的循环发生的卡顿，也就是各种未完成的定向反应所导致的主体自身状态的长期“悬置”。这些未完成的定向反应可以理解成各种“未竟之事（未完成的斗争、不胜任的挑战）”或“应发生而未发生之事（被忽视的心理危机）”。自己的心中有太多放不下的东西，也就无法放开自己去重建与世界的情感连接。催促和批评都毫无意义，因为他们也不想这样。这些未竟之事意味着主体的心灵地图中存在过多的空白，严重影响了地图的连续性，以致即使发现了新地标也不知道该填在哪里。它不仅不完整，而且失去了可扩展性。

一些创伤自救理论将超越停滞的过程称为“自我母育”，将超越受伤的过程称为“自我父育”。

3.9.2创伤性压力与创伤化

在持续不断的社会合作中，主体的应对能力从他们熟悉的、胜任的层次向他们可能理解、可能胜任的层次发展。主体作为独立个体所能胜任的内容与主体在社会合作中所能理解和完成的内容之间的距离被维果茨基（Lev Vygotsky）称作“最近发展区”。创伤普遍形成在主体跨越最近发展区的过程中。

发展性与创伤性是压力的两个侧面。压力不仅会挑战主体的技能储备，也会挑战到他现有的社会支持系统（本文在交流圈中讨论所有概念，因此当说到社会支持系统时，也是在说它和主体的关系，受困者很容易忽视自己在关系中拥有的力量）。一种压力被视作发展性压力还是创伤性压力（traumatic stress），很大程度上取决于主体在应对过程中体验更多的是同心协力还是被遗弃被孤立。

所有创伤性压力的本质都是各种人祸而非天灾。不论问题严重到什么程度，安全感都不主要取决于特定的个人经历，而是更多地取决于主体能否成功地对经历做出有意义的理解。不论是突如其来的的急性压力事件（显著的创伤性压力，也称“创伤事件”），还是长期、反复、无法逃脱的慢性摧残（微妙的创伤性压力），都不足以直接造成创伤。真正造成创伤的是主体在这些经历中体验到的“情感遗弃”。他们体验到了无法名状的痛苦，身心状态受到了剧烈扰

动，却没有得到现实世界的任何回应，仿佛这些痛苦理所当然，毫无意义。他们无法对这些痛苦进行有效的处理，遭遇冲突-解决冲突的循环无法完成，身心状态无法复原。他们无法从压力中获得成长，把自己困在了心灵的无人之境，只能用自我抑制来逃避痛苦。长此以往，主体将形成可怕的情感盲区，他们将变得呆滞而愚蠢。

创伤性压力以霸凌者般的姿态告诉主体，他原来的注意力品质并不足以应对“普通的”压力，于是主体只能从平衡的注意力品质退化到局限性的、僵化的注意力品质，以应付随时可能出现的灾难。虽然主体对付特定伤害的能力增强了，但对付意料之外伤害的能力更弱了，甚至别人健康的攻击性都足以触发他的恐惧感。他变成了一个开不起玩笑、扛不住压力的人。

创伤事件已经成为历史，创伤则不断破坏着我们当下的生活。如果把创伤事件理解为地震，把受伤的心灵比作废墟，创伤就是我们在废墟上感受到的各种不便。我们需要的是重建家园而非坐在废墟上咒骂或者陷入对地震成因的抽象讨论。对创伤经历的过度关注会赋予创伤更多影响力，甚至造成二次创伤。就好像你在废墟上拼命踢踩很可能会崴脚一样。

在身体层面上，创伤早期表现为活动性受限。主体的身体和精神处在不自知的紧张或瘫软状态，与环境明显不协调。在情感层面上，创伤早期表现为逃避情绪波动，任何触动都令主体感到如临大敌。主体仿佛只剩下恐惧和愤怒等简单激烈的情绪，就像亡命天涯的歹徒一样心虚。心虚使主体倾向于给自身各种冲动作出消极的解读，于是愈发自卑。在认知层面上，创伤早期表现为闪回、噩梦和自我否定，仿佛随时可能出现自己无力应对的危险。

随着创伤的不断累积，主体的探索与应对能力将愈发受限甚至完全丧失。他被卡在了不知如何是好的状态，被放不下的紧张感折磨着，只能用消极的自我安慰策略（神游、解离、自我刺激等）回避压力。创伤限制了主体的情感直觉，使他们只能依赖逻辑分析理解人际互动，自然无力应对复杂多变的人际关系。长此以往，主体将代偿出各种明显偏离社会常模的认识图式与行为模式。

任何人在一生中都会经受各种创伤性压力，但只有一部分人会留下严重的长期创伤（应激障碍）。想克服创伤，就要向那些承受过创伤性压力而免于陷入创伤的人学习。而且是在观察中学习，光听故事没用。也就是说，受困者应

该努力寻找榜样而非同类。

那些能够走出创伤的人普遍拥有强大的反思（再消化）能力。他们可以利用闪回完成对创伤的再加工，完成被卡住的应对过程，释放被阻塞的能量，让自己归于平静。他们的再加工过程所依赖的资源往往来自生活中对真诚、善良、勇敢、担当等美好品质的强烈共情。如果主体在闪回中总是崩溃、逃避或陷入反刍，就可能发展出越来越复杂的问题。

3.9.3创伤易感性与二次创伤

人们平常说的“脆弱”在心理治疗理论中称作“创伤易感性”。创伤使人脆弱，脆弱使人更容易遭受创伤，“麻绳专挑细处断”就是这个道理。

一个孩子摔了一跤，趴在地上开始哭闹，此时一只蝴蝶从身旁飞过，他马上站起来跑了过去，之前的沮丧一扫而光。生命皆有韧性，每个人身上都有着与生俱来的强大自愈力。真正将个体长期困在创伤之中的，往往是二次创伤。

想象一个已经有一定行为能力的孩子，因父母的疏忽而被遗弃在了无人的荒野。他起初会感到强烈的无助和恐惧，但很快会冷静下来，开始独自探索。他可能会意外发现这个孤独世界的魅力，他甚至可能以为父母希望自己了解并守护这片小世界。当他最终找到了父母时，会感到格外强烈的兴奋。他满怀期待地摆出了自己的探索成果，可父母不仅没有表现出任何认同或关怀，反而不假思索地将它们全部当成了脏东西并对他加以嘲讽和指责。此时孩子会感到整个世界坍塌了，他在情感上彻底失去了归宿。

这就是二次创伤，二次创伤拥有远比一次创伤强大得多的杀伤力。很多在观察者看来并不严重的事件却给主体造成了极大的创伤，这样的创伤往往属于二次创伤。例如有的人会在失恋后陷入严重抑郁状态，他们会因此寻求心理治疗，但实际上失恋绝非原始创伤源。创伤的种子在成长的道路上早已埋下，只等待着最后的契机破土而出。被记录的所谓创伤经历很可能只是种子萌发前浇的最后一次水。创伤越多，个体的适应能力就越差，也就越无力应对新的创伤，就像雪球越滚越大越势不可挡。创伤与创伤易感性（心理脆弱性）互为因果，我们无法断言一个人是因脆弱而留下创伤还是因创伤而变得脆弱。探索创伤的过程就像剥洋葱一样，一层套着一层，每一层都足以使人泪流满面，很多人会

半途而废。

受困者普遍脆弱，长期的心理脆弱性必然导致生理脆弱性，反之亦然。长期的脆弱性往往表现为整体能力的过度虚弱和局部能力的过度代偿。受困者的很多特殊天赋（诸如“超级注意力”等）都是长期代偿的结果。

受困者在创伤化表现爆发后会出现强烈的倾诉欲，然而他们的倾诉往往锚定在爆发前的最后经历及其狭隘归因上。他们不懂得挑选倾诉的受众和时机，也没有足够的运气遇到那样的受众和时机，因此很难得到理解，他们也就更加孤立。鲁迅小说《祝福》中的祥林嫂就是这样的人。

3.9.4生理脆弱性与心理脆弱性

心理素质与身体素质存在相互作用，二者在长期水平上保持一致。一方面，创伤形成得越早，对体格的影响越大，个体的运动系统、消化系统、呼吸系统、内分泌系统、免疫系统、神经系统和循环系统等各个方面的机能都可能受到严重干扰。极端情况下，婴儿可能在出生时就十分虚弱。另一方面，身体的行动力是一切应激过程的基础。身体越虚弱，个体应对压力的能力就越差，也就越容易遭受心理创伤。生理脆弱性与心理脆弱性互为因果，很难说明孰先孰后，这是一个蛋-鸡循环问题。“天生体弱”和“天生高敏感”一样，都是过于草率的说法。

体弱的儿童在探索充满未知的世界时往往承受着比常人更大的压力，体验着比常人更多的精神痛苦，导致他们对各种刺激都比普通孩子更加敏感，但行动却比普通孩子迟钝得多。如果养育者因自身局限无法回应这些痛苦，无法向他们提供支持，他们就很容易发展出复杂的创伤表现。

体弱意味着行动吃力，应变能力弱。充满活力的孩子与生活中的重要他人经过了充分的互动，与养育者建立了深刻的安全依恋关系，能够较为平衡地看待养育者身上各种易解和费解的表现。他们可以在第一时间识别出养育者状态转化的信号，及时调整自己的互动模式。例如“爸爸大多数时候都非常可靠，但偶尔也会非常令人费解。有时他会变得跟雕塑或者机器人一样，被一股沉默而僵硬的气场包围，仿佛他的内心突然陷入了某种看不见的危机。这时我需要立刻调整状态，暂时离开他或者尝试用其他方式接近他，不然他很可能会爆发

出让我难以应对的一面。”这种敏感度和反应力使孩子能够免疫创伤。等他们再长大一些，他们就可以理解养育者的那些极端反应实际上是由养育者自己的心理困境造成的，与他们无关。但体格偏弱的孩子往往会说“爸爸（妈妈）总是喜怒无常，令人摸不着头脑。”分开养育者身上养育性的一面和创伤性的一面这一任务压力太大，这些孩子无法胜任。这些孩子的现象学世界总是充斥着可怕的不确定性，他们的崩溃（前额叶皮层“宕机”）是迟早的事情。

3.9.5微妙的生理缺陷与情感忽视

身体的隐秘缺陷是造成童年情感忽视的重要原因之一。这些缺陷的根源往往可以追溯到早期发育的异常。这些发育异常所造成的各种微妙的缺陷（肌肉缺陷、神经缺陷等）就像一个无时不在的隐形魔鬼，持续干扰着主体的活动，妨碍主体与他人建立积极的情感连接。面对压力，这样的主体远比常人更容易感到无助和被忽视。他们的养育者可能自以为十分关心他们，但他们的困境实际上从来没有被任何人看见，人们只能看见他们的胆小和脆弱。人分析问题不仅要靠推理，还要靠身体的感受，甚至推理的可靠性也要靠感受来确认。脆弱而偏离常态的身体很难提供笃定的体觉反馈，这些孩子感到自己仿佛缺失了某个重要的感官维度，比起别人似乎存在一种难以言说的局限。

以全身韧带松弛症为例。该病是自胚胎期开始出现的一种发育异常，基本表现为关节活动范围过大。在放松状态下，患者的身体如同一具螺丝松动的货架，可以轻易作出常人必须经过辛苦锻炼才能作出的很多动作。患者全身各处关节的稳定性、关节的抗冲击能力、身体的平衡能力、活动中的感知觉反馈的清晰性都比常人弱得多。患者在同等条件下远比常人更容易受伤，在从事各种活动时需要过度绷紧身体以维持身体的稳定性和抗冲击能力。这种自己制造的紧张状态与急性压力事件造成的过度紧张具有相似的生理与心理意义，甚至更加难以定向。在很多时候，患者虽然直观上保持着正常的姿势，但由于关节并没有摆放到最合适的位置，导致肌肉的发力方式与常人并不相同。患者总是感觉哪里不太对，但别人却完全无感，仿佛自己出现了一种挥之不去的“幻觉”。这种无法定向的感受和应激过程中的定向反应困难拥有相同的心理意义。患有全身性韧带松弛症的主体唯有进行科学的肌肉训练，增强关节周围的肌肉支撑

力，用强大的肌肉补偿松弛的韧带才能实现自救，否则他们的身体会随着年龄的增长暴露出越来越严重的问题，他们甚至可能在中年阶段就出现严重的关节退化。

如果你认同上一段表述，可能会觉得全身韧带松弛症造成的心理脆弱性很容易干预，只要科学健身，用强大的骨骼肌实现代偿就行，但它的病理很可能没这么简单。韧带发育的异常可能意味着全身结缔组织的异常，神经系统因而变得脆弱。很多受困者（尤其是涉及 ASD/ADHD 时）的神经系统极为脆弱，很容易受到药物和病毒等因素的干扰，他们对麻醉类和止痛类药物常表现出惊人的不耐受。

小脑发育的微妙异常可能造成与全身韧带松弛症相似的影响，不再赘述。

有的生理缺陷具有一定的遗传性（比如前文提到的全身韧带松弛症）。这类生理缺陷无法在现有医疗条件下直接干预，只能从其他方面代偿，比如避开有毒物质、避开有毒人际关系、科学合理健身、培养乐观心态等等。有的生理缺陷与生活习惯有关，而生活习惯往往有家族一致性，这类生理缺陷只有动员全家成员或者等到被养育者独立生活后才能得到有效干预。相似的生理缺陷导致相似的适应能力不足，适应能力不足又强化了被养育者对养育者的心理依赖，使被养育者更容易受到养育者创伤的影响。这些因素使心理创伤表现出类似遗传病的家族聚集性。

3.9.6创伤的代际传递

如果说解决物质匮乏是上一代的使命，那么解决情感忽视就是我们这代人的任务。每一代人的事业都来自上一代的未竟之事，这种传承是不可否认的事实。相比原生家庭创伤，本文更倾向使用“创伤的代际传递”，后者不仅能够涵盖前者的中心思想，而且突出了当事者的主体性。

婴幼儿拥有最健康的活力和最饱满的激情，他们在被抚育的同时也在将这份能量回馈给养育者。受困者在成为父母时，实际上获得了一次重启第一类成长的机会。如果他的创伤化已在认知层面根深蒂固，那么他将亲手摧毁这份生命的馈赠，成为一名“创伤化养育者”。不安全的依恋关系、创伤的代际重演和不良精神状态的共情等等都是创伤的传播途径。

创伤会影响养育者与被养育者建立依恋关系的能力。当无法与养育者建立安全依恋的个体成为养育者后，他们与子女建立依恋关系的过程往往会遇到相似的困难，这就是“不安全依恋的代际传递”。儿童对养育者的情绪状态非常敏感。创伤化严重的养育者经常陷入不自觉的解离之中，他们的身体虽然在场，精神却根本不在场，这会严重影响儿童的安全感。极端情况下，创伤化养育者完全无法与被养育者建立安全的依恋关系。他们将培养出心理问题最严重的儿童。

但这样的养育者毕竟是极少数，更多的创伤是在爱的名义之下完成传递的，这才是代际创伤最令人痛惜的地方。被养育者的身体素质越差，和养育者的心理羁绊越深，就越容易受到父辈创伤的影响。

儿童从父母身上最早学到的最重要的东西就是如何与自己的各种感受相处。习惯于解离和回避感受的父母常常养育出习惯于解离和回避感受的儿童。习惯了解离和回避，自救动机自然也不强烈。本文更加关注那些遭受情感遗弃（非主观恶意）而又没有陷入解离、一直苦苦硬撑乃至发展出各种心身疾病的人。这些可怜的孩子仿佛一直在等待他们的父母“回过神来”，等待父母们变得可靠。他们甚至会把这种互动模式扩展到一般的人际交往中，导致自己总是陷入毫无必要的纠缠。因此，和养育者心理羁绊最深的人不是那些健康成长、人格独立的个体，而是那些在不安全依恋（尤其是矛盾型依恋）关系中长大的人。很多和依恋有关的故事看似感人至深，背后却隐藏着残酷的家庭真相。

3.9.7共情与创伤的传染

很多心理问题的成因不是“父母不爱自己”，而是“奶奶不爱爸爸，而爸爸又太爱自己”。祖辈无法正常养育父辈，给父辈留下了严重的心理创伤。父辈和后代关系亲密，创伤通过情感共振实现了传染。但所有家庭成员都无法理解这些莫名其妙的情感体验是从哪儿来的，他们只能归结为自己的问题或归结为世界本就如此。

不良精神状态的共情是传染创伤的重要途径。儿童越是生性敏感，这种现象就越容易发生。因此，我们可以通过了解养育者对自身成长史的建构理解被养育者的创伤表现。比如有一些存在遗弃抑郁问题的儿童，人们在他们身上找

不到任何与遗弃创伤相关的经历。但是他们的父母中的一方往往从小就在家里不受待见，属于被母亲嫌弃、被兄弟欺凌的角色。这样的父母平时往往有唉声叹气的习惯，身上时常弥漫着一股忧郁的气场。他们喜欢跟儿童分享自己悲惨无助的人生经历却无法让儿童从中收获任何力量。子女只能从这种无助的家庭氛围中认识到自己是家庭的负担，是不被世界接纳的多余人。又比如某些存在ADHD 表现的儿童，他们的父母中往往有一方特别喜欢给儿童打岔。这些父母一边声称支持孩子，一边又在孩子探索环境、表达好奇的过程中大惊小怪，态度激烈地提出各种否定意见，但他们丝毫不觉得自己的表现有何不妥。当旁观者指出了他们的问题时，他们就好像突然失忆了一样，只会矢口否认（由此可见受困者及其家庭成员的自我报告有多么不可靠，了解创伤决不能过度信任当事者的陈述，还应该有侦探般的洞察力）。这些父母往往从小就缺少支持，经常被人像踢皮球一样踢来踢去，自己却找不到原因，他们身上时常弥漫着一股令人感到压抑和恐惧的气场。这些在迷迷糊糊中长大的人很容易培育出患有ADHD 的儿童。

这些孩子体验到的恐惧感、被遗弃感其实都是父母的感受，只是他们幼小的心灵还没有办法在共情父母的同时完成课题分离（topic separation, differentiation）。很多儿童之所以容易被毒性羞耻感淹没，只是因为他们深切地感受到了养育者的恐惧，他们自责只是因为他们不希望养育者沉浸在恐惧中，他们希望能为养育者分忧。

创伤总是从家庭中最具影响力的人开始，蔓延至每一个家庭成员。了解创伤的代际传递机制不是为了怨恨父母，而是为了让自己更全面地看待痛苦。自己超越痛苦的过程正是承担家庭责任的过程，家族中世代传承的业力将在自己身上终结。不论创伤如何揭示了残酷的家庭真相，这最终仍然是一个延续爱、传递爱的故事。

没有责任意识的人倾向于逃离原生家庭，有责任意识的人倾向于承担责任，改变家庭困境。有责任意识的人不仅是在疗愈自己的创伤，同时也在疗愈家庭乃至社会的未来。这种发心和格局决定了他们有更好的预后。当前有关原生家庭创伤的讨论存在鲜明的性别特点。当今社会虽然赋予了两性同等的受教育权，却没有培养女性足够的责任意识。我们的社会和家庭在一定程度上仍然把女性

当成“客人”甚至“寄居者”对待。女性有关创伤的讨论无不充满了鲜明的去责任化色彩。女性受困者要想获得良好的预后，恐怕必须学会把自己当成男人对待，像社会要求男性那样要求自己。当今社会，女性完全也可以成为“君子”。

共情可以传染创伤，这提醒我们爱惜羽毛，不要在不值得的人身上浪费能量。

3.9.8家庭关系中的课题分离

理想的课题分离是承担自己的责任，尊重对方的选择和权利，同时保持彼此的情感连接。这在一般意义的人际关系中很重要，但是在家庭关系（尤其是中国式家庭关系）中却不太现实。

家庭关系中的课题分离，意味着分清楚自己的问题和家人的问题，分清楚自己的事情和家人的事情，分清楚自己的使命和家人的使命。但家庭关系的复杂之处和动人之处就在于你中有我，我中有你。这是个人力量的源泉，但同样也是创伤代际传递的根源。很多时候，道理讲清楚了，爱就没有了，心也被掏空了。另一方面，因为家庭对于个体拥有原初的塑造作用，如果个体的课题分离能力能够达到如此水平，他也不会受限于代际创伤。与其说课题分离能力可以帮助我们终结创伤的代际传递，不如说是打破代际创伤的锁链之后，我们才深刻认识到了什么是真正的课题分离。课题分离只能帮到心理问题并不严重，可以一点即通的人。

虽然我们无法否认个别养育者不配为人父母，但人无完人，绝大多数的父母都是爱孩子的，只是自身的局限使他们总是事与愿违。他们 “自以为充满爱地”摧毁了自己的孩子，这才是代际创伤最令人扼腕的一面。它是命运给那些风雨飘摇的家庭开的一个最恶毒的玩笑。心理治疗再怎么教他们学习课题分离，也没办法让他们放下亲人之间的心理羁绊。创伤的毒素又不断借由这种心理羁绊反复交叉感染每一位家庭成员。

分析创伤的代际传承机制有助于认识创伤的影响，却无助于创伤的解决。问题的解决方案不会出现在问题成型的地方。要打破代际创伤的锁链，视野就不能受限于原生家庭。任何创伤的解决，都依赖于当事者找到自己的力量，发

展自己的事业。这些都需要在家庭关系之外去探索。当主体在追求生活目标的过程中找到了志同道合之人，这些以共同目标为基础的关系将成为他们发展更广泛社会关系的基石。心理治疗只有在此方向上不断努力，主体才可能超越原生家庭。他们只有在超越了原生家庭之后，才有能力考虑拯救其他家庭成员的可能性。局限于家长里短、生活琐事和恩恩怨怨的人注定只能永远被困在人生的初始设定中。

3.9.9消沉的代际传递

“未竟之事”形成的时间越早，在主体的行为模式中占据的位置就越基础，主体就越难意识到它的存在，在尝试突破它时感到的痛苦就越强烈，主体的行为表现就越接近 ASD。

本节以消沉的代际传递为例讲述未竟之事概念的应用。

面对热情洋溢的伙伴，有的人不但不能唤起心中的热情，反而会感到莫名的恐惧，甚至有意识地避免融入大家。他为自己的孤独感到苦恼，却无法说明原因。

这种表现可能与主体和母亲的关系有关。这种关联并不绝对，但它是一个值得参考的模型。这位母亲由于某些原因而具有抑郁、消沉、迷糊的性格。主体只要表现出健康积极的互动模式，就一定会在与母亲的互动中碰壁。长此以往，他将学会抑制自己的能量，降低自己的唤醒水平，以确保自己与母亲的互动能够稳定而流畅。他在这种消沉的状态下充分体会了与母亲之间的依恋。从此，这种消沉的精神状态就和安全与信任关联了起来，而兴奋的精神状态则跟挫败与孤立关联了起来。

当他走出家门，开始在更大范围内与人建立关系时，先前的互动模式自然会成为新关系的起点。大家的热情会唤起他的能量，而他在兴奋的同时，莫名的恐惧与孤立感也会被反射性地唤起。

如果他的应对能力发展良好，可以在强烈的情绪中保持与当下的连接，那么他就会把这种莫名的恐惧理解成挑战的一部分。他接受了伙伴们的挑战，而伙伴们的热情会最终感染他。他将突破恐惧，融入新的集体。当他回到家中时，充满活力的他必然会和母亲产生冲突，他将认识到母亲身上存在的严重问题。

他为了与伙伴们之间的羁绊而破坏了与母亲之间的羁绊，这也是成长的必经之路。当然，他也可能发挥聪明才智最终改变母亲，这是皆大欢喜的结局。

如果他的应激能力发展得并不充分，或者身体过于虚弱，强烈的恐惧就会打断他与现实的连接。他识别不出伙伴们身上的善意，感受不到环境的可靠，只是单纯感到了危险，这会使他有意识地逃避互动。他为了维持与母亲的羁绊而牺牲了与同伴建立羁绊的可能性。此后，他就只能和像母亲那样抑郁、消沉、迷糊的人打交道了。这会严重影响他的社会能力的发展，使他容易遭受各种创伤。

在第二种情形中，“重新审视与母亲之间的羁绊”就成为了一件未竟之事。

3.9.10 推拉效应

一名儿童通常拥有两位主要的养育者（一般是父母）。如果两位养育者的养育风格并不协调，由其引发的强烈定向反应就会驱使儿童进行各种“出圈”的探索以明确自身处境。这既可能帮助他实现自救，也可能使他走上歧途。如果两位养育者都是创伤化的养育者而且类型互补，比如一位专横苛刻而另一位怨天尤人，一位自我关注而另一位抑郁消沉，那么两位养育者就会对儿童形成一种“推拉效应”，这可以类比为谈判中的“红白脸战术”。这种“合谋”对CPTSD的形成具有可怕的助推作用。

如果养育者在生活中的不同方面表现出显著的矛盾，比如在生活上悉心呵护，在精神上完全忽视甚至极尽打压，同样也会产生推拉效应。衣食无忧者抑郁，劫后重生者感恩。物质富足而精神匮乏远比纯粹的逆境糟糕得多。二者的落差所产生的推拉效应可以摧毁被养育者的意志力。

3.9.11 情绪稳定性的丧失

当受困者好不容易从消沉中暂时苏醒，表现出探索行为时，长期悬而未决的切分和未释放的对抗性很容易将他们迅速推向恐惧和躁狂，随后他们又为自己的失态感到羞耻而重新陷入抑郁，如此在两个极端之间反复摇摆。这与双相情感障碍（bipolar disorder）有本质不同，受困者的躁狂在一般人看来是可怕的，但并不存在社会危害性，相反，它是恐惧和退缩的表现。

情绪的涨落和转化具有自发性，即使置之不理，焦虑也会逐渐转化为兴奋或抑郁，反之亦然。这也是人体生物性节律的体现。但是，只有完成定向反应，进而完成切分和应对，情绪才能真正平息。否则，主体将不断被日常各种微小刺激反复触发情绪闪回，他将反复在呆滞麻木和情绪爆发之间耗尽自己的精力。

人类一般从 6 岁开始逐渐褪去儿童式的激情，受困者因生动感缺失而造成的强迫症状往往在此时开始显露。在青春期后期（15 岁左右），剧烈波动的激素水平和日趋复杂的人际关系所带来的各种体验如排山倒海一般令他们无所适从，他们的各种焦虑、恐惧和抑郁问题会在此时全面爆发。25 岁以后，身体激素水平趋于稳定，他们开始逐渐冷静。处处碰壁的生活经历会迫使主体走上自救之路。

3.10 早期崩溃

3.10.1 创伤知情思想的扩展

创伤知情（trauma informed）一定程度上可以理解为对“创伤多样性”的知情。创伤多样性意味着心理创伤远比人们目前所了解的更加复杂、更加广泛、更具影响力。人们的各种行为表现的背后可能都有创伤的影响，但这些创伤以及它们发挥影响的过程却极少得到足够的认识和报告。创伤可以发生在个体成长过程中的任意时刻，个体可能在胚胎期和婴儿期就已经遭受了严重的创伤却没有得到任何关注。创伤经历可能依托于具有清晰故事线的创伤性事件，也可能十分复杂微妙，难以构成故事性较强的叙事。基于创伤知情原则的心理治疗面向每一位个体的独特创伤经历，而不是生硬的医学诊断标签。

创伤从一般到特殊可以划分出连续的谱系。创伤越有社会性（一般性），就越容易得到充分的关注和处理。人类社会的诸多仪式（例如葬礼）都具有创伤治疗（接纳丧失，完成哀悼）的性质。创伤的个体性（特殊性）越强，创伤就越容易被忽视，极端情况下甚至根本无法在公共话语空间中找到恰当的表达方式。像“胚胎期创伤”这种概念光说出来就足以惊世骇俗。长期以来，人们对创伤的认识过于肤浅，相关研究手段和表达方式都过于简陋。对于无法在创伤框架下得到合理解释的问题，人们只能贴上各种“精神障碍”的标签，将问

题的责任推给各种说不清道不明的“先天因素”，这些个体也就被彻底边缘化了。

随着人们对创伤的认识日渐深入，越来越多的心理障碍开始重新在创伤的框架下得到审视。行走江湖，我们每个人或多或少都会经受各种心理创伤，在某种程度上，我们每个人都是受困者。我们的许多强烈动机的背后可能都有创伤的影子，这并不丢人 。认识到创伤的普遍性和多样性，有助于我们对创伤及相关心理障碍“去妖魔化”和“去污名化”，唤起更多人对创伤的重视和对自救者的同情。

因创伤而寄存在身体中的能量既可以带来多余的压力，也可以产生额外的动力。其具体意义完全取决于个体如何与它们相处。心理治疗并不是为了简单地释放这些能量，而是为了让主体学会灵活地掌控这些能量。

3.10.2 神经多样性与标签化

与智力障碍者不同，ASD 人士时常体会到强烈的受限感，他们觉得自己完全有能力表现得更加出色，可这副躯壳却仿佛不听自己使唤一般，但他们显然又没有瘫痪。这种模糊的缺陷感经年累月地发展，逼迫他们在“接纳自我”与“改变自我”之间作出选择。

接纳自我将促使 ASD 人士寻求某个共同的身份标签。对于这类主体，神经多样性意味着身份标签的多样性。ASD 或 aspie（这类 ASD 人士的自称）并不是一个中性的名词，而是代表了一种身份认同。他们的独特性因此拥有了可分享的意义，这使他们感受到了安宁与力量。他们不再盲目追求改变，而是将这份独特性看作了命运的礼物。他们虽然在某些方面相比常人更加受限，却也因此在另外一些方面有机会得到更加充分的发展，所谓“失之东隅收之桑榆”。改变虽然可能使他们在某些方面的生活质量得到提升，但也可能使一些被他们珍视的能力（比如局限性的超级洞察力和瞬间定位能力等）遭受意外的损失。这些能力往往极具观赏性，有时也有实用性，令许多 ASD 人士引以为傲。当 ASD 人士因觉醒而不再具有典型 ASD 表现后，由于智力资源被重新分配，他们一般会丧失这些能力。虽然丰盈的情感世界补偿了他们的损失，可他们还是会感到遗憾。人的智力如同肌肉，不论主体相信自己强健的肌肉是一种天赋还是

来自锻炼，用进废退都是不争的事实。告知这类 ASD 人士“所谓的神经多样性特质只是一类特殊的创伤化表现”将使他们感到冒犯。

另外一类 ASD 人士则在改变自我的道路上努力探索着。对于这类主体，神经多样性就是人的多样性，这是一个无需强调的概念。对于愿意欣赏他们的人，他们和其他所有人一样，都是独一无二、不可替代的。如果他们要给自己贴上标签，那么也应该给每一个人贴上标签。对于心存偏见的人，创造一个标签并强调其独特价值并不能改变那些人的看法，反而会加深隔阂，引起无谓的争论，招致更多恶意。虽然早期创伤不像一般的创伤性事件那样具有清晰的故事性，但这类主体仍然更愿意将自己的异常表现置入 PTSD 的谱系而非自闭症谱系障碍之中。他们宁可丢掉神经多样性人士的标签，认为只有觉醒才能使自己的人格得到充分的舒展。只有改变“小我”，才能接纳“大我”。每一位个体的创伤故事都是独特的，这条探索之路如此孤独，以致很多人都会半途而废，在不断的挫败中陷入习得性无助。其中每一位坚持到最后的人都称得上是英雄。本文只适用于第二类人。

3.10.3 显著的早期崩溃

早期创伤涉及的创伤经历有一定隐蔽性，然而最终造成的心理后果和致命创伤经历相同甚至更严重。这是它与成人创伤最大的不同。这种温和性不符合创伤的一般定义，因此早期创伤也称早期崩溃（early breakdown）。

身心分化在胚胎发育到一定阶段时就已经开始，因此，身心解离几乎可以发生在一生中的任意时刻。极端情况下，儿童可能在出生之前就经历了严重的身心解离。那些发生在成长历程极早期，造成了严重身心解离的创伤经历就是早期崩溃。儿童与生俱来的依恋行为系统(attachment behavioral system)受到了近乎致命的干扰，但儿童最终幸存。母亲在孕期的身心健康危机（例如目睹亲人突然去世而精神崩溃、长期失眠）、母亲的慢性健康问题（例如抑郁症）、胚胎发育过程中的异常（例如受到有毒物质干扰）、分娩时发生的严重窒息、养育者与婴儿建立依恋关系的过程受到的强烈干扰（例如婴儿遭受重伤却无人照看）都可以成为早期崩溃的来源。以恐惧为底色的早期崩溃会造成类似 ADHD 的表现，以绝望为底色的早期崩溃会造成类似自闭症谱系障碍的表现。这些孩

子的创伤经历无人见证，他们只知道自己好像天生就是这种状态。

胎儿的情绪状态几乎总是与母体保持一致。如果母亲在自己从怀孕到婴儿周岁以前的这段时间里遭受了严重的精神创伤（或者长期承受精神创伤），巨大的痛苦所引起的身体内环境（internal environment）的变化和个人气场的变化可以给胎儿或出生不久的婴儿造成巨大压力，甚至直接影响他们的神经系统的发育。胎儿与初生婴儿无法区分自身与环境，无法区分属我与非我。他们从接收到的反馈中意识到自身各种丰富细腻的活动是得不到回应的，是不必要的。对这种如石沉大海一般的恐怖体验，他们唯一有效的应对方式就是利用自己的神经可塑性（Neuroplasticity），调整大脑皮层神经突触的连接，使大脑进入一种相对封闭的运转方式，把自己变得呆滞麻木，以适应这种“情感遗弃”。这使主体在人生起点上就处在 “自我关注”的精神状态。情感遗弃并非由养育者主观上的恶意造成，但它却是孩子不得不面对的“情感现实”。实际上，正是因为不存在主观恶意，情感遗弃才难以被回溯。它将以一种隐秘的方式对孩子的人格发展产生持续影响，使孩子很难与他人建立起强有力的情感连接，从而形成类似自闭症谱系障碍的表现。

母亲的抑郁会影响胎儿的大脑发育，在抑郁、焦虑的家庭氛围中长大的孩子普遍存在严重的记忆检索困难。这样的孩子对于很多事物必须要知其所以然才能记住，因此常常显得过于热衷追根究底。他们在陷入困境时很难像普通孩子那样轻松地通过回溯细节找到切入点，游刃有余地作出反应。对于他们来说，世界似乎格外混乱，自己一不小心就会受到伤害。他们在巨大的精神压力下将逐渐代偿出 ADHD 或者 ASD 的特点。

窒息刚刚发生时，主体通常会拼命挣扎。随着氧气逐渐耗尽，挣扎逐渐停止，肌张力明显下降，主体逐渐失去知觉，最终走向死亡。一部分受困者由于窒息时间过久而出现了不可逆的脑损伤，他们会被诊断出智力障碍。另一部分受困者的窒息时间相对较短，他们受到的影响更多地表现为身心活动水平的下降，这类主体有很大概率发展出 CPTSD 或 ASD。幸存的初生婴儿并不懂得什么是最佳唤醒水平，他们只是在本能地适应身体，适应环境。他们接受了这种迷迷糊糊的“僵瘫”状态作为自己人生的起点，在此基础上与世界互动，这为他们一生的坎坷命运埋下了伏笔。僵瘫使他们不得不额外绷紧身体以完成各种本

该轻松完成的日常活动，这种僵瘫与创伤性事件造成的僵瘫拥有相同的生理与心理意义。

3.10.4 微妙的早期崩溃

有些儿童的早期崩溃虽然不那么显著，但同样不容忽视。那些出生时身体就软塌塌的，活动量明显低于一般同龄人的孩子很可能在出生前经历过微妙的的身心解离。他们与生俱来的依恋行为系统(attachment behavioral system)受到了虽不极端但仍然不容忽视的干扰，导致他们有发展出 ASD 的潜在风险。这样的孩子远比普通的孩子更脆弱，更“难以亲近”，生活中一个不起眼的压力源就可能刺激到他们。他们的养育者天然肩负着更沉重的责任，必须投入养育更多的爱和精力。这些孩子一旦受到情感忽视和代际创伤的影响，就很容易发展出 ASD 的表现。

3.10.5 ASD 和 ADHD 的创伤故事

早期崩溃是 ASD 和 ADHD 的根本来源。各种总微妙的生理缺陷、童年的情感忽视和创伤的代际传递则是它们的催化剂。ASD 和 ADHD 属于极端 PTSD（eXtremely Complex PTSD 或 eXtremely Early PTSD），本文对 CPTSD 的表述都适用于它们。受困者的创伤化进程开始得越早（尤其是早于一周岁时），其长期表现就越接近 ASD 或 ADHD。由于早期发育进程遭受的剧烈扰动，主体在人生的起点上就处在“脆弱状态”。这种状态使他在人生早期的探索中极易被各种在常人看来微不足道的刺激伤害到。ADHD/ASD 患者的创伤化进程在幼儿期甚至更早的人生阶段就已经开始，经过长期迁延和代偿，形成了乱麻般复杂混乱的表现。人们很容易看见压死骆驼的最后一根稻草，但“屋漏偏逢连夜雨”才是各种心理障碍形成过程的真实写照。不同的受困者在相似的表现之下可能隐藏着完全不同的病因和病理。将 ASD/ADHD 归咎于基因是过于偷懒的做法，ASD/ADHD 只是一个症状集合而非科学的诊断标签。

使用形象化的语言，早期崩溃受困者的创伤故事可以讲述成：一个天生身体虚弱的人，被一种虽然客观上并不强大但却比自己强大得多的力量击倒在地，他想站起来却发现很困难，而常人因为意识不到严重性所以并未提供足够的帮

助，然后他就只能爬着生活。他逐渐适应了这种生活方式，虽然不那么方便但也不再觉得痛苦。如果他要改变自己，首先要借助各种工具和方法努力使自己站起来，回到久违的中立状态，然后通过强化和拉伸调节因为长期爬行而失衡乃至萎缩的肌肉，才能恢复正常的生活。此后他需要通过不懈锻炼使自己的活力超过常人，才能实现创伤免疫。

这种讲述方式有点像精神分析中使用的象征和隐喻，但它简明直接，完全没有隐喻中神秘主义的玄妙内涵。事实上，ASD 人士和创伤易感者普遍存在着各种与生俱来的身体缺陷。脆弱的身体决定了脆弱的心理，正所谓生理动力学决定心理动力学。

神经可塑性可以造成 ASD，也可以将主体从 ASD 中拯救出来。神经可塑性是心理障碍可治愈性的生理基础。

3.10.6 儿童创伤的隐蔽性

虽然我们区分了微妙的早期崩溃和显著的早期崩溃，但是从事后补救的角度来说，隐蔽性是儿童创伤的基本特征。

一方面，人们只会在刚刚陷入惊吓状态时有明显的初始反应，之后的创伤反应会越来越隐蔽，特别是当人们不知道该关注哪些线索时更是无迹可寻。这种隐蔽性本来是生物体为避免暴露弱点而形成的基本生存策略，结果却成了疗愈创伤的障碍。另一方面，父母总是一边担心子女会遭遇最坏情况，一边又希望他们能有最好的结果。在这种情绪激动的状态下，创伤的重要线索很容易被“一时冲动”掩盖。儿童创伤的识别也就成了一项复杂艰巨的任务。

3.11 创伤的交织

主体的创伤化就是主体间关系的创伤化。创伤可以依据主体与创伤性事件中的其他主体的关系划分为早期创伤（早期崩溃）、家庭创伤、社会创伤和急性创伤。

早期创伤使儿童更加需要稳定安全的环境。只有足够敏感、温暖和稳定的养育者才能和这样的孩子建立安全依恋关系。敏感度不足甚至自身存在严重创伤的父母在养育这些孩子的过程中会遇到很大困难。他们难以理解这些孩子的

需求，因而无法与之建立安全依恋。同时，这些孩子对早年分离、频繁更换照料者等依恋相关创伤更加易感。

家庭创伤来自人生早期的依恋关系（主要是主体和养育者之间的关系）的异常，它和早期创伤存在重叠关系，无法划出一条明确的分界线。正因如此，ASD与CPTSD无法准确切分。父母遭受的早期创伤、家庭创伤、社会创伤和急性创伤都可以成为子女所遭受的家庭创伤的来源。

社会创伤来自主体在和他人建立并发展关系的过程中遭受的挫折。在不安全依恋关系中成长起来的个体（尤其是被抑郁型母亲养育的个体）无法处理社会交往中的微妙情感信息。他们要么完全不知所措，在强烈的被遗弃感中陷入绝望；要么只能代入家庭关系，轻信他人，因此容易遭受各种伤害。

急性创伤来自各种突发的天灾人祸。

考察创伤事件中的主体间关系必须考虑到主体自身意识对象的分化程度。例如同样是来自家庭成员的创伤，对于一个社会经验丰富、意识对象高度分化的个体，可能仅仅属于急性创伤的范畴，但对于一个意识对象分化程度较低的个体，他会感到自己的整个人格都被否定了。主体与创伤性事件中的其他主体的关系越密切，创伤就越隐蔽，越微妙，越复杂，否则就越显著，越清晰，越单纯。

创伤会增加创伤易感性，创伤越多，就越容易产生新的创伤。早期创伤使主体承受压力的能力在人生的起点上就弱于常人，面对家庭创伤和社会创伤也就更加无力，因此ASD人士很容易发展出一般意义的CPTSD。受困者“混沌散漫”的气质使他们很容易成为不怀好意者的目标，因而更容易遭遇急性压力事件，从而患上PTSD。

各类创伤的交织可导致极为复杂的创伤化表现，对治疗师和当事人的勇气、耐心、细心和智慧都提出了极高的要求。

4 自助的基本工具

本章所述工具，重要性不分先后，读者可以从自己最容易上手的部分开始。在开始之前，读者需要确认前文所述两位“引路人”已经就位。

更多工具可参考文末推荐书目。

4.1 生物性节律

4.1.1 生物性节律的概念

从主体-世界交流圈的角度来说，一切活动都是在紧张和放松的循环中有节奏地进行的。小到每一个精细动作的完成，大到个体的生命周期乃至社群的发展周期，都有显著的周期性。这些不同尺度的节律相互叠加，构成了生物性节律的分形结构。

吸气-呼气循环是最简单自然的紧张-放松循环。动中觉察一般都会要求主体在缓慢的深呼吸中调整并体会身体状态的变化。呼吸可以影响唤醒水平。劳动有助于安全快速地提高唤醒水平，而平稳的深呼吸有助于维持唤醒水平稳定。

呼吸是生物体的一种内在生物性节律。所有同时受到高级中枢、低级中枢和自主神经调节的生物性节律，包括但不限于“呼吸”“睡眠”“吞咽”“排泄”等都是重要的自我调节工具。严重的心理问题一般都是从破坏这些生物性节律开始影响主体的生活质量。如果一个人外出工作期间排便规律，而居家期间总是频繁腹泻或长期便秘，这种生物性节律的变异很可能提示了家庭创伤的存在，反之则可能提示了社会创伤的存在。

从主体间交流圈的角度来说，一切活动都是在积极探索和安抚滋养的循环中有节奏地进行的。所有在不安全依恋关系中长大的孩子身上都存在探索-安抚节律的异常。回避型依恋的儿童不再积极寻求安抚，探索的成就感成了安抚的唯一来源。矛盾型依恋的儿童不再积极探索，设法寻求安抚成了唯一有意义的探索。混乱型依恋的儿童完全无法体会探索与安抚的概念。

作息节律是和呼吸一样重要的生物性节律。受困者的生物性节律远比常人

脆弱，早睡早起、恢复正常的作息节律是他们自救的第一步。

通过体育运动改善植物神经系统的功能，有利于改善人体的生物性节律。

4.1.2情绪节律

很多人都体验过半夜醒来被沮丧和恐惧淹没的感觉。拖着疲惫的身体，各种消极悲观的念头在脑海中浮现：父母的争吵是否预示着家庭的破裂？暗恋对象的冷淡回应是否意味着自己已经败露？等等。到了第二天中午身体最有活力的时候，自己又变得雄心勃勃，回想起半夜的想法，觉得简直荒唐可笑。

在这个过程中，我们的身心状态经历了一次从低落到亢奋的摆动。即使我们安静地待上一天，没有受到什么重大刺激，我们的情绪也会经历从消沉到高涨的循环。这就是我们的“情绪节律”。人的精神状态和身体状态一样，既有昼夜周期，也有季节周期、生命周期、乃至时代周期。不同层面上的周期相互嵌套，使我们的心理状态即使在平静时也会像天气那样不断变化。

各种功能障碍性疾病和心身疾病（psychosomatic diseases）的病情波动周期往往与主体的情绪节律直接相关。

4.1.3摆动

与情绪波动对应，我们的身体也会同步表现出收缩与舒展的节律，这种节律在体感疗法中被称为“摆动（pendulation）”。摆动代表了身体天生的恢复性节律，是自我调节能力的核心。

摆动的过程就是身体内在的抵抗力（stability）、恢复力（resilience）和自组织力（organization）发挥作用的过程。摆动就像海浪，不断冲刷着过往经历在我们心中留下的各种烙印。在大部分时间，摆动是在我们的意识中不被注意的角落里完成的，因此我们的注意力可以集中在手头的工作上。如果涌起的情绪性记忆过于强烈或者主体因为种种原因陷入无所事事的状态，这些情绪化素材就会占据意识的中心，主体可能因此陷入思维反刍。

正如运动会改变呼吸和心跳的节奏，使心跳和呼吸变强变快一样，主体可以通过从事一定强度的劳动来改变情绪波动的节奏，使情绪的波动变得更强更快更清晰，主体就有机会充分体验那些寄存在身体中的创伤能量，让它们在流

畅感的冲刷下流出身体。这是一项有挑战性的工作，自救者必须有能力胜任。

4.1.4劳动

在本文语境下，劳动可以理解为有目的、有产出、被认可的活动。这样的活动最容易产生流畅感。但要注意我们的最终目的是为了体会而不是为了逃避痛苦，因此劳动强度不可过低，也不宜过高。过低无法造成足够的情绪波动，过高会妨碍体会。主体可以在生产和生活中探索适宜的劳动强度。在不妨碍体会的前提下，这个强度越高越好。

4.2 眼动脱敏与再加工技术的启示

眼动脱敏与再加工技术（Eye movement desensitization and reprocessing，简称 EMDR）是一种被广泛应用的创伤治疗技术。其简单的手法与神奇的效果令很多复杂的创伤治疗技术相形见绌。很多理论家对此进行了各种解释。这里简单介绍一种躯体体验视角的解释：

视觉信息对于主体感知空间、保持平衡、调节自身状态具有重要意义。我们如果尝试一下在睁眼和闭眼的状态下分别保持单腿站立，就能认识到这些平时从未被自己注意的信息有多少价值。因此，“眼动”是一种高效的活动，它既可以打破僵瘫的状态，又不会因过于吃力而造成分心。在创伤体验被唤起时，它可以使主体免于陷入完全的僵直，身体的自我调节能力因而能够保持活跃，这使主体有能力直面被唤起的痛苦体验，进而有机会消解创伤。

从这一观点出发，所有可以打破僵或瘫状态同时不会造成显著分心而且具有清晰反馈的活动都具有潜在的疗愈价值。但是，对于自救来说，这样的活动还必须拥有足够的强度。

创伤如同窨井，怎么掉进去就要怎么爬出来。走出创伤和形成创伤一样需要巨大的能量支持。EMDR 看似简单，“眼动”完全谈不上什么强度，但它离不开治疗师的指导。治疗情境的规范设置和治疗师清晰、温和、坚定的声音是疗愈能量的重要来源。如果没有治疗师，受困者就需要找到其他可靠的社会资源。当社会资源暂时不可用时，我们的身体就成了最重要最可靠的能源。我们可以充分依靠自己的身体为自己供能，让自己能够在直面创伤能量的同时感受

到身体的灵活和强健。

自助读物往往回避有关强度的话题。一方面是因为很多读者乐于接受“我是弱者”这样的暗示，这可以减少他们的压力。另一方面，作者普遍不想看到读者因为尝试高强度活动而出现意外。所以我在这里也要贴一个免责声明：我的所有建议都是基于亲身实践提出的，它们在我身上经检验足够安全，但这无法代表一般情况。身体素质的评估需要医疗知识，而我不是医生。

团体性活动效果最好，但是对组织者和参与者都有一定要求。我在自省时最喜欢的运动是跳绳。无绳跳绳不算，因为它无法提供足够的反馈。跳绳可以让我们在直面最强烈恐惧感的同时和我们的内在力量保持有效连接，从而有机会完成对痛苦体验的再加工。跳动不止的状态正如拳击手的跳动，使我们的身体充分激活，随时准备战斗。这种在正念状态下进行的跳绳被我称为“正念跳绳”。

在把跳绳用于疗愈之前，我们的耐力和熟练度需要达到足够水平，自己才不会因为反复中断或体力不支而烦躁或分心。这听起来似乎很麻烦，实际上并不难。只要动作规范，跳绳越熟练就越轻松。它远比跑步要省力，安全。跳绳作为有氧运动，可以促使呼吸加深，血液循环加快，这有利于保持正念状态。我们的目标不是竞速，稳定远比速度重要。对我来说，时长控制在半小时以内，节奏稳定在50次/组，总数达到800次就已经足够（我还额外添加了一定配重）。只要我们科学训练（网络教程俯拾皆是），坚持不懈，即使从零起步，也能在三个月之内轻松达到这样的水平。对于艰辛的疗愈之路来说，这样的投入微不足道。实际上，一旦我进入状态，实际强度会远超这些数字。

允许恐惧、退缩、僵硬的能量和柔软、灵活、有力的能量在体内自由碰撞，同时坚信后者终将战胜前者，这正是爱的具象化。只有和最深层次的恐惧交手过的人才能迎来质变。在很大程度上，心理治疗就是在教会我们对自己的恐惧保持诚实。如果一个人能够单凭自身天赋做到这一点，那么所有的心理治疗知识都是多余的。

4.3 肢体对抗能力训练

4.3.1 对抗的意义

CPTSD 的干预仅从心理层面入手远远不够，健身是绕不开的话题。健身的过程会迫使主体的注意力在整体感受、具体动作和知觉细节之间保持平衡。这种平衡注意力的体验具有重要的治疗意义。

创伤让心智失去了和体觉的连接，而肢体对抗（比如拳击，摔跤等）需要主体实时地准确注意双方的身体状态，时刻保持和自己身体的对话，根本没有工夫进行微观管理，这有利于重建心智和身体的同步性。拳击和摔跤以安全的方式教人学会如何在控制中释放攻击性。参与者可以在全身心投入的过程中突破应激障碍的限制，重建对危险的适应性反应。

拳击手在竞技过程中会经历各种焦虑、恐惧、兴奋、惊讶、愤怒的瞬间。如果参与者充分接纳了这些强烈情感，完成了挑战而没有陷入崩溃，那么他们的现象学世界也就经历了一次洗礼。

这类训练需要满足三个基本要素：能够唤起一定程度的恐惧感；具有一定技巧性；足够的安全措施。

4.3.2 肌肉的强化与松解

脆弱的身体使受困者在进行肢体对抗时很容易受伤，因此在培养肢体对抗能力前需要完成基本的力量训练，使自身力量至少达到常人的水平。受困者普遍存在身体缺陷，在训练的最初阶段要重视过渡，避免轻易超过自身极限。要确保自己在每次训练完成时处于兴奋大于痛苦的状态，如果出现了意料之外的痛苦，一定要找到确切的原因，必要时可向专业人士求助，一定要避免出现练一个月就不得不休息两个月的情况。

许多受困者在训练过程中都会发现自身的某些力量格外强大。例如一些人一个俯卧撑都做不了，却可以轻易扎上 10 分钟马步。长期蜷缩不展的姿态使他们的大腿前侧肌肉过度紧张。这些过度紧张的肌肉需要通过拉伸或按摩得到充分的松解。

有关无伤运动的具体内容，可参考文末推荐书目中有关著作。

4.4 注意力的牵引

将主体从极端受限的注意力中解放出来，和自身体验保持一个恰到好处的距离的过程就是牵引。牵引注意力的直接目的是逼迫主体信任并依靠自己的本能。前文提到的正念、劳动、EMDR 和肢体对抗都体现了牵引的思想。这里再提供一些牵引的技巧。

4.4.1补充知觉反馈

一个连刷牙都觉得吃力的人在洗漱时偶然抬头看了一眼镜子中的自己，意外发现如煎熬一般的洗漱过程变得轻松了。镜子中的影像不仅吸引了一部分注意力，还给自己补充了知觉（这里主要是视觉）反馈。强迫性的自我凝视被削弱了，自我抑制也就被削弱了，这时候他才意识到这些简单的活动本可以很轻松。

密集而温和的人际互动同样具有补充知觉反馈的作用。更多的实时反馈可以让主体对自身的各种自发活动和本能反应更加“放心”，从而能够更加灵活更加随意地支配注意力。

4.4.2看见空白

当我们注意画面中的某个图案或者注意环境中的某个声音时，我们注意的是具体的“有”。但是当我们注意到所有的图案和所有的声音时，我们就注意到了图案之间的空白，注意到了声音之外的寂静，注意到了“无”。正念练习经常提示我们温和地注意周围的一切，就是为了让我们透过这些具体的事物注意到那些无所不在的将一切托举起来的力量，和这种力量待在一起。

4.4.3看见他人

孤独是很多受困者的现象学世界的底色。在他们在为自己的体验赋予的画面中，自己几乎永远是唯一的“活物”。即使偶尔有其他人被提及，也毫无主体感，仿佛木偶或演员一般。让他们沉浸于这样狭隘的画面只会强化他们的注意力缺陷。

解决方法有两种。一种是让他们开始想象之前先置身于各种人员相对密集的环境中，当他们有了足够的体验以后，就可以要求他们必须以类似场景为素材展开想象。如果需要安静的画面就想象自己身处图书馆或自习教室，如果需要热闹的画面就想象自己身处大商场或集市。另一种是当发现他们的画面十分孤独时，要求他们不断扩展画面，让画面变得更广、更远，直到囊括足够多的人。比如一个人想象自己坐在一间屋子里。如果有声音，就让他注意这些声音是怎么来的，是谁在制造这些声音。如果很安静就让他注意房屋的结构，注意楼上楼下和邻居。如果是荒郊野外的独栋，就让他想象自己的交通方式，想象自己手边的每个物品是如何从无到有，最后来到自己身边的，它们经历了哪些人之手。

4.4.4树立榜样

很多人都有这样的经历：自己一个人跑步时，跑两步就跑不动了，强烈的疲惫感使自己的身体仿佛灌了铅一样，根本活跃不起来。但是只要前边有另一个跑步的人，或者是其他一直跑在自己前面的有趣事物，他就好像突然变得坚强了。他能坚持的时间几十倍地增长，跑完也感到了更多的振奋而非疲惫。

这就是榜样的力量。榜样激活了我们的内在资源，使我们达到了更适于特定活动的唤醒水平，同时减少了对自身疲劳感的关注。受困者中有很多人都特别依赖这样的榜样，当他们独处时，“启动困难”表现得极为严重，似乎干什么都特别吃力。可是，一旦有一个靠谱的同伴，哪怕这位同伴并没有刻意激励他，他也会变得情绪高涨，注意力集中，行动力惊人。

4.4.5找到精神寄托

我们在培育一株植物的过程中无论如何细心照料，最终仍然要依赖植物自己去生长。我们只能仔细观察植物的生长状况，不断获取反馈，及时调整自己照顾它们的方式，让它们可以充分施展天性，长得越来越好。我们看到植物在自己的细心培育下茁壮成长，也会感到自身的活力得到了肯定，“自我”得到了扩展。

许多心理障碍者的病情往往会在他们的子女被诊断出更为严重的心理问题

时迎来转机。主体从自救转入了救人，就像一个直面挑战的拳击手那样，彻底摆脱了自怨自艾和自我凝视，走出了自己狭隘而闭塞的小世界，释放了自己的战斗本能。森田疗法认为，治疗心理障碍的最高境界是放弃治疗，但是这个具有黑色幽默意味的道理领会起来颇为不易。

与自怜相对的就是“忘我”。父母因子女的创伤或其他更重要的问题而无暇自顾。他们扛起了责任，开始努力发挥自己的光和热，释放出了抗争与创造的生命本能。这种生命本能正是对抗一切心理问题最有力的武器。

4.4.6找到值得对话的伙伴

当主体对“活力”有所领悟后，就可以尝试在人际互动中投注于他人了。我们要把注意力放在别人身上，认真聆听，仔细观察，顺应我们的定向反应不断提问，慢慢地激活我们天生的社交能力，而不是关注自己是否紧张，是否愚蠢。如果对方是一位情绪成熟的个体，而且怀着真诚的态度，那么他就会从我们的提问中感受到我们的尊重，而不会轻率地认定问题“愚蠢”，我们也可以从对方的态度中判断出互动是否值得继续。实际上，只要我们认真倾听，就不可能问出蠢问题。不恰当的提问往往意味着互动出了问题，而这并不单是你的责任。它或许意味着你们需要探讨一些额外的东西，或许意味着互动已经是时候终止了。

自救的第一要义，是通过有意识的观察和筛选，为自己营造出非暴力的沟通氛围。接近那些有能力平等沟通的人，远离那些把一切互动都看成“地位博弈”的人。

4.5 动中觉察与体感疗法

4.5.1滴定

体感疗法对创伤化严重的个体有一定危险性，因此需要采用“滴定（titration）”的手法。滴定是指缓慢地、渐进式地接近在求生过程中涌起的痛苦感受，以防止在处理创伤的过程中再度受创。滴定体现出的“慢动作”思想正是动中觉察的核心。滴定类似延长暴露疗法（Prolonged Exposure，PE）的做

法，只是更加温和、更加强调唤起主体的灵活性，帮助主体意识到自己在压力面前除了僵直以外还有更自然、更有力的选择。

4.5.2动中觉察和体感疗法的自助改造

动中觉察源自费登奎斯方法（The Feldenkrais Method），在体态矫正、运动康复和心理治疗中应用广泛。

动中觉察是体感疗法的重要辅助手段。它帮助主体在相对安宁的状态下扩展体觉，探索全新的身心状态。只有让受困者意识到自己的身心状态还可以有其他可能性，他们才可能知道努力的方向。

动中觉察要求主体集中注意于体觉随动作发生的变化（“体觉”和“体觉变化”是同义语，体觉本身就意味着变化）。具体的动作只是一个“把手”，目的在于通过这种轻、小、慢的活动方式快速抓住正念的感觉。

在较低的唤醒水平下，自我对抗处于隐身状态，正如一个极为松弛的体态无法暴露肌肉的协调性问题。因此，极端舒缓的动中觉察只是一个起点，当主体能够从活动中体会到流畅感之后，应当持续增加活动强度，使主体在较高的活动强度下保持同等的觉察。随着活动强度增加，唤醒水平会逐渐提升。保持同等的觉察，可以避免主体在唤醒水平提升时陷入僵直或神游。只有在较高的唤醒水平和较高的活动性下，主体才能识别并突破自我抑制。这其实和篮球运动的例子类似，只是它既不要求高强度的社交情境，也不要求任何专业技术。

在咨询情境下，体感疗法一般用于治疗 PTSD，因为 PTSD 相关的自我对抗往往简单而强烈。其典型过程可以概括为：创造一个相对安全的环境（来访者与治疗师形成信任关系）→支持来访者探索和接纳躯体体验→建立起摆动（pendulation）和控制（containment）唤醒的空间→利用“滴定”技巧促进“摆动”本能发挥作用→探索和体会在创伤性事件发生前和发生时的内部资源，用积极、有力的对抗反应取代崩溃和无助的消极反应→将内部资源与创伤体验连接，有意识地探索身体和脑海中一切引起不适的东西→继续使用滴定技巧，利用摆动本能，分离相互冲突的冲动，例如向外沟通的冲动和因厌恶而躲闪的冲动→完成悬置的定向反应和应激过程→解离被解除，被阻塞的求生能量得到释放并被重新分配→中立状态恢复→重新与环境建立连接，恢复互动平衡的注

意力品质。

在自助情境下，体感疗法可以用于处理 CPTSD，因为受困者的自我对抗往往复杂而微妙。在这种情况下，体感疗法发挥作用的过程就是主体以体会为工具在微活动层面上通过一系列精细而微妙的调整使创伤能量的涡流（trauma vortex）与疗愈能量的涡流（healing vortex）重归和谐的过程。一种比较常见的流程可概括为：获取流畅感→激活创伤体验→维持身体与心智的对话→突破自我抑制→重建情感连接。过程始终伴随着唤醒水平的波动，其中的任何有效步骤都伴随着体会的形成，体会的形成往往会推动认知图式的更新和扩展。这一系列步骤并没有任何特殊性，它们对于受困者是需要学习而且可以学会的，对于情绪智力出色的人来说则是习以为常的。因此，这些步骤并不会引入额外的代偿或自我抑制，它们既是自救的步骤，也是心智锻炼的步骤。这些步骤的讲述方式完全符合谱系观的要求。

4.5.3 获取流畅感

当主体因定向反应无法完成而变得呆滞以后，重启定向反应就成为了强烈的本能冲动。受困者如果不理解自己的这种本能，就可能因冲动行事造成严重后果。他们甚至可能不顾自己的现实处境，放弃自己的工作，盲目寻求改弦更张，致使自己陷入更大的困境。

重启定向反应、再次激活自身活力最便宜的方式是利用自己手边现有的资源，全身心投入一项具体的、有目的的、有价值的、能让自己忙碌起来的活动。比如做一顿健康美味又营养丰富的饭，看一本好书并写下读后感，完成一次有章法的健身，等等。我们可以在玩游戏的孩子身上清晰地观察到类似过程。孩子们如果在追求一个游戏目标的过程中反复陷入茫然的状态，他们就会抛开这个“扫兴”的游戏目标，在不改变游戏设定的前提下换成别的游戏目标，然后重新兴奋起来。

当主体的身、心、智进入了一种活跃且同步的状态时，主体就会体验到流畅感。有流畅感充当锚点，正念状态才可持续，自我疗愈才能开展。获取流畅感的过程可以简记为两步：1.深呼吸放松，2.劳动。

4.5.4激活创伤体验

在绝大多数情况下，当闪回被触发，主体当前的状态被打断时，主体只会抱怨自己注意力不集中，无法意识到遭遇了什么问题。正如当我们看见闪光灯的光芒时，我们已经不可避免地成为了照片的一部分。我们要想在第一时间注意到闪回，必须以安全的方式有意识地激活创伤体验，为体会闪回创造条件。

身体的劳累和疼痛是闪回最常见的触发器。通过有目的地使用身体，让它不那么舒服，到了一定程度后，创伤与卡点就会暴露出来。主体就可以充分体验它们，让它们流出身体。

4.5.5见证自我抑制

在咨询情境下，这一步是在治疗师的见证下进行的。如果没有治疗师，就要珍惜外界反馈，完成自我见证。这样的机会可遇不可求，一些觉醒体验就是这样的机缘下出现的。主体必须珍惜自己身上那些在意识之外自发涌现的各种行为，用正念抱持它们，体会它们。它们代表的是主体身上最原始的活力，它们仿佛一群脆弱而充满好奇心的孩子，只在稍微感到安全的时候才会悄悄探出头来。

想象你正在进行一个有关“怎样释怀”的正念冥想练习。提示音让你安住当下，享受此时此刻，但环境中不时发出的噪音令你不安，身体总是要不自觉地与之对抗。你努力抑制这种对抗，可自己不但无法放松，反而越来越烦躁。这时，冥想的提示音恰好告诉你注意周围的声音，觉察对这些声音的抵触，任由它们自行来去。你突然感到自己被“看见”了，身体立刻放松了下来。当我们意识到那些干扰互动的因素和身体对这些干扰因素的反应都是互动的一部分，我们会立刻释怀，注意力也会变得集中。

4.5.6注意自身驱力

帮助主体找到自己在急性压力事件中的内部资源，尤其是能够体现主体的社会联系的内部资源（往往与积极体验相关），可促进主体对自身驱力的觉察。只有充分连接到内部资源，主体才可能在突破自我抑制的过程中承受得住强烈的消极情绪。

对于创伤化严重的主体， 流畅感本身就已经足够吸引他努力保持活跃。他会感到自己平日吃力的活动变得高效而流畅，自己既能对互动对象保持足够的注意，又能保持对环境的完整感知。他一面会努力维持这种意识状态，一面又感到莫名的恐惧。这种“拧巴”感将自我抑制充分暴露了出来。他可以在这种不适体验中初步确认压力事件与自己的关系。

4.5.7 身体与心智的对话

自我抑制被暴露出来后，主体就要为身体和心智的对话留出足够的空间和时间，体会才可能涌现。在此过程中，主体必须一面充分体验积极感受（兴趣与好奇），一面与恐惧和无助感保持充分连接。

想象你正在一个困境中竭力探索，却突然受到了同伴（支持者）的背刺。新的定向反应使你产生了向后探索的强烈冲动，可当下的探索过程却十分紧急，无法中断，不同冲动之间的强烈冲突把你卡在了进退不得的状态。如果你拥有足够的活动性，及时注意到了同伴的异常，你就会在此时感受到强烈而清晰的危机感，你会采取适当的行动克制住向后探索的冲动，使向前探索能够稳定推进，并在适当的时机回过头来解决向后探索的问题。在这一情形下，你对这种克制拥有足够的自觉。如果你的活动性很差，或者因为探索难度过大陷入了笨拙的“脆弱状态”，你就很难注意到这种落井下石的事件，只是模糊地感到自己突然变得更脆弱了。此时你会体验到强烈而混沌的恐惧、愤怒或羞耻。在巨大能量的冲击下，你的探索冲动被下意识地阻断了，你感到自己突然丧失了继续探索的动力。在这一情形下，你对这种自我抑制没有任何掌控能力。可见，互相冲突的冲动并不会直接造成创伤，被动的自我抑制才是造成创伤的关键。

在躯体体验的视角下，活动性的退化来自不自觉的自我抑制。正如认知行为疗法认为认知决定情绪一样，主流的心理治疗技术都会强调主体自身对于当下处境所负有的责任。

在正念的意识状态下，想法（ideas/thoughts/whims）不是独立的存在，而是对情感（情绪和感受）和身体状态（体觉和自发行为）的命名性解读。想法总是伴随着各种各样的躯体体验，体验越生动，想法就越具体。用拟人的说法就是人的心智和身体之间有一种与生俱来的对话能力或“自组织力”。人类的

意志力不是为了对抗自身不合时宜的冲动，而是为了给身体中的各种冲动提供广阔的空间和充足的能量，使身体能够自发涌现出合宜的行为。善于体会的人能够在自己的想法和躯体体验之间保持平衡，在“自我”和“无我”之间保持平衡。简单说就是他们充分尊重了自己的“内部对话”天赋，他们会把各种互动的节奏维持在既能保证互动稳定进行，又能让自己的体会相对充分的水平上。这样的人总是给人以沉着稳健的印象，他们总是能主导互动的节奏。

对于常人来说，身体与心智的对话过程就是主体在探索中不断涌现灵感，不断完成切分的过程。

4.5.8突破自我抑制

在自我对抗中，恐惧、羞耻等消极情绪越强烈，形成体会需要的时间就越久。在体会形成期间，主体必须勉力维持唤醒的稳定，使自己能够充分容纳这些情绪。如果主体最终战胜了恐惧，在躯体体验层面上分离开了相互冲突的冲动，体会就形成了。这种精神层面的对抗与身体层面的对抗一样，都可能使身体出现不随意的战栗。战栗的消退意味着自我抑制的突破，意味着被悬置的应激过程得到完成。

在认知层面上，使相互冲突的冲突相分离的过程就是重构创伤叙事的过程。所有适应不良的反应模式和身心状态最初都具有适应性。找到与这些反应模式或身心状态相适应的情境也是显著化创伤的手段之一。

当主体感到自己难以维持某种常人眼中的舒展体态时（假设不是因为过度疲劳），可以尝试将自己调整到当下最舒服的姿态（换句话说，主体要尊重自身那些舒适而不合理的体态），然后仔细观察这一姿态（可以先做好录像），在脑海中寻找一个与之相适应的情境。例如含胸驼背头前伸的姿态虽然会被看成下位者的标志，但假如你是一名在战火之下的手无寸铁的平民，你现在要冒着生命危险出门取个东西，那么你很自然地就会处于这一姿态，所不同的是在这种情境下这一姿态是充满能量的而非瘫软的。如果你没有经历过战争，那么可以另外想象一个对你来说足够生动的情境。想象的目的在于促进唤醒，给这种姿态注入能量。当你感到身体充满了能量后，就可以像在那种情境中的其他人一样，四处张望，敏锐观察，小心试探。当你能够从获取的感官信息中确认

危险已经不复存在时，身体自然会恢复到比较舒展的体态，这种舒展才是充满能量的自然舒展状态而非勉强维持的僵硬的“挺直”。

人们在学习和工作中的大部分时间里都在重复相似而又高度受限的活动模式，身体的活动性无法得到充分释放。一些替代疗法（alternative medicine）之所以会偶然发挥出神奇的功效，往往是因为这些疗法在实施过程中都会打破主体的日常行为模式。以针灸为例，患者必须配合医者不断调整身体姿势，有意识地收紧或放松身体特定部位以配合医师，而这些体态都是患者在平时生活中不怎么使用的。这常常会使主体误打误撞地回归中立状态，恢复了植物神经系统的平衡，间接改善了免疫系统功能。实际上，只要我们进行有节律的、系统性的、舒缓而细致的身体激活和肌肉拉伸，就可以起到相似的效果。值得注意的是，受困者初学拉伸时往往倾向于反射性地绷紧相关肌肉，抗拒真正的放松，使拉伸难以发挥效果。对于他们来说，放松意味着放下戒备，放下戒备总是意味着受到伤害，因此看似简单的拉伸对于他们实际上是一个挑战。参与者必须对自己保持充分的耐心，用深呼吸缓解紧张情绪，仔细觉察自己的身体状态，一点点放下这些寄生的紧张，感受放松所带来的安宁。主体要珍惜在练习过程中发生的情绪闪回，这是识别自我抑制的机会。

本文末尾推荐书目中《Switched On》的作者 John Elder Robison 在参与经颅磁刺激（Transcranial Magnetic Simulation，简称 TMS）实验后被意外唤醒的经历就很可能与他在实验过程中意外回归了中立状态有关。他敏锐地“聚焦”到了自身现象学世界发生的变化。由于他并未过多受到来自创伤化养育者的伤害，在认知图式层面的创伤化并不严重，这使他成为了少有的只经历了单次“开悟”就进入了可自我维持的觉醒状态的人。

自我抑制被突破后，恐惧就被转化成了振奋。对常人来说，突破自我抑制的过程就是释放对抗性、回归中立状态的过程。主体突破了自我抑制，也就解除了压力事件的残迹对感知能力造成的限制，完整而灵活的感知能力和定向能力得以恢复。

4.5.9 重建情感连接

自我抑制被突破后，个体在人际互动中就能拥有更多自由去感受自己，感

受别人。只有当我们可以从别人身上看见自己，在自己身上感受到别人时，才能在社交中真正平静下来，自觉融入人潮之中。自救到最后，不过是为了成为一个普通人。

4.6 特殊思想工具

4.6.1 链网释法与互释法

链网释法可不是简单的循环定义，它是自助治疗的重要思想工具，有助于主体深刻理解概念，完成自我概念化。链网释法中的概念如同一条项链上的所有珍珠或一张网上的所有节点，拿起其中一个就会把所有节点一起带起来，根据实际需要剪下一部分，就可以形成一条完整的符合线性逻辑的概念链。链网释法在自我概念化中可以发挥重要作用。互释法是链网释法的特例，指的是在缺少上位概念的情况下，我们可以通过对立概念的互释来认识概念。举例：客观是集体的主观，主观是个体的客观。焦虑是慢性的恐惧，恐惧是急性的焦虑。知识是公共的经验，经验是私人的知识。冲动是萌发的行为，行为是完成的冲动。冲动是急促的倾向，倾向是和缓的冲动。神游是心智的躁动，躁动是身体的神游。

在自助治疗中，链网释法之所以行得通，在于世界（现象学世界）只有联系而没有逻辑。假使世界真像人类所谓的“理性”那样具有逻辑，这种逻辑也没理由迁就人类的利益与认知。逻辑只是人类在具体情境下发现的世界的某种“序列化现象”，逻辑链的起点就是这种“序列化现象”的触发点。人类自以为“客观规律”反映了世界的本质，但实际上它反映的是人与世界的互动方式。换言之，所谓自然的故事，其实都是人类自己的故事。

互释法之所以行得通，是因为这些对立的概念本为一体，它们的分野是人类研究工具、研究方法及表达能力的限制造成的。这种人为的割裂在自省走向深入后就会不可避免地陷入自相矛盾的困境，这便是所谓“对立统一”思想的来源。在现象学层面上界定这些概念，意义十分有限，直面这些矛盾，以之为出发点，反而有助于对经验的深刻体会。

4.6.2配对意识

面对压力，受困者常常在两种对立的极端反应之间反复摇摆，无法保持冷静和平衡，就像一条单薄的小船遇到一点点风浪就会左摇右晃。比如：极端羞耻（自我责备）与极端耻辱（责备他人），极端自我苛责和极端自我放纵，极端僵直与极端瘫软，极端服从（自我否定）与极端对抗（无法接纳任何新信息），极端轻信与怀疑一切，极端解离与极端沉迷，极端情绪化与极端淡漠，强迫性地追求掌控感和熟悉感（自我封闭）与强迫性地寻求随机性和混乱（自我刺激），极端的外部关注（意识固着于环境中某个能够引起微妙情绪变化的细节，比如音乐的节奏，光影的变化等）与极端的自我关注，极端自我膨胀与极端自我缺失，过于依赖感受与完全不信任感受，为受到他人无意伤害而暴怒与为无意伤害他人而羞耻，爹味和孩子气等等。

这些反应看似矛盾，实际拥有共同的基础。它们如同磁铁的两极，无法脱离对方独立存在，组合在一起刚好可以构成一对加害者和被害人的角色。消解其中一极所需的资源往往就隐藏在另一极之中。一个具体的活动往往只能暴露出其中一极，因此受困者很少有机会把它们作为一个整体考虑。受困者必须学会像侦探那样有意识地发掘自身各种矛盾反应，努力找出它们背后的共性，直到看见完整的问题。这种串联自身两极表现的能力是受困者自省和自助的重要思想工具。

4.6.3图像式思考

受困者很难学会运用内在声音或内心对话分析各种意见和问题解决方法的优缺点。他们的内心对话要么在各种细节中越陷越深，很快就失去了方向，要么被情绪化的批判与指责主导。因此，起源于童年早期的“图像式思考”成了他们长期依赖的思想工具。与现实交互，会收到现实变化引起的知觉反馈；用图像思考，反馈来自图像本身的变化。定向反应困难使受困者的认知过程缺少知觉反馈，而图像化思考一定程度上弥补了这种缺陷。图像化思考十分消耗认知资源，它会遏制唤醒水平的提升，阻断主体的外界接触。图像化思考的过程和内容缺少社会性，导致受困者虽然显得压抑而深刻，实际上却很少反思（虽然很多时候反思都是在安宁的独处中进行，但实际上反思以主体对社会常模的体

会为根基，因此具有极强的社会性，社会性越弱的个体反思能力越差），缺乏自我认知。受困者的图像式思考能力经过长期发展而高度发达，是激发灵感、协调精细而复杂的思维活动的重要工具，运用得当可以释放出惊人的创造力。

图像式思考适用于分析和体会宏大、稳定、结构清晰的系统，不适用于实时的人际互动。

4.6.4 关系映射

世界具有分型结构，与之对应。主体会在不同的时空范围、时空尺度和生活层面上重演相同的行为模式和互动风格。所谓关系映射，就是我们在行为分析中把对主体来说相对陌生的关系类型映射到对他来说相对熟悉的关系类型中，或者把较晚发展的关系类型映射到较早发展的关系类型中，通过分析主体在自身相对熟悉或较早发展的关系中的行为表现和情感动力，识别出主体在自身相对陌生或较晚发展的关系中的行为表现背后的情感动力，或者反过来。关系映射对于微妙创伤的显著化有重要意义。目前研究最充分，应用最广泛的关系映射是家庭-社会关系映射。

家庭是浓缩的社会，社会是复杂的家庭。婴儿和家庭（依恋层级系统）的关系关乎他的生死存亡，正如成年人和社会（作为整体的社会，而非具体的社会人）的关系决定了他能否在社会上立足一样。通过观察一个人在家庭关系中的表现可以在很大程度上预测他在社会关系中的表现。在一般的家庭分工中，母亲通常充当了无条件养育者的角色，给予孩子最基本的生活支持。而父亲通常充当了条件养育者的角色，引导孩子学会面对挑战，学会适应和利用社会规则。主体与母亲的关系会影响到他如何认知自身和世界的关系，主体和父亲的关系会影响到他如何认知自身和社会的关系。如果母亲的生活态度消极悲观，心胸狭隘，那么即使主体受到了悉心的呵护，他也可能养成冷漠自私的性格。如果父亲情绪极为不稳定而且难以预测（比如时而关心呵护，时而残酷暴虐），那么主体可能永远无法对社会规则和权威力量产生亲和感，任何看起来有力量的人都会使他感到恐惧。面对挑战和压力，他总是会轻易屈服。

4.6.5角色代换

在复盘自身经历时，先将自己作为主角叙述，然后想象这件事发生在另一个人（最好是某个自己比较熟悉、比较欣赏的人）身上，把自己想象成场景中的其他参与者或旁观者，重述一遍。如果是独自完成的活动，就想象一个可爱的伙伴（最好是孩子，因为孩子总是充满了好奇心，总是能积极作出回应），留意那些欲言又止的瞬间和那些被打断的探索冲动，在想象中为它们安排一个适当的回应。体会自己在两次叙述中的情感和想法的不同。最后把所有角色全部换成自己，想象故事会如何发展。

这也是一种换位思考。

4.7 认知矫正与社会常模

认知发展的过程就是消解认知冲突以使新近经验在认知图式中得到恰当安置的过程。认知矫正是识别陷入停滞的想象知觉，消解极端的情绪反射，修正适应不良的认知图式，使主观现实与客观现实恢复同步的过程。认知矫正的框架与细节可参考文末推荐书目。

一个人无论处境有多么孤独，经受过多少背叛，社会常模（在个体层面上也可理解为“人之常情”）永远都是他最基本、最可靠的认知资源。对社会常模的理解直接反映了主体的社会化程度。社会化使主体能够从简单原始的情绪和知觉中发展出复杂、丰厚、细腻的情感与良知，使主体从一个普通的生物体成为一个“人”。霸凌者往往都是首先占领道德的制高点，让被霸凌者相信他们才是规则的掌控者，从而在精神上击垮被霸凌者，使之陷入无助，然后才能肆无忌惮地施展霸凌。

受困者对社会常模普遍迟钝。社会常模在他们的认知过程中的地位被各种过度精细而不切实际的认知图式取代了。认知矫正的目的就是帮助主体识别并消除自身不切实际的认知图式，放下早已不合时宜的自我抑制，重新对社会常模变得敏感。良好的道德感（正义感）是自救者最重要的情感动力。

4.8 哀悼

4.8.1 哀悼的概念

哀悼（mourning）是主体在经历了丧失后，校准自我意象，使主观现实与客观现实恢复同步的过程。它不是简单的悲伤宣泄，而是一种心理重建技术。它既是对丧失的臣服，也是对存在的重构。丧失与获得相对，哀悼与庆祝相对。无法哀悼丧失的人，也无法庆祝收获。他们看似超越了得失，实际从未真正投入生活，他们只活在生命的最表层。

丧失通常是客观的，而哀悼往往是主观的。想象一对夫妻迫于生活压力每天深夜就要外出工作，天亮才能回来。他们年幼的孩子时常在一片昏暗与孤寂中醒来，感受不到一丝亲切的气息，必然会感到强烈的悲痛。对于一些天性敏感的孩子，这种悲痛甚至具有与丧亲相似的心理意义。如果家庭成员能够充分认识到这种分离体验的创伤性，能够和孩子一起做好心理建设，孩子就可以以此为契机区分“有距离的守护感”和“被遗弃感”，从而学会坚强。否则，孩子很可能会因为这种情感忽视而留下心理创伤。

成长既是不断收获的过程，也是不断丧失的过程。生命中存在一种否定性的力量，不断消解着我们的意义，否定着我们的价值。从死亡哲学的视角来看，我们每天都在经历着微小的死亡。落空的期待、无效的努力、被轻视的付出、本该拥有但实际上从未存在过的温馨日常等等都具有丧失的性质，都会冲击主体的心理承受能力。常人每天都会进行很多微小的哀悼。哀悼的能力很大程度上决定了主体接受现实的能力。

不论在哪个心理流派中，哀悼的应用都非常依靠缘分，无法刻意为之。但缘分绝不意味着纯然被动的等待，它也需要努力挣扎才能更容易获得。对于心理创伤严重的人，哀悼只有在充分处理了被遗弃感，不再回避痛苦体验之后才可能进行。

在万籁俱寂的午夜，一切都隐于黑暗之中，白天的纷纷扰扰暂时被放在一边，身体的能量也来到了一天当中的最低点。此时主体感到的情绪可视为自身的“情感底色”。如果一个人的情感底色总是被沮丧所淹没，想哭却又完全不知为何，那就意味着自己身上存在大量未完成的哀悼。

4.8.2 哀悼与羁绊

哀悼始于触动。想象街边一位过客的身影使你联想到了某位已经逝去的亲人，曾经只有亲人才能唤起的亲切感在你心中涌起。然而你还没来得及迎上去，你的意识就开始提醒你亲人已不复存在。阻止你陷入亲人回归的幻觉，这是意识的职责。然而胸中不可遏制的触动则是人类的本能。这种情感与认知强烈撕扯的体验就是悲恸。为这种撕扯留出足够的心理空间，使身心状态重新恢复协调的过程就是哀悼。

哀悼终于责任。每个人在确认自己已无能为力之前，都必须要经历充分的挣扎与撕扯，否则哀悼就不可能彻底。哀悼无法完成，个体就无法放下过去，他可能反复重演早已不合时宜的行为模式，妄图拯救曾经的自己，这会严重限制他的适应能力。许多受困者的发展水平长期停滞在了童年阶段，他们很容易沉湎于回味那些一去不复返的美好时光，然而这种回味不但无法带来力量，反而会加重抑郁。哀悼的完成意味着身心的再度整合，主体重新鼓起了勇气，开始直面更加广阔也更具挑战性的人生。此时，那些成长中激动人心的时刻才能成为激励人们不断前进的内在力量。

电影《泰坦尼克号》中，面对巨轮即将沉没而只有少数人能够获救的现实，登上救生艇的人们几乎都是带着泪水与留在船上的亲人告别。眼泪有一种神奇的力量，它使人们可以放下原本难以解脱的心理羁绊而不必带着负罪感度过余生。但露丝面对着杰克却流不出一滴眼泪，她最终在救生艇被放下的前一刻跳回了船上。她不愿落泪，不是不愿接受丧失，而是知道自己还没到说放弃的时候，她还有未尽之责与未竟之事。哀悼丧失与坚持不懈都是勇者的品格，背后都是直面现实的勇气。哀悼的眼泪和逃避的眼泪只有当事者自己才分得清。

4.8.3 哀悼与仇恨

哀悼几乎总是伴随着仇恨和懊恼，正如初学走钢丝的人难免左摇右晃一样。哀悼的过程就像练习走钢丝一样辛苦难熬，它通常远比当事者预想的要久得多。

哀悼始于愤慨。在对世界的无数次叩问和对自己的无数次鞭打过后，仇恨终将突破狭隘的个体意义，无能为力的愤怒将逐渐升华为正义的愤慨。一方面，主体强烈地感到自己彻底“受够了”，不是受够了加害者的摧残，而是受够了

这种整天担惊受怕、疑心任何人随时可能伤害自己的可怜状态。另一方面，主体深刻地认识到自己不是一个孤立的个体，自己的痛苦是人类共同经验的一部分，这是哀悼与自怜的根本区别。

哀悼终于释怀。释怀是与世界和解，更是与自己和解。主体放下了仇恨，却收获了力量。在哀悼的过程中，主体会发掘出越来越多能够进一步促进自己复原的爱，自己和世界、和他人的羁绊越来越深刻。主体一旦唤醒自己的内在力量，就不会再对别人抱过高期待。个体可能突然发现加害者早已和自己不再相干，自己对加害者的命运也已失去兴趣。他可能为加害者感到悲哀，产生同情，但这种释怀的感受完全不同于宽恕。宽恕是放过别人，而释怀是放过自己。他也可能继续追究加害者，但这种追究已不是出于狭隘的报复心。相比惩罚加害者，主体更愿意把注意力放在自己的能力上，他会用实际行动捍卫自己所坚持的道德标准，承担自己因创伤而未尽的责任。个体将摆脱毒性羞耻感的束缚，开始追求那些允许自己光明磊落、不再需要掩藏或躲避的人际关系。哀悼完成后，个体将回归平凡的生活，同时有能力直面这世界残酷而不讲道理的一面。

4.8.4哀悼实例一则

考虑到儿童的情形更加纯粹，更加温和，不容易引起读者不适，这里选取一名儿童的例子。事件中无人受伤，可放心阅读。

A 是一名两周岁出头的儿童。她周末经常在奶奶家度过，和奶奶有很深的心理羁绊。叔叔周末也在家，经常和她一起玩，他们关系也很好。一天下午，奶奶在安抚她入睡后要出去办事，将她一个人留在床上，叮嘱叔叔留心照看，此时叔叔正在隔壁房间工作。两个小时之后，A 醒来，随即大哭，口呼奶奶不止。叔叔闻声而至，欲抱起她，A 不情愿。叔叔把床头她最喜欢的玩偶递给她，她视若不见。叔叔告诉她，奶奶有事外出，很快就会回来，提议他们一起边玩积木，边等奶奶。A 不回应，继续趴在床上哭喊。叔叔又问：“叔叔也困了，咱们一起睡吧。”然后给 A 盖上小被子，自己也在旁边躺下装睡。A 哭喊得更厉害了。叔叔觉得没有办法，试探她说：“不管你了，就把你一个人放在这儿哭，我出去，行吗？”A 答：“你出去吧。”叔叔遂离开房间，A 继续趴在床上大哭，口呼奶奶不止。约五分钟后，哭声、呼声渐止。A 下床离屋。抱着玩

偶找到叔叔，要一起游戏。叔叔问她：“还伤心吗？”A 答：“不伤心。”叔叔问：“你不知道奶奶一会儿就会回来吗？”A 答：“知道。”叔叔问：“那你为什么哭呢？”A 陷入沉默。叔叔意识到答案可能超出了她的表达能力，于是问她：“你虽然知道奶奶会回来，但是觉得心里太难受了，必须哭出来才能舒服，是吗？”A 连连点头，答：“嗯嗯，是。”

A 性格活泼，和奶奶有很深的感情。在母亲不在场期间，奶奶实际充当了她的安全依恋对象。有了依恋关系的支撑，儿童可以在很高的唤醒水平下充分展开探索而免于感官超载。依恋使她有勇气从事具有挑战性的活动并从中收获超常的兴奋感和成就感。在收获这些成就感的同时，她和依恋对象的羁绊也会变得更深。探索的过程就是享受奶奶对自己的守护的过程，她在探索过程中展现的活力也是对奶奶的悉心呵护的回馈。在探索过程中，她的唤醒水平和压力水平都达到了最佳，活动性达到了极限。在这种状态下，如果依恋对象突然缺位，安全预期的丧失破坏了正常的注意力模式，她将体验到极大的恐惧感。巨大的感官压力会令她体验到感官超载，精神迅速崩溃。当 A 在奶奶的怀抱中安眠，却在一片孤寂中醒来时，她会发现在她心中最坚实可靠的一部分突然消失了。她带着放松的身体，活跃的情感，开放的感官，却一头撞进了虚空之中，感受到了强烈的压迫感和空虚感。

A 的哭喊显然不是为了“操纵”奶奶，因为她知道奶奶不可能听见；更不是因为感受到了抛弃，因为她知道奶奶不久就会回来。她体验到的悲痛绝不是简单的孤独感，否则她就不会拒绝叔叔陪她一起玩的建议。这种悲痛之中蕴含着非常丰富的力量。其中不止有失望、恐惧、孤独、悲伤和挫败感，更有愤怒、不屈、怀念、珍惜和渴望。好比她所珍爱的玩偶们意外洒落了一地，她要小心翼翼地把它们重新收拾整齐。她不希望这个整理的过程被外力打断。最后，她收拾好了心情，重新组织了感官。开始一边跟叔叔玩游戏，一边等待奶奶回家。

在这个事件里，孩子并没有经历永久性的丧失，但这仍然是一次非常典型的哀悼。两岁多的孩子已经能够理解“奶奶还会回来”的含义。但是，不管她什么时候回来，孩子当下体验到的痛彻心扉的丧失感都是真切的，必须得到适当的处理。只有当这种情感被充分处理之后，“奶奶还会回来”才能成为一句实际的安慰，正如我们在安慰别人的时候常说的那句“来日方长，要更加珍惜

生命中的美好”那样。可见，哀悼既是放下失望，也是重拾希望。两岁的孩子不懂得什么大道理，她所作出的反应真实地展示了自己的情绪智力。孩子能有如此情绪智力，可以预见她的成长之路会比常人走得更远。情绪智力较差的孩子在这种情境下很容易体会到羞耻、无助和沮丧。如果长时间得不到回应，他们很可能逐渐变得麻木，直至解离。

4.9 书面表达

4.9.1 书面表达的意义

人类的口头表达往往随情境迁移，拥有极强的灵活性，常常自相矛盾而不自知。但它们一旦落在纸面上，就要被迫接受一致性检验。书面表达会强迫我们保持认知一致性，这有助于我们发现自己认知中的漏洞，促进自我认知的发展。我们只有认识到自己有多么喜欢使用双重标准，才会有足够的动力展开自我剖析。

书面表达可分为分析式表达和记叙式表达。受困者普遍不擅长口头表达，但往往具有优秀的书面表达能力，尤其是分析式的书面表达能力。受困者既要充分发挥分析式表达的优势，也要重视记叙式表达的价值，尤其是令人振奋的积极生活经历的价值。

随着书面记录的不断积累，主体很容易从中注意到自己的情感底色。例如以被遗弃感为底色的人往往擅长记录那些自己被忽视（消极）或者被照顾（积极）的体验。实际上他们从未被忽视，只是这种情感底色限制了他们的注意力和兴奋点。

在不同的心境下反复检视分析式表达有助于主体识别出隐藏在分析背后的情感动力，增加认知加工的深度。任何表达的背后都有情感的驱动，正所谓“有感而发”。绝对中立的表达根本不现实，只是我们身为当局者往往意识不到那些隐匿的动机。当时过境迁，我们再次拿起曾经的记录时，就很容易发现问题。这是了解自我的一个机会。我们要牢记分析是为了行动，而不是为自己的不作为找借口。只有行动才能完成现实检验，分析必须以行动为终点。不能导向行动的分析一律可以算作思维反刍。

受困者的生活中充满了负性压力事件和各种消极体验。这些被记录下来的积极生活事件所蕴含的能量将成为治疗中的稀缺资源，它们会成为抵抗思维反刍的重要力量。任何令自己感到振奋的短暂经历都应该得到翔实的记录，在将经历转化为语言的过程中主体往往会有意想不到的发现。许多受困者习惯将“从未有过积极经历”挂在嘴上，但这并不现实。每个人的生活中都有积极的经历，哪怕只是些极为短暂的微妙体验。受困者否认了自己的积极体验，也就说服了自己不用再承担改变自己的责任了。

4.9.2书面表达的原则

1) 正向表达原则

正向表达是书面表达的基本原则。所谓正向表达不是盲目乐观，不是弱化灾难，更不是歪曲事实。正想表达指的是表达必须能够体现能量的流动。

比如，“下次请不要迟到”不如“下次请 8：30 之前到”。前者给人一种被限制感，后者给人一种被指引感。

又如，“由于婴儿没有能力理解父母行为背后的动机，婴儿很容易相信父母的恐惧、退缩或解离都应该怪罪自己”不如“……婴儿很容易相信父母的恐惧、退缩或解离都是需要自己应对（负责）的”。前者体现出一种压迫感，后者则隐含了能动性。

又如，“我不得不上课”不如“我决定去上课”。后者会促使自己反思自己的心理动力。

又如，“我感到开心”不如“我感到欣慰/满足/鼓舞”。后者更加具体，具有方向性。

又如，“他用这种方式否认内心的孤独”不如“这成了他维持与社会基本情感连结的方式”或者“他寄希望于用这种方式让人看见自己，好摆脱孤独”。后者肯定了生命力的不可否认性，表达出了人的基本需要。

2) 理解自己的触动

注意那些能够让自己浮想联翩的音乐，仔细体会自己在聆听时的感觉和感受。现在的音乐应用都有互动功能，可以在评论区找到最贴近自己的感受而又毫不拖泥带水的描述。这种“我知道有人了解我的内心世界”的体验有火花般

的力量。当然，这个“火花”能发挥多大作用，还是要看“燃气”积累的程度。视频中的实时弹幕也有类似效果。在我们情绪激动时，旁人的一句随意的评价也有类似效果。这些生活碎片都有助于我们理解自己的触动，都值得记录。

3) 留意背景和空白

受困者的注意力缺陷使他们无法注意到互动的背景。很多时候，问题的解决方案其实就在背景之中，但是自己无法看见。写作时可以多问自己几个关于背景的问题：当时是什么时间？空气里有什么味道？自己坐在（站在）什么位置？旁边还有谁？他们在做什么？旁边摆放着什么？自己的视线如何？

记录不仅要聚焦发生的事情和存在的东西，也要记录那些本该发生而没有发生的事情、本该存在而没有存在的东西，也就是画面中的“空白”。比如现场有谁缺席了？你本以为应该发生什么？它和实际发生的事情存在哪些偏差？

4) 关注情感动力

每个人都会做出很多在事后看来很傻的事，但只有能理清自己在事中的情感动力的人才能吸取教训，积累经验。

5) 摄像头意识

明确地将事实、情绪、解释分开。记录事实就只写能被摄像头拍到的东西（行为、话语、时间、结果），情绪要用最具体的词汇，解释就只写从事实中得出了什么。

以上全都是认知行为疗法的基本要求，这也是我一再强调认知行为训练重要性的原因。

4.10 梦境与半醒时分

4.10.1 梦

睡眠时大脑高级皮层活跃度下降，强迫性的自我抑制被解除，在自我抑制中被主体回避的躯体体验就可能在梦境中得到表达，因此梦境可以成为我们了解自身真实体验的窗口。这里主要关注的是梦境的情绪性内容，而非弗洛伊德式的隐喻或象征。受困者的神秘主义倾向使他们很容易被弗洛伊德式的分析吸

引，简单直接的分析反而变得困难。

梦的画面和情节只是表象，重要的是支撑这些画面和情节的感受。例如一个人经常梦见自己房间外楼道下的阴影里藏着一个陌生人，这可能意味着他身处复杂的人际关系，感到巨大压力，仿佛随时会被人算计。这种惊悚的感受和自家楼道下藏着一个陌生人的体验是相似的，因而它们可以互相唤起。

受困者的梦境有很强的创伤化色彩。比如有的受困者常常在深夜发出可怕的尖叫，令家人或室友深受困扰。梦境中的他们处于一种极度孤独而无比压抑的状态。这提示了遗弃创伤的存在。

有关梦境解析的更多内容，可参考现代心理动力学治疗技术，比如欧文·亚隆（Irvin Yalom）的很多著作都涉及了对梦境的利用。

4.10.2 半醒时间

受困者的前额叶皮层活跃度明显低于常人，体现在精神状态上，就是他们时常处在一种混沌散漫的状态，仿佛从未完全睡醒一般。这也是他们的现实检验能力明显弱于常人，对环境中的异常信息过于麻木的原因。他们的各种想象拥有接近梦境的真实感，以致他们常常用神游为自己解闷并乐在其中。

人在起床前，会经历一个从梦境中逐渐苏醒的过程。其间，我们既能看到梦中的画面，感受到梦中的情绪，又能听到外界的声音，拥有一定现实检验能力；我们既具备一定的自我意识，又不会有过度的自我抑制；想法激起的各种冲动都可以在梦境中实现闭环，不会发展出真正的行为；身体处在日常生活中所能体会到的最为放松的状态。常人的前额叶皮层如同一个电力充足的电动机，启动后可以立刻运转起来。他们很少注意，也很难利用中间的加速过程。而受困者的前额叶皮层如同一个动力不足的电动机，这有助于他们掌握某种维持大脑低速运转的“诀窍”，使苏醒的过程被大幅度延长。他们由此获得了一种观察自身行为冲动和反应模式的特殊方式。在这种半睡半醒状态下，主体有机会观察身体中那些长期被自己忽视的寄生性紧张。这种意识状态也是一种特殊的催眠状态。

受困者之所以难以通过聚焦形成深刻的体会，原因之一是他们的创伤化进程开始得太早了。大量的寄生性紧张已经被他们深度接纳，很难被自己识别，

也就无法被聚焦（也可以理解成这些寄生性紧张高度稳定，失去了活动性，也就无法得到觉察）。虽然大部分的寄生性紧张已经成为习惯，但仍有一小部分会在睡眠中得到一定程度的松解，然后在醒来后又迅速变回老样子。这一部分跟随作息波动的寄生性紧张可以在半睡半醒时间被捕捉。对这些寄生性紧张的聚焦往往可以“拔出萝卜带出泥”，从而为识别更主要的寄生性紧张提供线索。

快节奏的活动一旦接受聚焦，就会逐渐慢下来，慢节奏的活动一旦接受聚焦，就会相互唤起而变得越来越丰富，这就是聚焦的力量。如同一个过度活跃的人，在我们温和的注视下，很快就会因为意识到自己的“出格”而逐渐慢下来，或者一个消沉的人，在“共舞”中找到了“感觉”而逐渐活跃起来。也正是因为我们的温和态度，他才会轻松地安静下来或者活跃起来而不会因为羞耻而突然僵住。这个逐渐放慢或相互唤起的过程非常重要，主体将在其中体会到神游与健康的想象力的根本区别。神游是单调乏味、以自我为中心的，而健康的想象力是丰厚细腻、以关系为中心的，神游使主体自我封闭，而健康的想象力使主体深刻融入世界。神游具有强迫性，节奏难以控制，而健康的想象力具有很强的活动性，节奏会随时变化。神游强化自我抑制，而健康的想象力促进自我表达。神游使主体注意力涣散，而健康的想象力能够维持并促进互动平衡。

和催眠状态一样，这种半睡半醒的状态可以辅助自我觉察，但无法解放驱力，因为这种状态本身就排斥驱力。解放驱力必须在生活中进行，其间可能反复唤起神游。主体将在神游的反复消退与唤起中逐渐将创伤显著化。只有当创伤得到了充分处理，自我抑制被解除，驱力被解放后，受困者才能摆脱神游。这一过程可类比为一台高速运转的设备出了故障，我们在处理故障前先要把设备停下来，但停下来以后我们的检修过程无法得到实时的反馈。我们只能先修一点，然后启动一下看看，然后再停下来，再调整，再启动。如此循环多次以后，我们又发现设备的很多问题是相互关联的，我们根本不可能在一个问题完全处理完毕后再处理其他问题。好比安装轮胎，我们不是把一个螺丝完全拧紧后再去拧别的螺丝，而是先把主要的几个螺丝放进去，然后每个螺丝依次拧一点，经过多轮循环，所有螺丝全部被拧紧，轮胎也完全固定到了正确的位置。这实在是个考验心性的过程，但好在大部分自救者都拥有耐心细致的品格。

这种状态相当奢侈，维持它需要宽裕的时间和安宁的外界环境（安宁绝非

死寂，它包括了柔和而丰富的环境刺激，比如阳光，鸟鸣，花香，孩子们的笑声，准备早饭的声音等等，这一切信号都在传递着安全、平和的信息），当主体离开这种状态时，应当感恩为他提供了这些条件的人。

4.10.3 梦与闪回

人们特别擅长捕捉那些能给自己带来强烈情绪体验的画面，无论这些画面是来自亲身经历，还是来自读过的书、看过的电影或听过的故事。人们把这些画面收入脑海，成为日后表达自身体验的素材。这些素材对应的情绪体验越强烈，真实感就越强。当我们陷入闪回时，这些画面会随着相应的情绪一起被唤起。因此，纠结这些碎片化影像是不是真实的记忆，对疗愈没有任何好处。它们只是我们的身体在向我们传递信息的过程中自发调用的素材，用来帮助我们理解当下的体验。

我们无法直接看见自己的表情和动作，而别人无法直接看见我们的闪回，因此表情和肢体语言主要是对外沟通的工具，而闪回是身体向主体发出的呼喊，要求主体关注自己的状态。闪回的各种碎片信息无论真实性如何，都只是一系列“词汇”。就像我们说话时无须关心每个词的词源一样，值得我们关心的不是闪回中的各种细节的来源，而是它们对于当下的意义。闪回相当于一种清醒梦，我们该怎样对待梦境，就应该怎样对待闪回。当我们执着于给梦境理出逻辑时，我们已经不是在回忆梦境而是在创作故事了。同理，当我们执着于从这些闪回的碎片化影像中梳理出完整的记忆时，我们很可能已经开始“编造”记忆了。对于有强烈情绪色彩的事件，当事人的记忆往往十分不可靠。比如孩子说父亲因自己算不出数学题而一边破口大骂，一边拿笔戳自己。实际情况很可能是父亲把孩子骂到无地自容，根本不敢正眼看父亲。他只看到了父亲拿笔用力戳本子的残影，听到了笔尖撞击桌面的咚咚声，同时心里感受到了巨大的冲击。当他回顾这段经历时，那种强烈的痛苦就好像父亲在用笔戳自己一样。对于严重的创伤事件，其真实性需要刑侦人员和专业手段的介入，这不是心理治疗的工作。对于心理治疗来说，创伤体验（心跳紊乱、身体僵硬、大脑空白、视野受限、时间静止、手足无措）远比创伤故事重要得多。

4.11 幽默感训练

交流使人放松，放松促进交流。我们只有在整体放松的状态下，才能准确感受局部的紧张并作出解读。放松而活跃的互动场是滋生幽默感的土壤。幽默感是生活最重要的润滑剂，也是受困者最缺乏的品质之一。

当事物的表现与我们的认知相冲突时，或者事物不同部分的表现令我们感到不协调时，就产生了一个“失谐”情境。面对失谐，我们首先会“惊讶”，然后会迅速发展出古怪、别扭、新奇、神秘、可笑等感受。幽默就是把各种失谐之感转为可笑之感的能力。古怪和别扭是消极感受，可笑是积极感受。面对无须刻意解决的问题，幽默以一种富有智慧的方式消解了其灾难性，使能量恢复了流动。

如果你在无意中被人推了一把，你必须在第一时间重新站定，恢复平衡，然后才能决定下一步反应。同样，主体受到刺激后，从震惊到定神的时间越短越好。主体必须有能力迅速接受自己的真实触动，才能充分发挥训练的作用。

不论采用哪一流派的训练方法，训练过程中都要避免次生情绪的干扰，避免用尬笑或自责回避不舒服的体验，如果发现自身开始产生回避倾向，就要放慢训练步调，适当深呼吸，以保证自己能够完全承受情绪唤起。过程中要关注自己在经历什么，而不是自己看起来是否奇怪或异于常人，更不要忙着为体验到的东西进行抽象的解释。

4.12 贵人

不论成长还是堕落，最快的方式都是“共舞”（或者叫“合谋”）。

本文多次使用了观察者视角。自救者很容易把观察者理解成某种冷漠而超然的角色，但我希望他能够被理解成一位拥有健全人格和旺盛生命力的同伴。这位同伴情绪稳定，生活自律（懂得自我规划），善于观察和换位思考。因为某些机缘，他发现了自救者身上某些超乎寻常的闪光点，同时感受到了他们内心深处的压抑，这种强烈的矛盾体验使他对受困者发自内心地感兴趣。他对自救者心存关爱，善于与之调谐一致并且从容自若。他就是巴瑞·普瑞桑（Barry M. Prizant）笔下那种天然具备“灵性”的人。这种缘分对于自救者可遇而不可

求，否则根本不会有人对长篇大论的治疗理论感兴趣。讽刺的是，这种人中的绝大多数不会成为治疗师，治疗师中的大多数也没有这些品质。

不要幻想在创伤群体中找到这样的人。在现实生活中，人和人打交道的基本前提只能是大家一样正常，而不是预设对方有病，人格健全是交友的底线而不是上限。在课堂教学中，你有一个问题，我有一个问题，我们互相交流，大家都没了问题，因为问题写在练习册里。在心理互助中，你有一个问题，我有一个问题，问题互相影响，我们有了更多问题，因为这些问题长在自己身上。心理互助的设想看似美好，实际上对参与者和组织者要求极高，实践起来非常困难。大多数时候，所谓互助不过是一次又一次地复制那些病态的互动模式罢了。加入互助团体之前必须充分确认其资质，不可轻易高估自己的互助精神和互助能力。电影《叫我第一名（Front of the Class）》中，主人公的母亲在带领主人公观摩了所谓的“互助小组”后的第一件事就是让主人公忘掉这次经历。缺少有力组织核心的互助小组最后无一例外都会沦落成情绪的“垃圾站”。它把个体的思维反刍变成了集体的思维反刍，不仅无助于成员摆脱创伤，反而促成了创伤的“交叉感染”。这样的场面很容易给观察者留下 “受困者心胸狭隘，创伤咎由自取”的印象。

自救者在有所领悟后往往倾向于帮助其他有需要的人，这是基本驱力正常发挥作用的表现。但是在有所行动之前，自救者必须问一下自己：自己的觉醒真的已经达到 “免疫创伤”的程度了吗？虽然自己可以用语言把领悟传达给别人，但是自己身上受困者的气质可能更容易感染对方，导致事与愿违。

尽可能多地发现好人，接近好人，是人生最值得做的事情。守正心，行正道，待人以诚，不造恶业，就能不断遇见新的贵人。

4.13 饮食调整

长期的应激障碍会造成消化系统和免疫系统紊乱，造成脑内物质失衡，营养因素对于 CPTSD 不容忽视。有关营养学知识可参考文末相关资料，也可咨询相关专业人士，本文不做赘述。

5 自我概念化

5.1 自我概念化的内涵

受困者的自我报告常常不可靠。这不利于受困者与救助者建立对等合作关系，一定程度上影响了创伤知情原则的实践，但我们又不能期待受困者像治疗师那样接受系统性的专业训练。本文的创作目的之一，就是帮助受困者发展出可靠的自我报告能力。

自我概念化糅合了概念化（conceptualization）和心智化（mentalization）。它与咨询关系中的个案概念化不同，并不能简单地比喻成医生自己给自己看病。主体之所以选择自助，也正是因为咨询关系常常失效。更好的比喻应该是：一个迷路的人，凭借自己的所见所闻和手中的工具，一边探索，一边绘制地图。他还要爬上路过的每一座高塔（相当于生活中收获新体会的“觉醒时刻”），反复确认自己绘制的地图是否足够准确。他每画好一片区域，就要拿起来和已经公开的大地图仔细比对，看看自己的地图能不能拼上去，大约该拼在什么地方。直到有一天他发现自己的地图可以完美融入大地图之中。他终于走出来了，大地图也变得更加完整，他的贡献也将为别人的寻路带来方便。

个案概念化的专业内容，可从本文末尾推荐书目中获取。自我概念化的过程只能依靠自己完成，这里仅为大家提供一些“导航”，这些导航以真实或具有隐喻意味的故事的形式呈现。

当主体挣脱了神游和反刍式思维的束缚，重新与身体和感受建立了深刻的连接，能够从平静之中体会到幸福感之后，就可以放下戒备，对各种情感体验敞开怀抱了。从此，各种现实活动所激发的丰富能量不再是恐惧和羞耻的来源，而是成为了生活的养料。

这趟超越 CPTSD 的旅程是一部专属于个体心灵的史诗。

5.2 从复杂性创伤中毕业

5.2.1 康复与毕业

不少学者坚定地认为 CPTSD 不可能彻底康复，比如《不原谅也没关系》的作者皮特·沃克。但仍然有不少自救者十分自信地报告了自己的康复体验。这使 CPTSD 的康复带上了一定程度的玄学色彩。

康复与痊愈都是典型的病理学概念。它们以个体受伤之前的状态为基点，而治疗就是通过各种干预手段帮助个体回归基点。正如严重的疾病都会留下各种后遗症，CPTSD 不可能完全康复也在意料之中。

但是，将心理创伤视同生理创伤的做法终归只是一种粗糙的类比。人的心理成长具有不可逆性，很少有人希望自己历经生活的洗礼却毫无长进，康复的概念首先在理论上就无法适用于心理创伤。如果我们能够理解在每个健康人体内都有十几万种病毒，就更容易理解病理学范式的局限性——它无法解释我们和自己体内这些病毒的关系，甚至连病毒的定义都会遭受质疑。相比痊愈或康复，社会关系范式更倾向于使用毕业（graduating from CPTSD）或创伤后成长（posttraumatic growth）的说法。毕业者不以康复为目标，他们有更高的追求。他们凭借自己的天赋和韧性，胜任了命运安排的艰巨挑战，走向了新生。

5.2.2 强者与弱者

所谓强者或弱者并不是什么严谨的概念，如果愿意，叫成智者和愚者甚至“幸运儿”和“倒霉催的”也没啥问题。这里论及强者与弱者，并非为了制造二元对立，而是为了引出最特殊的一类自救者。

在小说《遥远的救世主》中，作者豆豆借主人公丁元英之口道出了她的强势文化与弱势文化哲学。这一思想同样适用于心理自助理论。心理治疗的最终目的本来是为了帮助人们变得更强（更具胜任力和适应力），然而当前的社会现实决定了依赖心理治疗的人大部分都是弱者。这浓厚的弱者氛围严重影响了心理治疗理论的话语建构。很多创伤治疗理论自带一种“弱者气质”，它们可以帮助受困者改善症状，却无法帮助他们超越创伤。

弱者首先以康复或痊愈为理想，求之不得后，态度逐渐转为学习接纳与共

生。强者以“毕业”为节点，凭借自己超人的智慧和毅力，不断走向新生。前者忍受的是伤口滴血的痛苦，后者忍受的是分娩的痛苦。在强者看来，弱者所谓的自救只是在不停地舔舐伤口，按摩伤口，让它不再流血而已，根本算不上什么科学。弱者总是喜欢假定自己在受伤之前处在某种“完美状态”，把心理治疗理解成向完美状态回归。然而这种向后看的康复注定只是奢望。当康复的梦想破灭后，也就只能接受与创伤共存的现实。

人要成长，就必须向前看。成长好比健身，肌纤维在不断地轻微撕裂和超量修复的过程中变得越来越粗壮。强者才不希望自己折腾了半天，最后又回到原点。世上除了作茧自缚抱残守缺之人，又有谁不是遍体鳞伤呢？创伤让弱者坠入地狱，让强者变得更强。它是弱者的墓志铭，是强者的磨刀石。

在经过长期的挣扎后，很多人不再追求成为强者，转而开始为自己的处境寻求辩护，以实现自洽，获得安慰。但总有一些不屈之人，他们的心中始终埋藏着一颗强者的种子。他们的自强之路是一曲人类生命力的赞歌。他们用实力证明，CPTSD 不仅可以“康复”，而且可以超越。本文最关注的正是这类人群，他们是自己的“革命者”。社会需要强者，也需要弱者。强者值得骄傲，弱者也不丢人。比起互相嘲讽和指责，我们更需要尊重各自的命运，扮演好各自的角色。

5.2.3 毕业的现象学指征

总体来看，CPTSD 的毕业具有以下主观特征（现象学特征）。这些体验之强烈，常令当事者有重生之感。

注意，这些指征只是为了给自我评估提供适当参照，而不是为了取代客观指标。任何一个达到毕业水平的人，或者说任何一个人格健全的人，首先都有能力让人感到“靠谱”。

1) 能够稳定地维持安宁而警醒的精神状态。

所谓安宁，是指主体不再感到麻木，不再陷入神游。丰富的环境信息同时涌入脑海却不再引起感官超载，而是成为了精神的一种滋养。个体在刚刚找到这种状态时，往往会体验到如母亲怀抱般的幸福感。所谓警醒，是指一般意义的压力不再使主体感到焦虑、恐惧和羞耻，反而可以让主体变得清醒、灵活、

机敏和振作。主体在互动中可以一边体会，一边思考。他找到了自己的“中立状态”。

2) 平常心成为心境的基调。

主体不再有遗世独立之感，能深切感受到自己是人类中的普通一员。自己的烦恼仿佛水滴一般，可以很自然地融入人类情感的汪洋之中。主体的气场给人一种熟悉的、易于交流的印象。亲社会性得到充分激活，维持情感连接成为了自然而然的事。主体不再将他人视为各种陌生动作的随机堆砌，在互动中无需思考就能够感受到他人的个性和倾向，能够自然形成良好的边界感。他找到了人类的“日常状态”。

3) 变得爱好活动。

主体在空闲的时候总是忍不住要动起来，觉得必须给自己找点事做，但他并不会为此焦虑。

4) 乐于体会情绪而不再回避情绪。

与爱好活动相伴随的，是主体开始积极拥抱各类情绪的全部细节，不论是积极情绪还是消极情绪。

5) 闪回变得具有建设性。

闪回不再使自己崩溃，而是成为了过往自己与当下自己的一次对话，成为了当下自己与过往自己的“相互共情”。极端的闪回变成了寻常的“记起”，从灾害性的风暴变成了可利用的经验。它不会消失，但也不再可怕。抱持闪回和消化闪回的能力是情绪智力的重要组成部分，这种能力的大小是强者与弱者的根本区别。

6) 强烈的灵性体验。

强烈的灵性体验是 CPTSD 康复过程区别于一般意义的 PTSD 康复过程的最显著特点。

所谓灵性体验，可以理解为体验感受和意识对象的错位。比如上文所说的什么也没做，却体验到了像在母亲怀里一样的感觉。这可以比拟为儿童时期因为遭受情感遗弃而封闭了感官的孩子终于等到了母亲的到来。他激活了封闭已久的感官，投入了世界的怀抱，恢复了与他人之间最基本的情感连接。只不过由于童年的母亲和自己都已不在场，所以这种体验就成为了一种难以言说的

“神秘体验”。

CPTSD 的康复过程具有螺旋上升的特点。在不断循环的过程中，主体经历的闪回会越来越强烈，应对闪回的资源也越来越丰富。随着主体逐渐形成新的适应，神秘体验会自然消失。如果把精神状态类比为身体状态，那么神秘体验就相当于突然变换姿势时产生的超重感和失重感，具有一过性。灵性体验本身无所谓好坏，但自我封闭的受困者容易沉迷神秘体验，甚至会刻意诱导神秘体验，导致出现各种精神病性表现。

7) 享受一般意义的对抗

日常生活中的普通冲突不再令自己感到羞耻或者如临大敌，而是成了维持唤醒的最基本工具。

一位高中数学老师正在上课，一名休假结束的学生从后门悄悄走了进来。学生们齐刷刷地扭头观看。老师批评道：“看什么，这位同学脸上有高考题吗？”学生们笑了一下，回过头继续听课。这中间所有人的反应都没有任何问题。学生们表现出了应有的警觉性，老师尽到了维持教学秩序的责任。我们每个人都是在这样的对抗中成长的。如果养育者无法成为一个称职的值得对抗的有力角色，被养育者就很难发展出内在力量。

8) 积极迎接生活挑战

毕业好比一个常年卧床的人终于挺拔地站了起来，可以灵活地开展各种活动。但是主体要想融入社会生活，实现自我价值，还要充分接受生活的洗礼，补全在人格发展方面落下的功课。这同样是一个宏大而严肃的人生课题。主体将带上自己久违的生命力，投入生活的洪流，开启人生的“二次成长”，就像一个刚毕业的大学生投入了充满机遇和挑战的社会那样。毕业之后，生活压力更多了，极端的情绪体验也更常见了。但主体不再视自己为受害者，而是真正成为了世界的探索者和生活的博弈者。

5.3 迷路者的小故事

注意：本节涉及较为具体的生活经历，容易触发情绪闪回。

用身体或生活的语言讲述心理的故事，常常比貌似严谨实则苍白地堆叠名词更加准确。这里列举几个描述受困者日常状态的故事，这些故事既有真实成

分，又有隐喻色彩。请留意其中能够引起自己共鸣的部分，它们将帮助自己完成创伤的显著化。

5.3.1 自我认知类

1) 王座

他不假思索地接受了主宰者的角色，然后陷入了茫然无措之中。他的病态羞耻感并非单纯来自童年遭受的过度贬低。当自己被暗示处于世界的中心，举手投足都受到万众瞩目，然而自己完全无法胜任这样的角色，仿佛自己的一举一动都充满了过错时，自己就会体验到压倒性的羞耻和恐惧。

2) 散场

众人欢庆之时，他躲在窗外默默地观望着场内的热闹与精彩，一边期待，一边逃避。散场之后，他悄悄走入场内，在寂寞与孤独中想象与回味。孤独是他生活的基调。他被孤单感所包围，总是感到缺少了什么（被欢迎，自己的社会性存在得到确认），又想不起来是啥。

3) 忧伤的音乐

他喜欢沉醉于旋律优美舒缓的抒情音乐。但与一般人不同的是，不论什么音乐几乎都能被他品出忧伤的味道，仿佛所有的音乐都是在用乐景写哀情一般。沉醉于这种忧伤体验不仅无助于放松，反而进一步削弱了身体的活动性。直到有一天，朋友指出了他身上的孤独感，他才意识到这种忧伤其实源自他的寂寞与孤独。

当人们为某物心动时，他们会用行为表达出这种心动，然后期待从互动对象或其他参与者那里得到回应，得到回应的心动就会发展为真正的喜悦。如果这份期待落空，那么他们就只能收敛自己的行为，将这份心动压抑下去。这种心动被压抑的感受就是忧伤，它等同于心中的美好事物被否定甚至被摧毁时的体验。

4) 寒颤

他第一次体验“寒冷”的感觉。他感到身体在自发地收缩甚至颤抖，可他不知道该做些什么，也没有人告诉他该怎么做。他要么顺应身体的冲动蜷成一团，

要么躲避任何让他产生这种体验的环境。直到有一天，他发现可以在寒冷时穿上衣服。

5) 痛苦的歌者

只要伤口开始作痛他就唱歌（神游）转移注意，当他转移注意的能力炉火纯青以后，他经常不自觉地唱起来却忘了原因为何。他以“精神病”自嘲，但心有不甘。

6) 莽撞的盲人

压抑的成长环境令受困者不能区分平和的宁静、尴尬的沉默和危险的死寂。长期的精神紧张使受困者难以区分安全的放松感和危险的坠落感，因而他们容易将自己置身险境而不自知。

7) 蝴蝶效应

他恍惚而又慌张地走在上学路上，完全没有注意到来往的车辆。突然，一只大手一把拽住了他。他扭头才发现居然是个多年未见的老同学。就在这时，一辆疾驰的大货车与他擦肩而过，他差一点就非死即残。

命运就是这么奇妙，充满了各种机缘巧合。很多时候，一个小小的失误就足以令以后几十年的努力相形见绌。在不经意间，我们已经一次次与死神擦肩。受困者众多复杂问题的根源，常常只是来自人生起点上的一点点偏差。蝴蝶效应听起来很酷，但只有当它落在我们身上时，我们才能感受到它的分量。人生的戏剧性是多么令人唏嘘，感恩的品质又是如此难得。

8) 声东击西的生理缺陷

这是一个典型的“磨损性创伤”案例。

他的双足有些畸形，但因为没人看得见，所以他不以为意。他也从未觉得这和自己身上的其他更严重的问题有什么关联。真正让他痛苦的是驼背、腰痛和极差的平衡能力。他从小站不直，走不稳，稍微一动就累，却从未得到任何正确的指导，只是不断地得到“矫情”“脆弱”“废物”的评价。直到有一天，他读到一篇关于足外翻（因足骨发育异常而引起的一种病征）连锁反应的文章。他尝试照着文章所述摆正了双脚姿势，意外发现自己居然可以轻松地站直了。一种前所未有的轻盈灵便之感涌遍全身。可他还没来得及高兴，就感到一阵尖

锐的刺痛从脚底传来。他终于意识到了，自己长期以来所谓的腰背问题根源全在脚底。腰背的症状正是身体努力适应足部异常的必然结果。因为足部问题的发展是渐进的，身体可以及时适应，所以他从未感受过来自脚的痛苦。身体通过“足外翻”、“胫骨内旋”等方式将尖锐的局部问题转化成了温和的全局问题。身体的适应使问题变得更容易忍受了，但也同时将他长期固定在了活动能力严重受限的体态，最终招致了各种创伤，损害了他的身心健康和生活质量。

明白了这些以后，他开始努力学习像正常人那样走路，同时努力进行康复训练。一段时间后，脚底长出了老茧，疼痛变得可以忍受了（这个彻底解决需要手术，而手术成功率并不高，他选择了接纳这一缺陷，学会与之共处）。在康复过程中身上各种肌力失衡的问题一一暴露又被一一解决。这为心理创伤的康复做好了生理上的准备。

9) 问题复读机

年幼的孩子很容易在危机中陷入无可注意的意识状态和笨拙的身体状态。在这种状态下的孩子最容易受到暗示和引导的影响。如果养育者经常在这种时刻表现得过于神经质，甚至对孩子作出贬损性的评价和强烈的消极暗示，那么孩子就会对自己的自我支持能力和养育者的安抚能力失去信任。当孩子产生危机感时就很容易成为一个“问题复读机”，反复询问养育者同样的问题，即使得到确切的回答，也只能发挥极为短暂的安抚作用。比如孩子手上破了一点皮，流了一点血，他就可能反复询问父母伤口能否痊愈，直到伤口真的结痂为止。孩子将最终学会用解离压抑自己的危机感，直至发展出焦虑障碍和更严重的心理问题。主体表面上安静下来了，但是在他的内心深处，“复读机”从未停机，一直在折磨着自己。

10) 哼警报的人

他茫然地站在那里，眼神空洞，头脑发蒙，他觉得自己应该想到些什么，可又不知道该想些啥。解离使他情感淡漠，如果不允许自己神游，他就会感到茫然和空虚。此时远方一辆救护车驶过，响起“呜呜”的警铃声。他仿佛在漆黑的夜空中看到一颗流星一般，突然兴奋起来，也跟着发出了响亮的“呜呜”声。附近所有的人一齐看向他，那眼神就像发现了一个精神病人。他感觉到无比羞耻，好不容易放松了一点点，最后却蜷缩得更紧了。

11) 床边的魔鬼

那时的他还是个孩子。他在半夜醒来，看见如深渊般漆黑的魔鬼就站在床边，不声不响也不动，默默地盯着自己。他感到恐惧，同时体会到了深深的孤独感，仿佛坠入无底深渊。他想哭，但知道没人听得见。他听到了外边道路上车辆渐行渐远的声音，他知道那些过客与自己无关。他的家人都在外地谋生，他们现在帮不了自己。他听着客厅里座钟的滴答声、窗外清风吹动树叶的沙沙声，知道周围一片寂静。四周一片昏暗，这是三更半夜。他只能自欺欺人地让自己再度睡去，而他的身体被留在了创伤中。从此风声、钟声、幽夜等等一切原本象征安宁的意象都深深打上了创伤和孤独的烙印，他的世界被恐惧和孤独感淹没了。

12) 脆皮鬼与胆小鬼

脆皮鬼是特别容易受伤的人，胆小鬼是难以将高唤醒状态的能量转化为行动的力量的人。胆小与脆皮互为因果。他们把自己和环境对立起来，轻率地把自己放在了“猎物（被支配者）”而非“猎人（支配者）”或“合作者”的位置，甚至都懒得挣扎一下。如果说低唤醒状态下寻找完美解决方案的能力体现了人的创造力，那么高唤醒状态下的危机应对能力体现了人的资源储备。受困者往往重视创造力而轻视资源储备。

13) 没睡醒的人

活跃的身体才能产生丰富的感觉刺激，丰富的感觉刺激是维持唤醒的前提。二者构成正反馈循环。他的同事总是评价他仿佛从未睡醒一般。

14) 脱臼的肩膀

心理创伤好比肩膀脱臼，脱位痛苦，复位也痛苦。主体自救的过程就好比自己凭借努力战胜痛苦完成复位。其间的笨拙、惊慌与无措都值得被理解而非被嘲笑。而主体想要得到别人的理解和支持，首先要学会理解并支持自己，受困者必须学会自我同情（self-compassion）。

15) 辗转反侧

他并不失眠，但他每次睡着前，总是要辗转反侧半天。在他还住集体宿舍时，这一习惯曾给下铺的室友带来很大困扰。他不停地改变身体姿势，但始终

感觉浑身不自在。他没有意识到这些如同关节炎一般寄存在全身各部位的紧张状态正是心理创伤的遗迹，它们在身体需要放松时或外界干扰减少时（比如晚上睡觉前）暴露出来。躁动是受困者下意识地调节这些寄生性紧张的手段。如果他们连躁动都不被允许的话，这些寄生在身体中的紧张状态就可能引发更复杂的身心问题。

注意这个故事存在潜在的复杂性：全身性的肌肉或关节不适可能是某类肌肉或关节缺陷（比如全身性韧带松弛）导致，而这种全身运动系统的缺陷造成的脆弱性可能使主体对创伤十分易感。因此他的这些不适可能是心理创伤和生理缺陷混合的产物。

16) 叹息

我们在完成一项紧张而艰巨的任务或者放弃一项无法胜任的任务后，往往会“长叹一声”。这一声长叹卸载了身上积蓄的紧张感，降低了唤醒水平，使我们进入了一种相对松弛的状态。因此叹息具有卸载压力、打断驱力的效果。受困者（尤其是卡在克制阶段的受困者）由于微活动水平下降，他们在日常的感受与思考中常常习惯性地把身体绷紧在远超常人的水平，在感受和思考结束后也就需要更多的放松，因此往往会有习惯性的叹息。

为了能保持一定的专注，我们必须与身边的人分享一定的控制权，所以他们莫名其妙的一声长叹不仅会打断他们自己的驱力，也会打断我们的驱力。积极的人都不愿意跟整天唉声叹气的人相处，受困者就这样推开了能帮助自己的人。

17) 扩句与缩句

心理问题的形成和治疗的过程非常像小学语文课学过的缩句和扩句。问题形成的过程就是习惯缩句、忘记原句的过程，疗愈的过程就是还原（扩句）并重新适应的过程。

例：

原句：我爸爸的爸爸是我的爷爷。

缩句：爸爸是爷爷。

路人听后大惑不解，爸爸怎么会是爷爷？这孩子傻了吧？当事人已适应缩句的说法，同样无法觉察问题所在，也陷入了困惑。这就是问题形成的过程。

要破解这一问题，就要对问题怀有充分的敬畏和好奇。严肃地思考一下，什么情况下“爸爸是爷爷”这种表达会成立呢？我们很容易想到一种情景：

爸爸严厉地对儿子说：“我的爸爸是你的爷爷。”儿子若有所思地复述道：“爸爸的爸爸是我的爷爷。”爸爸赞许道:“说得对，以后就这样说，记住了吗？”儿子骄傲地说:“记住啦。”然后，儿子转身冲着一个陌生人大喊道：“爸爸是爷爷！”儿子甚至还没上过语文课，就精确地理解了句子的主干。这是孩子们的语言天赋。

很多心理问题都可以映射到这种亲子互动情节中。

18) 偷窥者/旁观者

他从未全身心投入过任何活动。参与感的匮乏使他对一切交互对象都怀有一种将信将疑、欲拒还迎的态度。他把自己卡在了探索前的定神阶段，永远也不会展开真正的探索，只活在自以为是的观察和想象中。他甚至会沉醉于这种“身处其中却置身事外”的感受。

19) 苛责者

受困者很容易被各种自主性很强但极不靠谱的人吸引，成为其附庸。为了能和这些人共处，他们甚至愿意忍受各种苛责乃至羞辱。如果我们观察这些“垃圾人”，就会发现这些人身上普遍拥有一种受困者最为缺乏的强大能量（类似于“匪气”）。这种野蛮原始、简单粗暴的能量虽然有显著的破坏性，但可以使这些人表现出强大的活力和抗争精神，这在受困者的眼中具有别样的魅力。

受困者普遍存在“启动困难”，苛责与羞辱可以产生额外的刺激，促进活动的发起和完成。如果没有人苛责他们，他们甚至会在脑海中想象出一个苛责的声音不断催促自己，让自己提高效率，这样的声音就是“内在批评者”。可见，受困者无法走出创伤的阴影，一定程度上是因为他们已经对创伤中寄存的能量形成了依赖。他们很难意识到活动的效率是由互动的流畅性决定的。如果我们能够在健康的人际关系中和互动对象建立积极的情感连接，在互动中体验到流畅感，活动效率自然会迅速提升，自己也会变得更有力量。受困者的低效率不是因为缺少督促，相反，他们由于过分的自责而缺少建立和维持交流圈的耐心和激情。

20) 否定者

这个故事一定程度上体现了创伤的代际传递模式。

创伤化的养育者在回答需要技巧的问题时会触发强烈的情绪闪回。如果提问者是陌生人，他会刻意抑制自己，避免失态。但如果提问者是被养育者，他就可以无所忌惮地宣泄情绪。他不会回答问题，而是会直接斥责提问者“愚蠢”。在被养育者的记忆中，自己的表达欲总是被养育者否定，似乎他一开口就只会暴露出自己的愚蠢。慢慢地，他变得畏惧表达，总是为自己问不出好问题而羞耻。他已经忘了，如果自己认真的倾听和真诚的提问遭到了否定，自己首先应该感到愤怒而非羞耻。他疲于在提问前进行自我审查，于是聪明地习得了解离，完全丧失了好奇心和探索欲，这样他就很少需要提问了。探索的缺失使他对世界极为无知，他也就更问不出好问题了。

21) 抱着石头的人

如果把遭遇创伤性事件比作被丢了一块巨石，石头太重，难以负重前行，那么哀悼是把石头稳稳地放在地上，愤怒是把石头砸回去，癫狂是抱着石头乱撞，抱怨是抱着石头哀嚎，抑郁是抱着石头躺在地上，神经质是带着石头挣扎前行。

22) 学外语的人

受困者常用“学外语”来形容自己学习人际交往技能、发展适应能力的艰难程度。这并不是矫情。成年受困者实现“二次成长”的难度完全可以跟学外语相提并论。

语言学家龙飞虎（Chris Lonsdale）用亲身经历证明了，成人之所以难以高效掌握一门新语言，并不是因为大脑学习能力退化，而是因为没有人再像对待小孩子那样，用纯粹的热情、关怀和耐心对待他们。他们也很难再像小孩子那样，充满激情与好奇地拥抱一场新鲜的互动而不带任何先入为主的偏见。受困者之所以难以发展适应能力，也是一样的原因。龙飞虎的研究为人们理解“学习”带来了全新的启发。受困者要想完成自己因创伤而被落下的人生功课，实现二次成长，就必须珍惜生活中的一切善意与关怀，抓住一切机会去应用这种婴儿般的学习方式。

23) 未竟之事

他总是习惯于一个人默默埋头探路。当别人把他从沉迷中唤醒时，他那冷峻的神态简直令人生畏。他自己也常常为自己如此缺少亲和力而懊恼。直到有一天他意识到，自己与外界的隔阂是因为自己还有“未竟之事”。他被困在无人之境太久了。他要修好路标，画好地图，要把重要的信息带回给世人。他的冷漠不是因为什么人格缺陷，而正是因为与世界之间的深切羁绊。

24) 功亏一篑

“我已经走了九十九步，他只要迈出那最后一步，这事就成了，可他为什么就是不动呀。”对不起，这一步只属于他，不属于自己。

自己上学的时候常被一些同学蠢哭，仿佛跟他们在一起什么都干不好。当时真的好生气，觉得自己怎么沦落到跟这些人做同学。现在仔细想想，其实是我的母亲一向严格要求自己，我在她的熏陶下养成了严格要求自己的习惯和细腻的行事风格。然而我的父亲并没有培养起我对秩序和权威的理解。我把这些都当成了空气，没有认真对待。一方面，当时的我将母亲的努力视为理所应当，认为人就应该这样。另一方面，我完全不懂得统战，不知道如何借力。所以当别人不配合我时我只会感到生气。当我意识到了母亲的努力后，也就看到了自己的努力，开始学会欣赏自己，同时不再苛求别人。当我看到自己父性成长的缺失后，我开始观察和学习别人身上的各种模式和套路，体会他人运用力量的方式。

5.3.2 人际关系类

1) 宅男上街

一名从幼年开始宅家直到成年的宅男在励志鸡汤的鼓励下终于走出了家门。为了有足够的安全感，他带了很多的钱，结果第一次上街就遭遇了抢劫。从此他看谁都觉得是想来抢钱，更加不愿出门了。励志鸡汤只鼓励他上街，却从来没有告诉他第一步该怎么走。

2) 缩头乌龟

小乌龟躲在壳里瑟瑟发抖，恐惧淹没了感官，使他无法接收环境的反馈。于是他一辈子都没再出来，甚至忘了该怎么出来。

3) 半生不熟的朋友

他有很强的表达欲，总是很慷慨地与人分享自己的知识或经历。但他发现别人似乎都不怎么感兴趣，甚至时常出现鄙夷、不屑等反应，令他感到挫败甚至愤怒。偶尔有人摆出了感兴趣的样子，他兴奋了半天，结果发现要么对方和自己根本不在一个频道，要么这只是一次捉弄。他终于崩溃了，变得抗拒互动，抗拒社交。即使有人真心愿意接近他，他也只能在惶恐中裹紧自己的盔甲。

经过了许多年的反思，他终于意识到自己从未正确认识与他人的关系。那些伤害他的人不过是半生不熟之人，他们的反应只是对被冒犯（“冒犯”可以理解成主体感到自身的定向反应受到了恶意的干扰）的反击而已，其中只有少部分出自真正的恶意。而那些真正愿意亲近他的人、真正可结交的人，反而很多时候都被他忽视了。

在陌生的情境中，我们最自然的行为与别人的会有很大不同。如果我们对彼此作出不习惯的动作，就会令自己和他人同时感到不舒服。建立熟悉感的过程就是我们从身体上（而不仅仅是意识中）感受到与他人同步，与他人拥有共同经历的过程。他的身心状态长期紧张，从未体验过舒展与同步，也就从未体会过“熟悉”和“陌生”的区别。他想当然地将自己的家庭关系扩展到了社会中，在吸引了一小部分人成为朋友的同时，也招来了无数的恶意。

4) 不经意间的招惹

由于认知僵化，受困者对人际冲突十分迟钝。他对各种利害关系的处理往往简单粗暴，虽然主观上毫无恶意，但常常给人以蛮不讲理，盛气凌人的印象，因此很容易招致他人的激烈反抗，使自己遭受出乎意料的恶性报复。他不知道自己为什么这么容易引起他人的敌意，逐渐在沮丧中陷入习得性无助。

5) 无聊的感悟

他对驱力的引导比常人吃力得多，应对各种挑战都需要更多的生理动员和心理建设。当挑战胜利完成后，他的成就感也就比一般人强得多。这种强烈的成就感使他急于向身边的人分享自己的感悟。可是，人类的生活语言并不是为这些复杂微妙的感悟准备的。他努力了半天，讲出来的东西在别人听来要么只是稀松平常，要么根本不成话。无聊的表达和兴奋的状态之间的失谐感使他给人留下了“愚蠢”的印象，他的沟通欲深受挫败。长此以往，他代偿出了强烈

的自恋倾向。

6) 从主体到主体间

他被一阵刺耳的轰鸣声吵醒。声音很大，床头的墙壁都在跟着震动。他感到不安，披上衣服打开了房门。声音更大了，应该就是这栋楼里的某个住户发出来的。他刚刚走出房门，声音突然停下来了。他站在门口，向四周看了看，没发现什么异常，于是又往外走了几步。声音又响起来了，似乎来自楼上。声音并不稳定，像一个人在手动操作维修工具。他顺着楼梯往上走，隐隐听到有人在说话，仔细一听，似乎是房东。可能房东在跟装修师傅修理空房间吧。他走到了楼上靠近楼道的门口，看到房门半开着。里边是房东的背影，旁边还有很多砖块。他跟房东打了声招呼，问明了原因，知道声音大约还要持续半个钟头。他看了看时间，房东的时间安排没有问题，并不算扰民。是他自己今天身体不好，才选择了在这个时间休息。他请房东把门关好，自己回去戴上静音耳塞，又休息了一会儿。

这是一个完整的从主体-世界互动切换到主体间互动最后又回到主体-世界互动的过程。

7) 碎片化的养育者

设想你只是一个孩子，你的一切资源都来自某个人。你受到的各种呵护都来自他，而你受到的各种伤害也来自于他。他鼓励你作出各种行动，可你作出的任何行动几乎都会遭受他的否定。你应该如何面对他？在他对你进行伤害时你应该如何反应？你的脑子不够用了，认知加工无法完成，于是你把自己变成了一个精神病人。

漫画《风云》中的第一邪皇在一次与儿子比武的过程中被逼出了魔性，挥刀劈死了儿子。电视剧非常形象地用阴阳脸表现了他魔性上头的状态。创伤化的养育者都是这样很容易唤醒魔性的人，只是他们不会给自己“化妆”，所以只能靠被养育者自己去察觉变身信号。认识到养育者随时可能变得不可靠，意味着接受了“养育者碎片化”的现实。认识到养育者是精神病人，是很多孩子走向康复的起点。

养育者的碎片可能散落在世界上的任何角落。主体需要做的是不再把养育者的反应当作完整的参考系，而是去观察、模仿其他人：邻居、老师、同学的

父母、书里的角色、电视里的形象，等等。不靠谱的父母身上也有养育者的碎片，甚至可能是最多的，否则孩子活不到能见到邻居的那一天。我们应该珍惜生活中积极互动的经历，珍惜善待自己的人。

在这种“替代依恋”的滋养下，孩子同样有机会获得健康成长，他们甚至可能比常人更加深切地体会到这个世界的美好与善良。

8) 停滞的代际联结

有一些成年人，完全有能力独立生活，自主决策。他们明明知道父母的一些说法根本没道理，但还是很容易受其影响。实际上影响他们的很可能不是父母的看法，而是父母的感受。在这些没道理的意见背后，传达的是父母的焦虑、不安、担忧等各种消极情绪。这些情绪都可以感染他们，让他们产生同样的感受。当他们明白这些感受属于父母以后，就会明白自己其实很在乎父母的感受。他们希望自己能让父母放心，也希望父母能让自己放心。

父母和子女最密集最深入的互动往往发生在子女很小的时候，随着子女年龄渐长，子女和世界的互动越来越深入，和父母的互动逐渐流于表面。子女和父母之间的互动流长期得不到更新，他们之间的互动方式也得不到发展。在父母眼中，子女可能从未长大，而子女也会在和父母的互动中不自觉地“退行”到小时候和父母争吵的状态。这就是互动流的惯性。子女为父母的不可理喻感到烦恼，但他们不知道，这些责备和偏执可能父母向他们表达关心或索取关心的唯一方式。要想打破这种惯性，子女就要打开思路，主动更新互动流，向父母提供关心自己的新方式。我们可以让他们看到自己乐观积极、充满能量的一面，让他们感到自己生活充实，富有意义，也可以不时地给他们带些东西，带着他们出去玩，和他们分享自己的经历和见闻，让他们感到他们仍然有能力参与子女的生活并发挥积极作用。让他们认识到曾经的孩子已长大成人，能够独当一面，能够主动关心他们，他们的状态自然而然会发生变化，这样他们和子女才有可能互相放心。与其期待自己能够改变他们，不如先看看自己能改变多少。

自己可以通过调整自己和他人互动的细节从他人身上获取自己需要的反应，最终使自己关心的人产生自己期待的改变，这是一种非常重要的“开悟”体验。我们和他人互动的方式与我们和自己互动的方式是一致的。当我们明白了自己

不能直接改变他人，也就明白了为什么 CBT 经常在自己身上失效。CBT 所强调的纪律和约束在很多人眼中都是和“强迫”绑定的。强迫只会触发创伤体验，唤起逆反心理。CBT 能够起作用的前提，是我们给自己定下的目标和原则真正体现了自己秉持的核心信念和自己最迫切的需要。如果我们不仔细观察自己的言行，充分体会自己的感受和需要，我们就不可能制定出值得自己坚持的计划。回想学生时代的自习课，明明自己希望专心学习，可总有一些过度活跃的同学给自己制造着不大不小的干扰，让自己分心。如果此时有一位讲原则有威严的老师坐在讲台上，他几乎不需要做什么，我们的学习效率也会极大提升。CBT 所强调的纪律和约束就是这样一位老师的角色，它是一种温和而坚定的内在声音，守护着我们的原则和信念。很多受心理问题困扰的人在他们最关键的成长阶段缺失了这样一位角色，导致他们没有发展出健全的自我约束和自我驱动能力，所以他们现在才需要用 CBT 补上这样的角色。

9) 被抢的台词

当他想要请教上位者问题时，上位者从不提供任何有意义的信息，只会指责他死脑筋，不懂灵活应对，把他整得很无助。我们请求上位者是为了获得明确的原则性方向性信息，这些基本的信息一旦明确，下位者自然会充分考虑具体操作中的余地，“灵活应对”是下位者的台词而不是上位者的台词。上位者是不懂原则的草包，下位者就只能自己去想象原则，把自己变成死板僵化的人。

在身心智模型中，上层结构是下层结构的上位者。如果养育者总是抢被养育者的台词，被养育者就可能养成十分纠结的性格，给人一种经常“左右脑互搏”的印象。

10) 笑场

笑可以迅速抖落紧张感，是比深呼吸还简单的放松手段。笑声可能意味着放松，也可能意味着对压力的抗拒和回避，无论这些压力是建设性的还是伤害性的。简单的一声笑既可能打破剑拔弩张的对立，也可能破坏辛苦建立的气氛。情况严重的受困者经常给人以“傻乐”的印象。

社交互动意味着能量的涌动，可他完全不知道如何利用这些能量。体内被卡住的能量已经使他不堪重负了，他无法再容忍更多的情绪。他时刻都在准备逃避，甚至可能在重大场合极不合时宜地笑出声来。自笑加上神游，相当于持

续地给心灵“按摩”， 虽然无法消除压力，却让痛苦变得可以容忍。他在脑海中各种可笑的场景中神游，不时发出笑声。对笑声的抑制又会消耗本就不多的意志力。他只能放纵自己不断傻笑，这种表现与精神分裂症的“自笑”极其相似，简直令他怀疑人生。

11) “驯化”

借用《小王子》中的“驯化”概念，心理创伤是受困者与创伤性事件互相驯化的结果。床边的魔鬼使一切普通的意象都被打上了创伤的烙印。对创伤的治疗和超越也是相似的驯化过程。无论是房子、星星还是沙漠，它们都因为某种看不见的东西（神秘的宝藏、一朵玫瑰花、隐藏的水井）而美丽。望向心中的星空，问问自己：“绵羊”是否已经把“那朵花”吃掉了？你会发现一切都会因你的答案而不同。

12) 外来者

当受困者以外来者的身份进入某个特殊氛围中时，由于氛围中的其他人不存在相似的定向反应，主体难以理解自身的定向反应冲动而无所适从，因认知加工困难而出现焦躁、兴奋等情绪异常。

13) 完美之人

受困者为取悦创伤化的养育者而构建了一整套精细而不切实际的标准化人格或理想人格。所有符合标准的行为都是理所当然的，而所有不合标准的行为都应当受到谴责。如果一时找不到这样的标准，他就会崩溃。对完美之人的执念，使他在人际交往中对他人偏执而苛刻，对自己缺乏自知。

14) 审判者与罪人

每当他恢复一点点活力时，创伤化的养育者那严厉的神情和苛刻的指责就会立刻将他打回原形。他逐渐习得了对自身天性的恐惧和羞耻。当他将这种恐惧与羞耻扩展到对同龄人的态度中以后，他的异常就再也无法通过和同龄人的健康互动得到矫正了。

羞耻感强化了自我关注，退缩限制了现实知觉，强烈的想象知觉把这种自我关注包装成了外部关注（这也是情绪推理），仿佛自己是审判庭上的罪人，永远被一群审判者苛责的目光所包围。他人只需要散发出和审判者相似的气场

或语调就足以唤起受困者的焦虑、恐惧和羞耻，受困者就这样成为了一个“懦夫”。他们在互动中总是轻易把自己放在不对等的地位上，在“地位博弈”中总是处于劣势，使自己非常容易受到催眠暗示，自身的能动性根本得不到发展。

他们的成长环境使他们难以区隔养育者身上养育性的一面与摧残性的一面。如果我们能够以成年人的视角重新体会与原生家庭的互动过程，就有可能理解并转化那些适应不良的心理状态和认知图式。虽然完美的养育者并不存在，但是聪明的儿童善于通过观察和探索，更多地和养育者身上养育性的一面建立并发展关系，在此过程中，儿童会逐渐体会到人格的复杂性，慢慢地能够理解养育者的缺陷与不足，最终学会客观地看待人的优势和缺陷。受困者若要突破自我，就必须与自己的出身和解。和解不是原谅，更不是清算，而是真正看见了成长的全貌。和解的过程是整合，是哀悼，更是独立。盲目逃离养育者的人无法发展出自身的“父性”和“母性”，他们没有责任意识和自律精神，不会照顾自己也不会关怀他人。

15) 奴才

他倾向于不假思索的接受种种限制乃至伤害，然后小心翼翼地寻求与种种威胁共处，然后在不断受挫中习得无助。这称得上是一种自虐。

他的自虐倾向源自创伤化的养育者留下的心理阴影。他在和养育者互动的过程中，一方面他的身心表达了强烈的抗拒倾向，另一方面他的认知告诉他“他们是爱你的，你也应该爱他们，这样紧张成何体统。”主体在认真尝试某项活动时处在一种笨拙的“脆弱状态”，这种状态下主体会向同伴分享一部分自身的控制权，许多创伤都是在这种状态下由不可信的同伴造成的。主体越是投入，自身就越脆弱，交出的控制权也就越多，受到的创伤就可能越重。分享控制权是人与人相互了解并建立信任的最基本途径，一般人可借此识别同伴的可靠程度。而他在盲目依赖同伴的同时表现出强烈的回避倾向，显得认知混乱，行为矛盾，效率低下。巨大的精神压力使他更容易与负面情感而非积极情感共鸣。他的身边逐渐形成了一个情绪化社群。

16) 身后的眼睛

一些受困者的情感底色极为诡异，他们时常感到背后仿佛有一双眼睛，在冷冰冰地看着自己。他们无法解释这种感觉，甚至可能因此变得神神叨叨。 实

际上，这种被冰冷目光监视的感觉就是掺杂着强烈孤立感的羞耻感。创伤会限制人们表达情绪的能力，导致这些人只能诉诸这样画面感鲜明的惊悚表达。羞耻与恐惧互相促进。如果一个人的情感底色充斥了太多羞耻，他就会成为众人眼中的怂人。

这种颇具画面感的表达虽然惊悚，但却创造性地将羞耻具体化了。这种将情感具体化的能力是人类的本能。早在史前时代的岩洞壁画中，人类就已经充分展现了这种天赋。这种被冷眼监视的感觉提示了羞耻感的来源。它告诉我们，被毒性羞耻感支配的个体失去了与那些“身后的眼睛”相处的能力。

所谓身后的眼睛，就是位于生活舞台背景中的各种人。当我们参与社会活动时，我们不仅在与具体的个体打交道，我们也是在和环境中的所有人打交道。我们的一举一动都可能产生广泛的影响，进而造成难以预料的后果。当我们在与人争辩时，只要有第三人在场，我们的争辩就会超出单纯争论的范畴，在不知不觉中演变为对第三方的争夺。甚至可以说，在绝大多数时候，我们的争论都是争给第三人听的。如果没有第三方存在，针锋相对的两个人很可能会直接大打出手，因为他们都深知自己根本不可能说服对方。

所有怂人都是对“空气”不敏感的人。他们不知道怎样与这些身后的眼睛相处，却又无法忽视其存在。他们总是困惑于不知怎么地别人对自己的态度就变了。他们在苦恼中寻求各种心灵鸡汤的安慰，这些鸡汤要么告诉他们“走自己的路，让别人说去吧”，要么告诉他们“别想那么多，别人根本没那么在意你”。这种话虽然有一定的安慰作用，但更多时候会把人带到反面，使人愈发麻木迟钝，自我孤立。在复杂的社会环境中，这些人一方面总是严重忽视他人释放出的各种重要信号，另一方面常常对自身行为所释放出的丰富信息估计不足，最后总是“自己都不知道自己怎么死的”。

影片《猩球崛起》中有一个桥段，觉醒的凯撒拿着一袋饼干，让另一只黑猩猩分给大家，但那只黑猩猩一把夺过袋子，掏出饼干就要独吞。凯撒一言未发，只是轻轻点头示意了一下。仿佛在说：“你有胆量就吃吧。”那只黑猩猩随即看到了众猩猩眼中的愤怒，瞬间没了脾气，乖乖发起了饼干。

在这一桥段中，凯撒收获了力量，而那只黑猩猩收获了恐惧。中间起决定作用的，正是大家的目光。当主体感到这些目光如审判之眼一般在冰冷地注视

着自己时，就会感到恐惧和羞耻。但是当他感到这些眼睛与自己同在时，就会感到力量。那些能够享受众人目光的人，都是能从众人的目光中收获力量的人。他们看到了众人的情绪随自己而动，感到众人与自己同在。

这种与众人连接的能力是人类的本能。早在原始社会，人类的祖先在草原上和丛林中追捕猎物、躲避猛兽的时候，就已经学会了跟随环境信息和团队氛围的各种微妙变化，及时有效地调整自己的行动，无须大吼大叫就可以完成协作。这种与环境建立并保持默契的能力是我们评估他人智力水平的重要参考。如果一个人缺少这种能力，就很容易受到轻视和排挤。

怂人之所以怂，不是因为他们愚蠢，而是因为创伤让他们失去了与这些身后的目光相处的能力。在他们的现象学世界里，自己仿佛囚犯一般，一举一动都被冰冷的目光监视着。自己只能埋头干活，连抬头张望一下都是罪过。就算身边没有任何人，他们也会自觉承担起那些监视者的职责，不停地苛责自己。他们天真地以为，只要自己抢先苛责过了自己，就能避免别人的苛责并获得宽恕。

这些人需要做的，不是学会对他人的目光脱敏，更不是用所谓“只要自己不尴尬，尴尬的就是别人”这种自欺欺人的话来安慰自己。这样不仅无济于事，反而会使自己更加孤独，更加无力。相反，这些人需要做的是在每一次互动中更加留意“空气”。如果自己感到无措，不妨放慢节奏，轻轻环顾四周，或许就能从他人的音容笑貌、谈吐举止中意外收获力量。即使他们发现根本没有人注意自己，也会感到自由和放松而非无助。同一环境下的两个人即使不存在任何实质交流，他们也在为对方提供着支持。他们的一举一动都在向对方传递着关于环境的各种信息。告诉对方现在是否值得紧张，是否出现了值得注意的异常。重建人类最基本的默契是受困者康复过程中的重要环节。对他人的信任使我们可以真正放松。

能够看到别人身上与自己同在的力量，这是极为鼓舞人心的体验。这样的体验只要经历过一次，就足以将所有羞耻感一扫而光。此时那种背后有人的恐怖感觉自然就消失了，个体会感到从未有过的自由。

17) 危险的专注

他总隐隐觉得，只要自己集中注意，就会有非常可怕的事情发生在自己身

上。所以除非事物的诱惑力大到足以让他忽视一切风险，否则他无法专注于任何需要耐心的事情。

在他的成长过程中，只要他作出紧张而用心的行动，他的养育者会立刻以笨拙、迟钝、拖沓、离谱、磨洋工为由辱骂、打断甚至殴打他。实际上这些行为不仅不笨拙，不离谱，反而很用心，甚至很有创造力，然而养育者自身的创伤和局限使养育者无法看到这些积极的品质，无法理解这些行为的意义。

养育者对此毫无自觉，治疗师无法从他们的自我报告中获取此类信息。

18) 管家与修炼者

受困者沉浸于自己的小世界，需要他人为自己提供各种基本保障，因此往往对他人有着高标准的细致要求，显得极为苛刻，没有边界感。他们对身边的人有着过高的期待和精神依赖，一旦期待落空，他们就会感到失望和愤怒。

19) 迷路的旅人

无助的人期待援助，但专注的人憎恶打岔。普通人在解决问题时，问题本身会引导他们的探索行为的发展，使他们越来越活跃。而受困者则相反，他们倾向于依靠安静的思考寻找办法，这可能导致身心活跃度进一步下降。受困者长期困于指向内心对象的意识活动，不能区分孤独的无助状态和沉浸的探索状态，他们不但意识不到自己真的非常需要帮助，反而常常对别人的帮助感到嫌弃，仿佛自己被鄙视了一般。他们就像脱离组织孤军深入而不自知的士兵，无力应对敌人却又识别不出战友。生理上处于高唤醒状态而认知上陷于无助。

受困者回避眼神接触并非由于先天缺陷，而是作为一名“孤立者”，无法确认他人是否安全可靠。他们想要观察环境，又怕引起注意，眼神接触所伴随的高唤醒会让他们感到恐惧和羞耻。他们无法利用恰当的眼神接触获取信息，他们既不知道什么时候应该有眼神接触，也不知道什么时候该把眼睛移开。

20) 被遗弃的孩子

想象一名儿童陷入了困境。他可以用语言或者行动表明对抗态度，如果抗拒无效，他可能出现激烈的战或逃反应。如果战或逃反应同样无效，他还可以寻求身边之人的帮助。但如果求助始终无法得到任何有意义的回应呢？这时候，强烈的恐惧感会帮助他封锁感官，使他进入解离状态。如果对压力的应对过程

始终无法完成，解离就会转为相对温和但也更加持久的形态。对于许多受困者，解离的背后都是一种深刻的被遗弃感。他们一方面表现得情感淡漠，一方面又很容易被他人操纵，来自任何人的否定都会使他们伤神。他们在情感上失去了“归宿”。

21) 黑暗迷宫

人们面对弱者时很容易暴露出内心最阴暗邪恶的一面。受困者难以通过人际互动发展认知图式，原因之一就是他很难得到常人的待遇。对于许多受困者来说，常人都是两面三刀阳奉阴违自私自利的小人，他们分享的所谓经验根本没有任何实际价值。

实际上，受困者在生活中同样得到了很多善意和关怀，只是他的身心状态使他很难和这些人性中的光辉一面共鸣，正如所有的鲜花在黑暗中都会黯然失色一般。受困者已经忘了，自己的身体就是最好的探照灯。只要他和世界保持积极互动，迟早能走出迷宫。他所留下的痕迹也会成为后来者的路标。

22) 学车与解题

对于常人，将成长类比为学开车更容易理解。在无数难以言传的微妙互动中，人和车逐渐达成默契，动作从生疏僵硬到流畅自然，精力从全神贯注到游刃有余。人的社会发展过程同理。但受困者习惯于将学习理解为“找原理”或“背公式”。在他们眼里，世界是僵化的，没有活力的。但实际上，僵化的是他们自己。用接纳与承诺疗法（Acceptance and Commitment Therapy，简称 ACT）的话说，他们丧失了“心理灵活性”。他们很难理解感受是理智的基础，总是用所谓的理性封锁甚至逃避感受。被压抑的情感会见缝插针地寻找一切出口。受困者自以为追求“理性”，但在他人眼中不是显得冷漠刻薄，就是显得极端情绪化。

创伤会限制一个人的“学习窗口”。常人学开车，白天可以学，晚上也可以借着路灯学。但是在受困者的世界里，路灯不存在。他们想在人最少的时间练车，却发现根本不可能。他们无法理解为什么自己的世界没有路灯，于是拼命寻找原因，把阳光也错过了。他们没有时间学习，也就永远不会开车。

世界上既有温暖的阳光，也有阴暗的角落，没有灯就更要珍惜阳光。创伤使人更容易感知环境中的威胁因素，不容易注意到其中的发展因素。即使受困

者身边充满了拥有爱心和激情的人，他们也完全视而不见。在他们眼里，世界充满了冷漠、自私和贪婪，没有人理解自己。可别人却觉得，他们过于神秘莫测，让人根本不知如何靠近。他们拒人千里之外，不能接受也不会表达善意。人不可能从不了解自己的人身上感到爱意，正如人不可能被不理解自己的人说服。远离爱心、关怀和帮助太久，人的心灵必然变得僵硬。他们无法理解自己的各种僵硬表现，开始怀疑自己存在先天缺陷。

接纳别人的善意，找到生活的激情所在，这是必须靠受困者自己才能启动的课题。他们不伸出手，就永远没有人能拉住他们。

23) 拯救者与被拯救者

很多受困者习惯以“拯救者”的姿态出现在各种关系中，他们有一种强烈的、不可遏制的助人情结。这和常人的利他性有本质区别。

拯救者往往是因长期受到情感忽视而丧失了活力的人，孤独是他们的情感底色。一方面，他们在和强者的竞争中总是落败，因此只能从弱者身上获得肯定。拯救者普遍有架子，爱“端着”，生怕一不小心就会暴露弱点。他们只想着从别人身上获得肯定，却始终不愿接纳自己。这种居高临下而又高度紧绷的拧巴姿态很难交到真正的朋友，反而容易吸引别有所图的人，所以他们的孤独感永远挥之不去。令一方面，他们需要依赖别人的活力驱动自己。但别人是自由的，为了能让他人的活力为自己所用而不是伤害自己，他们必然显得控制欲过强。换句话说，“拯救者”同时也是“期待被拯救者”。他们希望别人能够像自己拯救别人那样拯救曾经被忽视的自己。救世主情结意味着一种无声的呐喊，他们在向当初忽视自己的亲人表达自己的愤怒与不满，在声讨他们：你们本来应该这样做，你们完全可以这样做。

考虑到创伤的代际传递，救世主情节还有更令人窒息的成因。很多孩子从小就常听父母讲述他们的痛苦。这些父母不仅无法照顾孩子的情绪，反而常常寄希望于从孩子那里获得安抚。成长在这种家庭的子女对世界负有强烈的负罪感和亏欠感，他们在人际交往中总是倾向于“向下看”，仿佛拯救他人是他们义不容辞的责任。

很多拯救者为了帮助他人而过度付出，甚至不惜耽误自身发展。他们之所以显得没有边界感，是因为他们太努力了，即使面对根本不熟的人，他们也会

像亲兄弟甚至长辈一样“热心过度”。如果别人因为警觉或感到冒犯而拒绝了他们的好心，他们会立刻感到像被亲人抛弃了一样。拯救者因为自己受过创伤，因此更容易感受他人的无助，同情心也就更强。他们深切地相信，很多人做不好该做的事情只是因为这些人没有得到本应得到的支持，而不是因为他们自己的问题。因此单从助人动机上来说，他们与常人并没有本质区别，只是程度更加强烈。

拯救者要做的，一方面是认可自己为寻求拯救所付出的努力，充分哀悼自己的童年，不再期待被拯救。另一方面，是理解亲人的局限性，如果无法接纳他们的局限，就要有所行动，而不是像一个长不大的孩子一样在心中抱怨。但最重要的，是将自己对待他人的强烈同情心也用到自己身上，照顾好自己，做好自己该做的事。当拯救者接纳了童年丧失，完成了自我整合，重新捡起了自己的内在力量，不再对别人怀抱过高期待后，他就会重新成为一个热心肠的普通人，明白助人的前提是互相尊重，是各行其是，是有所为有所不为，而不再只是做一个卖力不讨好的“救世主”。

造化弄人，命运残酷，人必须竭尽全力才能在尊重命运与改变命运之间找到自己的平衡。

5.4 觉醒时刻的小故事

这里列出几个捕捉受困者日常觉醒时刻的故事。创伤化严重的个体需要经历很多次“觉醒时刻”，他的觉醒状态才能达到可自我维持的水平，就跟虚弱的身体需要持续锻炼才能强壮起来一样。为避免读者产生边界被入侵之感，这些故事不会使用第二人称。当事者在记叙自己的故事时，可以尝试不同的人称，体会人称的变换对表达效果造成的影响。一般来说，第一、第二人称更容易唤起情绪，第三人称更有利于“反思”和“标记”。

1) 值得紧张之事

他像平日一样快要迟到了，但是如果跑起来的话倒也来得及。可他就是一点也感觉不到紧张，仿佛存心要迟到一般。此时耳机中的《柴可夫斯基第一钢琴协奏曲》正进行到气氛幽暗诡谲而节奏明显加快的部分。不知怎么地，他的脚步越来越快，居然不自觉地跑了起来。他第一次感受到了迟到是一件值得慌

张的事。他跑得很快，却并不觉得累，仿佛身上充满了力量。路上需要转弯，草木影响视线，他在奔跑的同时还要留意路况，但这已然成为不费吹灰之力之事。最终，他在迟到前最后一秒冲入办公楼成功打卡。在长舒一口气的同时，他感到整个世界变得无比清晰。整天萦绕在心间的噪声消失了，他感到从未有过的放松和清醒，平时总是绵软无力的身躯第一次感到了轻盈和灵活。

这是应激反应第一次使他得到了行动的力量而不是立即陷入了崩溃。他没有用意志强迫自己，而是让涌起的能量带动全身完成了任务。

音乐是受困者排遣寂寞、寄托情感、保持唤醒的工具。音乐一响，受困者就陷入了神游，从而避免了面对现实所带来的感官超载或精神空虚之苦。音乐既然可以使他陷入神游、抽离现实，就也可以被用来推动解除自我抑制，将他推入现实。

注意这里说的音乐是真实的音乐而不是神游中的噪音，更不是精神分裂症的幻觉。

2) 值得兴奋之事

他在商场里吃完饭，正准备下楼。外边传来一阵异响，随后是人们的喧哗。他早已习惯了自我抑制，所以异响丝毫没有影响到他。毕竟在他的经验里，自己总是为一些不足为道的事大惊小怪，常被当成神经病。他不假思索就适应了这阵异响，就像一般人适应了春节假期的鞭炮声那样。但随后这欢呼声，让他隐约觉得不简单。“还是抬头看看吧。”他这样想着，抬起了头，看见商场门口人头攒动。有的人打着伞，有的人举着手机。异响和喧闹还在持续着，他终于意识到有什么值得注意的事情发生了。

就在这一瞬间，他感觉世界仿佛被点亮了一般。他产生了少有的清醒之感，就像那次为了赶时间跑进公司那样。这一次不同的是他感受到了自己的好奇心。他快速走出了大门，这才发现外边下起了一场好大的冰雹。年轻的人们有的在拍照，有的在议论，有的的脸上洋溢着惊喜，有的显露出慌张甚至忧虑。大块的冰雹哗啦啦砸在地上，立刻溅出很远，有的滚到了他的脚边。他看着这一切，被众人的情绪所感染，成为了大家的一员。这一次他没有失态，而是“觉醒”了。童年被无端呵斥的场景和痛苦体验在脑海和身体中闪过，复杂的情绪涌上心头。他感到有些恐惧，有些愤怒，有些兴奋，又有些悲伤。最后，这些情绪都消失

了，只留下了能量顺畅流动的兴奋感。他终于认识到了众人的反应并不令人羞耻，相反正是活力的体现。他的应对能力长期得不到发展，始终停留在婴儿水平，因此才会时常显得大惊小怪。

一种陌生的表达活力的方式如同一种陌生的艺术形式，起初可能令我们好奇，也可能令我们感到古怪。但是，只要我们以舒展的心态面对它，就有可能在未来的某个机缘下与之产生共鸣。从此我们就如同被唤醒一般，有了欣赏甚至参与其中的能力。这是人与艺术的缘分，对待生活也应如此。

3) 可爱的人

她们太可爱了，令他沉醉。经过几次互相帮助后，他和她们有了一些熟悉感，互动开始热烈起来。他起初还有些羞耻，但他从她们身上感受到的善意很快就压制住了他的焦虑反射和对抗倾向，他逐渐认识到了这是单纯而友善的互动，没有任何捉弄的成分和隐匿的动机。他感觉到身体里有一种长期被自己压抑的能量开始缓慢流动了。他真切地体会到了以前的自己有多么狭隘。他再也不会因为一点点心动就以为是自己爱上了别人或者别人爱上了自己，也不会再轻率地认为别人在捉弄自己。

他在更细微的水平上区分开了不同的“心动”感受。他开始厌恶之前那种萎靡瘫软的体态，因为那种体态会妨碍他体会人际互动中的心动时刻所蕴含的美妙能量。慢慢地，他变得“支棱”起来。

认识到他人的可爱之处，产生对他人的兴趣，是受困者走出自我，走向他人的第一步，这样的机会可遇不可求。

4) 深度拉伸

他在晚上跑完步以后有些疲惫，于是找到一段跑步后深度拉伸的视频教程，跟着里边的老师在缓慢而有节奏的深呼吸中一点点将身体调整到正确的姿势，缓慢地放松全身，清晰地感受着身体中的紧张逐渐在特定肌肉的拉伸中被释放的感觉。他一边确认自己的动作足够正确，一边在深呼吸中努力保持着姿势的稳定。在完成一整套动作后，他就去睡觉了。他在半夜醒来时，发现长期困扰他的“脑中剧场”竟消失得无影无踪，世界简直从未如此宁静。

全身贯注而有条不紊（忘我投入而不过度激动）的活动是重置身心状态的最佳选择。

5) 共舞

她将他从神游中叫醒。她的友善态度和她的经验让他在非正式教学的情形下学习跳舞。她舞动时多少也带着他舞动，舞步并不复杂，经过一些尴尬的时刻后，他的耳朵感觉到音乐和舞步有某种关联，他开始意识到她的动作是有节奏的。舞会结束时，他发现自己已经可以跟随她的动作，脚步也比较轻松，甚至能避免不小心踩到她的脚。

当我们帮助受困者改善活动性时，就好像在与他们共舞，我们引发一种状态，让他们在其中学习，却不需要由我们来教他们。当主体尝试扩展自身的活动能力时，他会下意识地不断调整姿势和动作，直到自己能够获得“流畅感”。这个例子具有隐喻的意味，如果将“她”比作正念的注意力品质，将“他”比作被阻塞的体验流，那么共舞的过程就是体会形成的过程。如果将“她”比作施助者，将“他”比作受助者，那么共舞的过程就是最理想的救助过程。

6) 带领者

这是一个想象中的情境，具有梦境的品质，它是否合乎逻辑并不重要，重要的是它展现的能量的唤起与释放的过程。这种借助想象情境锻炼抗压能力的练习在职业运动员的训练中经常被使用。

想象：你的孩子在楼上荡着秋千，你在楼下看着他。孩子好像发现了某个诀窍，逐渐越荡越高。然后他突然发现高得有点过头了，他想停下来，却发现自己并没有办法。他有点慌了，开始试着挣扎，却发现还是越荡越高——他的行为已经僵化了，把自己卡在了越荡越高的动作模式中，他终于在慌乱中哭了出来。你眼看着他就要被甩出去了，此时想冲上楼也来不及了。于是你用坚定的语气对着他呼喊，告诉他在往低处荡时蹲下，荡起来时再站起——他好像本来就是这么做的，所以并不管用，于是哭得更厉害了。你这才意识到自己说反了。于是你深吸一口气，强忍住慌张，也告诉他要深吸一口气，在往下荡时努力站起来，往上荡时就蹲下去。他的腿已经有些使不上劲儿了，但你的坚定和沉稳赋予了他力量。他听从你的指令，努力地执行动作。终于，秋千慢下来了。你冲上楼，迎面将他抱住，仿佛你们刚刚经历了一次重生。

对于受困者来说，无论是成为带领者被一个脆弱的人信任，还是成为被带领者去信任一个可靠的人，都一样可怕。学习在压力之下的相互信任，是受困

者人格发展中的重要一课。

7) 娴熟的理发师

理发师娴熟的技艺如行云流水一般，声音清脆，动作流畅，触感轻柔。双手如舞蹈般在他头顶游走，每一次推按都轻柔而又笃定，使他毫不费力就能完成配合。每一次落剪都点到即止却又毫不含糊，动作游移快如闪电，令他一时竟不清楚自己头上有几只手。他的注意力想紧紧追随那美妙的触感和声音，却发现根本做不到，它们虽然无比清晰但又完全无法预知。慢慢地，他发现其实根本没必要费力去注意那每一个动作。当他不再控制自己的注意力时，那些触感和声音竟然汇集成了一部美妙的交响曲。他终于放下了他那强迫性的自我控制，开始欣赏起这动人的乐章。生活中的轻松时刻逐渐在脑海中浮现，他想起了许多年前和家人在一起的温馨日常。

当他结完账走出理发店时，夜晚小镇的万家灯火、车水马龙、扰攘人流竟让他感受到了从未有过的祥和与温情。小镇一直如此，变得是他自己。这时他才意识到，自己平日神游时脑子里那响彻不停的音乐竟是对缺失的生活乐章的代偿。他第一次体验到了真正的放松。他的高级皮层第一次放下了身段，从压迫者变成了聆听者。

8) 勇者的狼狈

经过了几天科学而循序渐进的健身，他似乎找到了某种流畅感。这种流畅感正在迅速扩展到生活的方方面面，他感到久违的能量正在回归。与此同时，强迫性的自我凝视又像一位苛刻的监工那样在逼迫他，辱骂他。他努力地维护着身体和环境的互动，避免内在批判者支配自己。虽然脑海中没有闪回任何画面，可他的身体却像一个独自面对凌辱的孩子那样，一边倔强地保持着活跃，一边不自主地战栗着。这一次，他没有理会心中那个苛刻的声音，没有刻意地抑制这狼狈的战栗，而是努力把注意力集中在最重要的互动上。慢慢地，他从内心深处涌起了一股深切的自我同情。这一刻，他终于领悟了“顺其自然、为所当为”的真意。

此前，“狼狈”对于他一直是出丑的代名词。每次面对可能出丑的场面，他都会用尬笑或自我贬低来回避不舒服的体验。如今，他第一次感受到了战栗之中的勇气，他为自己曾经嘲笑别人的狼狈而羞愧。这种亲社会性的羞愧感

（内疚）与退缩性的羞耻不同，它不但不会使他陷入自我否定，反而使他感受到了自身与世界之间的深刻羁绊。被卡住的冲动得到释放的过程往往伴随着战栗，这种突破自我的战栗和退缩的战栗在主观体验上无法区分，只有在个体走出创伤之后才能得到恰当的评估。

心理突破普遍伴随着战栗与狼狈，任何狼狈都值得同情。任何轻易蔑视别人的狼狈的人都可以从自己的好友名单中清理掉。

6 念给自己的咒语

咒语不追求严谨，只需要好记好用，随时能用。这些咒语一定程度上也是对全文内容的总结。好用程度取决于自己的体会，如果觉得过于抽象，那就没用了。

理解身心关系：人可以自欺，但身体不会忘记。

理解自己的行为：我这么做的唯一理由是世界需要我这么做，而我爱这个世界，不是什么规则要求我这么做。

面对痛苦：感到难受的时候，正是修行的时候。

想表达情绪：上位者隐藏情绪，等位者沟通情绪，下位者沉溺情绪。

理解修行：一切坏事都是未完成的好事。

面对情绪：只要我用心觉察和跟踪在情绪之下的冲动、感觉和感受，我就不会失控。

想要寻求帮助：找贵人，不找同类。

面对不良人际关系：要么感恩，要么自强。

面对上位者的指责：上位者承担责任，下位者才会自省。

想要助人：不给无所作为的人搭把手，不给毫无想法的人出主意。

面对躲不开的人：我很喜欢他，让他讲点有趣的吧。

面对思维反刍：是什么感受在支撑这些思维？它是怎么被触发的？

面对自己的笨拙：我是否足够认真？是否真的存在限制？

7 参考资料与推荐书目

以下资料，列出了英文名的应当以英文版为中心，中文版仅作参考。在阅读中文版时遇到的很多困难都可以通过阅读英文版得到解决。

7.1 心理学基础必读

中文名	英文名	作者	出版社	译者	出版时间
心理学与生活(第 19 版)	Psychology and Life	[美]理查德·格里格/[美]菲利普·津巴多	人民邮电出版社	王垒 等	2016
改变心理学的 40 项研究	Forty Studies that Changed Psychology: Explorations into the History of Psychological Research	[美] 罗杰·R·霍克	中国人民大学出版社	白学军等	2015

7.2 早期崩溃必读

中文名	英文名	作者	出版社/期刊	译者	出版时间
	Autism as an Infantile Post-trauma Stress Disorder: A Hypothesis	周婷/易春丽	Journal of Mental Disorders and Treatment		2017
	The Vanished Last Scream: Winnicott And Bion	[以]Ofra Eshel	The Psychoanalytic Quarterly		2019
爸妈治好了我的自闭症	Autism Breakthrough: The Groundbreaking Method	[美]劳恩·考夫	重庆大学出版社	陈曦	2018

	That Has Helped Families All Over the World	曼			
心理治疗中的依恋：从养育到治愈，从理论到实践	Attachment in Psychotherapy	[美] David J. Wallin	中国轻工业出版社	巴彤/李斌彬/施以德/杨希洁	2014
儿童心理创伤的预防与疗愈	Trauma Through a Child's Eyes: Awakening the Ordinary Miracle of Healing	[美]彼得·A.莱文/[美]玛吉·克莱恩	机械工业出版社	杨磊/李婧煜	2023

7.3 认知行为疗法必读

中文名	英文名	作者	出版社	译者	出版时间
★被忽视的孩子：如何克服童年的情感忽视	Running on Empty: Overcome Your Childhood Emotional Neglect	[美]乔尼丝·韦布/[美]克里斯蒂娜·穆塞洛	机械工业出版社	王诗溢/李沁芸	2018-10
不成熟的父母	Adult Children of Emotional Immature Parents: How to Heal from Distant, Rejecting, or Self-Involved Parents	[美]琳赛·吉布森	机械工业出版社	魏宁/况辉	2017-6
伯恩斯新情绪疗法II	The Feeling Good Handbook	[美]戴维·伯恩斯	科学技术文献出版社	李亚萍	2017-2
不原谅也没	Complex PTSD: From Surviving to	[美]皮特·沃	北京	严	2023

关系：复杂性创伤后压力综合征自我疗愈圣经	Thriving	克	科学技术出版社	菲菲	
叙事疗法实践地图	Maps of Narrative Practice	[澳] 迈克尔·怀特	重庆大学出版社	李明 / 曹杏娥 / 党静雯	2019-7
创伤后应激障碍的治疗：认知加工疗法实用手册	Cognitive Processing Therapy for PTSD：A Comprehensive Manual	[美]帕特里夏·A.雷西克/等	中国轻工业出版社	许梦然 / 程明	2022-5

7.4 心理动力学必读

中文名	英文名	作者	出版社	译者	出版时间
存在主义心理治疗	Existential Psychotherapy	[美] 欧文·亚隆	商务印书馆	黄峥	2015-5

7.5 体感疗法&感觉运动心理疗法&身心学必读

中文名	英文名	作者	出版社	译者	出版时间
身体从未忘记：心理创伤疗愈中的大	The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma	[美]Bessel van der Kolk	机械工业出版	李智	2016-3

脑、心智和身体			社		
★唤醒老虎：启动自我疗愈本能	Waking the Tiger: Healing Trauma: The Innate Capacity to Transform Overwhelming Experiences	[美] 彼得·莱文/[美] 安·弗雷德里克	机械工业出版社	王俊兰	2016-4
动中觉察	Awareness through Movement	[以] 摩谢·费登奎斯	北京科学技术出版社	林若宇/曹晓东/郭建江	2019-3
聚焦心理：生命自觉之道	Focusing	[美] 尤金·T·简德林	东方出版中心	王一甫	2009-6
创伤后的自我成长	Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors: Overcoming Internal Self-Alienation	[英] 雅尼娜·菲舍尔	世界图书出版公司	刘竹	2023-10

7.6 无伤运动必读

中文名	英文名	作者	出版社	译者	出版时间
健身路线图：精准训练与无伤运动导航书		陈邹琦	北京科学技术出版社		2023

7.7 选读

中文名	英文名	作者	出版社	译者	出版时间	备注

精神障碍诊疗规范（2020年版）		中国卫健委			2020-11	精神障碍诊疗规范
对伪心理学说不	How to Think Straight about Psychology	[加]基思·斯坦诺维奇	人民邮电出版社	窦东徽 / 刘肖岑	2012	心理学科普
深入大脑	The Brain with David Eagleman	[美]David Eagleman	PBS		2015	纪录片，心理学科普
维莱亚努尔·拉马钱德兰：通往心灵中央的旅程	Vilayanur Ramachandran: 3 Clues to Understanding Your Brain	[印]维莱亚努尔·拉马钱德兰	TED		2007	讲座，心理学科普
心理咨询面谈技术(第四版)		[美]John Sommers-Flanagan / Rita Sommers-Flanagan	中国轻工业出版社	陈祉妍 / 江兰 / 黄峥	2014	个案概念化技术
蛤蟆先生去看心理医	Counselling For Toads: A Psychological Adventure	[英]罗伯特·戴博德	天津人民出版社	陈赢	2020-8	心理咨询科普

生						
唤醒大脑：神经可塑性如何帮助大脑自我疗愈	The Brain's Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers of Neuroplasticity	[美]诺曼·道伊奇	机械工业出版社	闾佳	2016-9	神经可塑性相关研究
身体会替你说不：内心隐藏的压力如何损害健康	When the Body Says No: The Cost of Hidden Stress	[加] 加博尔·马泰	机械工业出版社	李汉婕 / 侯灿 / 薛飞 / 周惠敏	2023-9	心身疾病与创伤的代际传递
孩子的注意力90%可以靠营养改善	Finally Focused	[美] 詹姆斯·格林布拉特 / [美] 比尔·戈特利布	北京科学技术出版社	胡晓红	2021-7	ADHD的营养学，请谨慎使用
用图像思考：与孤独症共生	Thinking in PIctures: My LIfe with Autism	[美]天宝·格兰丁	华夏出版社	范玮	2014-	ASD人士自传
习得性无助：论抑郁、发	Helplessness: On Development,Depression and death	[美]马丁·塞利格曼	中国人民大学出版社	李倩	2020-7	抑郁的习得性无助

展与死亡						理论
这世界唯一的你：自闭症人士独特行为背后的真相	Uniquely Human: A Different Way of Seeing Autism	[美]巴瑞·普瑞桑/汤姆·菲尔兹-迈耶	机械工业出版社	陈丹/黄艳/杨广学	2016-3	自闭症谱系障碍科普
	Switched On: A Memoir of Brain Change and Emotional Awakening	[美]John Elder Robison	Spiegel & Grau		2017-2	阿斯伯格觉醒者自传
阿斯伯格综合征完全指南	The Complete Guide to Asperger's Syndrome	[英]Tony Attwood	华夏出版社	燕原/冯斌	2012-8	阿斯伯格综合征科普
临床催眠实用教程	Trancework an Introduction to the Practice of Clinical Hypnosis	[美]雅普克	中国轻工业出版社	高隽	2015-11	催眠理论基础
催眠疗法：探索性案例集锦	Hypnotherapy: An Exploratory Casebook	[美]Milton H. Erickson/[美]Ernest L. Rossi	中国轻工业出版社	于收	2015-9	催眠治疗临床实践
体验催眠：催眠在心理治疗中的应用	Experiencing Hypnosis: Therapeutic Approaches to Altered States	[美]Milton H. Erickson	中国轻工业出版社	于收	2015-7	催眠治疗的理论与实践

心理创伤疗愈之道：倾听你身体的信号	In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness	[美]彼得·莱文	机械工业出版社	庄晓丹 / 常邵辰	2024-7	体感疗法科普
聚焦：在心理治疗中的运用	Focusing in Clinical Practice: The Essence of Change	[美]Ann Weiser Cornell	中国轻工业出版社	吉莉	2016-5	聚焦的临床实践
焦虑症与恐惧症手册	The Anxiety and Phobia Workbook	[美]艾德蒙·伯恩	重庆大学出版社	邹枝玲 / 程黎	2018-4	认知行为疗法自助经典
人间游戏：人际关系心理学	Games People Play	[美]Eric Berne	中国轻工业出版社	刘玎	2014-2	沟通分析理论
给心理治疗师的礼物：给新一代治疗师及其病人的公开信		[美]欧文·亚隆	中国轻工业出版社	张怡玲	2015-3	心理动力学相关
	Care of the Soul	[美]Thomas Moore	PIATKUS BOOKS		1992	心理动力学相关
情感依附：为	Lives Across Time / Growing Up	[美]亨利·马西 / [美]内森·塞恩伯	世界图书出版公司	童俊 /	2021	心理动力

何家会影响我的一生		格		武怡堃 / 陈昉 / 韩丹		学相关
积极心理治疗案例：幸福、治愈与提升		[澳]George W. Burns	中国轻工业出版社	高隽	2012-2	积极心理学临床实践
费解与显然：动作神经可塑性和健康	The Elusive Obvious: The Convergence of Movement, Neuroplasticity, and Health	[以]摩谢·费登奎斯	北京科学技术出版社	曹晓东 / 郭建江 / 商顺利	2023	费登奎斯的身心学理论综述
成为有能的自己：探索自发性与强迫性		[以]摩谢·费登奎斯	心灵工坊	易之新	2018-11	费登奎斯的身心学理论与方法
身体的智慧		[以]摩谢·费登奎斯	张老师文化	易之新	2017-5	费登奎斯的身心学理论

						与方法
解放聪明的“笨”小孩		吴端文	中国发展出版社		2014-3	感觉统合疗法对儿童行为失调问题的探索
爱的艺术	The Art of Loving	[美]艾·弗洛姆	上海译文出版社	李健鸣	2011-7	家庭-社会关系映射
ACT就这么简单	ACT Made Simple	[澳]路斯·哈里斯	机械工业出版社	王静/曹慧	2022-7	接纳承诺疗法入门
森田疗法指导：神经症克服法		[日] 高良武久	上海交通大学出版社	王祖承/陆谢森/陈幼寅	2014-9	森田疗法实践
非暴力沟通	Nonviolent Communication: A Language of Life	[美]马歇尔·卢森堡	华夏出版社	阮胤华	2009	中立表达技巧
宗教经验种种	The Varieties of Religious Experience	[美]威廉·詹姆斯	华夏出版社	尚新建	2012-12	神秘体验综述

如何在6个月内学会任何一种外语	How to learn any language in 6 months	[新]Chris Lonsdale	TEDx			讲座，思想启发
少有人走的路：心智成熟的旅程	The Road Less Traveled	[美]M·斯科特·派克	吉林文史出版社	于海生	2007	思想启发
原始思维		[法] 列维-布留尔	商务印书馆	丁由	1981	思想启发
小王子		[法] 圣埃克苏佩里	人民文学出版社	马振骋	2003-8	思想启发
中国哲学简史		冯友兰	北京大学出版社	涂又光	2010-8	思想启发